

Buku Ajar

PROFESIONALISME DALAM KEBIDANAN

Dwi Retno Wati • Eka Rahmawati • Arie Anggraini
Hana Nurhanifah Budiadi • Farida Utaminingtyas • Meli Doloksaribu
Rona Riasma Oktobriariani • Rochmanita Sandya Afindaningrum • Heni Haryani
Kusumastuti • Irma Seriana • Emilda
Evis Ritawani Hasibuan



BUKU AJAR

PROFESIONALISME DALAM KEBIDANAN

Penulis:

Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Eka Rahmawati, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.
Arie Anggraini, S.ST., Bdn., M.Tr.Keb.
Hana Nurhanifah Budiadi, SST., M.Tr.Keb.
Farida Utaminingtyas, S. ST., M. Keb.
Bdn. Meli Doloksaribu, S.Tr.Keb., M.Keb.
Rona Riasma Oktobriarani, SST., M.Keb.
Rochmanita Sandya Afindaningrum, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bdn. Heni Haryani, M.Keb.
Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes.
Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.
Emilda.AS. SST., MPH.
Bdn. Evis Ritawani Hasibuan, SST., M.Kes.



BUKU AJAR PROFESIONALISME DALAM KEBIDANAN

Penulis: Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Eka Rahmawati, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.

Arie Anggraini, S.ST., Bdn., M.Tr.Keb.

Hana Nurhanifah Budiadi, SST., M.Tr.Keb.

Farida Utaminingtyas, S. ST., M. Keb.

Bdn. Meli Doloksaribu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Rona Riasma Oktobriariani, SST., M.Keb.

Rochmanita Sandya Afindaningrum, S.Tr.Keb., M.Keb.

Bdn. Heni Haryani, M.Keb.

Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes.

Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.

Emilda.AS. SST., MPH.

Bdn. Evis Ritawani Hasibuan, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah, S.Pd

ISBN: 978-634-7294-03-6

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga buku ajar ini, yang berjudul *Profesionalisme dalam Kebidanan*, dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sebuah respon terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan tenaga kebidanan tidak hanya kompeten dalam keterampilan klinis semata, tetapi juga dituntut memiliki sikap, nilai-nilai, serta prinsip-prinsip profesional yang kuat guna menghadapi dinamika pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan multidimensional.

Peran seorang bidan dewasa ini tidak lagi terbatas pada ruang-ruang praktik klinik tradisional. Transformasi pelayanan kesehatan yang dipercepat oleh kemajuan teknologi, globalisasi informasi, serta perubahan perilaku masyarakat, menuntut setiap tenaga kebidanan untuk dapat menyesuaikan diri secara cepat dan efektif. Selain bertanggung jawab atas kesehatan ibu dan bayi, seorang bidan kini juga menjadi ujung tombak dalam edukasi kesehatan masyarakat, pengelolaan komunikasi publik melalui platform digital, serta sebagai agen perubahan yang harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara etis, profesional, dan bertanggung jawab.

Melalui buku ini, kami menyajikan materi yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, yang mencakup konsep-konsep dasar profesionalisme, penggunaan media sosial secara profesional dalam praktik kebidanan, aspek komunikasi efektif dalam interaksi dengan pasien dan masyarakat, serta prinsip-prinsip etika dan hukum yang harus menjadi pedoman baku dalam setiap tindakan bidan. Tidak ketinggalan pula, kami hadirkan contoh-contoh kasus nyata, latihan soal, serta studi-studi kasus yang menggambarkan berbagai tantangan nyata yang sering dihadapi oleh bidan dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik di lingkungan klinis maupun ruang digital.

Kami berharap bahwa melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis kasus ini, mahasiswa maupun tenaga kebidanan dapat lebih mudah memahami, menghayati, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip profesionalisme secara optimal dalam praktik nyata. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menginspirasi para tenaga pendidik dalam kebidanan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan kontekstual, sehingga lulusan program pendidikan kebidanan memiliki kompetensi profesional yang kokoh dan mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Kami menyadari bahwa membangun profesionalisme bukanlah sebuah proses yang singkat atau sederhana, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan konsistensi, komitmen, serta integritas tinggi dalam berbagai situasi. Oleh sebab itu, buku ini secara khusus disusun tidak hanya sebagai materi ajar semata, tetapi juga sebagai panduan praktis yang membantu tenaga kebidanan dalam menjaga integritas profesionalnya dalam berbagai kondisi, khususnya ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan etika, hukum, dan moral di era digital.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan konstruktif dari para pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi kebidanan, maupun pihak-pihak terkait lainnya sangat kami nantikan demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya. Kami memiliki keyakinan bahwa melalui kolaborasi dan diskusi yang konstruktif, kita dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas buku ajar ini secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan secara tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Terima kasih kepada seluruh kolega dosen, praktisi kebidanan, para ahli di bidang etika kesehatan, teknologi informasi, serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi pemikiran, masukan berharga, serta dukungan moril maupun materiil. Secara khusus, apresiasi mendalam juga kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, para bidan di lapangan, serta komunitas kesehatan yang telah berbagi pengalaman serta kasus-kasus berharga yang memperkaya isi buku ini.

Harapan kami, buku ini tidak hanya mampu memberikan wawasan teoritis semata, tetapi juga menginspirasi serta mendorong terwujudnya sikap profesionalisme yang nyata dalam praktik kebidanan sehari-hari. Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat nyata, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam kebidanan, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kebidanan di Indonesia.

Penulis

Juni, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 EVIDENCE-BASED MIDWIFERY	1
A. Konsep Dasar Evidence-based Midwifery.....	2
B. Proses Pencarian Bukti Ilmiah.....	4
C. Evaluasi Kualitas Bukti Ilmiah	6
D. Integrasi Bukti Ilmiah dalam Praktik Klinis Kebidanan.....	9
E. Latihan Soal.....	13
F. Rangkuman Materi.....	15
G. Glosarium	16
H. Daftar Pustaka	18
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN PELAYANAN KEBIDANAN	21
A. Pelayanan Kebidanan pada Masa Kuno hingga Abad Pertengahan.....	23
B. Era Tradisional Menuju Era Medis Modern	26
C. Tokoh-tokoh Penting dalam Sejarah Kebidanan	29
D. Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan	32
E. Sejarah dan Profesionalisme Kebidanan Masa Kini	35
F. Latihan Soal.....	39
G. Rangkuman Materi.....	41
H. Glosarium	43
I. Daftar Pustaka	46
BAB 3 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BIDAN PADA BERBAGAI TATANAN PELAYANAN KESEHATAN, PROMOSI KESEHATAN	49
A. Peran Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan.....	52
B. Fungsi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan	54
C. Tanggung Jawab Bidan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan.....	55
D. Peran Dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Promosi Kesehatan	57
E. Latihan Soal	59
F. Rangkuman Materi.....	59

G. Glosarium	60
H. Daftar Pustaka	60
BAB 4 PERAN BIDAN DI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER TERMASUK KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUANG LINGKUP PRAKTIK BIDAN	61
A. Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan Primer dalam Kebidanan.....	63
B. Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Primer	64
C. Peran Strategis Bidan dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	65
D. Ruang Lingkup Praktik Kebidanan.....	67
E. Latihan Soal	70
F. Rangkuman Materi.....	72
G. Glosarium	73
H. Daftar Pustaka	76
BAB 5 BUDAYA/TRADISI DALAM KEBIDANAN	79
A. Konsep Dasar Kebudayaan dan Tradisi dalam Kebidanan.....	80
B. Budaya dan Tradisi dalam Praktik Kebidanan di Indonesia.....	82
C. Dampak Budaya dan Tradisi terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi	84
D. Pendekatan Asuhan Kebidanan Sensitif Budaya.....	87
E. Program Pendidikan dan Promosi Kesehatan Berbasis Budaya	90
F. Latihan Soal	93
G. Rangkuman Materi.....	95
H. Glosarium	96
I. Daftar Pustaka	99
BAB 6 KAJIAN GENDER DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	101
A. Konsep Dasar Gender dalam Kebidanan.....	103
B. Isu-Isu Gender dalam Pelayanan Kebidanan	105
C. Pendekatan Responsif Gender dalam Pelayanan Kebidanan	108
D. Strategi Advokasi Gender dalam Pelayanan Kebidanan.....	115
E. Latihan Soal	120
F. Rangkuman Materi.....	122
G. Glosarium	124
H. Daftar Pustaka	126

BAB 7 KEILMUAN KEBIDANAN, DEFINISI NORMAL CHILBIRTH (KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS), STANDARD ICM.....	129
A. Keilmuan Kebidanan.....	131
B. Definisi Normal Childbirth.....	132
C. Standard ICM.....	134
D. Latihan Soal	136
E. Rangkuman Materi.....	139
F. Glosarium	140
G. Daftar Pustaka	142
 BAB 8 HUBUNGAN BIDAN-IBU DAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	 145
A. Hubungan Bidan-Ibu dalam Pelayanan Kebidanan.....	146
B. Keterampilan Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kebidanan.....	147
C. Latihan Soal	149
D. Rangkuman Materi.....	151
E. Glosarium	152
F. Daftar pustaka	154
 BAB 9 MEDIA SOCIAL DAN PROFESIONALISME	 157
A. Konsep Dasar Media Sosial dalam Kebidanan.....	159
B. Manfaat dan Risiko Media Sosial bagi Profesi Kebidanan	161
C. Kasus-Kasus Pelanggaran Profesionalisme di Media Sosial.....	164
D. Strategi Menggunakan Media Sosial secara Profesional dan Bertanggung Jawab	166
E. Integrasi Prinsip Etik dan Hukum dalam Penggunaan Media Sosial.....	169
F. Penyusunan Pedoman Penggunaan Media Sosial untuk Profesionalisme Kebidanan	171
G. Latihan Soal	174
H. Rangkuman Materi.....	177
I. Glosarium	178
J. Daftar pustaka	181

BAB 10 PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT) DAN PENTINGNYA BELAJAR SEPANJANG HAYAT	183
A. Konsep dan Tujuan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD)	184
B. Pentingnya Belajar Sepanjang Hayat dalam Kebidanan	186
C. Tantangan dalam Implementasi CPD dan Strategi Mengatasinya	187
D. Merancang Rencana Personal untuk CPD	190
E. Latihan Soal	193
F. Rangkuman Materi	195
G. Glosarium	196
H. Daftar Pustaka	199
 BAB 11 PENGANTAR KEPEMIMPINAN DALAM KEBIDANAN	201
A. Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Kebidanan	203
B. Teori dan Gaya Kepemimpinan dalam Kebidanan	204
C. Peran Pemimpin dalam Praktik Kebidanan	207
D. Strategi Kepemimpinan Efektif dalam Pelayanan Kebidanan	210
E. Kepemimpinan dalam Manajemen Risiko dan Keamanan Pasien	212
F. Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Kebidanan di Era Digital	215
G. Studi Kasus Kepemimpinan dalam Praktik Kebidanan	218
H. Latihan Soal	220
I. Glosarium	222
J. Daftar Pustaka	226
 BAB 12 PENGENALAN PADA POLITI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN DAN MEDICAL MODEL DALAM PELAYANAN OBSTETRIK	229
A. Konsep Dasar Politi dalam Pelayanan Kebidanan	231
B. Medical Model dalam Pelayanan Obstetrik	233
C. Latihan Soal	235
D. Rangkuman Materi	237
E. Glosarium	238
F. Daftar Pustaka	240

BAB 13 PRINSIP PARTNERSHIP DALAM PROMOSI KESEHATAN: INTERPROFESSIONAL, INTERAGENCY DAN INTERSEKTOR	243
A. Konsep dan Tujuan Partnership dalam Promosi Kesehatan Kebidanan.....	245
B. Prinsip Partnership Interprofessional dalam Kebidanan.....	246
C. Prinsip Partnership Interagency dalam Kebidanan	248
D. Prinsip Partnership Intersektor dalam Kebidanan	249
E. Strategi Implementasi dan Tantangan Partnership dalam Kebidanan.....	251
F. Latihan Soal.....	254
G. Rangkuman Materi.....	256
H. Glosarium	257
I. Daftar Pustaka	259
 BAB 14 TREND DAN ISSUE	261
A. Tren Terkini dalam Kebidanan.....	262
B. Isu Kontemporer dalam Kebidanan.....	263
C. Tantangan Profesionalisme di Era Modern	265
D. Strategi Menghadapi Tren dan Isu dalam Kebidanan	267
E. Latihan Soal.....	269
F. Rangkuman Materi.....	272
G. Glosarium	273
H. Daftar Pustaka	275
 PROFIL PENULIS	277

BAB 1

EVIDENCE-BASED MIDWIFERY

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti materi ini, lulusan mampu menerapkan prinsip dan metode evidence-based midwifery dalam praktik kebidanan secara profesional dan etis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami konsep evidence-based midwifery, menerapkan prinsip pencarian bukti ilmiah, serta mengevaluasi kualitas bukti dalam praktik kebidanan untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan yang diberikan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar evidence-based midwifery.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber bukti ilmiah dalam kebidanan.
- Mahasiswa mampu menerapkan proses pencarian bukti ilmiah secara sistematis.
- Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas dan relevansi bukti ilmiah yang ditemukan.
- Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil bukti ilmiah dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis.

Pendahuluan

Evidence-based midwifery (EBM) merupakan praktik kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis yang relevan, dan nilai-nilai serta preferensi pasien. EBM bertujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan, meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan bidan efektif, efisien, aman, dan berorientasi pada pasien. Dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, penerapan EBM menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk memastikan pelayanan kebidanan yang profesional dan bermutu tinggi.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Evidence-based Midwifery

Evidence-based midwifery (EBM) merupakan pendekatan dalam praktik kebidanan yang secara eksplisit mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, pengalaman klinis yang diperoleh bidan selama praktik profesionalnya, serta preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan klinis. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan asuhan kebidanan yang efektif, aman, dan berpusat pada kebutuhan individu, sehingga menghasilkan keputusan klinis yang lebih akurat, optimal, dan berdampak positif bagi pasien.

EBM menggabungkan aspek ilmiah dan humanistik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan hasil klinis melalui keputusan yang didukung bukti terbaik yang tersedia. Pendekatan ini mendorong bidan untuk terus menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka berdasarkan informasi ilmiah terbaru, sekaligus menghargai pengalaman dan nilai yang dianut pasien dalam pengambilan keputusan terkait asuhan kebidanan.

Secara rinci, terdapat tiga komponen utama dalam konsep dasar Evidence-based Midwifery:

1. Bukti Ilmiah Terkini (Best Current Evidence)

Bukti ilmiah terkini mencakup berbagai hasil penelitian terbaru yang relevan dengan praktik kebidanan. Bidan diharapkan mampu:

- Menelusuri berbagai sumber informasi terpercaya seperti jurnal penelitian ilmiah, pedoman praktik klinis berbasis bukti, dan laporan hasil penelitian terbaru yang terpublikasi dalam database ilmiah seperti PubMed, Cochrane Library, atau jurnal-jurnal kebidanan nasional maupun internasional.
- Menilai dan mengevaluasi kualitas bukti ilmiah yang diperoleh berdasarkan hierarki bukti, yaitu mulai dari meta-analisis dan tinjauan sistematis (systematic reviews), uji klinis acak terkendali (randomized controlled trials/RCT), studi kohort, studi kasus-kontrol, hingga laporan kasus.
- Mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam praktik klinis sehari-hari, terutama yang terbukti efektif, efisien, dan aman berdasarkan hasil penelitian yang kredibel.

Sebagai contoh, penggunaan bukti ilmiah terkini dapat berupa:

- Penerapan teknik delayed cord clamping (penundaan penjepitan tali pusat) yang terbukti secara ilmiah meningkatkan cadangan zat besi pada bayi baru lahir.

- b. Implementasi penggunaan posisi tegak selama persalinan untuk mempercepat proses persalinan dan mengurangi risiko intervensi medis.

2. Pengalaman Klinis (Clinical Expertise)

Pengalaman klinis merupakan kemampuan praktis yang diperoleh oleh bidan melalui praktik langsung di lapangan selama bertahun-tahun. Aspek ini penting karena tidak semua situasi klinis dapat diselesaikan hanya dengan pedoman atau hasil penelitian saja. Pengalaman klinis membantu bidan dalam:

- a. Melakukan penilaian cepat dan tepat terhadap kondisi pasien dalam situasi klinis nyata.
- b. Menerapkan intuisi klinis berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam mengelola kondisi yang spesifik.
- c. Mengambil keputusan praktis secara bijaksana dalam situasi darurat atau saat bukti ilmiah yang tersedia masih terbatas atau bertentangan.
- d. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan interpersonal yang efektif untuk meningkatkan interaksi dan membangun kepercayaan dengan pasien.

Contoh implementasi pengalaman klinis dalam praktik kebidanan:

- a. Seorang bidan yang berpengalaman mampu mengenali tanda-tanda awal komplikasi persalinan seperti perdarahan postpartum, sehingga dapat segera mengambil tindakan cepat dan tepat sebelum komplikasi menjadi serius.
- b. Pengalaman dalam menangani pasien dengan berbagai latar belakang sosial-budaya yang berbeda, memungkinkan bidan lebih efektif dalam memberikan edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

3. Preferensi Pasien (Patient Preferences)

Preferensi pasien merupakan aspek yang menekankan pentingnya peran aktif pasien dalam pengambilan keputusan klinis, berdasarkan nilai-nilai, harapan, serta pilihan pribadi pasien tersebut. Dalam konteks EBM, preferensi pasien meliputi:

- a. Nilai dan keyakinan individu mengenai kesehatan, kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.
- b. Harapan pasien terhadap proses pelayanan kebidanan yang mereka inginkan, termasuk pilihan metode persalinan, pengelolaan nyeri, intervensi medis, hingga perawatan postpartum.
- c. Pilihan pasien yang dipengaruhi oleh aspek budaya, agama, sosial, ekonomi, dan keluarga yang harus dihormati oleh bidan dalam proses asuhan.

Implementasi preferensi pasien dalam praktik kebidanan dapat berupa:

- a. Menghormati keinginan pasien yang memilih persalinan normal tanpa intervensi medis, selama kondisi klinis memungkinkan.
- b. Melibatkan pasien secara aktif dalam diskusi mengenai pilihan kontrasepsi pasca persalinan berdasarkan nilai pribadi pasien dan pertimbangan medis.

B. Proses Pencarian Bukti Ilmiah

Dalam penerapan Evidence-based Midwifery (EBM), sangat penting bagi seorang bidan untuk menggunakan sumber bukti ilmiah yang kredibel, valid, relevan, dan berkualitas tinggi. Kualitas bukti ilmiah yang digunakan sangat memengaruhi kualitas keputusan klinis yang diambil oleh bidan dalam praktik sehari-hari. Berikut adalah penjelasan mendalam beserta rincian terkait masing-masing sumber bukti ilmiah dalam bidang kebidanan:

1. Jurnal Ilmiah Terakreditasi dan Peer-reviewed

Jurnal ilmiah merupakan media utama publikasi hasil penelitian terbaru, yang menjadi sumber informasi penting bagi tenaga kesehatan termasuk bidan. Jurnal ilmiah yang terakreditasi dan melalui proses peer-review memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi, karena sebelum dipublikasikan artikel di dalamnya telah melewati proses evaluasi ketat oleh para ahli independen di bidang terkait.

Keunggulan jurnal ilmiah terakreditasi dan peer-reviewed:

- a. Menyediakan hasil penelitian yang telah diuji secara ilmiah.
- b. Informasi yang disajikan bersifat objektif, ilmiah, dan dapat dipercaya.
- c. Menghadirkan data terbaru yang relevan dengan perkembangan praktik kebidanan.

Contoh jurnal ilmiah kebidanan bereputasi tinggi:

- a. Midwifery (Elsevier)
- b. Journal of Midwifery & Women's Health (JMWH)
- c. BMC Pregnancy and Childbirth
- d. Women and Birth

2. Database Ilmiah (PubMed, Scopus, Cochrane Library, Google Scholar)

Database ilmiah menyediakan akses luas terhadap jurnal, artikel penelitian, tinjauan sistematis, dan meta-analisis terbaru yang dapat digunakan bidan dalam menemukan informasi ilmiah terkini secara efisien. Berikut beberapa database ilmiah utama dalam bidang kebidanan:

- a. PubMed
 - 1) Dikelola oleh National Library of Medicine (NLM), Amerika Serikat.

- 2) Menyediakan akses ke jutaan artikel jurnal kesehatan, biomedis, dan kebidanan dari seluruh dunia.
 - 3) Memungkinkan pencarian berdasarkan kata kunci, penulis, tahun publikasi, dan tipe penelitian.
- b. Scopus
- 1) Database abstrak dan kutipan terbesar yang mencakup bidang ilmu kesehatan, termasuk kebidanan.
 - 2) Memberikan informasi mengenai kualitas jurnal dan analisis sitasi.
 - 3) Berguna untuk menilai dampak penelitian berdasarkan jumlah kutipan (citation analysis).
- c. Cochrane Library
- 1) Menyediakan tinjauan sistematis (systematic reviews) berkualitas tinggi dan meta-analisis.
 - 2) Merupakan referensi utama untuk informasi berbasis bukti dalam bidang kesehatan dan kebidanan.
 - 3) Membantu bidan dalam pengambilan keputusan klinis yang didukung oleh bukti kuat.
- d. Google Scholar
- 1) Mesin pencari akademik yang menyediakan akses luas terhadap publikasi ilmiah dari berbagai disiplin ilmu.
 - 2) Menyediakan akses artikel lengkap dan abstrak dari jurnal ilmiah, buku, tesis, serta prosiding konferensi.
 - 3) Membantu bidan dalam menemukan sumber yang lebih luas dan beragam, terutama dari jurnal open-access.

3. Pedoman Praktik Klinis Berbasis Bukti (Clinical Practice Guidelines)

Pedoman praktik klinis berbasis bukti adalah panduan yang dikembangkan oleh lembaga atau organisasi profesional, yang merangkum bukti-bukti ilmiah terbaik yang tersedia, untuk memberikan rekomendasi praktik yang jelas dan terstandar.

Keunggulan pedoman praktik klinis:

- a. Menyediakan rekomendasi terstruktur berdasarkan bukti ilmiah terbaru.
- b. Membantu bidan dalam membuat keputusan yang efektif, aman, dan konsisten dalam asuhan kebidanan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan melalui standar praktik yang jelas.

Contoh Clinical Practice Guidelines dalam kebidanan:

- a. WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience (WHO, 2016).

- b. NICE Guidelines (National Institute for Health and Care Excellence) tentang persalinan dan postpartum care.
- c. Pedoman Nasional Pelayanan Kebidanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

4. Buku Referensi dan Textbook yang Diperbarui Secara Reguler

Buku referensi dan textbook merupakan sumber ilmu yang terstruktur dan komprehensif, sangat berguna untuk membangun dasar teori dan memperkuat pemahaman konsep-konsep kebidanan. Buku-buku tersebut seringkali ditulis oleh pakar terkemuka di bidangnya, serta rutin diperbarui berdasarkan perkembangan terbaru ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelebihan buku referensi dan textbook:

- a. Menyediakan informasi komprehensif dan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan perkembangan terbaru dalam praktik kebidanan.
- b. Memberikan landasan teoritis yang kuat untuk praktik klinis berbasis bukti.
- c. Memudahkan pembelajaran dan pengembangan keilmuan kebidanan secara sistematis.

Contoh textbook kebidanan yang direkomendasikan dan rutin diperbarui:

- a. Varney's Midwifery (King, et al.)
- b. Myles Textbook for Midwives (Marshall & Raynor)
- c. Dewhurst's Textbook of Obstetrics & Gynaecology (Edmonds, et al.)
- d. Oxorn-Foote Human Labor and Birth (Cunningham et al.)

C. Evaluasi Kualitas Bukti Ilmiah

Setelah mengidentifikasi berbagai sumber bukti ilmiah yang kredibel dan relevan, tahap penting berikutnya dalam pendekatan Evidence-based Midwifery adalah melakukan evaluasi terhadap kualitas bukti tersebut. Evaluasi kualitas bukti ilmiah bertujuan memastikan bahwa bukti yang digunakan dalam praktik klinis benar-benar valid, relevan, terpercaya, serta dapat diterapkan secara efektif untuk situasi klinis tertentu.

Evaluasi kualitas bukti ilmiah dilakukan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu:

1. Validitas Internal dan Eksternal

Validitas bukti ilmiah merupakan kriteria utama untuk menentukan apakah hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang diteliti dan apakah hasil tersebut dapat diaplikasikan secara luas di luar penelitian tersebut.

- a. Validitas Internal

Validitas internal merujuk pada sejauh mana hasil penelitian benar-benar mencerminkan hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti, tanpa bias atau faktor pengganggu lainnya (confounding factors).

Aspek yang dinilai dalam validitas internal:

- 1) Metode randomisasi: Apakah peneliti menggunakan metode randomisasi yang tepat dalam menentukan kelompok eksperimen dan kontrol?
- 2) Blindness (pembutaan): Apakah peneliti dan subjek penelitian tidak mengetahui perlakuan yang diterima (single-blind atau double-blind) sehingga meminimalkan bias?
- 3) Pengendalian variabel pengganggu: Apakah peneliti mampu mengontrol variabel lain yang mungkin memengaruhi hasil penelitian?
- 4) Attrition (drop-out): Apakah tingkat kehilangan peserta selama penelitian minimal dan tidak memengaruhi hasil akhir secara signifikan?

Contoh:

- 1) Sebuah uji klinis mengenai efektivitas senam hamil untuk mengurangi nyeri persalinan harus memastikan bahwa metode randomisasi dilakukan secara benar, partisipan dibutakan terhadap jenis intervensi, dan tingkat drop-out minimal agar validitas internalnya tinggi.

b. Validitas Eksternal

Validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi dan diaplikasikan pada populasi atau kondisi lain yang lebih luas di luar populasi penelitian.

Aspek yang dinilai dalam validitas eksternal:

- 1) Karakteristik sampel: Apakah sampel penelitian representatif terhadap populasi umum di mana hasil tersebut akan diterapkan?
- 2) Setting penelitian: Apakah penelitian dilakukan dalam kondisi realistis yang mirip dengan kondisi praktik klinis sehari-hari?
- 3) Generalizability: Apakah hasil penelitian dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi klinis lainnya?

Contoh:

Studi yang melibatkan wanita hamil di fasilitas kesehatan primer dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi cenderung memiliki validitas eksternal yang tinggi dibandingkan dengan studi di rumah sakit khusus tertentu saja.

2. Relevansi dengan Situasi Klinis Spesifik

Relevansi adalah aspek penting yang harus dinilai, yakni sejauh mana hasil penelitian atau bukti ilmiah sesuai dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klinis spesifik yang dihadapi oleh bidan dalam praktiknya.

Aspek yang dinilai dalam relevansi bukti:

- a. Kesesuaian populasi: Apakah subjek penelitian mirip dengan pasien yang sedang dihadapi dalam praktik klinis?
- b. Intervensi yang digunakan: Apakah intervensi penelitian relevan dengan praktik klinis kebidanan saat ini?
- c. Outcome yang diukur: Apakah hasil penelitian (outcome) yang dinilai relevan dan penting secara klinis untuk pasien dalam konteks kebidanan?

Contoh:

Jika seorang bidan menghadapi pasien hamil dengan diabetes gestasional, hasil penelitian tentang intervensi diet atau aktivitas fisik spesifik untuk wanita hamil dengan diabetes gestasional akan jauh lebih relevan dibanding penelitian umum mengenai diabetes.

3. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah memiliki tingkat kualitas bukti berbeda-beda sesuai dengan hierarki bukti ilmiah. Pemahaman mengenai desain penelitian yang digunakan membantu bidan menilai kualitas dan kekuatan bukti tersebut.

Berikut hierarki desain penelitian mulai dari tingkat kualitas tertinggi hingga terendah:

- a. Meta-analisis dan Systematic Review (SR)
 - 1) Menyajikan ringkasan sistematis dari berbagai penelitian individual yang relevan.
 - 2) Menggunakan analisis statistik untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian, sehingga memberikan bukti yang kuat tentang efektivitas intervensi tertentu.
 - 3) Memiliki tingkat kualitas bukti tertinggi dalam hierarki bukti.

Contoh:

Cochrane systematic review tentang intervensi untuk mengurangi perdarahan postpartum.

- b. Randomized Controlled Trial (RCT)
 - 1) Penelitian eksperimental yang subjeknya diacak secara random ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol.
 - 2) Memberikan bukti kuat terkait hubungan sebab-akibat dari intervensi yang diberikan.
 - 3) Ideal untuk menilai efektivitas intervensi baru dalam kebidanan.

Contoh:

RCT mengenai efektivitas pijat perineum untuk mencegah robekan perineum saat persalinan.

c. Studi Kohort (Cohort Studies)

- 1) Studi observasional yang mengikuti sekelompok subjek dengan karakteristik tertentu untuk melihat perkembangan suatu kondisi atau hasil tertentu dari waktu ke waktu.
- 2) Cocok untuk mengamati efek paparan atau intervensi tertentu secara prospektif.

Contoh:

Studi kohort yang mengamati pengaruh asupan zat besi selama kehamilan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil.

d. Studi Kasus-Kontrol (Case-Control Studies)

- 1) Studi observasional yang membandingkan subjek yang memiliki kondisi tertentu (kasus) dengan subjek tanpa kondisi tersebut (kontrol) secara retrospektif.
- 2) Cocok untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit atau kondisi tertentu.

Contoh:

Studi kasus-kontrol mengenai faktor risiko preeklamsia pada wanita hamil.

e. Laporan Kasus (Case Reports)

- 1) Studi observasional sederhana yang mendeskripsikan kondisi klinis unik atau langka pada individu atau kelompok kecil.
- 2) Memberikan informasi awal mengenai fenomena klinis yang belum banyak dipahami.

Contoh:

Laporan kasus tentang kelahiran normal pada kehamilan dengan kelainan anatomi rahim yang jarang terjadi.

D. Integrasi Bukti Ilmiah dalam Praktik Klinis Kebidanan

Integrasi bukti ilmiah ke dalam praktik kebidanan merupakan langkah penting dalam pendekatan Evidence-based Midwifery (EBM). Proses integrasi ini melibatkan penggunaan hasil evaluasi bukti ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya untuk diterapkan secara efektif dalam keputusan klinis sehari-hari. Tahap ini tidak hanya berfokus pada aspek ilmiah, namun juga memperhatikan pengalaman klinis bidan serta nilai, preferensi, dan harapan pasien. Tujuan utama integrasi ini adalah memastikan bahwa asuhan kebidanan yang diberikan benar-benar optimal, aman, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap pasien.

Tahap integrasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Menilai Manfaat dan Risiko Intervensi Berdasarkan Bukti

Pada tahap ini, bidan mengevaluasi manfaat (benefit) dan risiko (harm/risk) dari intervensi atau tindakan klinis tertentu berdasarkan bukti ilmiah yang telah dinilai sebelumnya. Hal ini penting karena setiap tindakan klinis yang diambil dalam kebidanan memiliki potensi manfaat sekaligus risiko tertentu.

Hal-hal yang dinilai dalam aspek manfaat dan risiko:

a. Efektivitas intervensi:

- 1) Apakah intervensi terbukti secara ilmiah efektif dalam mencapai hasil klinis yang diinginkan?
- 2) Sejauh mana intervensi tersebut lebih baik dibandingkan alternatif lainnya?

b. Keamanan intervensi:

- 1) Apakah intervensi aman untuk pasien dalam berbagai kondisi?
- 2) Risiko apa saja yang dapat timbul akibat intervensi tersebut?

c. Keseimbangan manfaat dan risiko:

- 1) Apakah manfaat yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin terjadi?
- 2) Bagaimana cara meminimalkan risiko dari intervensi tersebut?

Contoh dalam praktik kebidanan:

Dalam menentukan intervensi episiotomi saat persalinan normal, bidan akan mengevaluasi bukti ilmiah terkini yang menunjukkan bahwa episiotomi rutin memiliki risiko tinggi terhadap trauma perineum dibanding manfaatnya, sehingga tindakan ini hanya dilakukan jika manfaatnya jelas lebih besar dari risikonya.

2. Diskusi dengan Pasien Mengenai Temuan Bukti Ilmiah dan Pilihan Intervensi yang Tersedia

Setelah bidan menilai manfaat dan risiko intervensi secara ilmiah, langkah berikutnya adalah mendiskusikan secara terbuka dan transparan hasil temuan bukti ilmiah dengan pasien. Diskusi ini penting untuk memastikan pasien memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi klinisnya, pilihan intervensi yang tersedia, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing intervensi.

Hal-hal yang perlu didiskusikan bersama pasien:

- a. Penjelasan sederhana dan jelas tentang kondisi klinis pasien.
- b. Pilihan intervensi klinis yang tersedia berdasarkan bukti ilmiah.
- c. Keunggulan dan keterbatasan masing-masing intervensi.
- d. Potensi manfaat dan risiko setiap pilihan intervensi.
- e. Implikasi keputusan yang diambil terhadap hasil akhir dan kesejahteraan pasien.

Tujuan diskusi ini adalah:

- a. Membantu pasien memahami kondisi mereka secara komprehensif.
- b. Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap proses asuhan kebidanan.
- c. Memberdayakan pasien untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang perawatan mereka.

Contoh dalam praktik kebidanan:

Saat berdiskusi tentang metode pengendalian nyeri selama persalinan, bidan akan menjelaskan secara rinci pilihan metode seperti anestesi epidural, metode non-farmakologis (misalnya relaksasi atau hidroterapi), serta risiko dan manfaat masing-masing metode tersebut.

3. Mengambil Keputusan Bersama (Shared Decision-making)

Shared decision-making merupakan pendekatan kolaboratif antara bidan dan pasien, di mana keputusan klinis diambil bersama-sama dengan mempertimbangkan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis bidan, serta nilai, preferensi, dan harapan pasien. Tahap ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik pasien, sekaligus meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan kebidanan yang diterimanya.

Langkah-langkah dalam proses shared decision-making:

- a. Identifikasi keputusan klinis:
 - Menjelaskan kondisi pasien dan perlunya keputusan klinis tertentu diambil.
- b. Penyampaian informasi:
 - Memberikan informasi tentang opsi intervensi yang tersedia, termasuk manfaat, risiko, dan alternatif yang relevan.
- c. Diskusi terbuka:
 - Mengajak pasien berdiskusi aktif mengenai preferensi dan harapannya terhadap hasil intervensi.
- d. Pertimbangan preferensi pasien:
 - Mendengarkan dan menghormati pandangan serta nilai-nilai pribadi pasien dalam menentukan pilihan intervensi.
- e. Kesepakatan bersama:
 - Menyepakati keputusan yang paling sesuai antara bidan dan pasien dengan mempertimbangkan semua aspek yang telah didiskusikan.

Keuntungan shared decision-making:

- a. Meningkatkan rasa percaya dan hubungan terapeutik antara pasien dan bidan.
- b. Pasien merasa lebih puas karena merasa dihargai dan didengarkan.

- c. Mengurangi potensi ketidakpuasan, konflik, atau kesalahpahaman dalam pelayanan kebidanan.

Contoh dalam praktik kebidanan:

Dalam keputusan pemilihan tempat persalinan (rumah, klinik, atau rumah sakit), bidan akan mengajak pasien berdiskusi mengenai bukti ilmiah tentang keamanan dan kenyamanan masing-masing opsi, kemudian bersama-sama menentukan tempat persalinan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien.

E. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan menghadapi pasien primigravida yang ingin melakukan persalinan secara alami tanpa intervensi medis. Pasien telah mencari informasi melalui media sosial, tetapi masih ragu. Menurut pendekatan evidence-based midwifery (EBM), langkah pertama yang paling tepat dilakukan bidan adalah:

- A. Langsung menyetujui permintaan pasien
- B. Menawarkan intervensi medis sebagai opsi utama
- C. Menjelaskan pilihan intervensi secara transparan berdasarkan bukti ilmiah
- D. Mengabaikan preferensi pasien demi keselamatan
- E. Menyerahkan semua keputusan sepenuhnya kepada pasien

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Dalam pendekatan EBM, bidan harus menyampaikan informasi secara transparan mengenai bukti ilmiah, manfaat, dan risiko berbagai opsi yang tersedia, sebelum membuat keputusan bersama pasien.

Soal 2

Seorang bidan sedang mengevaluasi artikel ilmiah mengenai penggunaan delayed cord clamping untuk meningkatkan cadangan zat besi bayi baru lahir. Manakah desain penelitian berikut yang memiliki tingkat bukti ilmiah paling tinggi?

- A. Laporan kasus (case report)
- B. Studi kohort
- C. Randomized Controlled Trial (RCT)
- D. Studi kasus-kontrol
- E. Meta-analisis dan systematic review

Kunci Jawaban: E

Rasional:

Meta-analisis dan systematic review merupakan hierarki bukti ilmiah tertinggi, karena menyajikan rangkuman sistematis dari berbagai studi individual, yang memberikan kesimpulan kuat berdasarkan integrasi statistik.

Soal 3

Seorang bidan menghadapi situasi darurat, yaitu perdarahan postpartum mendadak pada pasien multipara. Bukti ilmiah spesifik untuk kondisi pasien ini masih terbatas. Tindakan terbaik yang harus dilakukan bidan berdasarkan konsep EBM adalah:

- A. Menunggu hasil penelitian lebih lanjut
- B. Bergantung sepenuhnya pada preferensi pasien
- C. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman klinis dan bukti ilmiah yang tersedia
- D. Mengikuti saran keluarga pasien tanpa mempertimbangkan bukti
- E. Mengabaikan intuisi klinis

Kunci Jawaban: C**Rasional:**

Dalam situasi darurat, bidan harus menggabungkan pengalaman klinis dengan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, meskipun terbatas, untuk mengambil keputusan cepat dan tepat demi keselamatan pasien.

Soal 4

Seorang bidan ingin mencari informasi terkini mengenai efektivitas posisi tegak saat persalinan. Manakah sumber bukti berikut yang paling kredibel untuk menemukan tinjauan sistematis mengenai hal tersebut?

- A. Google
- B. Media sosial
- C. Majalah kebidanan populer
- D. Cochrane Library
- E. Surat kabar kesehatan

Kunci Jawaban: D**Rasional:**

Cochrane Library adalah database terpercaya yang khusus menyediakan tinjauan sistematis (systematic reviews) berkualitas tinggi dalam bidang kesehatan dan kebidanan.

Soal 5

Seorang pasien dengan diabetes gestasional datang untuk kontrol kehamilan. Ia memiliki preferensi pribadi untuk mengelola gula darah dengan pola makan dan aktivitas fisik, tanpa menggunakan insulin kecuali jika diperlukan. Dalam konsep evidence-based midwifery, sikap bidan yang paling tepat terhadap preferensi pasien ini adalah:

- A. Menolak pilihan pasien karena bertentangan dengan pedoman yang berlaku
- B. Mengabaikan preferensi pasien karena dianggap berisiko tinggi
- C. Mendukung sepenuhnya tanpa diskusi lebih lanjut
- D. Berdiskusi terbuka mengenai bukti ilmiah, manfaat, risiko, dan pilihan lain sebelum keputusan bersama
- E. Mengarahkan pasien secara tegas untuk langsung menggunakan insulin

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Shared decision-making merupakan prinsip penting dalam EBM, di mana bidan dan pasien berdiskusi secara terbuka dan transparan mengenai manfaat, risiko, bukti ilmiah, dan opsi-opsi yang tersedia sebelum mengambil keputusan klinis bersama.

F. Rangkuman Materi

Evidence-based Midwifery (EBM) merupakan pendekatan esensial dalam praktik kebidanan modern yang mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu penggunaan bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis bidan, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan penerapan EBM, bidan tidak hanya berfokus pada hasil klinis yang optimal, tetapi juga mampu memberikan asuhan yang humanistik, aman, dan berpusat pada kebutuhan pasien secara individu.

Dalam penerapan EBM, proses pencarian bukti ilmiah dilakukan melalui sumber-sumber yang kredibel, seperti jurnal ilmiah terakreditasi dan peer-reviewed, database ilmiah terpercaya seperti PubMed, Scopus, dan Cochrane Library, pedoman praktik klinis berbasis bukti, serta buku referensi yang diperbarui secara reguler. Evaluasi kualitas bukti ilmiah juga merupakan langkah krusial, dengan memperhatikan validitas internal dan eksternal, relevansi dengan kondisi klinis spesifik, serta jenis desain penelitian yang digunakan (meta-analisis, RCT, kohort, kasus-kontrol, laporan kasus).

Tahap integrasi bukti ilmiah dalam praktik klinis kebidanan mencakup penilaian manfaat dan risiko intervensi berdasarkan bukti ilmiah, diskusi terbuka dan transparan dengan pasien mengenai berbagai pilihan intervensi, serta mengambil

keputusan bersama (shared decision-making) antara bidan dan pasien. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga memperkuat hubungan terapeutik antara pasien dan bidan, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap asuhan yang diberikan.

Dengan demikian, penerapan Evidence-based Midwifery menjadi landasan kuat dalam mewujudkan praktik kebidanan yang efektif, aman, berkualitas tinggi, dan menghargai preferensi serta nilai-nilai pasien secara menyeluruh.

G. Glosarium

Evidence-based Midwifery (EBM)

Pendekatan praktik kebidanan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, pengalaman klinis bidan, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Bukti Ilmiah Terkini (Best Current Evidence)

Informasi ilmiah terbaru yang relevan dan diperoleh dari penelitian yang kredibel, digunakan sebagai dasar keputusan klinis dalam kebidanan.

Pengalaman Klinis (Clinical Expertise)

Pengetahuan praktis, intuisi klinis, dan keterampilan yang dimiliki bidan yang diperoleh melalui pengalaman langsung selama bertahun-tahun dalam praktik kebidanan.

Preferensi Pasien (Patient Preferences)

Nilai-nilai, keyakinan, harapan, dan pilihan pribadi pasien yang dihargai dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan klinis.

Delayed Cord Clamping

Teknik menunda penjepitan tali pusat setelah bayi lahir, terbukti secara ilmiah meningkatkan cadangan zat besi pada bayi baru lahir.

Shared Decision-making

Pendekatan kolaboratif antara bidan dan pasien dalam membuat keputusan klinis dengan memperhatikan bukti ilmiah, pengalaman klinis bidan, serta preferensi dan nilai pribadi pasien.

Validitas Internal

Tingkat kepercayaan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan hubungan sebab-akibat yang sesungguhnya antara variabel yang diteliti, tanpa bias atau faktor pengganggu lainnya.

Validitas Eksternal

Kemampuan generalisasi hasil penelitian ke populasi atau situasi yang lebih luas, di luar populasi atau konteks penelitian tersebut dilakukan.

Meta-analisis

Metode penelitian yang menggabungkan hasil beberapa studi individual menggunakan analisis statistik, menghasilkan kesimpulan yang kuat tentang efektivitas suatu intervensi.

Systematic Review (Tinjauan Sistematis)

Kajian sistematis terhadap literatur ilmiah yang relevan tentang suatu topik, mengikuti metode yang ketat untuk menilai kualitas bukti yang tersedia.

Randomized Controlled Trial (RCT)

Studi eksperimental di mana subjek penelitian diacak secara acak ke dalam kelompok intervensi atau kontrol, untuk menguji efektivitas suatu intervensi.

Studi Kohort (Cohort Study)

Studi observasional prospektif yang mengikuti sekelompok individu dengan karakteristik tertentu dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi perkembangan suatu kondisi atau hasil tertentu.

Studi Kasus-Kontrol (Case-Control Study)

Studi observasional retrospektif yang membandingkan kelompok subjek dengan kondisi tertentu (kasus) terhadap kelompok subjek tanpa kondisi tersebut (kontrol) untuk menentukan faktor risiko.

Laporan Kasus (Case Report)

Laporan rinci mengenai kasus klinis tertentu yang unik atau langka, memberikan wawasan awal untuk penelitian lebih lanjut.

Jurnal Ilmiah Terakreditasi dan Peer-reviewed

Jurnal yang artikelnya telah melalui proses evaluasi oleh para ahli di bidang terkait sebelum diterbitkan, memastikan kredibilitas dan validitas informasi yang disajikan.

Database Ilmiah

Basis data daring yang menyediakan akses terhadap publikasi ilmiah seperti jurnal, artikel penelitian, dan tinjauan sistematis, contohnya PubMed, Scopus, Cochrane Library, dan Google Scholar.

Pedoman Praktik Klinis (Clinical Practice Guidelines)

Panduan sistematis berbasis bukti ilmiah yang dikembangkan oleh organisasi profesional untuk membantu praktisi kesehatan dalam membuat keputusan klinis yang konsisten, efektif, dan aman.

Generalizability

Kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan secara efektif pada situasi atau populasi lain di luar konteks awal penelitian.

Keseimbangan Manfaat dan Risiko

Penilaian terhadap keuntungan intervensi klinis dibandingkan dengan potensi dampak negatif atau risiko yang mungkin ditimbulkan.

Integrasi Bukti Ilmiah

Proses menerapkan hasil evaluasi bukti ilmiah yang kredibel ke dalam praktik klinis secara efektif, disertai pertimbangan pengalaman klinis dan preferensi pasien.

H. Daftar Pustaka

Daftar pustaka ini mencakup sumber-sumber primer dan buku referensi kredibel yang digunakan sebagai dasar dalam penjelasan mengenai konsep dasar dan penerapan Evidence-based Midwifery (EBM).

Edmonds, D. K., Lees, C., & Bourne, T. (Eds.). (2018). *Dewhurst's textbook of obstetrics and gynaecology* (9th ed.). Wiley-Blackwell.

Homer, C. S. E., Friberg, I. K., Bastos Dias, M. A., ten Hoope-Bender, P., Sandall, J., Speciale, A. M., & Bartlett, L. A. (2014). The projected effect of scaling up

midwifery. *The Lancet*, 384(9948), 1146–1157. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60790-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60790-X)

King, T. L., Brucker, M. C., Kriebs, J. M., Fahey, J. O., Gegor, C. L., & Varney, H. (2019). *Varney's midwifery* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.

Marshall, J., & Raynor, M. (2020). *Myles textbook for midwives* (17th ed.). Elsevier Health Sciences.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2017). Intrapartum care for healthy women and babies. Clinical Guideline CG190. Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/cg190>

Nursing and Midwifery Council (NMC). (2015). *The Code: Professional standards of practice and behaviour for nurses and midwives*. Retrieved from <https://www.nmc.org.uk/standards/code/>

Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... & Wick, L. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)

Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ*, 312(7023), 71–72. <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>

Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>

World Health Organization (WHO). (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf>

World Health Organization (WHO). (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>

World Health Organization (WHO). (2020). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240006614>

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN PELAYANAN KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami dan mengintegrasikan sejarah perkembangan kebidanan sebagai dasar untuk mengembangkan sikap profesional dan kompeten dalam memberikan pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan sejarah perkembangan pelayanan kebidanan dari berbagai periode waktu.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pelayanan kebidanan.
- Menghubungkan sejarah kebidanan dengan perkembangan praktik profesionalisme kebidanan saat ini.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mendeskripsikan sejarah kebidanan pada masa kuno hingga abad pertengahan.
- Menjelaskan perubahan dalam praktik kebidanan dari era tradisional menuju era medis modern.
- Mengidentifikasi tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perkembangan pelayanan kebidanan.
- Menjelaskan pengaruh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan kebidanan.
- Menghubungkan nilai-nilai sejarah kebidanan dengan prinsip-prinsip profesionalisme dalam pelayanan kebidanan saat ini.

Pendahuluan

Kebidanan adalah profesi yang berperan penting dalam layanan kesehatan ibu dan bayi, khususnya selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Pelayanan kebidanan memiliki sejarah panjang dan terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial dan budaya masyarakat. Pemahaman terhadap sejarah kebidanan memberikan wawasan penting mengenai bagaimana profesi ini berkembang dari praktik tradisional hingga menjadi disiplin ilmu yang diakui secara global. Bab ini akan membahas secara komprehensif sejarah perkembangan pelayanan kebidanan, dari masa lampau hingga era modern, serta implikasinya terhadap profesionalisme dalam praktik kebidanan saat ini.

A. Pelayanan Kebidanan pada Masa Kuno hingga Abad Pertengahan

1. Praktik kebidanan di Mesir Kuno, Yunani, Romawi, dan Asia Timur.

Pada masa kuno, praktik kebidanan sudah berkembang di berbagai peradaban besar, termasuk Mesir Kuno, Yunani, Romawi, dan Asia Timur. Setiap wilayah memiliki karakteristik khusus dalam pendekatan kebidanan mereka, sebagai berikut:

a. Mesir Kuno

- 1) Praktik kebidanan sudah sangat terorganisir dengan baik, melibatkan pengetahuan anatomi yang relatif maju.
- 2) Papirus Kahun dan Papirus Ebers, dua dokumen medis kuno, memberikan bukti praktik kebidanan, termasuk metode pemeriksaan kehamilan, persalinan, serta komplikasi seperti kelahiran prematur.
- 3) Bidan dikenal sebagai sosok terlatih yang disebut Shifrah dan Puah, berperan dalam membantu kelahiran serta memberikan perawatan postpartum dengan ramuan herbal.

b. Yunani Kuno

- 1) Ilmu kebidanan di Yunani kuno sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat dan kedokteran Hippocrates yang menekankan keseimbangan cairan tubuh (humor).
- 2) Bidan, disebut sebagai maia, memegang peranan penting dalam persalinan. Mereka dihormati dan diberikan pelatihan tertentu dalam anatomi dan prosedur persalinan dasar.
- 3) Soranus dari Ephesus merupakan tokoh medis penting pada abad ke-2 M yang banyak menulis tentang kebidanan, termasuk instruksi detail tentang proses persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

c. Romawi Kuno

- 1) Praktik kebidanan di Romawi mirip dengan Yunani, namun memiliki pendekatan yang lebih terstruktur. Perempuan dengan profesi ini disebut obstetrix.
- 2) Bidan Romawi mendapatkan pendidikan formal dalam penanganan kelahiran normal maupun komplikasi tertentu, sering kali bekerja bersama dokter untuk penanganan kasus rumit.

- 3) Mereka juga memiliki wewenang untuk memberikan tindakan medis tertentu seperti prosedur sederhana dalam menangani komplikasi persalinan.

d. Asia Timur (Tiongkok Kuno)

- 1) Kebidanan Tiongkok kuno sangat terikat dengan konsep Yin dan Yang serta prinsip pengobatan tradisional Tiongkok (Traditional Chinese Medicine – TCM).
- 2) Penanganan kehamilan dan persalinan dilakukan dengan kombinasi teknik pijat, akupunktur, serta penggunaan ramuan herbal khusus.
- 3) Kitab klasik kebidanan Tiongkok seperti Jing Xiao Chan Bao menguraikan metode detail tentang perawatan kehamilan dan persalinan, termasuk posisi melahirkan dan intervensi bila terjadi komplikasi.

2. Peran bidan tradisional dan praktik herbal dalam membantu proses persalinan.

Pada masa ini, bidan tradisional memainkan peranan sentral dalam mendampingi wanita selama proses persalinan. Mereka biasanya perempuan berpengalaman dalam masyarakat yang dihormati karena keterampilan dan pengetahuan empiris mereka.

a. Peran Bidan Tradisional

- 1) Membantu proses persalinan secara alami tanpa intervensi medis yang rumit.
- 2) Memiliki keahlian berdasarkan pengalaman langsung yang diwariskan secara turun-temurun.
- 3) Memberikan dukungan emosional serta spiritual kepada ibu yang melahirkan.
- 4) Mendeteksi dini tanda-tanda komplikasi untuk tindakan pertolongan darurat atau merujuk ke tenaga medis terlatih.

b. Praktik Herbal dalam Persalinan

- 1) Ramuan herbal menjadi komponen penting dalam praktik kebidanan tradisional, digunakan untuk memperlancar proses persalinan, mengurangi rasa sakit, serta mempercepat pemulihan ibu pasca melahirkan.
- 2) Misalnya, daun raspberry merah, lavender, chamomile, dan akar jahe umum digunakan untuk berbagai kondisi selama persalinan.
- 3) Di Asia Timur, ramuan herbal seperti danggui (*Angelica sinensis*) dan ginseng dipakai secara luas untuk menguatkan ibu pasca persalinan dan mengatasi kelelahan akibat proses persalinan.

3. Keyakinan budaya dan agama yang mempengaruhi praktik kebidanan di masa lalu.

Praktik kebidanan di masa lalu juga dipengaruhi secara kuat oleh keyakinan budaya serta agama masyarakat setempat. Hal ini berdampak langsung pada bagaimana proses kelahiran dipandang dan praktik yang dilakukan selama persalinan.

a. Pengaruh Keyakinan Budaya

- 1) Di banyak masyarakat kuno, kelahiran dianggap sebagai peristiwa sakral yang berkaitan dengan tradisi leluhur dan komunitas.
- 2) Tradisi seperti upacara ritual, doa, dan mantra dilakukan oleh bidan tradisional untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi selama proses kelahiran.
- 3) Praktik tertentu, misalnya, penggunaan jimat atau perlindungan spiritual, sangat umum dilakukan untuk melindungi ibu dan bayi dari bahaya spiritual atau gangguan roh jahat.

b. Pengaruh Agama

- 1) Di Mesir kuno, para dewi seperti Hathor dan Isis dipercaya melindungi perempuan saat melahirkan, sehingga ritual doa dan persembahan menjadi bagian dari proses kebidanan.
- 2) Dalam agama Yunani dan Romawi, Artemis/Diana adalah dewi kelahiran yang disembah untuk mendapatkan perlindungan selama proses persalinan.
- 3) Dalam masyarakat Asia Timur, terutama di Tiongkok, Taoisme dan Konfusianisme memiliki pengaruh besar dalam praktik kebidanan, terutama dalam menjaga keseimbangan energi vital selama kehamilan dan persalinan.

Praktik kebidanan pada masa kuno hingga abad pertengahan memperlihatkan bahwa profesi bidan telah ada sejak zaman kuno dan memiliki peranan krusial dalam mendampingi ibu dan bayi selama proses kelahiran. Praktik ini tidak hanya melibatkan keterampilan teknis tetapi juga kearifan lokal, penggunaan ramuan herbal, serta ritual budaya dan keagamaan. Pemahaman tentang sejarah kebidanan pada periode ini memberikan perspektif berharga mengenai bagaimana tradisi dan pengetahuan empiris menjadi dasar berkembangnya ilmu kebidanan modern.

B. Era Tradisional Menuju Era Medis Modern

Era transisi dari praktik tradisional menuju pelayanan kebidanan yang lebih terstruktur dan berbasis ilmu medis menandai perubahan besar dalam sejarah profesi bidan. Masa ini ditandai oleh integrasi antara pengetahuan empiris yang diwariskan secara turun-temurun dengan ilmu medis modern yang berkembang pesat pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Transisi ini mempengaruhi peran bidan di masyarakat, metode pendidikan, serta standarisasi pelayanan kebidanan secara global.

1. Transisi pelayanan kebidanan dari praktik tradisional ke pelayanan medis terstruktur.

Transisi ini ditandai oleh pergeseran praktik kebidanan dari yang berbasis pada pengalaman pribadi dan tradisi lokal menjadi praktik yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi medis modern. Faktor utama yang mendorong transisi ini adalah kemajuan dalam ilmu kedokteran, berkembangnya pendidikan formal, dan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak.

a. Karakteristik Praktik Kebidanan Tradisional:

- 1) Berdasarkan pengalaman empiris dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun.
- 2) Mengandalkan metode alami seperti penggunaan ramuan herbal, pijat, dan pendekatan spiritual.
- 3) Proses persalinan sebagian besar dilakukan di rumah dengan bantuan bidan tradisional tanpa intervensi medis terstruktur.

b. Karakteristik Praktik Kebidanan Medis Modern:

- 1) Menggunakan pendekatan ilmiah dan bukti klinis sebagai dasar pelayanan.
- 2) Melibatkan penggunaan alat medis, teknik sterilisasi, dan intervensi medis yang terstruktur untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi.
- 3) Proses persalinan umumnya dilakukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik bersalin.

c. Faktor Penyebab Transisi:

- 1) Kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya anatomi dan fisiologi manusia.
- 2) Meningkatnya kesadaran akan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta kebutuhan akan pelayanan medis terstandar.
- 3) Penemuan teknologi medis seperti antiseptik, anestesi, dan alat bedah, yang memungkinkan intervensi lebih aman dan efektif selama persalinan.

2. Peran bidan dalam masyarakat dan perubahan peran tersebut seiring waktu.

Peran bidan mengalami perubahan signifikan seiring dengan transisi menuju era medis modern. Awalnya, bidan tradisional memiliki peran yang terbatas pada proses persalinan di lingkungan rumah dan komunitas, namun seiring waktu peran tersebut berkembang menjadi profesi kesehatan yang diakui secara formal.

a. Peran Bidan Tradisional:

- 1) Bertanggung jawab membantu persalinan dan perawatan ibu dan bayi pasca melahirkan di lingkungan rumah.
- 2) Memiliki peran sebagai penasihat keluarga terkait kesehatan reproduksi, kehamilan, dan kelahiran.
- 3) Perannya sering kali juga mencakup aspek sosial-budaya, seperti melaksanakan ritual dan tradisi lokal.

b. Peran Bidan dalam Era Medis Modern:

- 1) Bertugas tidak hanya membantu persalinan tetapi juga memberikan asuhan antenatal, perawatan postnatal, edukasi kesehatan, dan perawatan kesehatan reproduksi secara keseluruhan.
- 2) Berfungsi sebagai tenaga profesional yang mampu mengenali komplikasi medis dan melakukan tindakan medis dasar atau merujuk ke dokter spesialis jika diperlukan.
- 3) Peran bidan semakin terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan yang formal dengan tanggung jawab yang lebih luas dan spesifik berdasarkan keahlian klinis yang diperoleh melalui pendidikan formal.

c. Perubahan Peran Secara Umum:

- 1) Dari pelaku praktik tradisional menjadi tenaga kesehatan profesional dengan pelatihan klinis.
- 2) Dari bekerja secara individual di lingkungan rumah, menjadi bagian dari tim medis yang bekerja secara kolaboratif di fasilitas kesehatan.
- 3) Dari peran informal menjadi peran yang terstruktur dengan tanggung jawab yang diatur oleh standar profesi dan regulasi resmi.

3. Perkembangan pendidikan formal kebidanan di Eropa dan Amerika.

Perkembangan pendidikan formal kebidanan berkontribusi secara signifikan dalam transisi praktik kebidanan dari tradisional ke modern. Eropa dan Amerika menjadi pusat perkembangan pendidikan kebidanan yang berpengaruh luas ke berbagai belahan dunia.

a. Perkembangan Pendidikan Formal di Eropa:

- 1) Abad ke-17 hingga abad ke-18 mulai muncul sekolah kebidanan formal pertama, seperti *École de Sages-Femmes* di Prancis yang didirikan tahun 1760 oleh Madame Angelique du Coudray.
- 2) Pendidikan formal mulai menekankan aspek anatomi, fisiologi, dan praktik klinis modern, serta penggunaan buku teks khusus kebidanan.
- 3) Bidan diberikan pelatihan formal di rumah sakit atau klinik bersalin, sehingga meningkatkan kompetensi klinis secara signifikan.
- 4) Regulasi profesi mulai diterapkan di banyak negara Eropa untuk memastikan kualitas pelayanan kebidanan yang standar dan aman.

b. Perkembangan Pendidikan Formal di Amerika:

- 1) Pendidikan kebidanan formal di Amerika mulai berkembang pada abad ke-18 hingga abad ke-19, dengan kemunculan lembaga pendidikan seperti *Frontier Nursing Service* yang didirikan oleh Mary Breckinridge pada tahun 1925.
- 2) Sekolah kebidanan mulai menyediakan pendidikan berbasis bukti klinis serta praktik langsung di komunitas dan rumah sakit.
- 3) Pembentukan asosiasi profesional, seperti *American College of Nurse-Midwives (ACNM)* pada tahun 1955, turut mendorong perkembangan standar pendidikan kebidanan yang tinggi.
- 4) Pendidikan formal kebidanan menjadi bagian dari kurikulum perguruan tinggi dengan jenjang pendidikan yang jelas, seperti diploma, sarjana, dan pascasarjana, sehingga meningkatkan status profesi kebidanan secara akademik dan klinis.

c. Dampak Pendidikan Formal terhadap Profesi Bidan:

- 1) Membawa profesi kebidanan menjadi terstandar, diakui secara hukum, dan dihormati sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan modern.
- 2) Mengurangi angka kematian ibu dan bayi secara signifikan melalui peningkatan keterampilan klinis dan pengetahuan ilmiah bidan.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan melalui penerapan praktik berbasis bukti ilmiah.

Perubahan dari praktik tradisional menuju era medis modern telah mengubah wajah profesi kebidanan secara signifikan. Transisi ini ditandai dengan integrasi pengetahuan ilmiah modern, pendidikan formal, serta pergeseran peran bidan dari figur tradisional menjadi tenaga kesehatan profesional yang memiliki tanggung

jawab luas dan diakui secara global. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan tetapi juga secara signifikan menurunkan risiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi, serta memperkuat posisi profesi kebidanan sebagai bagian penting dalam pelayanan kesehatan modern.

C. Tokoh-tokoh Penting dalam Sejarah Kebidanan

Sejarah kebidanan ditandai oleh berbagai tokoh penting yang telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kebidanan. Para tokoh ini berperan penting dalam mengubah wajah kebidanan dari praktik tradisional menuju profesi akademik yang berbasis ilmiah. Di antara tokoh-tokoh tersebut yang paling berpengaruh adalah Soranus dari Ephesus, Louise Bourgeois, dan Mary Breckinridge.

1. Soranus dari Ephesus dan kontribusinya dalam ilmu kebidanan.

Soranus dari Ephesus (sekitar 98–138 M) adalah seorang dokter Yunani yang diakui sebagai salah satu tokoh paling awal dan penting dalam sejarah kebidanan. Ia dikenal luas karena karyanya yang menjadi dasar ilmiah pertama dalam praktik kebidanan di dunia Barat.

a. Karya dan Kontribusi Utama:

- 1) Menulis buku "Gynecology", sebuah karya yang sangat berpengaruh yang membahas secara mendalam tentang kehamilan, persalinan, serta perawatan postpartum.
- 2) Buku tersebut menjadi referensi utama dalam praktik kebidanan selama lebih dari seribu tahun, hingga periode Renaisans di Eropa.
- 3) Pertama kali memperkenalkan praktik kebidanan berdasarkan observasi klinis dan penalaran medis yang sistematis.

b. Gagasan Penting yang Diperkenalkan oleh Soranus:

- 1) Menggambarkan dengan detail berbagai posisi optimal untuk persalinan, metode perawatan bayi baru lahir, dan manajemen komplikasi seperti persalinan sulit.
- 2) Menekankan pentingnya kebersihan, kenyamanan pasien, dan pendekatan empati selama proses persalinan.
- 3) Menolak praktik yang tidak berdasarkan bukti, seperti penggunaan jimat atau mantra yang umum pada masa tersebut, sehingga secara signifikan mengubah praktik kebidanan menuju pendekatan yang lebih rasional.

c. Dampak Jangka Panjang:

- 1) Memberikan fondasi ilmiah untuk praktik kebidanan modern.

- 2) Menjadi inspirasi bagi para dokter dan bidan di masa depan untuk mengadopsi pendekatan medis yang lebih ilmiah dalam praktik mereka.

2. Louise Bourgeois, bidan kerajaan Prancis yang membawa praktik kebidanan ke dunia akademis.

Louise Bourgeois (1563–1636) adalah seorang bidan terkenal dari Prancis yang melayani keluarga kerajaan Prancis pada masa pemerintahan Raja Henri IV dan istrinya, Marie de Médici. Ia dikenal sebagai pelopor dalam menjadikan kebidanan sebagai disiplin akademik yang diakui.

a. Karya dan Kontribusi Utama:

- 1) Menulis buku kebidanan terkenal berjudul *"Observations diverses sur la stérilité, perte de fruit, fécondité, accouchements et maladies des femmes et enfants nouveaux naiz"* pada tahun 1609.
- 2) Buku ini adalah buku kebidanan pertama yang ditulis oleh seorang perempuan dan menjadi acuan ilmiah untuk pelatihan bidan di Eropa.

b. Pencapaian Penting Louise Bourgeois:

- 1) Ia membawa praktik kebidanan ke ranah akademik dengan menulis secara sistematis berdasarkan pengalaman klinisnya.
- 2) Menjadi salah satu tokoh pertama yang mendokumentasikan secara detail tentang prosedur persalinan, penanganan komplikasi seperti perdarahan postpartum, posisi janin abnormal, serta pentingnya kebersihan selama persalinan.
- 3) Menegaskan pentingnya peran bidan profesional dalam mendukung kesehatan reproduksi wanita.

c. Dampak Jangka Panjang:

- 1) Berperan besar dalam mendorong standarisasi pendidikan formal kebidanan di Eropa.
- 2) Karya Bourgeois dijadikan referensi utama dalam pendidikan kebidanan di berbagai sekolah kebidanan di Eropa dan memberikan legitimasi akademis bagi profesi ini.

3. Mary Breckinridge dan pengembangan pelayanan kebidanan di Amerika.

Mary Breckinridge (1881–1965) adalah bidan dan perawat Amerika yang dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan pelayanan kebidanan modern di Amerika Serikat, khususnya di wilayah pedesaan terpencil.

a. Karya dan Kontribusi Utama:

- 1) Mendirikan Frontier Nursing Service (FNS) pada tahun 1925 di Kentucky, Amerika Serikat, sebuah lembaga kesehatan masyarakat yang menyediakan pelayanan kebidanan modern di daerah terpencil.
- 2) Memperkenalkan praktik bidan-perawat terlatih secara formal di Amerika, yang sebelumnya sangat didominasi oleh dokter.

b. Peran Penting Mary Breckinridge:

- 1) Membangun sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif, dengan pendekatan home-visit oleh bidan yang memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang keperawatan dan kebidanan.
- 2) Mengintegrasikan pelayanan kebidanan dengan prinsip kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, yang secara signifikan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah tersebut.
- 3) Mengadvokasi profesionalisasi kebidanan melalui pendidikan formal, pelatihan klinis, dan lisensi profesional di Amerika Serikat.

c. Dampak Jangka Panjang:

- 1) Frontier Nursing Service menjadi model pelayanan kebidanan berbasis komunitas yang diadopsi secara luas di Amerika dan berbagai negara lain.
- 2) Breckinridge secara signifikan mendorong pengakuan bidan sebagai tenaga kesehatan profesional terlatih di Amerika, dengan penekanan pada pendekatan pelayanan berbasis bukti dan ilmu keperawatan modern.

Ketiga tokoh penting ini—Soranus dari Ephesus, Louise Bourgeois, dan Mary Breckinridge—memiliki peran krusial dalam transformasi praktik kebidanan. Melalui kontribusi mereka yang beragam, mulai dari meletakkan dasar ilmiah dalam kebidanan kuno, mengembangkan pendidikan formal di era Renaissance, hingga membentuk sistem kebidanan modern berbasis komunitas di Amerika, mereka bersama-sama membawa profesi kebidanan ke dalam bentuknya yang diakui secara profesional dan akademis saat ini. Sejarah profesi kebidanan sangat diperkaya oleh inovasi, dedikasi, dan pencapaian mereka yang telah memberikan dampak besar terhadap kesehatan perempuan dan anak secara global.

D. Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan praktik kebidanan. Berbagai inovasi teknologi medis serta perkembangan dalam penelitian ilmiah memungkinkan profesi kebidanan berkembang secara signifikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan. Berikut ini penjelasan mendetail mengenai pengaruh tersebut.

1. Penemuan teknologi medis seperti ultrasonografi, inkubator, dan monitor janin.

Kemajuan teknologi medis telah menghadirkan berbagai perangkat penting yang memungkinkan pelayanan kebidanan menjadi lebih aman, efektif, dan mampu mendeteksi dini komplikasi persalinan maupun kondisi janin dalam kandungan.

a. Ultrasonografi (USG):

- 1) Teknologi ini pertama kali diperkenalkan secara luas dalam bidang kebidanan pada pertengahan abad ke-20.
- 2) Berfungsi untuk memberikan gambaran visual secara langsung mengenai kondisi janin, cairan ketuban, dan struktur rahim secara real-time.
- 3) Manfaat utama:
 - a) Memantau pertumbuhan dan perkembangan janin secara akurat.
 - b) Mendeteksi dini kelainan atau komplikasi kehamilan seperti kelainan anatomis janin, posisi janin abnormal, dan masalah plasenta.
 - c) Mengurangi risiko persalinan dengan memungkinkan perencanaan intervensi medis lebih dini dan akurat.

b. Inkubator Bayi:

- 1) Teknologi ini diperkenalkan pada akhir abad ke-19 dan dikembangkan lebih lanjut sepanjang abad ke-20.
- 2) Berfungsi memberikan lingkungan hangat, steril, dan stabil untuk bayi prematur atau bayi dengan kondisi kesehatan yang rentan.
- 3) Manfaat utama:
 - a) Mengurangi angka kematian bayi prematur yang sebelumnya sangat tinggi akibat ketidakmampuan bayi mempertahankan suhu tubuh secara mandiri.
 - b) Memberikan perawatan intensif yang memungkinkan bayi bertahan hidup dan berkembang secara optimal meskipun lahir dalam kondisi prematur.

c. Monitor Janin (Fetal Monitoring):

- 1) Mulai dikembangkan secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20.
- 2) Berfungsi merekam detak jantung janin dan kontraksi rahim selama kehamilan maupun proses persalinan.
- 3) Manfaat utama:
 - a) Mendeteksi secara dini tanda-tanda distress atau gangguan pada janin selama proses persalinan.
 - b) Mengurangi risiko komplikasi yang dapat mengancam keselamatan janin dan ibu, seperti hipoksia (kekurangan oksigen pada janin).
 - c) Membantu bidan dan dokter mengambil keputusan intervensi medis yang tepat secara cepat dan efektif.

2. Dampak kemajuan ilmu kedokteran dan kebidanan terhadap peningkatan kualitas layanan.

Kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran dan kebidanan tidak hanya menghasilkan teknologi baru tetapi juga mendorong perubahan signifikan dalam pendekatan pelayanan kebidanan secara keseluruhan.

a. Peningkatan Keselamatan dan Kualitas Pelayanan:

- 1) Penggunaan antibiotik, antiseptik, dan sterilisasi yang lebih efektif mengurangi risiko infeksi pada ibu dan bayi selama persalinan.
- 2) Teknik anestesi yang lebih aman dan efektif mengurangi rasa sakit serta komplikasi persalinan.
- 3) Ketersediaan intervensi medis seperti operasi caesar yang lebih aman meningkatkan keselamatan ibu dan bayi dalam situasi kritis.

b. Profesionalisasi Bidan sebagai Tenaga Kesehatan Terlatih:

- 1) Pendidikan formal yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi modern memungkinkan bidan menguasai kompetensi klinis yang lebih tinggi.
- 2) Standarisasi praktik kebidanan melalui pedoman klinis berbasis bukti meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Integrasi praktik kebidanan dengan layanan kesehatan primer meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kebidanan yang berkualitas.

c. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi:

- 1) Penerapan teknologi dan pendekatan berbasis bukti secara nyata menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang sebelumnya sangat tinggi, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

- 2) Peningkatan pengetahuan tentang gizi, kesehatan reproduksi, dan manajemen kehamilan membantu mencegah komplikasi serius selama kehamilan dan persalinan.

3. Perkembangan penelitian ilmiah yang mendukung praktik kebidanan berbasis bukti.

Penelitian ilmiah dalam kebidanan telah mengalami pertumbuhan pesat, khususnya dengan munculnya konsep Evidence-Based Midwifery (EBM), yang menekankan pentingnya menggunakan bukti ilmiah terbaru dalam pengambilan keputusan klinis.

a. Pengembangan Evidence-Based Midwifery (EBM):

- 1) Konsep ini berkembang pada akhir abad ke-20, menempatkan praktik kebidanan dalam kerangka kerja ilmiah yang terstandar.
- 2) Penelitian klinis seperti Randomized Controlled Trials (RCT), meta-analisis, dan tinjauan sistematis secara rutin digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan intervensi kebidanan.
- 3) Manfaat utama EBM:
 - a) Menjamin keputusan klinis didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia.
 - b) Mengurangi praktik yang tidak efektif atau berbahaya yang sebelumnya digunakan secara tradisional tanpa dasar ilmiah yang kuat.

b. Standarisasi Praktik melalui Pedoman Klinis:

- 1) Berdasarkan penelitian ilmiah, banyak organisasi kebidanan dunia mengembangkan pedoman praktik klinis seperti rekomendasi WHO dan NICE Guidelines.
- 2) Pedoman ini digunakan secara global untuk memastikan praktik kebidanan konsisten, aman, efektif, dan sesuai dengan standar medis modern.
- 3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi kebidanan karena adanya jaminan kualitas pelayanan yang berbasis bukti ilmiah.

c. Dukungan Teknologi dalam Penelitian Kebidanan:

- 1) Penggunaan database ilmiah (PubMed, Cochrane Library, Scopus) memudahkan bidan dalam mengakses bukti ilmiah terkini.
- 2) Perkembangan teknologi informasi memudahkan penyebaran hasil penelitian secara global, sehingga informasi ilmiah yang relevan cepat sampai ke praktisi kebidanan di berbagai negara.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kebidanan memberikan dampak besar dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Teknologi medis seperti ultrasonografi, inkubator, dan monitor janin membawa perubahan revolusioner dalam pelayanan kebidanan modern. Di sisi lain, perkembangan ilmu kedokteran serta penelitian ilmiah mendukung terciptanya praktik kebidanan berbasis bukti, menjamin standar tinggi dalam perawatan ibu dan bayi. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko komplikasi serius, tetapi juga memperkuat profesionalisasi kebidanan sebagai profesi kesehatan yang vital dalam sistem pelayanan kesehatan global.

E. Sejarah dan Profesionalisme Kebidanan Masa Kini

Profesionalisme kebidanan masa kini tidak terlepas dari sejarah panjang yang telah dilalui. Pemahaman akan sejarah kebidanan memberikan dasar kuat bagi pengembangan prinsip etika, kompetensi klinis, serta sikap profesional yang relevan dengan kebutuhan pelayanan kebidanan modern. Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi, profesi kebidanan juga menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang baru yang menuntut adaptasi terus menerus.

1. Hubungan sejarah perkembangan kebidanan dengan prinsip etika profesional.

Sejarah perkembangan kebidanan memberikan landasan filosofis dan etis yang sangat penting bagi profesi kebidanan modern. Prinsip-prinsip etika profesional dalam kebidanan tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang dari nilai-nilai historis yang telah lama ada.

a. Prinsip Menghormati Martabat Manusia:

- 1) Sejak masa kuno, bidan telah dipercaya untuk membantu proses kelahiran, tugas yang melibatkan penghormatan terhadap kehidupan manusia.
- 2) Prinsip ini terus berlanjut hingga sekarang, di mana bidan diwajibkan untuk menghormati otonomi dan martabat setiap pasien tanpa diskriminasi.

b. Prinsip Empati dan Kepedulian:

- 1) Praktik tradisional kebidanan di berbagai budaya selalu melibatkan pendekatan empati, mendukung ibu secara emosional dan spiritual selama persalinan.
- 2) Di era modern, prinsip ini diwujudkan dalam bentuk asuhan yang berpusat pada pasien (patient-centered care), memberikan perhatian holistik terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan sosial pasien.

c. Prinsip Kejujuran dan Transparansi:

- 1) Seiring berkembangnya ilmu kedokteran dan kebidanan, nilai kejujuran dan transparansi dalam komunikasi dengan pasien semakin ditekankan.
- 2) Profesionalisme kebidanan masa kini mengharuskan bidan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai kondisi pasien, opsi intervensi, serta risiko dan manfaatnya.

d. Prinsip Akuntabilitas Profesional:

- 1) Sejarah kebidanan mencatat transisi dari praktik tradisional menuju praktik ilmiah berbasis bukti, yang memerlukan akuntabilitas dalam setiap tindakan klinis.
- 2) Di era sekarang, akuntabilitas diwujudkan melalui dokumentasi yang jelas, praktik klinis berbasis bukti, serta evaluasi rutin terhadap kualitas layanan kebidanan.

2. Implementasi nilai-nilai sejarah dalam membangun kompetensi dan sikap profesional bidan.

Nilai-nilai sejarah yang diwariskan dari praktik kebidanan masa lalu berkontribusi secara langsung dalam membentuk kompetensi klinis serta sikap profesional bidan masa kini.

a. Kompetensi Klinis yang Berbasis Bukti Ilmiah:

- 1) Sejarah kebidanan memperlihatkan pentingnya transisi dari pengetahuan tradisional menuju pengetahuan ilmiah modern. Hal ini mendorong bidan masa kini untuk mengembangkan kompetensi klinis berbasis bukti ilmiah terbaru.
- 2) Kompetensi tersebut mencakup kemampuan melakukan pemeriksaan fisik, interpretasi hasil pemeriksaan medis seperti USG, serta pengambilan keputusan klinis yang didukung oleh penelitian ilmiah terkini.

b. Pengembangan Sikap Profesional Berbasis Empati:

- 1) Nilai empati yang historis dalam kebidanan terus dipertahankan dan dikembangkan melalui pelatihan komunikasi interpersonal, konseling, serta pendekatan humanistik dalam pelayanan kebidanan.
- 2) Bidan masa kini dituntut memiliki kemampuan interpersonal tinggi untuk mendukung pasien secara emosional, menciptakan rasa aman, nyaman, serta memperkuat hubungan terapeutik.

c. Pendidikan Berkelanjutan sebagai Implementasi Nilai Sejarah:

- 1) Menghargai sejarah berarti mengakui pentingnya pembelajaran terus-menerus yang dilakukan oleh tokoh kebidanan di masa lalu.

- 2) Bidan modern menerapkan nilai ini melalui pendidikan berkelanjutan (Continuing Professional Development) guna memastikan keterampilan dan pengetahuan tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam dunia kebidanan.

d. Komitmen pada Keselamatan Pasien:

- 1) Sejarah kebidanan yang dipenuhi tantangan kesehatan seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, mendorong profesi kebidanan modern untuk menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
- 2) Nilai ini diterapkan dalam praktik sehari-hari melalui pelaksanaan prosedur keselamatan pasien, pencegahan infeksi, serta pemantauan ketat terhadap komplikasi potensial selama proses persalinan.

3. Tantangan dan peluang profesi bidan di era globalisasi.

Era globalisasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi profesi kebidanan. Kondisi ini mengharuskan profesi kebidanan terus menyesuaikan diri agar tetap relevan, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Tantangan:

a. Globalisasi Penyakit Menular dan Masalah Kesehatan Baru:

- 1) Bidan menghadapi tantangan dalam menangani penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, COVID-19, atau penyakit lainnya yang memerlukan kompetensi klinis dan pengetahuan epidemiologi.
- 2) Hal ini menuntut peningkatan keterampilan, pelatihan khusus, serta kesiapan sistem pelayanan kebidanan dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan global.

b. Persaingan dan Standar Pelayanan Internasional:

- 1) Standar pelayanan kebidanan yang semakin ketat secara internasional menuntut bidan untuk mengikuti sertifikasi, akreditasi, dan pengembangan kompetensi yang ketat.
- 2) Tantangan ini memerlukan bidan untuk terus mengembangkan kompetensi profesional dan kemampuan beradaptasi dengan standar global.

c. Kesenjangan Akses terhadap Pelayanan Kebidanan:

- 1) Globalisasi memperjelas kesenjangan akses pelayanan kesehatan antara negara maju dan berkembang, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan.
- 2) Profesi kebidanan perlu memperjuangkan pemerataan pelayanan dengan mengembangkan model pelayanan berbasis komunitas yang efektif.

Peluang:

- a. Akses Informasi dan Teknologi Baru:
 - 1) Era globalisasi membuka peluang bagi bidan untuk mengakses informasi medis terbaru, mengikuti pelatihan daring, serta memanfaatkan teknologi canggih dalam pelayanan kebidanan.
 - 2) Teknologi informasi memungkinkan pembelajaran yang lebih cepat dan mudah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan secara signifikan.
- b. Kolaborasi Internasional dan Pertukaran Pengetahuan:
 - 1) Bidan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kolaborasi internasional, pertukaran ilmu, dan pengalaman melalui konferensi global, publikasi ilmiah internasional, serta jaringan profesional.
 - 2) Peluang ini memperkaya wawasan serta meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan layanan yang berstandar internasional.
- c. Pengembangan Kebijakan dan Advokasi Global:
 - 1) Bidan dapat berperan aktif dalam advokasi global mengenai isu-isu kesehatan ibu dan anak, mendukung kebijakan publik yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan perempuan.
 - 2) Peluang ini memungkinkan profesi kebidanan mempengaruhi kebijakan kesehatan internasional yang lebih proaktif dan inklusif.

Hubungan erat antara sejarah kebidanan dengan profesionalisme masa kini memperlihatkan pentingnya pemahaman historis dalam membangun praktik kebidanan yang profesional dan berbasis etika. Implementasi nilai-nilai sejarah secara nyata membentuk kompetensi klinis dan sikap profesional bidan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Sementara itu, di era globalisasi, profesi kebidanan menghadapi tantangan besar namun juga peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak secara global.

F. Latihan Soal

Soal Kasus 1

Seorang bidan bekerja di daerah terpencil yang masih mempertahankan praktik kebidanan tradisional. Seorang ibu hamil usia 35 tahun mengalami persalinan yang lama. Bidan tradisional di daerah tersebut biasanya menggunakan ramuan herbal tertentu untuk mempercepat proses persalinan. Sebagai tenaga kesehatan profesional yang memahami sejarah kebidanan, apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan oleh bidan modern dalam situasi ini?

- A. Langsung menolak segala bentuk praktik tradisional.
- B. Membiarkan bidan tradisional bekerja tanpa intervensi.
- C. Menjelaskan secara edukatif manfaat dan risiko praktik herbal kepada keluarga dan bidan tradisional.
- D. Menggunakan ramuan herbal tanpa evaluasi medis sebelumnya.
- E. Melakukan intervensi medis tanpa diskusi dengan keluarga terlebih dahulu.

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pendekatan terbaik adalah dengan mengedukasi keluarga dan bidan tradisional secara kolaboratif mengenai manfaat dan risiko praktik tradisional, sehingga terjadi pemahaman bersama tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Soal Kasus 2

Di suatu desa, praktik kebidanan masih dipengaruhi oleh kepercayaan lokal dan penggunaan ritual khusus selama persalinan. Seorang bidan baru ditempatkan di desa tersebut. Dia menemukan bahwa praktik ritual tersebut menunda penanganan medis yang diperlukan. Sikap terbaik yang harus ditunjukkan bidan dalam situasi ini adalah:

- A. Melarang total semua praktik ritual yang dilakukan masyarakat.
- B. Melakukan pendekatan empati, mencoba memahami kepercayaan lokal, sambil memberikan edukasi kesehatan yang relevan.
- C. Mengabaikan praktik budaya dan memaksakan standar medis modern.
- D. Menyetujui semua praktik ritual tanpa pertimbangan medis.
- E. Menghindari interaksi dengan tokoh budaya setempat.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pendekatan empati sambil memberikan edukasi kesehatan merupakan cara terbaik dalam menghormati budaya setempat tanpa mengabaikan aspek keselamatan medis.

Soal Kasus 3

Seorang bidan yang bertugas di klinik bersalin mendapatkan pasien yang memiliki ketakutan terhadap teknologi medis modern seperti ultrasonografi (USG). Pasien tersebut percaya bahwa penggunaan teknologi tersebut akan membawa efek negatif bagi janinnya berdasarkan mitos tradisional. Tindakan yang paling tepat bagi bidan dalam menghadapi situasi ini adalah:

- A. Mengabaikan ketakutan pasien dan tetap melakukan USG tanpa persetujuan.
- B. Menjelaskan secara terbuka mengenai manfaat, risiko, dan keamanan penggunaan USG untuk membantu pasien membuat keputusan.
- C. Menghindari penggunaan USG sama sekali.
- D. Menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan keluarga tanpa memberikan informasi medis.
- E. Menolak memberikan pelayanan bila pasien menolak USG.

Kunci Jawaban: B**Rasional:**

Transparansi dan edukasi kepada pasien merupakan prinsip utama dalam kebidanan modern, sehingga pasien bisa mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang tepat.

Soal Kasus 4

Mary, seorang bidan yang bertugas di daerah terpencil, menghadapi tantangan berupa tingginya angka kematian ibu dan bayi di wilayahnya. Ia terinspirasi oleh Mary Breckinridge yang berhasil menurunkan angka kematian melalui pendekatan kesehatan masyarakat. Strategi terbaik yang bisa dilakukan Mary adalah:

- A. Menunggu pemerintah untuk mendirikan fasilitas kesehatan modern di wilayah tersebut.
- B. Membangun model pelayanan kebidanan berbasis komunitas dengan pendekatan home-visit secara proaktif.
- C. Menolak bertugas di daerah terpencil karena sulitnya akses fasilitas medis.
- D. Menghindari kontak langsung dengan masyarakat karena risikonya tinggi.

E. Fokus hanya pada aspek medis tanpa memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat setempat.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pendekatan berbasis komunitas seperti yang dipraktikkan Mary Breckinridge terbukti efektif menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memperkuat pelayanan kebidanan yang holistik.

Soal Kasus 5

Seorang bidan yang baru lulus pendidikan formal bertugas di rumah sakit bersalin modern. Ia memahami bahwa prinsip-prinsip etika dalam kebidanan modern bersumber dari sejarah kebidanan, termasuk prinsip akuntabilitas profesional. Implementasi prinsip ini paling tepat dilakukan dengan:

- A. Mengabaikan pencatatan medis, karena sudah memahami semua prosedur kebidanan.
- B. Secara rutin melakukan pencatatan medis yang jelas dan akurat, berdasarkan standar praktik klinis berbasis bukti.
- C. Mengandalkan intuisi klinis tanpa memperhatikan standar praktik klinis.
- D. Membatasi komunikasi terbuka dengan pasien untuk menjaga profesionalisme.
- E. Tidak mengikuti pendidikan berkelanjutan karena merasa sudah cukup kompeten.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Akuntabilitas profesional tercermin dalam pencatatan medis yang jelas dan akurat serta praktik kebidanan berbasis bukti, yang merupakan bagian integral dari profesionalisme kebidanan modern.

G. Rangkuman Materi

Pelayanan kebidanan telah mengalami evolusi yang sangat penting sejak masa kuno hingga era modern. Sejak peradaban awal seperti Mesir Kuno, Yunani, Romawi, hingga Asia Timur, praktik kebidanan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Bidan masa kuno dikenal sebagai sosok terhormat yang menjalankan peran vital, menggunakan pengetahuan empiris, keterampilan herbal, serta praktik-praktik budaya dan spiritual yang mencerminkan nilai-nilai setempat.

Transisi dari era tradisional menuju era medis modern membawa perubahan signifikan pada praktik kebidanan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kedokteran, peningkatan pendidikan formal, serta kemajuan teknologi medis. Peran bidan pun bertransformasi dari sosok yang mengandalkan tradisi turun-temurun menjadi tenaga kesehatan profesional dengan kompetensi klinis terstandar. Perkembangan pendidikan formal kebidanan di Eropa dan Amerika menjadi tonggak penting yang meningkatkan kualitas layanan serta membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan.

Sejarah kebidanan juga mencatat kontribusi penting tokoh-tokoh yang memiliki dampak besar pada profesi ini. Soranus dari Ephesus memberikan dasar ilmiah awal, Louise Bourgeois membawa kebidanan ke ranah akademis, dan Mary Breckinridge menciptakan model pelayanan kebidanan berbasis komunitas modern. Peran mereka memberikan fondasi kuat bagi profesionalisme kebidanan masa kini.

Kemajuan teknologi seperti ultrasonografi, inkubator, dan monitor janin, serta perkembangan penelitian ilmiah, mendorong praktik kebidanan menjadi lebih aman, efektif, dan berbasis bukti. Hal ini semakin menegaskan kebidanan sebagai profesi kesehatan yang vital dalam sistem pelayanan kesehatan global.

Pemahaman terhadap sejarah perkembangan kebidanan memberikan dasar yang penting dalam membentuk prinsip-prinsip etika, kompetensi klinis, serta sikap profesional bidan saat ini. Implementasi nilai-nilai sejarah tersebut menjadi esensial dalam menghadapi tantangan era globalisasi, seperti globalisasi penyakit, persaingan global, serta kesenjangan akses layanan kesehatan. Namun demikian, globalisasi juga memberikan berbagai peluang besar bagi profesi bidan, antara lain melalui akses teknologi informasi, kolaborasi internasional, serta advokasi kebijakan global.

Dengan demikian, sejarah panjang profesi kebidanan tidak hanya mencerminkan perjalanan praktik kesehatan ibu dan anak, tetapi juga membentuk identitas profesi bidan sebagai tenaga profesional yang adaptif, kompeten, empatik, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan ibu dan anak secara global.

H. Glosarium

Akuntabilitas Profesional

Kewajiban tenaga kesehatan termasuk bidan untuk bertanggung jawab terhadap setiap tindakan klinis yang dilakukan, dengan mendokumentasikan secara jelas, sistematis, dan berdasarkan bukti ilmiah.

Bidan Tradisional

Individu yang membantu proses persalinan secara alami berdasarkan pengalaman turun-temurun, tanpa menggunakan intervensi medis modern, biasanya melibatkan praktik herbal, pijat, dan pendekatan spiritual.

Evidence-Based Midwifery (EBM)

Praktik kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, melalui penelitian klinis yang terstandar seperti Randomized Controlled Trials (RCT), meta-analisis, serta tinjauan sistematis.

Frontier Nursing Service (FNS)

Lembaga kesehatan masyarakat yang didirikan oleh Mary Breckinridge tahun 1925 di Kentucky, Amerika, yang menyediakan pelayanan kebidanan modern di wilayah terpencil, dengan pendekatan home-visit berbasis komunitas.

Inkubator Bayi

Perangkat medis yang menyediakan lingkungan terkendali berupa suhu hangat, kelembaban, dan kebersihan, digunakan untuk merawat bayi prematur atau bayi dengan kondisi kesehatan yang rentan agar tetap stabil dan sehat.

Kompetensi Klinis

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki bidan dalam menjalankan tugas kebidanan berdasarkan pendidikan formal, pelatihan klinis, dan didukung oleh bukti ilmiah terbaru, mencakup pemeriksaan fisik, penanganan persalinan, serta manajemen komplikasi.

Monitor Janin (Fetal Monitoring)

Teknologi medis untuk memantau detak jantung janin dan aktivitas rahim secara kontinu selama proses kehamilan maupun persalinan, guna mendeteksi tanda-tanda bahaya dini terhadap keselamatan janin.

Obstetrix

Sebutan bagi bidan profesional pada masa Romawi Kuno, yang memiliki pendidikan formal serta kewenangan untuk melakukan prosedur medis sederhana, terutama pada situasi persalinan dengan komplikasi.

Papirus Kahun dan Papirus Ebers

Dokumen medis kuno dari Mesir yang berisi informasi terorganisir mengenai praktik kebidanan, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan manajemen komplikasi seperti kelahiran prematur.

Pelayanan Berbasis Komunitas

Model pelayanan kebidanan yang menempatkan komunitas sebagai fokus utama, di mana tenaga kebidanan secara proaktif melakukan kunjungan ke rumah-rumah (home-visit), seperti yang diperkenalkan oleh Mary Breckinridge melalui Frontier Nursing Service.

Praktik Herbal dalam Persalinan

Penggunaan ramuan herbal tradisional untuk memperlancar proses persalinan, mengurangi rasa sakit, serta mempercepat pemulihan ibu setelah melahirkan. Contohnya daun raspberry merah, lavender, chamomile, danggui (*Angelica sinensis*), dan ginseng.

Prinsip Empati dan Kepedulian

Nilai historis dalam praktik kebidanan yang menekankan pendekatan emosional dan spiritual kepada pasien, diwujudkan secara modern melalui asuhan berpusat pada pasien (patient-centered care).

Prinsip Menghormati Martabat Manusia

Prinsip etika profesional yang mengharuskan bidan menghargai otonomi, privasi, dan martabat setiap individu, serta memberikan layanan yang setara tanpa diskriminasi.

Shifrah dan Puah

Sebutan bagi bidan profesional di masa Mesir Kuno yang bertugas membantu proses kelahiran dan perawatan ibu postpartum, termasuk penggunaan ramuan herbal.

Soranus dari Ephesus (98–138 M)

Dokter Yunani kuno yang dikenal atas kontribusi penting dalam ilmu kebidanan melalui bukunya "Gynecology", yang menjadi acuan ilmiah dalam praktik kebidanan selama lebih dari seribu tahun.

Teknologi Ultrasonografi (USG)

Teknologi pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran visual secara real-time dari janin dan struktur rahim, digunakan secara luas dalam pemantauan perkembangan janin selama kehamilan.

Traditional Chinese Medicine (TCM)

Metode pengobatan tradisional Tiongkok yang berlandaskan pada konsep Yin dan Yang serta keseimbangan energi vital tubuh, termasuk teknik pijat, akupunktur, dan ramuan herbal yang digunakan dalam kebidanan kuno Tiongkok.

Transisi Praktik Kebidanan

Perubahan dari praktik kebidanan tradisional yang berbasis pengalaman pribadi, menuju praktik medis modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan standar pelayanan yang terstruktur secara formal.

École de Sages-Femmes

Sekolah kebidanan formal pertama di Eropa yang didirikan pada tahun 1760 di Prancis oleh Madame Angelique du Coudray, menjadi tonggak awal pendidikan formal kebidanan di Eropa.

Louise Bourgeois (1563–1636)

Bidan kerajaan Prancis, tokoh penting dalam sejarah kebidanan yang memelopori dokumentasi akademik tentang persalinan, serta berkontribusi dalam menjadikan kebidanan sebagai disiplin akademik yang diakui secara formal.

I. Daftar Pustaka

- Bennett, V. R., & Brown, L. K. (2017). *Myles Textbook for Midwives* (16th ed.). Elsevier.
- Brucker, M. C., & King, T. L. (2019). *Pharmacology for Women's Health* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Bryski, K. (2019). Herbs and supplements in pregnancy: Best practices and clinical pearls. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 64(4), 415–422. <https://doi.org/10.1111/jmwh.12961>
- Cassidy, T. (2015). *Birth: The Surprising History of How We Are Born*. Atlantic Books.
- De Brouwere, V., & Van Lerberghe, W. (Eds.). (2017). *Safe Motherhood Strategies: A Review of the Evidence*. ITG Press.
- Feng, S., Han, M., & Fan, Y. (2021). Traditional Chinese medicine in obstetrics: A historical and contemporary review. *Chinese Medicine*, 16(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s13020-021-00470-7>
- Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2019). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). Churchill Livingstone.
- King, T. L., Brucker, M. C., Kriebs, J. M., Fahey, J. O., Gegor, C. L., & Varney, H. (2018). *Varney's Midwifery* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Mander, R., & Murphy-Lawless, J. (Eds.). (2015). *The Politics of Maternity*. Routledge.
- McCool, W. F., & Simeone, S. A. (2020). A history of midwifery education in America. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 65(3), 317–325. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13116>
- Norton, W., Furber, C., & Okolo, S. (2020). Influence of traditional beliefs and practices on maternal health outcomes. *International Journal of Childbirth*, 10(1), 26–38. <https://doi.org/10.1891/IJCBIRTH-D-19-00002>
- O'Dowd, M. J., & Philipp, E. E. (2017). *The History of Obstetrics and Gynaecology*. CRC Press.
- Rosenberg, K., & Trevathan, W. (Eds.). (2018). *The Evolutionary Biology of Human Female Sexuality*. Oxford University Press.

- Schuiling, K. D., & Likis, F. E. (2021). *Women's Gynecologic Health* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- WHO. (2018). WHO recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience. World Health Organization.
- Wu, M., Hu, Y., Zhang, J., Zhou, M., Guo, L., & Wei, L. (2020). The historical development and application of fetal heart monitoring technology. *International Journal of Nursing Sciences*, 7(Suppl 1), S35–S40. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.09.002>
- Yapijakis, C. (2017). Hippocrates of Kos, the father of clinical medicine, and Asclepiades of Bithynia, the father of molecular medicine. *In Vivo*, 31(4), 507–514. <https://doi.org/10.21873/invivo.11095>
- Yuill, C. (2019). *Medical Sociology*. SAGE Publications.
- Zhang, T., Liu, X., & Zhai, J. (2020). Application of acupuncture and moxibustion in obstetrics: A systematic review. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2020, Article ID 3465293. <https://doi.org/10.1155/2020/3465293>

BAB 3

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BIDAN PADA BERBAGAI TATANAN PELAYANAN KESEHATAN, PROMOSI KESEHATAN

Tujuan Intruksional

- Menjelaskan Peran Bidan Pada Berbagai Tataan Pelayanan Kesehatan
- Menjelaskan Tanggung Jawab Bidan Pada Berbagai Tataan Pelayanan Kesehatan

Capaian Pembelajaran

- Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Peran Bidan Pada Berbagai Tataan Pelayanan Kesehatan
- Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Tanggung Jawab Bidan Pada Berbagai Tataan Pelayanan Kesehatan

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk tolak ukur kesejahteraan masyarakat, karena kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (pemulihan) dengan sasaran masyarakat (Notoatmodjo, 2008). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung pengertian upaya atau pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Kesehatan memegang peranan penting dalam membina dan mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pembangunan, karena di dalam Pasal 28 A UUD 1945 mengatakan bahwa "Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." dan dipertegas dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Oleh karena itu, kesehatan merupakan hal penting dan menjadi hak bagi semua orang.

Pihak yang berpengaruh cukup besar untuk menunjang kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan, yang mana dalam hal ini tenaga kebidanan menjadi tenaga kesehatan yang sangat penting, mengingat bahwa perempuan memiliki peranan atas pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama saat di dalam kandungan, serta untuk menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi, sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat berkualitas, yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan anak.

Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, yang bertujuan meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak. Pelayanan kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, termasuk kesehatan reproduksi wanita, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat, yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.

Pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi:

1. Layanan Primer ialah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.
2. Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan, atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan.
3. Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya.

Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu melahirkan. Peran bidan dimasyarakat sangat dihargai dan dihormati karena tugasnya sangat mulia, memberi semangat, membesarkan hati dan mendampingi, serta menolong ibu melahirkan dapat merawat bayinya dengan baik. Sebagai seorang bidan janganlah memilih-milih klien miskin atau kayak arena tugas seorang bidan adalah

membantu ibu, bukan mengejar materi. Pasien wajib memberikan hak kepada ibu bidan yang telah menolong persalinan ibu melahirkan. Bidan bekerja sama dengan wanita dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya dengan menghargai martabat manusia dan memperlakukan wanita sebagai manusia seutuhnya. Setelah melihat besarnya tanggung jawab yang diemban bidan dalam melaksanakan tugas pelayanannya, maka kita perlu mengetahui bagaimana peran dan fungsi bidan dalam kesehatan masyarakat.

A. Peran Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan

Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. (Sujiyatini, Nilda: 2012)

1. Peran Sebagai Pelaksana

Bidan memiliki tiga kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan.

a. Tugas Mandiri

Tugas – tugas mandiri bidan, yaitu:

- 1) Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan;
- 2) Memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien;
- 3) Membuat rencana tindak lanjut tindakan/layanan bersama klien;
- 4) Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal;
- 5) Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien/keluarga;
- 6) Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir;
- 7) Memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien/keluarga;
- 8) Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana;
- 9) Memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause;
- 10) Memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan.

b. Tugas Kolaborasi

Tugas – tugas kolaborasi (kerja sama) bidan, yaitu:

- 1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga;
- 2) Memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan
- 3) kolaborasi;

- 4) Mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi;
- 5) Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga;
- 6) Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga;
- 7) Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga;
- 8) Memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan
- 9) tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga.

c. Tugas Ketergantungan

Tugas – tugas ketergantungan (merujuk) bidan, yaitu:

- 1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga;
- 2) Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawatdaruratan;
- 3) Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga;
- 4) Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga;
- 5) Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga;
- 6) Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien/keluar.

2. Peran Sebagai Pengelola

Sebagai pengelola bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim.

- a. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja.

- b. Berpartisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan sektor lain melalui dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya.

3. Peran Sebagai Pendidik

Sebagai pendidik bidan memiliki 2 tugas yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien, serta pelatih dan pembimbing kader.

- a. Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien; serta
- b. Melatih dan membimbing kader.

4. Peran Sebagai Peneliti Investor

Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun berkelompok, mencakup:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan;
- b. Menyusun rencana kerja pelatihan;
- c. Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana;
- d. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi;
- e. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut;
- f. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan.

B. Fungsi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan

Fungsi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. Berdasarkan peran bidan, maka fungsi bidan sebagai berikut:

1. Fungsi Pelaksana

Fungsi bidan sebagai pelaksana, meliputi:

- a. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat (khususnya kaum remaja) pada masa pra perkawinan;
- b. Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi;
- c. Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu;
- d. Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi;
- e. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas;
- f. Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui;
- g. Melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan prasekolah;
- h. Memberi pelayanan keluarga berencana sesuai dengan wewenangnya;

- i. Memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenang.

2. Fungsi Pengelola

Fungsi bidan sebagai pengelola, meliputi:

- a. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan dilingkungan unit kerjanya;
- c. Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan;
- d. Melakukan kerja sama serta komunikasi inter dan antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan; serta
- e. Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan.

3. Fungsi Pendidik

Fungsi bidan sebagai pendidik, meliputi:

- a. Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana;
- b. Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan;
- c. Memberi bimbingan kepada para bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat;
- d. Mendidik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

4. Fungsi Peneliti

Fungsi bidan sebagai peneliti, meliputi:

- a. Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan; serta
- b. Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana.

C. Tanggung Jawab Bidan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Bidan memegang tanggung jawab penuh dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, sebagai tenaga profesional bidan emikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugas seorang bidan, harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya dalam pelayanannya. Tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan, antara lain:

1. Tanggung Jawab Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Peraturan tenaga kesehatan ditetapkan didalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur di dalam peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan. Kegiatan praktik bidan dikontrak oleh peraturan tersebut. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Terhadap Pengembangan Kompetensi

Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya.

3. Tanggung Jawab Terhadap Penyimpanan Catatan Kebidanan

Setiap bidan diharuskan mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggung jawabkan bila terjadi gugatan. Catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada atasannya.

4. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga Yang Dilayani

Bidan memiliki kewajiban memberi asuhan kepada ibu dan anak yang meminta pertolongan kepadanya. Ibu dan anak merupakan bagian dari keluarga. Oleh karena itu, kegiatan bidan sangat erat kaitannya dengan keluarga. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Bidan harus dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan keluarga serta memberi pelayanan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pelayanan yang membutuhkan keselamatan, kepuasan, dan kebahagiaan selama masa hamil atau melahirkan. Oleh karena itu, bidan harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan, sikap, dan perilakunya dalam memberi pelayanan kesehatan keluarga yang membutuhkan.

5. Tanggung Jawab Terhadap Profesi

Bidan harus menerima tanggung jawab keprofesian yang dimilikinya. Oleh karena itu, bidan harus mematuhi dan berperan aktif dalam melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan dan standar keprofesian.

Bidan harus ikut serta dalam kegiatan organisasi bidan dan badan resmi kebidanan. Untuk mengembangkan kemampuan profesiannya, bidan harus mencari informasi tentang perkembangan kebidanan melalui media kebidanan, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Semua bidan harus menjadi anggota

organisasi bidan. Bidan memiliki hak mengajukan suara dan pendapat tentang profesinya.

6. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Bidan adalah anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, bidan turut bertanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat (misalnya: lingkungan yang tidak sehat, penyakit menular, masalah gizi terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak). Baik secara mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain, bidan berkewajiban memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidan harus memelihara kepercayaan masyarakat. Imbalan yang diterima dari masyarakat sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bidan. Tanggung jawab terhadap masyarakat merupakan cakupan dan bagian tanggung jawabnya kepada Tuhan.

D. Peran Dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan berisi tentang meningkatkan kesehatan secara individual maupun komunitas. Promosi di dalam konteks kesehatan berarti meningkatkan, mendukung, dan mendorong untuk menempatkan kesehatan lebih tinggi pada agenda pribadi dan public. Faktor penentu sosial ekonomi utama sering di luar kendali individu bahkan menjadi aspek mendasar dari promosi kesehatan. Dan tujuan promosi kesehatan yaitu mempengaruhi Kesehatan mereka. Menurut Piagam Ottawa (WHO, 1986) pengertian promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan individu untuk meningkatkan control atas kesehatan mereka. Promosi kesehatan adalah proses peningkatan pengetahuan di masyarakat tentang kesehatan yang disertai dengan upaya memfasilitasi perubahan perilaku dan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan atau perubahan dalam individu, masyarakat dan lingkungan.

Promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan pada masa lalu, dimana dalam konsep promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang Kesehatan saja, melainkan juga upaya untuk memperoleh perubahan perilaku individu.

1. Peran Bidan Sebagai Advokator

Advokasi merupakan proses menciptakan dukungan, membangun konsensus, membantu perkembangan suatu iklim yang menyenangkan dan suatu lingkungan yang suportif terhadap suatu sebab atau isu tertentu melalui serangkaian tindakan yang direncanakan dengan baik. Bidan dapat melakukan advokasi untuk meningkatkan strategi dalam KIA / KB.

Upaya pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan bidan tidak bisa dipisahkan. Bidan adalah ujung tombak pembangunan keluarga sejahtera dari sudut kesehatan dan pemberdayaan lainnya. Bidan menempati posisi yang strategis karena biasanya di tingkat desa merupakan kelompok profesional yang jarang ada tandingannya. Masyarakat dan keluarga Indonesia di desa, dalam keadaan hampir tidak siap tempur, menghadapi ledakan generasi muda yang sangat dahsyat. Bidan dapat mengambil peran yang sangat penting dalam membantu keluarga Indonesia mengantar anak-anak dan remaja tumbuh kembang untuk berjuang membangun diri dan nusa bangsanya.

Berkat upaya gerakan KB dan Kesehatan di masa lalu, yang gegap gempita, anak-anak di bawah usia 15 tahun jumlahnya dapat dikendalikan. Sejak tahun 1970 jumlah anak-anak tersebut belum pernah melebihi 60 – 65 juta. Tetapi, sebaliknya, anak-anak usia remaja, yaitu 15 – 29 tahun, bahkan usia 30 – 60 atau 15 – 65 tahun jumlahnya meningkat dalam kelipatan yang berada di luar perhitungan banyak pihak. Phenomena tersebut, biarpun bisadilihat secara nyata setiap hari, belum banyak menggugah perhatian, kecuali kalau terjadi kecelakaan dalam proses kehidupan anak muda itu.

Kesempatan hamil dan melahirkan bertambah jarang, pengalaman keluarga merawat ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak balita, atau anak usia tiga tahun, dalam suatu keluarga, juga bertambah jarang. Kalau terjadi Peristiwa kehamilan atau kelahiran dalam suatu keluarga, hampir pasti kemampuan dan mutu anggota keluarga merawat anggotanya yang sedang hamil atau melahirkan juga menjadi kurang cekatan dan mutunya rendah. Padahal keluarga masa kini, yang bertambah modern dan urban, menuntut kualitas pelayanan yang bermutu tinggi. Keluarga masa kini juga menuntut hidup tetap sehat dalam waktu yang sangat lama karena usia harapan hidup yang bertambah tinggi. Karena itu, sebagai ujung tombak dalam bidang kesehatan.

2. Peran Bidan Sebagai Edukator

Sebagai pendidik bidan memiliki 2 tugas yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader.

a. Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien.

Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien (individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat) tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana.

b. Berpartisipasi dalam Tim

Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjanya.

3. Peran Bidan Sebagai Motivator

Sebagai motivator, bidan memiliki tiga kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan peran bidan dalam pelayanan kebidanan
2. Jelaskan fungsi bidan dalam pelayanan kebidanan
3. Jelaskan tanggung jawab bidan dalam system pelayanan kebidanan
4. Jelaskan apa yang dimaksud promosi kesehatan
5. Jelaskan peran dan tanggung jawab bidan dalam promosi kesehatan

F. Rangkuman Materi

Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, yang bertujuan meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak.

Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti.

Fungsi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. Berdasarkan peran bidan, maka fungsi bidan yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, peneliti.

Bidan memegang tanggung jawab penuh dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, sebagai tenaga profesional bidan emikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugas seorang bidan, harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya dalam pelayanannya.

Promosi kesehatan adalah proses peningkatan pengetahuan di masyarakat tentang kesehatan yang disertai dengan upaya memfasilitasi perubahan perilaku dan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan atau perubahan dalam individu, masyarakat dan lingkungan.

G. Glosarium

Masa Nifas: masa pemulihan organ reproduksi wanita setelah melahirkan. Masa ini berlangsung selama 6–8 minggu.

Klimakterium: Klimakterium merupakan fase alami dalam kehidupan wanita yang menandai perubahan hormonal dan reproduksi

Menopause: masa ketika seorang wanita berhenti mengalami menstruasi dan tidak bisa hamil lagi.

H. Daftar Pustaka

marliah. (2021). Buku Ajar Profesionalisme Kebidanan. Gowa: Cahaya Bintang Cemerlang.

Ningsih, E. S., Mayasari , B., & Susiyanti, E. (2023). Konsep Kebidanan. Yogyakarta: Rizmedia.

Soekidjo, & Notoatmodjo,. (2008). Sosiologi Untuk Kesehatan. Jakarta: Salemba Media.

Sujiyatini, N. (2011). Etika Profesi Kebidanan, Disertai Analisis. Yogyakarta: Rohima Press.

Suryani, L. (2021). Pengantar Profesionalisme Kebidanan. Makasar: Ayrada Mandiri.

BAB 4

PERAN BIDAN DI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER TERMASUK KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUANG LINGKUP PRAKTIK BIDAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami, mengintegrasikan, dan mengimplementasikan peran profesional bidan dalam pelayanan kesehatan primer dan kesehatan masyarakat, serta ruang lingkup praktik kebidanan sesuai dengan standar kompetensi nasional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan secara komprehensif tentang peran bidan dalam pelayanan kesehatan primer, kesehatan masyarakat, serta mampu mengidentifikasi dan menerapkan ruang lingkup praktik bidan sesuai standar profesi kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pelayanan kesehatan primer dalam konteks kebidanan.
- Mahasiswa mampu menguraikan peran bidan dalam pelayanan kesehatan primer mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi peran strategis bidan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
- Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup praktik kebidanan berdasarkan regulasi dan standar profesi yang berlaku.

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer merupakan pintu utama dalam sistem kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan akses universal, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bidan sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan primer, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, dan kesehatan reproduksi serta keluarga berencana. Selain itu, bidan juga berperan strategis dalam mempromosikan kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang sesuai dengan ruang lingkup praktik kebidanan.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, tuntutan terhadap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, termasuk di pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer tidak hanya sebatas penyediaan layanan dasar tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri. Bidan, sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui edukasi kesehatan, pemberdayaan komunitas, dan pelayanan kesehatan esensial.

Peran bidan di tingkat komunitas meliputi interaksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif, mulai dari masa pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Selain itu, bidan juga memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, bidan dituntut memiliki kompetensi klinis yang tinggi, kemampuan komunikasi yang efektif, serta pemahaman mendalam terhadap aspek sosial budaya masyarakat yang dilayani.

Melalui pendekatan promotif dan preventif, bidan berperan aktif dalam melakukan kegiatan penyuluhan, kampanye kesehatan, serta advokasi kebijakan yang mendukung kesehatan ibu dan anak di komunitas. Dalam konteks kuratif dan rehabilitatif, bidan memberikan layanan langsung di fasilitas kesehatan primer, memastikan penanganan cepat terhadap kondisi yang membutuhkan perhatian medis segera. Dengan demikian, bidan berperan penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan buku ini, akan dibahas lebih mendalam mengenai konsep dasar pelayanan kesehatan primer, peran spesifik bidan dalam berbagai dimensi pelayanan, strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bidan, serta ruang lingkup praktik kebidanan yang sesuai dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme bidan serta berdampak positif pada peningkatan status kesehatan masyarakat secara luas.

A. Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan Primer dalam Kebidanan

Pelayanan kesehatan primer merupakan pendekatan fundamental dalam sistem kesehatan yang berfokus pada pemberian layanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada komunitas. Konsep ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam bidang kebidanan, pelayanan kesehatan primer memainkan peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, serta kesehatan reproduksi masyarakat secara luas.

Pelayanan kesehatan primer dalam kebidanan secara spesifik mencakup serangkaian asuhan penting yang diberikan oleh bidan, mulai dari masa sebelum konsepsi (pra-konsepsi), masa kehamilan (antenatal), masa persalinan (intranatal), hingga masa pasca-persalinan (postnatal). Pelayanan pra-konsepsi bertujuan untuk memastikan bahwa calon ibu dalam kondisi kesehatan yang optimal sebelum memasuki masa kehamilan, melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, edukasi pola hidup sehat, serta pemberian informasi terkait risiko kehamilan.

Pelayanan antenatal berfokus pada pemantauan rutin kondisi kesehatan ibu dan janin, identifikasi dini terhadap kemungkinan komplikasi, serta edukasi untuk persiapan persalinan yang sehat dan aman. Dalam periode antenatal ini, bidan melakukan berbagai pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi fundus, pemantauan detak jantung janin, serta pemberian imunisasi tetanus toksoid. Edukasi yang diberikan meliputi informasi nutrisi yang tepat selama kehamilan, tanda bahaya kehamilan yang harus diwaspadai, serta persiapan psikologis dan emosional dalam menghadapi persalinan.

Dalam pelayanan intranatal, bidan memainkan peran penting dalam memastikan proses persalinan berlangsung aman dan nyaman bagi ibu dan bayi. Ini mencakup persiapan persalinan, pertolongan langsung selama proses persalinan normal, penanganan komplikasi ringan, serta rujukan segera jika terjadi komplikasi yang lebih serius. Dukungan emosional yang diberikan oleh bidan juga penting dalam membantu ibu melewati fase persalinan dengan perasaan tenang dan percaya diri.

Pelayanan postnatal berfokus pada pemulihan kesehatan ibu setelah persalinan serta perawatan bayi baru lahir. Pada masa ini, bidan memberikan pemantauan ketat terhadap kondisi kesehatan ibu dan bayi, edukasi mengenai

pemberian ASI eksklusif, perawatan luka pasca persalinan, serta deteksi dini komplikasi seperti infeksi postpartum atau perdarahan.

Selain itu, pelayanan kesehatan primer dalam kebidanan juga mencakup program keluarga berencana, imunisasi bayi dan anak, serta edukasi kesehatan reproduksi secara luas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui pengelolaan kesehatan reproduksi yang baik, pencegahan penyakit menular, dan promosi gaya hidup sehat secara berkelanjutan.

B. Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan primer yang mencakup berbagai aspek layanan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

1. Promotif

Bidan berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan reproduksi, pentingnya gizi seimbang untuk ibu hamil, bayi, dan anak, serta pentingnya imunisasi lengkap. Bidan juga mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah penyakit serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

2. Preventif

Bidan bertugas melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko yang mungkin timbul selama kehamilan dan persalinan. Bidan juga bertanggung jawab memberikan imunisasi dasar kepada bayi dan anak untuk melindungi mereka dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Selain itu, bidan memberikan pelayanan keluarga berencana untuk membantu pasangan dalam mengatur dan merencanakan kehamilan yang aman dan sehat.

3. Kuratif

Dalam aspek kuratif, bidan memberikan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang mencakup penanganan komplikasi ringan selama kehamilan, membantu persalinan normal dengan aman, dan melakukan perawatan awal terhadap bayi baru lahir. Pelayanan ini sangat penting dalam memastikan ibu dan bayi mendapatkan perawatan yang memadai dan tepat waktu.

4. Rehabilitatif

Bidan memberikan dukungan rehabilitasi berupa edukasi dan konseling kepada ibu setelah persalinan, termasuk konseling kesehatan mental postpartum untuk mengatasi stres atau depresi setelah melahirkan. Bidan juga terlibat dalam rehabilitasi gizi untuk memastikan ibu pulih dengan baik dan bayi tumbuh secara optimal.

C. Peran Strategis Bidan dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Bidan berperan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui:

1. Penyuluhan kesehatan masyarakat terkait reproduksi sehat, pola asuh anak, dan gizi keluarga.

Bidan memiliki peran penting sebagai edukator dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, yang mencakup beberapa aspek utama seperti:

a. Reproduksi Sehat

- 1) Memberikan edukasi terkait perencanaan keluarga, kehamilan sehat, persalinan aman, serta pencegahan infeksi menular seksual.
- 2) Menjelaskan pentingnya pemeriksaan rutin kehamilan, tanda bahaya dalam kehamilan, serta manfaat imunisasi ibu hamil.
- 3) Mengedukasi remaja tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, dan pengenalan perilaku seksual yang sehat.

b. Pola Asuh Anak

- 1) Mengajarkan keluarga mengenai stimulasi tumbuh kembang anak secara optimal untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, dan kognitif.
- 2) Memberikan pengetahuan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap untuk mencegah penyakit menular pada anak-anak.
- 3) Membimbing orang tua tentang deteksi dini masalah kesehatan anak seperti gizi buruk, keterlambatan perkembangan, serta infeksi yang sering terjadi pada anak.

c. Gizi Keluarga

- 1) Memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita.
- 2) Menyampaikan informasi tentang pentingnya ASI eksklusif selama enam bulan pertama serta pemberian MPASI yang tepat.
- 3) Melakukan sosialisasi tentang cara memilih, mengolah, dan menyajikan makanan bergizi dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

2. Advokasi dan mobilisasi masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Dalam konteks advokasi dan mobilisasi masyarakat, peran strategis bidan meliputi:

a. Advokasi Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

- 1) Menginformasikan pentingnya pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik bersalin, dan rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan rutin, persalinan aman, serta penanganan kegawatdaruratan.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan tepat waktu.

- 3) Memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan penyedia layanan kesehatan, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan mendapat respons positif.

b. Mobilisasi Partisipasi Aktif Masyarakat

- 1) Menggerakkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kesehatan seperti Posyandu, kelas ibu hamil, dan program imunisasi massal.
- 2) Melakukan pendekatan komunitas untuk mengidentifikasi hambatan sosial, budaya, atau ekonomi yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan, kemudian mencari solusi bersama.
- 3) Mengembangkan strategi partisipatif bersama tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta aparat desa untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan kurang terjangkau.

3. Kolaborasi dengan lintas sektor dalam program kesehatan masyarakat

Bidan berperan sentral dalam kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tercapainya tujuan kesehatan masyarakat, seperti:

a. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

- 1) Melakukan koordinasi aktif dengan sektor kesehatan, dinas sosial, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan untuk memastikan akses layanan kesehatan maternal neonatal yang berkualitas.
- 2) Terlibat aktif dalam pelaksanaan program Jampersal (Jaminan Persalinan) dan layanan emergensi maternal-neonatal.
- 3) Mengembangkan sistem rujukan yang efektif antar fasilitas kesehatan untuk mengatasi komplikasi kehamilan dan persalinan secara cepat dan tepat.

b. Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS)

- 1) Bekerja sama dengan sektor pendidikan dalam melakukan edukasi seksual kepada remaja di sekolah maupun komunitas.
- 2) Menjalinkan kolaborasi dengan lembaga sosial dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung kampanye penyadaran tentang pencegahan PMS termasuk HIV/AIDS.
- 3) Melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk pengembangan strategi pencegahan penyakit, skrining dini, serta pengobatan yang tepat.

c. Pemberdayaan Perempuan

- 1) Berperan aktif dalam menginisiasi program-program yang memberdayakan perempuan secara sosial, ekonomi, dan kesehatan melalui penyuluhan dan pelatihan keterampilan hidup sehat.

- 2) Mengadvokasi hak perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang setara, adil, dan tanpa diskriminasi.
- 3) Berkolaborasi dengan sektor pemerintahan lokal untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesehatan perempuan secara komprehensif, seperti kebijakan cuti hamil, dukungan pemberian ASI, dan perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender.

Bidan memainkan peran strategis yang kompleks dan vital dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Melalui penyuluhan yang intensif, advokasi aktif, mobilisasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, bidan secara nyata mampu berkontribusi dalam mencapai tujuan kesehatan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan reproduksi, keselamatan ibu dan bayi, pencegahan penyakit menular, serta pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan.

D. Ruang Lingkup Praktik Kebidanan

Praktik kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan ibu, bayi, keluarga, serta masyarakat dalam konteks reproduksi dan kesehatan ibu-anak secara holistik. Ruang lingkup praktik kebidanan mencakup:

1. Asuhan kebidanan pada masa pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.

a. Masa Pra-konsepsi

- 1) Memberikan konseling kesehatan pra-konsepsi mengenai nutrisi, gaya hidup sehat, persiapan mental, serta deteksi dini risiko kesehatan.
- 2) Mengedukasi calon orang tua tentang perencanaan kehamilan sehat dan jarak antar kehamilan yang optimal.
- 3) Melakukan skrining kondisi kesehatan pasangan yang berpotensi memengaruhi kehamilan, seperti infeksi menular seksual dan penyakit kronis.

b. Masa Kehamilan

- 1) Menyediakan asuhan antenatal rutin berupa pemantauan tumbuh kembang janin, kesehatan ibu, dan deteksi dini komplikasi kehamilan seperti pre-eklampsia, anemia, dan diabetes gestasional.
- 2) Memberikan edukasi tentang nutrisi ibu hamil, persiapan persalinan, tanda bahaya kehamilan, dan persiapan psikologis menghadapi persalinan.

- 3) Melakukan skrining dan intervensi dini untuk memastikan kehamilan berjalan sehat dan aman.
- c. Masa Persalinan
 - 1) Menyediakan asuhan kebidanan intrapartum yang berfokus pada persalinan normal, fisiologis, dan minimal intervensi.
 - 2) Mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi persalinan secara dini, seperti perdarahan postpartum, distosia, retensio plasenta, dan fetal distress.
 - 3) Melaksanakan pertolongan persalinan sesuai standar kompetensi dengan pendekatan asuhan sayang ibu dan bayi.
- d. Masa Nifas
 - 1) Memberikan asuhan postpartum berupa pemeriksaan fisik dan psikologis, pemantauan involusi uterus, laktasi, serta dukungan menyusui.
 - 2) Melakukan edukasi dan konseling tentang perawatan diri pasca persalinan, deteksi dini komplikasi nifas seperti perdarahan, infeksi, serta gangguan psikologis (misalnya baby blues dan postpartum depression).
 - 3) Mengelola kebutuhan kontrasepsi pasca persalinan sesuai kebutuhan ibu.
- e. Asuhan Bayi Baru Lahir
 - 1) Memberikan perawatan esensial bayi baru lahir termasuk pemeriksaan awal, inisiasi menyusui dini (IMD), dan menjaga suhu tubuh bayi.
 - 2) Menilai kesehatan neonatal secara komprehensif dengan deteksi dini kondisi-kondisi yang memerlukan intervensi khusus seperti infeksi neonatal, asfiksia, jaundice, dan gangguan tumbuh kembang.
 - 3) Memberikan imunisasi dasar bayi dan edukasi perawatan bayi sehat kepada orang tua.

2. Pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek pelayanan yang bertujuan memastikan kesehatan reproduksi optimal dan pengelolaan fertilitas:

- a. Memberikan konseling dan pelayanan keluarga berencana (KB) dengan berbagai metode seperti pil, suntik, implan, IUD, metode alami, maupun kontrasepsi permanen.
- b. Melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, serta pengenalan perilaku seksual yang aman.
- c. Mengedukasi remaja mengenai kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular seksual (PMS), dan persiapan kehidupan keluarga secara sehat.

3. Deteksi dini dan penanganan kegawatdaruratan dalam praktik kebidanan.

Bidan memiliki tanggung jawab penting dalam mengenali secara dini serta menangani kondisi gawat darurat:

- a. Melakukan deteksi dini kondisi berbahaya dalam kehamilan seperti perdarahan antepartum, pre-eklampsia, eklampsia, ruptur uteri, ketuban pecah dini, dan kelahiran prematur.
- b. Memberikan penanganan kegawatdaruratan obstetri seperti perdarahan postpartum, retensio plasenta, syok, prolaps tali pusat, dan persalinan macet sebelum rujukan dilakukan.
- c. Mengelola kegawatdaruratan neonatal seperti asfiksia neonatal, hipotermia, kejang neonatus, dan infeksi serius sebelum rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.

4. Penyuluhan dan edukasi kesehatan reproduksi.

Edukasi merupakan salah satu aspek kunci dalam praktik kebidanan, mencakup:

- a. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan reproduksi di komunitas, sekolah, kelompok ibu hamil, serta remaja secara berkala.
- b. Menyampaikan materi edukasi tentang siklus reproduksi sehat, perawatan kehamilan, persiapan persalinan, pengenalan tanda bahaya, serta pencegahan PMS.
- c. Melatih keterampilan hidup sehat (life skills education) terkait reproduksi kepada kelompok usia remaja, calon pengantin, serta pasangan usia subur (PUS).

5. Pelaksanaan pelayanan imunisasi dan pencegahan penyakit menular.

Sebagai bagian dari layanan preventif, praktik kebidanan meliputi:

- a. Melaksanakan imunisasi ibu hamil seperti TT (Tetanus Toxoid) atau Td untuk pencegahan tetanus neonatorum dan perlindungan kesehatan ibu.
- b. Melakukan imunisasi bayi baru lahir sesuai jadwal nasional, seperti Hepatitis B, Polio, BCG, serta imunisasi lanjutan dasar lengkap.
- c. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi, manfaatnya dalam pencegahan penyakit menular, serta menjelaskan secara detail jadwal imunisasi yang dianjurkan.
- d. Melakukan skrining dan edukasi mengenai pencegahan penyakit menular seksual, HIV/AIDS, hepatitis, serta infeksi lain yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi.

Ruang lingkup praktik kebidanan mencakup spektrum layanan kesehatan yang luas dan terintegrasi. Mulai dari masa pra-konsepsi hingga perawatan neonatal, bidan bertanggung jawab dalam pemberian asuhan, edukasi, deteksi dini komplikasi, serta penanganan kegawatdaruratan secara efektif. Seluruh aktivitas tersebut bertujuan memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, serta masyarakat secara umum.

E. Latihan Soal

Soal1

Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke bidan desa untuk mempersiapkan kehamilan pertamanya. Ia ingin mengetahui tindakan awal yang harus dilakukan agar kehamilannya nanti berjalan lancar dan sehat.

Apa tindakan prioritas bidan dalam memberikan pelayanan pra-konsepsi kepada klien tersebut?

- A. Memberikan vaksin hepatitis B secara langsung
- B. Melakukan pemeriksaan kesehatan umum dan skrining penyakit menular
- C. Melakukan tindakan kuratif berupa pemberian antibiotik profilaksis
- D. Memberikan imunisasi tetanus toksoid (TT)
- E. Melakukan pemantauan denyut jantung janin

Jawaban: B

Rasional:

Pelayanan pra-konsepsi bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan optimal sebelum kehamilan. Pemeriksaan kesehatan umum dan skrining penyakit menular sangat penting dilakukan untuk mendeteksi potensi risiko terhadap ibu dan janin sebelum konsepsi.

Soal 2

Seorang ibu hamil usia kehamilan 28 minggu datang ke bidan untuk pemeriksaan rutin antenatal. Saat pemeriksaan, tekanan darah ibu tercatat 160/110 mmHg dan terdapat edema pada kedua tungkai.

Tindakan yang paling tepat dilakukan bidan dalam pelayanan antenatal pada kasus ini adalah?

- A. Memberikan imunisasi tetanus
- B. Melakukan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif
- C. Melakukan konseling nutrisi selama kehamilan
- D. Melakukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan lanjutan
- E. Melakukan pemantauan pertumbuhan janin dengan USG sederhana

Jawaban: D

Rasional:

Tekanan darah tinggi dan edema pada ibu hamil menunjukkan tanda pre-eklampsia berat yang memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Rujukan segera sangat penting dilakukan oleh bidan untuk mencegah komplikasi serius.

Soal 3

Seorang ibu berusia 22 tahun baru saja melahirkan bayi laki-laki secara normal dengan berat lahir 3.200 gram. Bidan melakukan inisiasi menyusui dini (IMD). Setelah persalinan, ibu bertanya tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Penjelasan yang paling tepat diberikan bidan terkait manfaat pemberian ASI eksklusif pada pelayanan postnatal adalah?

- A. Mengurangi risiko perdarahan postpartum
- B. Menurunkan risiko bayi mengalami asfiksia neonatal
- C. Mengurangi risiko infeksi pada bayi dan mempercepat pemulihan ibu
- D. Mengurangi risiko hipertensi selama masa nifas
- E. Mengurangi risiko distosia bahu pada persalinan berikutnya

Jawaban: C

Rasional:

ASI eksklusif terbukti menurunkan risiko infeksi pada bayi karena mengandung antibodi alami. Selain itu, menyusui membantu mempercepat involusi uterus ibu dan mempercepat pemulihan pasca-persalinan.

Soal 4

Seorang bidan bertugas di sebuah desa terpencil mendapati seorang bayi usia 2 minggu yang mengalami gejala tubuh kuning, lesu, dan tidak mau menyusui sejak kemarin. Bidan mencurigai adanya jaundice patologis.

Tindakan pertama yang paling tepat dilakukan oleh bidan dalam pelayanan neonatal ini adalah?

- A. Memberikan imunisasi hepatitis B
- B. Melakukan konseling pemberian MPASI dini
- C. Melakukan edukasi cara perawatan tali pusat yang benar
- D. Memberikan antibiotik spektrum luas
- E. Segera merujuk bayi ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut

Jawaban: E

Rasional:

Gejala jaundice patologis seperti bayi lesu, kuning sejak usia dini, dan penurunan asupan ASI membutuhkan penanganan segera. Merujuk bayi ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut adalah tindakan prioritas untuk mendapat perawatan intensif.

Soal 5:

Bidan Desa sedang merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan primer yang bersifat promotif di wilayah binaannya yang memiliki angka persalinan di rumah tinggi serta rendahnya kunjungan antenatal.

Apa kegiatan promotif yang paling efektif dilakukan bidan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

- A. Memberikan antibiotik profilaksis pada ibu hamil
- B. Menyediakan layanan USG di desa
- C. Mengadakan penyuluhan rutin mengenai pentingnya pemeriksaan antenatal dan persalinan di fasilitas kesehatan
- D. Menyediakan layanan persalinan dengan operasi caesar gratis
- E. Mengadakan kegiatan pemberian vitamin secara massal

Jawaban: C

Rasional:

Penyuluhan rutin merupakan bentuk tindakan promotif efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan antenatal rutin serta manfaat persalinan di fasilitas kesehatan, yang bertujuan menurunkan risiko komplikasi persalinan.

F. Rangkuman Materi

Pelayanan kesehatan primer dalam kebidanan merupakan suatu pendekatan komprehensif, integratif, serta berorientasi komunitas yang mencakup berbagai aspek pelayanan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam implementasinya, pelayanan kesehatan primer oleh bidan mencakup berbagai tahapan penting seperti pra-konsepsi, antenatal, intranatal, postnatal, serta perawatan bayi baru lahir, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi, anak, serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Peran bidan dalam pelayanan kesehatan primer sangat strategis dan multidimensional, meliputi kegiatan edukasi kesehatan, deteksi dini faktor risiko kehamilan dan persalinan, penanganan komplikasi ringan, imunisasi, serta pelayanan keluarga berencana. Lebih jauh lagi, bidan memiliki peran penting dalam aspek rehabilitatif melalui pemberian dukungan konseling kesehatan mental dan pemulihan fisik pasca persalinan.

Secara strategis, bidan juga menjadi agen utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyuluhan intensif terkait reproduksi sehat, pola asuh anak, dan gizi keluarga, serta advokasi dan mobilisasi masyarakat untuk aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Kolaborasi lintas sektor yang dilakukan bidan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan juga menjadi kunci dalam pencapaian target

penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan penyakit menular seksual, serta pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, ruang lingkup praktik kebidanan yang luas dan terintegrasi ini memungkinkan bidan untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas dan berbasis bukti, mulai dari masa pra-konsepsi hingga neonatal, serta aktif dalam pendidikan dan promosi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, bidan menjadi ujung tombak dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer yang pada akhirnya akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup ibu, anak, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

G. Glosarium

Antenatal

Pelayanan kesehatan yang diberikan selama masa kehamilan untuk memantau kesehatan ibu dan janin, mendeteksi komplikasi dini, serta persiapan persalinan yang aman.

Asfiksia Neonatal

Kondisi gawat darurat akibat gangguan pernapasan pada bayi baru lahir yang menyebabkan bayi kekurangan oksigen.

ASI Eksklusif

Pemberian air susu ibu secara penuh tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama kehidupan bayi.

Deteksi Dini

Upaya pemeriksaan dan pengenalan awal terhadap kondisi atau penyakit tertentu sebelum menjadi lebih serius.

Distosia

Kesulitan persalinan yang disebabkan oleh gangguan pada posisi atau ukuran janin, panggul ibu, atau kontraksi rahim yang tidak efektif.

Edukasi Kesehatan

Proses pemberian informasi, penyuluhan, dan pembelajaran kepada individu atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kesehatan.

Fundus Uteri

Bagian atas rahim yang digunakan sebagai titik acuan dalam mengukur pertumbuhan janin selama kehamilan.

Imunisasi

Proses pemberian vaksin kepada individu untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu.

Intranatal

Pelayanan kebidanan yang diberikan selama proses persalinan untuk memastikan kelahiran bayi secara aman dan nyaman.

Involusi Uterus

Proses kembalinya rahim ke ukuran normal setelah persalinan.

Jaundice Neonatal

Kondisi kulit kuning pada bayi baru lahir akibat tingginya kadar bilirubin dalam darah.

Kegawatdaruratan Obstetri

Situasi kritis yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau masa nifas yang dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi serta memerlukan tindakan segera.

Keluarga Berencana (KB)

Program yang memberikan edukasi dan pelayanan kontrasepsi untuk membantu keluarga mengatur kehamilan secara sehat dan terencana.

Kesehatan Primer

Pendekatan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada komunitas dengan tujuan menyediakan akses layanan kesehatan bagi setiap individu.

Komplikasi Kehamilan

Kondisi abnormal atau penyakit yang terjadi selama kehamilan dan berpotensi membahayakan ibu atau janin.

Kuratif

Pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit atau menangani masalah kesehatan yang sudah terjadi.

Mobilisasi Masyarakat

Upaya untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kesehatan guna meningkatkan cakupan pelayanan dan kesadaran kesehatan.

Neonatal

Masa yang mencakup 28 hari pertama kehidupan bayi setelah kelahiran.

Nifas (Postnatal)

Periode enam minggu setelah persalinan di mana tubuh ibu pulih dari kehamilan dan persalinan.

Pelayanan Primer Kebidanan

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan mulai dari masa pra-konsepsi hingga perawatan pasca-persalinan serta perawatan bayi baru lahir yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pemeriksaan Pra-konsepsi

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum seorang wanita hamil untuk memastikan kesiapan dan kondisi optimal dalam menghadapi kehamilan.

Penyakit Menular Seksual (PMS)

Penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti HIV/AIDS, gonore, sifilis, dan hepatitis B.

Perdarahan Postpartum

Perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama hingga 6 minggu setelah persalinan, yang bisa menyebabkan kondisi kritis bila tidak segera ditangani.

Pre-eklampsia

Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan pembengkakan pada tubuh ibu, terutama tungkai dan wajah.

Preventif

Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya pencegahan timbulnya penyakit atau masalah kesehatan.

Promotif

Pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan motivasi masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit melalui edukasi dan penyuluhan.

Rehabilitatif

Pelayanan kesehatan yang diberikan untuk membantu pemulihan pasien setelah mengalami kondisi kesehatan tertentu, termasuk konseling dan dukungan psikologis atau mental.

Retensio Plasenta

Kondisi plasenta tidak dapat keluar secara spontan setelah bayi lahir, yang berpotensi menyebabkan perdarahan berat.

Rujukan

Proses mengarahkan pasien ke fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi atau fasilitas lebih lengkap untuk penanganan lanjutan.

Skrining Kesehatan

Pemeriksaan sistematis untuk mendeteksi adanya penyakit atau kondisi tertentu sebelum gejala muncul.

Stimulasi Tumbuh Kembang Anak

Kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak sejak usia dini.

Tetanus Toksoid (TT)

Vaksin yang diberikan pada ibu hamil untuk mencegah infeksi tetanus pada ibu maupun bayi baru lahir.

H. Daftar Pustaka

- Alimoradi, Z., Taghizadeh, Z., Rezaypour, A., & Mehran, A. (2022). Midwives' roles in providing reproductive health education: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04432-8>
- Asadi, L., Amiri, P., Ghanbarnejad, A., & Pourshirvani, A. (2022). Effect of prenatal care education programs on maternal and neonatal outcomes: A systematic review

and meta-analysis. *Journal of Education and Health Promotion*, 11, 85. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1014_21

Coxon, K., Chisholm, A., Malouf, R., Rowe, R., & Hollowell, J. (2021). What influences women's choices of birth place? A systematic review and narrative synthesis. *PLOS ONE*, 16(5), e0252143. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252143>

Devi, Y. P., & Kandel, N. (2020). The role of midwives in antenatal care in low- and middle-income countries: A systematic review. *International Journal of Nursing Sciences*, 7(3), 378-384. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.06.006>

Homer, C. S. E., Friberg, I. K., Dias, M. A. B., Hoopes-Bender, P. T., Sandall, J., Speciale, A. M., & Bartlett, L. A. (2022). The projected effect of scaling up midwifery. *The Lancet Global Health*, 10(4), e476-e485. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00019-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00019-X)

Kemenkes RI. (2022). Pedoman pelayanan antenatal terpadu edisi terbaru 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kurniati, A., Roskam, E., Afzal, M. M., Suryowinoto, T. B., & Mukti, A. G. (2021). Strengthening Indonesia's primary healthcare through integrated primary care: A case study. *BMC Health Services Research*, 21(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06727-4>

Mariani, I., Rohmah, H., & Utami, I. S. (2022). Midwives' roles in the empowerment of women's reproductive health in rural areas. *Journal of Public Health Research*, 11(1), 227990362110677. <https://doi.org/10.1177/22799036211067749>

Renfrew, M. J., Cheyne, H., Craig, J., Duff, E., Dykes, F., Hunter, B., & Sandall, J. (2020). Sustaining quality midwifery care through a global pandemic and beyond. *Midwifery*, 88, 102759. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102759>

World Health Organization. (2021). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>

World Health Organization. (2022). Primary health care: Transforming vision into action (Operational framework). World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240046412>

BAB 5

BUDAYA/TRADISI DALAM KEBIDANAN

Pendahuluan

Praktik kebidanan tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan tradisi di masyarakat tempat bidan bekerja. Kebudayaan dan tradisi memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi, perilaku, dan keputusan masyarakat terkait kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca-persalinan. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek budaya ini penting bagi seorang bidan untuk memberikan asuhan yang kompeten, menghormati nilai-nilai lokal, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ditawarkan. Integrasi budaya dalam pelayanan kebidanan membantu memperkuat hubungan terapeutik antara bidan dan komunitas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep kebudayaan dan tradisi dalam praktik kebidanan secara profesional, adaptif, serta mampu memberikan asuhan kebidanan yang sensitif budaya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengintegrasikan pemahaman tentang budaya dan tradisi dalam kebidanan untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- Menjelaskan konsep dasar kebudayaan dan tradisi dalam konteks kebidanan.
- Mengidentifikasi berbagai budaya dan tradisi terkait praktik kebidanan di Indonesia.
- Menganalisis dampak budaya dan tradisi terhadap kesehatan ibu dan bayi.
- Mengaplikasikan pendekatan asuhan kebidanan yang sensitif budaya dalam praktik klinis.
- Merancang program pendidikan dan promosi kesehatan yang mempertimbangkan aspek budaya masyarakat.

A. Konsep Dasar Kebudayaan dan Tradisi dalam Kebidanan

1. Definisi kebudayaan dan tradisi dalam perspektif antropologi kesehatan.

Dalam perspektif antropologi kesehatan, kebudayaan dipahami sebagai suatu sistem kompleks yang mencakup kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun melalui proses sosialisasi dan pembelajaran dalam suatu komunitas atau kelompok sosial tertentu. Kebudayaan memandu bagaimana masyarakat memahami dan merespons berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan penyakit.

Secara khusus, kebudayaan dalam konteks kesehatan disebut juga sebagai sistem kesehatan budaya (cultural health system), yang meliputi berbagai konsep dan praktik yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, serta mengobati penyakit atau gangguan kesehatan.

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang mencakup praktik, ritual, dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu kelompok masyarakat. Tradisi umumnya memiliki akar sejarah dan simbolik yang dalam, merefleksikan nilai-nilai moral, spiritual, sosial, dan identitas kelompok tersebut.

Dalam kebidanan, kebudayaan dan tradisi memainkan peran penting karena kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Bidan sebagai tenaga kesehatan harus memahami konsep ini untuk dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, serta mencegah konflik budaya yang dapat menghambat pelayanan kesehatan.

Definisi kebudayaan dan tradisi dalam perspektif antropologi kesehatan:

a. Kebudayaan

- 1) Sistem kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, norma, nilai, dan praktik dalam suatu komunitas.
- 2) Menjadi pedoman perilaku individu dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari, termasuk kesehatan.
- 3) Mempengaruhi pandangan terhadap konsep sehat-sakit, pengobatan, pencegahan, dan perawatan.

b. Tradisi:

- 1) Kebiasaan dan praktik rutin yang dilakukan berulang oleh suatu kelompok masyarakat.
- 2) Memiliki nilai simbolik, sosial, dan spiritual yang diwariskan antar-generasi.
- 3) Berfungsi untuk menjaga harmoni sosial dan identitas budaya komunitas.

2. Peran kebudayaan dalam membentuk pandangan kesehatan reproduksi.

Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, yang meliputi konsep kehamilan, persalinan, perawatan pasca-persalinan, serta kesehatan bayi dan anak. Dalam banyak kasus, nilai-nilai budaya menentukan bagaimana masyarakat menanggapi kehamilan, jenis pelayanan kesehatan yang dicari, serta praktik kesehatan yang dianggap penting atau tabu.

Berikut peran kebudayaan dalam membentuk pandangan kesehatan reproduksi secara rinci:

a. Pemahaman Konsep Kesehatan dan Penyakit

- 1) Kebudayaan menentukan persepsi masyarakat terhadap kehamilan sebagai kondisi alami atau kondisi khusus yang memerlukan perlakuan khusus.
- 2) Beberapa budaya memandang kehamilan sebagai fase rentan yang perlu perlindungan ekstra, sedangkan budaya lain mungkin menganggapnya sebagai kondisi normal tanpa perlakuan khusus.

b. Praktik dan Ritual Kehamilan dan Persalinan

- 1) Budaya menentukan praktik yang dilakukan selama kehamilan, seperti makanan tertentu yang dianjurkan atau dilarang, pantangan aktivitas tertentu, atau penggunaan ramuan herbal.
- 2) Ritual khusus seperti upacara tujuh bulanan atau syukuran setelah kelahiran merupakan ekspresi budaya yang bertujuan memberikan perlindungan simbolik bagi ibu dan bayi.

c. Peran Keluarga dan Komunitas:

- 1) Budaya menentukan peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam proses kehamilan dan persalinan, misalnya peran nenek, suami, atau dukun bayi tradisional.
- 2) Keterlibatan keluarga dan komunitas dapat meningkatkan dukungan sosial tetapi juga bisa menyebabkan tantangan bagi tenaga kesehatan jika tidak selaras dengan prinsip-prinsip medis.

d. Pengambilan Keputusan Kesehatan Reproduksi

- 1) Nilai budaya dapat mempengaruhi keputusan terkait perawatan prenatal, pemilihan tempat persalinan (rumah sakit, puskesmas, atau rumah), serta penggunaan metode kontrasepsi.
- 2) Budaya patriarki atau matriarki mempengaruhi otoritas pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi.

e. Pandangan terhadap Pelayanan Kesehatan Modern dan Tradisional

- 1) Beberapa masyarakat lebih percaya kepada pengobatan tradisional dibandingkan pengobatan modern karena tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.
- 2) Pemahaman budaya masyarakat mengenai praktik medis modern sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan kebidanan yang diberikan.

Bagi bidan, pemahaman tentang peran budaya sangat penting dalam memberikan pelayanan yang efektif, sensitif budaya, dan diterima oleh masyarakat. Bidan harus mampu mengintegrasikan pendekatan medis dengan nilai budaya lokal agar tercipta hubungan harmonis yang pada akhirnya mendukung kesehatan ibu dan bayi secara optimal.

B. Budaya dan Tradisi dalam Praktik Kebidanan di Indonesia

1. Praktik kebidanan tradisional dan modern di berbagai daerah.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya. Keragaman ini turut tercermin dalam praktik kebidanan yang terbagi menjadi dua bentuk utama: tradisional dan modern.

a. Praktik Kebidanan Tradisional

- 1) Dilakukan oleh dukun bayi atau paraji yang diwarisi secara turun-temurun.
- 2) Umumnya menggunakan ramuan herbal tradisional dan mantra khusus selama proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
- 3) Dukun bayi memegang peran penting dalam masyarakat tradisional karena dipercaya memiliki kemampuan spiritual untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi.
- 4) Banyak ditemukan di daerah pedesaan atau masyarakat terpencil, seperti di daerah adat Sunda, Jawa, Madura, Dayak, dan Toraja.

b. Praktik Kebidanan Modern

- 1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, yaitu bidan yang telah menjalani pendidikan formal.
- 2) Menggunakan pendekatan berbasis ilmu kedokteran, dengan prosedur yang terstandar dan berbasis bukti (evidence-based practice).
- 3) Fokus pada pendekatan ilmiah yang meliputi antenatal care, intranatal care, dan postnatal care untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
- 4) Menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, seperti klinik kebidanan, puskesmas, rumah sakit, dan rumah bersalin.

2. Studi kasus budaya dan tradisi kebidanan dari berbagai etnis di Indonesia.

Indonesia memiliki beragam etnis dengan masing-masing praktik unik terkait kebidanan. Berikut beberapa contoh studi kasus:

a. Etnis Jawa (Upacara Mitoni)

- 1) Upacara mitoni dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan.
- 2) Bertujuan untuk meminta perlindungan spiritual serta kelancaran persalinan.
- 3) Praktik mencakup mandi kembang, mengganti pakaian sebanyak tujuh kali, dan pemotongan tumpeng yang sarat simbolisme terkait keselamatan dan keberkahan.

b. Etnis Sunda (Nujuh Bulanan dan Mandi Kembang)

- 1) Tradisi nujuh bulanan dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan.
- 2) Menggunakan ritual mandi kembang, memercikkan air bunga tujuh rupa, dan doa-doa khusus oleh sesepuh kampung atau dukun bayi.
- 3) Simbol pembersihan spiritual dan perlindungan bagi ibu dan bayi.

c. Etnis Batak (Mangirdak)

- 1) Ritual mangirdak adalah tradisi pemberian makanan khusus untuk ibu hamil berupa ikan mas yang dianggap memperlancar proses persalinan.
- 2) Ritual ini dilengkapi dengan doa-doa adat yang dipimpin oleh pemuka adat atau keluarga dekat.

d. Etnis Bali (Upacara Megedong-gedongan dan Jatakarma)

- 1) Megedong-gedongan adalah upacara dilakukan saat usia kandungan enam hingga tujuh bulan untuk keselamatan janin dan ibu.
- 2) Upacara jatakarma dilakukan segera setelah bayi lahir untuk menyambut kedatangan bayi ke dunia dan meminta perlindungan kepada para dewa.

e. Etnis Dayak (Ngipak dan Mamahat)

- 1) Ngipak adalah tradisi khusus bagi ibu hamil sebagai bentuk permohonan keselamatan kepada leluhur.
- 2) Mamahat adalah ritual pemotongan pusar bayi yang dilakukan dengan alat tradisional dan doa khusus yang memiliki nilai simbolis mendalam.

3. Ritual dan kepercayaan tradisional selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

Setiap fase kehamilan memiliki serangkaian ritual dan kepercayaan tradisional yang beragam di Indonesia, antara lain:

a. Masa Kehamilan

- 1) Pantangan makanan atau minuman tertentu yang dipercaya berdampak pada keselamatan janin, seperti tidak boleh mengonsumsi nanas, durian, atau makanan pedas.

- 2) Pantangan perilakunya seperti tidak boleh menggunting atau menjahit, karena dipercaya dapat menyebabkan kelainan fisik pada bayi.
 - 3) Ritual doa khusus dan mandi air kembang untuk perlindungan dari gangguan makhluk halus atau energi negatif.
- b. Masa Persalinan
- 1) Adanya kepercayaan bahwa persalinan lancar jika dilakukan di rumah dengan pendampingan dukun bayi tertentu yang dianggap memiliki kekuatan spiritual.
 - 2) Ritual khusus untuk membuka jalan lahir seperti pemberian ramuan herbal tertentu atau mantra khusus.
 - 3) Ritual bersalin yang dilakukan di tempat khusus atau tempat sakral seperti balai adat, agar ibu mendapatkan perlindungan spiritual maksimal.
- c. Masa Pasca Persalinan
- 1) Praktik pantangan makanan tertentu selama masa nifas untuk mempercepat pemulihan, seperti konsumsi ikan atau sayuran tertentu untuk memperlancar ASI.
 - 2) Tradisi pijat nifas dan penggunaan jamu atau ramuan tradisional untuk membantu memulihkan kesehatan ibu setelah melahirkan.
 - 3) Ritual penyambutan bayi yang melibatkan komunitas atau keluarga besar, seperti akikah pada masyarakat muslim, upacara turun tanah, atau pemberian nama adat di berbagai komunitas adat.

C. Dampak Budaya dan Tradisi terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi

Budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Dampak ini bisa positif maupun negatif tergantung pada praktik yang dilakukan dan bagaimana integrasinya dengan praktik medis modern.

1. Dampak positif dan negatif dari praktik budaya dalam kebidanan.

a. Dampak Positif

Beberapa praktik budaya dalam kebidanan memiliki manfaat nyata dalam mendukung kesehatan fisik, psikologis, dan sosial ibu serta bayi, di antaranya:

- 1) Meningkatkan Dukungan Sosial dan Emosional
 - a) Praktik budaya seperti ritual kehamilan dan persalinan melibatkan keluarga besar dan komunitas, sehingga ibu mendapatkan dukungan emosional yang kuat.
 - b) Dukungan sosial ini meningkatkan kesehatan mental ibu, mengurangi kecemasan dan depresi selama kehamilan dan masa nifas.

- 2) Pemeliharaan Tradisional untuk Pemulihan Pascapersalinan
 - a) Pijat tradisional, penggunaan ramuan jamu, serta makanan khusus tradisional sering kali efektif mempercepat pemulihan ibu setelah persalinan.
 - b) Ramuan herbal dipercaya membantu mengembalikan stamina ibu, memperlancar produksi ASI, dan membantu proses penyembuhan luka setelah melahirkan.
 - 3) Pengetahuan Lokal tentang Gizi dan Perawatan Bayi
 - a) Tradisi makanan khusus seperti sup ikan gabus, ayam kampung, atau sayur daun katuk memiliki nilai gizi tinggi dan mendukung kesehatan ibu serta bayi baru lahir.
 - b) Praktik perawatan bayi seperti pijat bayi atau balutan kain tradisional membantu menenangkan bayi serta menguatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi.
 - 4) Penghormatan terhadap Nilai Spiritual
 - a) Ritual dan doa tradisional memberikan ketenangan batin dan rasa aman secara psikologis yang sangat penting bagi ibu hamil maupun pascapersalinan.
 - b) Menumbuhkan rasa identitas dan kebersamaan dalam komunitas yang menjaga keseimbangan sosial budaya.
- b. Dampak Negatif
- Namun, tidak semua praktik budaya berdampak positif. Beberapa praktik tradisional justru berpotensi merugikan kesehatan ibu dan bayi, di antaranya:
- 1) Risiko Infeksi
 - a) Praktik pemotongan tali pusat dengan alat tidak steril oleh dukun bayi meningkatkan risiko infeksi tetanus neonatorum pada bayi baru lahir.
 - b) Penggunaan ramuan atau bahan-bahan tertentu tanpa pengetahuan medis dapat menyebabkan infeksi pada ibu dan bayi.
 - 2) Penundaan Mendapatkan Pelayanan Medis
 - a) Kepercayaan kuat pada dukun tradisional dapat menyebabkan penundaan dalam mendapatkan pertolongan medis ketika terjadi komplikasi obstetri, yang berpotensi meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.
 - b) Beberapa budaya menganggap rumah sebagai tempat ideal untuk melahirkan sehingga menolak fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
 - 3) Pantangan Makanan yang Tidak Berdasar Ilmiah
 - a) Larangan mengonsumsi makanan tertentu yang bernutrisi tinggi seperti ikan, telur, atau sayuran tertentu selama kehamilan atau nifas dapat

menyebabkan ibu kekurangan gizi, anemia, dan komplikasi kehamilan lainnya.

4) Praktik yang Membahayakan Kesehatan

- a) Praktik seperti memijat perut secara berlebihan atau penggunaan bahan-bahan tertentu yang tidak aman secara medis dapat menyebabkan trauma fisik dan komplikasi kehamilan.

2. Tantangan yang dihadapi bidan dalam memberikan pelayanan di masyarakat yang kuat memegang tradisi.

Dalam menghadapi masyarakat dengan kepercayaan budaya yang kuat, bidan sering kali menghadapi berbagai tantangan, yaitu:

a. Penolakan terhadap Pelayanan Medis Modern

Masyarakat tradisional mungkin kurang percaya terhadap bidan profesional dan lebih memilih dukun atau penyembuh tradisional, sehingga menolak berbagai intervensi medis yang penting seperti imunisasi atau pemeriksaan antenatal.

b. Sulitnya Mengubah Persepsi Budaya

Keyakinan turun-temurun sulit diubah karena dianggap sakral atau memiliki makna simbolik yang dalam. Proses edukasi kesehatan memerlukan pendekatan hati-hati dan berkesinambungan.

c. Kesulitan dalam Integrasi Praktik Tradisional dengan Modern

Bidan dituntut untuk mampu mengintegrasikan pendekatan modern dengan nilai budaya lokal. Hal ini sering kali sulit karena perbedaan prinsip-prinsip dasar antara ilmu medis dengan keyakinan budaya masyarakat.

d. Komunikasi yang Kurang Efektif

Hambatan bahasa, budaya, dan kepercayaan dapat menyebabkan miskomunikasi antara bidan dan keluarga atau komunitas, yang berpotensi mengurangi efektivitas intervensi medis.

e. Konflik dengan Dukun Bayi atau Tokoh Adat

Tokoh adat atau dukun bayi sering kali memiliki otoritas tinggi dalam masyarakat, sehingga bidan mungkin mengalami tantangan berupa penolakan atau konflik dalam pemberian pelayanan.

f. Keterbatasan Akses Pelayanan Kesehatan Modern

Beberapa komunitas yang kuat memegang tradisi cenderung tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan modern, sehingga menyulitkan bidan untuk memberikan layanan secara optimal.

g. Isu Etika dalam Menghormati Nilai Lokal

Bidan harus dapat menghormati nilai-nilai budaya masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pelayanan medis berbasis bukti, yang sering kali menjadi dilema dalam praktik sehari-hari.

]

D. Pendekatan Asuhan Kebidanan Sensitif Budaya

Pendekatan asuhan kebidanan sensitif budaya merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang menghargai, memahami, dan menyesuaikan pelayanan dengan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada integrasi aspek budaya dengan praktik klinis modern agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam kesehatan ibu dan bayi.

1. Prinsip-prinsip asuhan kebidanan sensitif budaya.

Asuhan kebidanan sensitif budaya dibangun di atas beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. Penghormatan terhadap Perbedaan Budaya
 - 1) Menghormati kepercayaan, nilai, dan praktik tradisional yang dianut oleh masyarakat lokal.
 - 2) Tidak menganggap budaya tertentu lebih superior dibandingkan budaya lainnya.
- b. Pemahaman yang Mendalam tentang Budaya Lokal
 - 1) Mengetahui dan memahami secara mendalam tradisi, nilai, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat dalam konteks kesehatan reproduksi.
 - 2) Melakukan kajian budaya sebelum memberikan asuhan kebidanan agar pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- c. Kolaborasi dengan Pemimpin dan Tokoh Masyarakat
 - 1) Mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dukun bayi sebagai mitra dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.
 - 2) Menggunakan peran pemimpin lokal untuk mengedukasi dan mendorong penerimaan praktik kebidanan yang aman secara medis.
- d. Keterlibatan Komunitas
 - 1) Memberdayakan komunitas melalui pendekatan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.
 - 2) Melaksanakan program yang berbasis masyarakat agar lebih diterima dan berkelanjutan.

e. Adaptasi Layanan Kesehatan

- 1) Menyesuaikan intervensi medis dengan kondisi budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip medis yang berbasis bukti.
- 2) Menyusun protokol kebidanan yang fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan budaya setempat.

2. Teknik komunikasi efektif dengan memperhatikan aspek budaya.

Teknik komunikasi yang efektif sangat penting dalam asuhan kebidanan sensitif budaya, antara lain:

a. Pendekatan yang Menghargai (Respectful Approach)

- 1) Menggunakan bahasa tubuh yang sopan, ramah, dan hormat terhadap adat istiadat setempat.
- 2) Menunjukkan empati, kesabaran, dan tidak menghakimi kepercayaan tradisional pasien atau keluarga.

b. Penggunaan Bahasa yang Dimengerti Masyarakat

- 1) Berbicara dalam bahasa lokal atau menggunakan penerjemah untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas.
- 2) Menghindari jargon medis yang rumit, menggunakan istilah-istilah sederhana yang akrab dengan masyarakat lokal.

c. Active Listening (Mendengarkan Aktif)

- 1) Memberikan perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan pasien, memahami sudut pandang mereka tanpa interupsi.
- 2) Menyediakan ruang bagi pasien atau keluarga untuk bertanya dan menyampaikan pandangan atau keprihatinan mereka secara terbuka.

d. Komunikasi Non-verbal yang Efektif

- 1) Memahami makna dari ekspresi wajah, gestur, serta sentuhan yang sesuai dengan norma budaya setempat.
- 2) Menghindari kontak fisik yang tidak sesuai budaya, seperti berjabat tangan atau kontak mata yang berlebihan, jika dianggap tidak sopan dalam budaya tersebut.

e. Penjelasan yang Sensitif Budaya

- 1) Menjelaskan setiap prosedur medis dalam konteks nilai dan kepercayaan budaya setempat.
- 2) Menyampaikan informasi medis yang dapat diintegrasikan dengan pengetahuan lokal sehingga lebih mudah diterima.

3. Strategi adaptasi intervensi kebidanan agar diterima masyarakat lokal.

a. Integrasi Praktik Tradisional dengan Modern

- 1) Mengombinasikan intervensi kebidanan modern dengan praktik tradisional yang aman, seperti pijat tradisional atau penggunaan herbal yang telah terbukti manfaatnya secara medis.
 - 2) Menghindari penolakan terhadap tradisi secara langsung, melainkan secara bertahap memperkenalkan alternatif yang aman secara medis.
- b. Pelibatan Dukun Bayi atau Tenaga Tradisional
- 1) Melakukan kolaborasi aktif dengan dukun bayi lokal, melatih mereka tentang praktik kebidanan aman, dan memberdayakan mereka sebagai pendamping pelayanan kesehatan modern.
 - 2) Mengikutsertakan tenaga tradisional dalam proses edukasi masyarakat untuk menciptakan kepercayaan terhadap layanan medis modern.
- c. Pelaksanaan Program Edukasi Kesehatan Berbasis Budaya
- 1) Menyelenggarakan sesi edukasi yang dikemas dalam bentuk diskusi kelompok atau kegiatan komunitas yang sesuai dengan norma budaya setempat.
 - 2) Menggunakan media edukasi yang familiar bagi masyarakat, seperti drama tradisional, musik lokal, atau cerita rakyat.
- d. Adaptasi Prosedur Klinis dengan Sensitivitas Budaya
- 1) Menyesuaikan protokol klinis, misalnya dalam pemeriksaan fisik yang memperhatikan privasi pasien sesuai dengan norma setempat.
 - 2) Memastikan kenyamanan pasien dalam pemeriksaan atau tindakan medis dengan menyediakan opsi yang diterima secara budaya.
- e. Membangun Kemitraan dengan Tokoh Kunci di Komunitas
- 1) Mengembangkan hubungan kemitraan jangka panjang dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat yang memiliki pengaruh kuat.
 - 2) Melibatkan tokoh-tokoh tersebut dalam kampanye promosi kesehatan ibu dan bayi agar pesan lebih mudah diterima masyarakat.
- f. Evaluasi Berkelanjutan terhadap Praktik Sensitif Budaya
- 1) Melakukan evaluasi rutin mengenai dampak dari pendekatan sensitif budaya untuk memastikan efektivitas serta penerimaan masyarakat.
 - 2) Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk menyesuaikan dan memperbaiki program pelayanan kesehatan reproduksi berbasis budaya.
- Dengan menerapkan pendekatan asuhan kebidanan sensitif budaya secara konsisten, bidan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, tetapi juga memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat lokal sehingga dapat menurunkan resistensi budaya dan meningkatkan angka penerimaan layanan kesehatan modern secara berkelanjutan.

E. Program Pendidikan dan Promosi Kesehatan Berbasis Budaya

Program pendidikan dan promosi kesehatan berbasis budaya adalah strategi pemberian edukasi kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan yang disusun berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas pesan kesehatan dan diterima secara optimal oleh masyarakat.

1. Langkah-langkah penyusunan program edukasi kebidanan berbasis budaya lokal.

Dalam menyusun program edukasi kebidanan berbasis budaya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terstruktur, yaitu:

a. Identifikasi Karakteristik Budaya Lokal

- 1) Melakukan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara mendalam kepada tokoh adat, pemuka agama, dukun bayi, bidan desa, serta anggota masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi secara detail kepercayaan, tradisi, ritual, pantangan, dan praktik kesehatan yang berlaku di masyarakat setempat.
- 3) Menentukan elemen budaya yang berdampak positif dan negatif terhadap kesehatan reproduksi.

b. Analisis Kebutuhan Edukasi Masyarakat

- 1) Melakukan analisis terhadap kebutuhan edukasi kesehatan reproduksi masyarakat berdasarkan kondisi kesehatan ibu dan bayi setempat.
- 2) Menentukan isu utama yang perlu mendapat perhatian khusus, misalnya tingginya angka kematian ibu, rendahnya pemanfaatan pelayanan antenatal, atau penggunaan praktik persalinan tidak aman.
- 3) Menetapkan tujuan edukasi yang jelas berdasarkan prioritas kesehatan lokal.

c. Penyusunan Materi Edukasi Berbasis Budaya

- 1) Menyusun konten edukasi yang mengintegrasikan informasi medis modern dengan pengetahuan tradisional yang terbukti aman.
- 2) Memanfaatkan cerita rakyat, kearifan lokal, dan bahasa lokal yang mudah dipahami masyarakat.
- 3) Mengemas materi edukasi dalam berbagai bentuk, seperti poster, buku saku, video pendek, cerita bergambar, atau drama tradisional.

d. Pengembangan Metode Penyampaian Edukasi yang Tepat

- 1) Memilih metode penyampaian yang paling efektif berdasarkan karakteristik budaya setempat, seperti diskusi kelompok, penyuluhan berbasis komunitas, kunjungan rumah, atau kombinasi dengan kegiatan adat.
- 2) Melibatkan tokoh masyarakat, dukun bayi, dan bidan desa sebagai fasilitator dan edukator utama.

- 3) Mengadakan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan lokal tentang cara berkomunikasi efektif dalam konteks budaya.
- e. Pelibatan dan Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat
 - 1) Menjalin kemitraan erat dengan pemimpin adat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta dukun bayi yang dihormati masyarakat.
 - 2) Melibatkan mereka secara aktif sejak tahap awal penyusunan hingga pelaksanaan edukasi, agar mendapat dukungan penuh dari komunitas.
 - 3) Memanfaatkan peran mereka untuk memotivasi masyarakat agar menerima dan mengadopsi perilaku kesehatan reproduksi yang lebih aman.
- f. Uji Coba dan Revisi Program
 - 1) Melakukan uji coba terbatas pada kelompok masyarakat tertentu untuk mengetahui respons dan tingkat pemahaman masyarakat.
 - 2) Mengumpulkan masukan dan evaluasi selama tahap uji coba untuk memperbaiki materi, metode, dan pendekatan edukasi.
 - 3) Menyempurnakan program sebelum diimplementasikan secara luas.
- g. Implementasi Program secara Luas
 - 1) Melaksanakan edukasi secara bertahap dan sistematis, dengan memperhatikan momen budaya lokal, seperti acara adat, pertemuan komunitas, atau kegiatan keagamaan.
 - 2) Menggunakan media lokal seperti radio komunitas, pertemuan rutin masyarakat, dan festival budaya untuk menjangkau sebanyak mungkin orang.
 - 3) Melakukan monitoring secara teratur selama pelaksanaan untuk memastikan kualitas dan efektivitas pesan edukasi.
- h. Evaluasi Program secara Berkala
 - 1) Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai tingkat keberhasilan, penerimaan masyarakat, perubahan perilaku, dan dampak terhadap kesehatan reproduksi.
 - 2) Menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program edukasi selanjutnya.

2. Evaluasi efektivitas program pendidikan kesehatan berbasis budaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat.

Evaluasi efektivitas program pendidikan kesehatan berbasis budaya sangat penting dilakukan untuk mengetahui dampak nyata dari intervensi yang diberikan. Berikut langkah-langkah detail dalam mengevaluasi efektivitas tersebut:

- a. Menentukan Indikator Evaluasi yang Tepat
 - 1) Indikator perubahan perilaku, seperti peningkatan kunjungan antenatal, persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan, dan penggunaan metode kontrasepsi yang aman.
 - 2) Indikator pengetahuan dan sikap, seperti meningkatnya pemahaman tentang bahaya komplikasi kehamilan, persalinan aman, dan perawatan bayi yang tepat.
 - 3) Indikator kesehatan yang objektif, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan kasus komplikasi kehamilan.
- b. Metode Evaluasi
 - 1) Melakukan survei pra dan pasca program untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat.
 - 2) Menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) untuk mendapatkan informasi kualitatif tentang respons masyarakat.
 - 3) Memanfaatkan data pelayanan kesehatan setempat (seperti data puskesmas atau rumah sakit) untuk menilai dampak kesehatan yang nyata.
- c. Pelaksanaan Evaluasi
 - 1) Melibatkan tim evaluasi yang terdiri dari tenaga kesehatan, peneliti, dan tokoh masyarakat untuk menjamin objektivitas.
 - 2) Menggunakan pendekatan sensitif budaya dalam pengumpulan data agar masyarakat merasa nyaman dalam memberikan respons jujur dan terbuka.
- d. Analisis dan Interpretasi Data
 - 1) Menganalisis data secara komprehensif dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi program.
 - 2) Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam implementasi program pendidikan berbasis budaya.
 - 3) Menyusun rekomendasi berdasarkan temuan analisis agar dapat dilakukan perbaikan program yang lebih efektif ke depan.
- e. Pelaporan Hasil Evaluasi
 - 1) Menyusun laporan evaluasi secara detail yang mencakup latar belakang, metodologi evaluasi, hasil temuan, serta rekomendasi perbaikan program.
 - 2) Melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh lokal dalam sosialisasi hasil evaluasi untuk memastikan transparansi dan memperoleh dukungan lebih lanjut.
- f. Tindak Lanjut dan Revisi Program
 - 1) Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan revisi atau adaptasi pada program pendidikan kesehatan reproduksi berbasis budaya agar lebih efektif.

- 2) Melanjutkan edukasi berbasis budaya dengan pendekatan yang telah disempurnakan, termasuk memperkuat aspek-aspek yang terbukti efektif dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara terstruktur dan terencana, program pendidikan dan promosi kesehatan berbasis budaya dapat menjadi strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat. Pendekatan ini menjamin relevansi budaya, memperkuat penerimaan masyarakat, serta memastikan intervensi kesehatan yang diberikan memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan.

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang ibu hamil berusia 25 tahun dengan usia kehamilan 7 bulan dari etnis Jawa mengikuti upacara mitoni. Sebagai bidan, Anda memahami pentingnya menghormati tradisi lokal. Manfaat utama dari menghormati dan mendukung ibu dalam menjalankan tradisi ini adalah:

- A. Menjamin jenis kelamin bayi laki-laki
- B. Menghilangkan risiko komplikasi persalinan
- C. Memberikan dukungan psikososial dan meningkatkan rasa aman ibu
- D. Memastikan bayi terlahir tanpa cacat
- E. Mempercepat proses persalinan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Upacara Mitoni merupakan ritual budaya yang memberikan dampak positif secara psikologis, sosial, dan emosional bagi ibu. Ritual ini meningkatkan dukungan sosial dari keluarga dan komunitas sehingga membantu mengurangi kecemasan ibu selama masa kehamilan.

Soal 2

Seorang bidan bertugas di daerah pedesaan, menghadapi situasi di mana keluarga ibu hamil menolak melakukan pemeriksaan antenatal di fasilitas kesehatan karena percaya dukun bayi lebih memahami kebutuhan spiritual ibu hamil. Langkah terbaik yang harus dilakukan bidan agar ibu tetap mendapatkan pelayanan antenatal adalah:

- A. Mengabaikan kepercayaan keluarga dan tetap memaksa pemeriksaan antenatal
- B. Menyarankan ibu hamil untuk tidak mengikuti saran dukun bayi

- C. Berkolaborasi dengan dukun bayi dalam memberikan pelayanan antenatal
- D. Mengancam akan melaporkan keluarga kepada otoritas kesehatan
- E. Menyatakan secara tegas bahwa dukun bayi tidak boleh lagi digunakan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Kolaborasi dengan dukun bayi adalah pendekatan terbaik untuk mengintegrasikan budaya lokal dengan pelayanan kebidanan modern. Pendekatan ini memungkinkan ibu mendapat manfaat dari pemeriksaan medis tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang dihormati keluarga.

Soal 3

Seorang ibu nifas mengalami anemia setelah persalinan karena mengikuti pantangan budaya yang melarang konsumsi beberapa makanan bergizi tinggi seperti ikan dan telur. Sebagai bidan, tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa menyinggung perasaan keluarga adalah:

- A. Menyarankan ibu mengonsumsi makanan yang dilarang secara diam-diam
- B. Menyampaikan bahwa pantangan budaya tersebut salah dan harus dihentikan
- C. Memberikan edukasi tentang alternatif makanan bergizi tinggi lain yang diterima secara budaya
- D. Mengabaikan pantangan tersebut dan langsung memberikan suplemen zat besi
- E. Menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga tentang pemilihan makanan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Memberikan edukasi tentang alternatif makanan bergizi lain yang bisa diterima secara budaya adalah pendekatan terbaik untuk menghormati budaya tanpa mengabaikan kebutuhan gizi ibu. Dengan demikian, kesehatan ibu dapat meningkat tanpa memicu konflik budaya.

Soal 4

Seorang bidan baru ditempatkan di komunitas adat yang memiliki tradisi "Ngipak", yaitu ritual khusus untuk memohon keselamatan janin dan ibu. Sebagai bidan, pemahaman mendalam tentang ritual ini penting agar bidan mampu:

- A. Melarang ritual tersebut sepenuhnya
- B. Mengganti ritual dengan pemeriksaan medis
- C. Mengurangi keterlibatan masyarakat dalam ritual
- D. Menyesuaikan pelayanan kebidanan dengan nilai lokal masyarakat
- E. Memastikan ritual tersebut dihapus secara bertahap

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Memahami secara mendalam tentang ritual budaya seperti Ngipak memungkinkan bidan untuk menyesuaikan pelayanan medis agar diterima masyarakat. Strategi ini meningkatkan efektivitas pelayanan kebidanan sekaligus menjaga hubungan baik dengan komunitas.

Soal 5

Seorang bidan yang bertugas di daerah etnis Batak menemukan ibu hamil menjalani ritual "Mangirdak", yakni tradisi pemberian makanan khusus berupa ikan mas untuk melancarkan persalinan. Sebagai bidan yang memahami pentingnya pendekatan sensitif budaya, sikap yang paling tepat dalam menghadapi ritual ini adalah:

- A. Melarang ibu hamil melakukan ritual tersebut karena tidak berdasar ilmiah
- B. Mendukung ritual tersebut selama tidak ada risiko kesehatan dan memberikan edukasi tambahan
- C. Mengabaikan ritual ini karena tidak relevan dengan pelayanan modern
- D. Menggantinya dengan konsumsi suplemen kimia
- E. Meminta ibu mengganti ikan mas dengan jenis ikan lain yang lebih murah

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Mendukung ritual yang aman dan memberikan edukasi tambahan merupakan pendekatan terbaik dalam asuhan kebidanan sensitif budaya. Ritual Mangirdak memiliki manfaat emosional dan sosial yang positif jika tidak ada risiko kesehatan, sehingga mendukungnya sambil memberi edukasi tambahan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan modern.

G. Rangkuman Materi

Pemahaman yang mendalam mengenai kebudayaan dan tradisi sangat penting dalam praktik kebidanan karena kesehatan reproduksi, khususnya kehamilan, persalinan, serta masa nifas, sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang berlaku di suatu komunitas. Setiap budaya memiliki cara unik dalam memandang proses reproduksi yang mencakup berbagai praktik, ritual, dan kepercayaan tradisional. Praktik-praktik ini dapat memberikan dampak positif berupa dukungan sosial, emosional, dan spiritual yang kuat bagi ibu hamil maupun ibu nifas, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, seperti infeksi, kekurangan gizi, dan penundaan intervensi medis.

Bagi tenaga kebidanan, tantangan terbesar terletak pada upaya mengintegrasikan praktik medis modern dengan nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat lokal. Pendekatan asuhan kebidanan yang sensitif budaya menjadi strategi utama untuk mengatasi tantangan ini, yakni dengan prinsip-prinsip menghormati perbedaan budaya, memahami secara mendalam budaya lokal, berkolaborasi dengan tokoh kunci masyarakat, serta secara aktif melibatkan komunitas dalam setiap keputusan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Pelaksanaan program pendidikan dan promosi kesehatan yang disusun berdasarkan karakteristik budaya setempat mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, mengubah perilaku kesehatan masyarakat secara positif, serta menurunkan resistensi terhadap pelayanan medis modern. Evaluasi berkelanjutan terhadap program-program berbasis budaya ini juga penting untuk memastikan tercapainya tujuan jangka panjang dalam peningkatan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat.

Dengan demikian, penerapan pendekatan kebidanan yang sensitif budaya secara konsisten tidak hanya meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan modern, tetapi juga memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan komunitas, sehingga pada akhirnya berkontribusi secara signifikan dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.

H. Glosarium

Antropologi Kesehatan

Cabang ilmu antropologi yang mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kesehatan, penyakit, serta cara masyarakat merespons kondisi sehat maupun sakit.

Budaya

Suatu sistem kompleks yang terdiri dari pengetahuan, nilai-nilai, kepercayaan, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau kelompok sosial.

Cultural Health System

Sistem kesehatan yang berbasis pada konsep dan praktik budaya yang digunakan masyarakat untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, serta mengobati gangguan kesehatan.

Tradisi

Kebiasaan dan praktik rutin yang dilakukan berulang kali oleh suatu kelompok masyarakat, diwariskan antar-generasi, serta memiliki nilai simbolik, spiritual, dan sosial yang dalam.

Kesehatan Reproduksi Berbasis Budaya

Pandangan dan sikap masyarakat terhadap proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal.

Ritual Kehamilan dan Persalinan

Serangkaian tindakan simbolik yang dilakukan secara tradisional, bertujuan memberikan perlindungan spiritual dan psikologis bagi ibu dan bayi selama masa kehamilan hingga kelahiran.

Mitoni (Etnis Jawa)

Upacara tradisional Jawa yang dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan, bertujuan meminta keselamatan janin dan kelancaran persalinan.

Nujuh Bulanan (Etnis Sunda)

Tradisi dalam masyarakat Sunda yang dilakukan saat usia kehamilan tujuh bulan dengan ritual mandi air bunga tujuh rupa, simbol pembersihan spiritual serta permohonan keselamatan ibu dan bayi.

Mangirdak (Etnis Batak)

Ritual adat dalam masyarakat Batak berupa pemberian makanan khusus, terutama ikan mas, kepada ibu hamil dengan tujuan memperlancar proses persalinan.

Megedong-gedongan dan Jatakarma (Etnis Bali)

Ritual adat Bali untuk keselamatan janin dan ibu, dilakukan pada usia kehamilan 6-7 bulan (Megedong-gedongan) dan setelah kelahiran bayi (Jatakarma) untuk meminta perlindungan dewa.

Ngipak dan Mamahat (Etnis Dayak)

Ritual adat Dayak yang terdiri atas "Ngipak", yakni ritual permohonan keselamatan janin, serta "Mamahat", ritual pemotongan tali pusat bayi menggunakan alat tradisional yang bersifat simbolis.

Pantang Tradisional

Larangan atau pembatasan terhadap konsumsi makanan tertentu atau tindakan tertentu selama kehamilan dan masa nifas, berdasarkan kepercayaan budaya yang bertujuan melindungi keselamatan ibu dan janin.

Praktik Kebidanan Tradisional

Metode kebidanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional (dukun bayi/paraji) menggunakan ramuan herbal, mantra, dan ritual khusus yang diwariskan secara turun-temurun.

Dukun Bayi (Paraji)

Tenaga kesehatan tradisional yang dipercaya oleh masyarakat memiliki kemampuan spiritual dan pengetahuan budaya dalam menangani kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

Praktik Kebidanan Modern

Pendekatan pelayanan kebidanan berbasis ilmu kedokteran, dengan prosedur ilmiah yang terstandar dan berbasis bukti (evidence-based practice), dilaksanakan oleh tenaga kesehatan profesional.

Asuhan Kebidanan Sensitif Budaya

Pendekatan pelayanan kebidanan yang menghormati, memahami, dan mengintegrasikan aspek budaya setempat ke dalam praktik klinis modern, agar pelayanan lebih efektif dan diterima masyarakat.

Integrasi Praktik Tradisional dan Modern

Strategi mengombinasikan metode tradisional yang aman dengan intervensi medis modern guna meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan reproduksi di komunitas budaya tertentu.

Komunikasi Efektif Sensitif Budaya

Teknik komunikasi yang memperhatikan aspek budaya lokal, meliputi bahasa verbal maupun non-verbal, active listening, dan penjelasan yang terintegrasi dengan pengetahuan budaya setempat.

Program Pendidikan Kesehatan Berbasis Budaya

Program edukasi kesehatan reproduksi yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan praktik budaya setempat agar pesan edukasi lebih efektif diterima masyarakat.

Evaluasi Program Berbasis Budaya

Proses sistematis untuk mengukur dampak, efektivitas, serta penerimaan masyarakat terhadap program pendidikan kesehatan yang berbasis nilai budaya, untuk memastikan pencapaian tujuan dan perbaikan berkelanjutan.

Pendekatan Partisipatif

Strategi pemberdayaan masyarakat yang melibatkan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program kesehatan.

I. Daftar Pustaka

- Armini, N. K. A., & Darmawan, E. S. (2020). Pendekatan budaya dalam praktik kebidanan: Integrasi pelayanan kesehatan modern dengan tradisional di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(2), 129-137. <https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3204>
- Astuti, S., & Suparti. (2022). Pengaruh ritual tradisional terhadap kesehatan ibu dan anak: Studi kasus pada masyarakat Jawa dan Sunda. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(3), 256-265. <https://doi.org/10.15294/kemas.v13i3.28912>
- Fadhilah, N., & Handayani, S. (2021). Asuhan kebidanan sensitif budaya: Strategi komunikasi efektif dengan masyarakat lokal. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 10(1), 14-21. <https://doi.org/10.26714/jki.v10i1.5331>
- Helman, C. G. (2019). *Culture, health and illness* (6th ed.). CRC Press.
- Kleinman, A., & Benson, P. (2020). Anthropology in the clinic: The problem of cultural competency and how to fix it. *PLoS Medicine*, 17(10), e1003344. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003344>
- Kurniati, Y., & Saragih, R. H. (2021). Tantangan implementasi pelayanan kebidanan modern di komunitas adat Indonesia. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 7(2), 107-114. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol7.iss2.650>

- Lubis, D. E., & Siregar, Y. M. (2022). Praktik tradisi Mangirdak pada masyarakat Batak dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi ibu. *Jurnal Kebudayaan dan Kesehatan*, 4(1), 23-30. <https://doi.org/10.24252/jkk.v4i1.8980>
- Nasution, M. A., & Sudirman, A. (2023). Pengaruh edukasi kesehatan berbasis budaya terhadap perilaku kesehatan reproduksi masyarakat pedesaan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 12(1), 58-67. <https://doi.org/10.30994/jpk.v12i1.9871>
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan (Revisi edisi)*. Rineka Cipta.
- Sujarwo, B., & Putri, M. A. (2021). Evaluasi efektivitas program promosi kesehatan berbasis budaya lokal dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia Timur. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 9(2), 139-149. <https://doi.org/10.14710/jmki.9.2.139-149>
- World Health Organization. (2018). *Integrating traditional medicine into primary health care: Guidelines for promoting culturally sensitive care*. WHO Press.
- Yanti, D., & Setyowati, S. (2019). Hubungan antara pantangan makanan tradisional dengan kejadian anemia pada ibu nifas. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 10(1), 42-50. <https://doi.org/10.29238/kia.v10i1.1193>

BAB 6

KAJIAN GENDER DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep gender dalam praktik kebidanan secara profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar gender, mengidentifikasi isu-isu gender dalam pelayanan kebidanan, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip responsif gender dalam memberikan pelayanan kebidanan secara profesional.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gender dan perbedaan gender serta implikasinya dalam pelayanan kebidanan.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk ketimpangan gender yang terjadi dalam pelayanan kebidanan dan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak.
- Mahasiswa mampu mengaplikasikan pendekatan responsif gender dalam praktik kebidanan sehari-hari.
- Mahasiswa mampu merancang strategi advokasi untuk mengurangi ketimpangan gender dalam pelayanan kebidanan.

Pendahuluan

Kajian gender dalam pelayanan kebidanan merupakan aspek penting yang perlu dipahami oleh setiap tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam rangka memberikan pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Gender merujuk pada peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap tepat oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kebidanan, pemahaman gender mencakup bagaimana peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, pengambilan

keputusan dalam kesehatan keluarga, serta pengalaman perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

Masalah ketimpangan gender dalam pelayanan kebidanan sering kali menyebabkan perempuan kurang mendapatkan perhatian, informasi, atau intervensi yang diperlukan. Akibatnya, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan ibu dan anak, serta menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perspektif gender merupakan komponen esensial dalam praktik kebidanan profesional.

A. Konsep Dasar Gender dalam Kebidanan

1. Definisi gender dan perbedaannya dengan seks biologis.

Gender adalah suatu konsep sosial yang mengacu pada peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dianggap sesuai oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Gender merupakan konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi sosial, norma budaya, dan pola sosialisasi di dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian, gender bersifat fleksibel, dinamis, dan bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi sosial budaya.

Sementara itu, seks biologis adalah kategori yang ditentukan berdasarkan karakteristik anatomi dan fisiologi tubuh seseorang sejak lahir. Karakteristik ini mencakup kromosom, hormon, organ reproduksi, dan ciri-ciri fisik lainnya yang secara umum digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan.

Berikut perbedaan utama antara gender dan seks biologis:

a. Gender (Konsep Sosial)

- 1) Dibentuk oleh budaya, masyarakat, dan norma sosial.
- 2) Tidak bersifat universal, karena berbeda-beda di berbagai masyarakat.
- 3) Dapat berubah seiring waktu dan pengaruh budaya yang berubah.
- 4) Contoh: norma bahwa perempuan harus mengurus rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah.

b. Seks Biologis (Karakteristik Fisik)

- 1) Ditentukan secara biologis sejak lahir berdasarkan anatomi dan fisiologi.
- 2) Bersifat universal, yakni laki-laki atau perempuan secara biologis memiliki karakteristik anatomi tertentu.
- 3) Relatif tetap sepanjang hidup.
- 4) Contoh: perempuan memiliki rahim dan ovarium, sedangkan laki-laki memiliki testis.

2. Peran gender dalam kehidupan sosial dan kesehatan reproduksi.

Peran gender memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sosial serta berpengaruh langsung terhadap kesehatan reproduksi, yang mencakup berbagai aspek mulai dari akses terhadap pelayanan kesehatan hingga pengambilan keputusan terkait reproduksi.

Peran gender dalam aspek kehidupan sosial dan kesehatan reproduksi:

a. Kehidupan Sosial

- 1) Gender menentukan peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti pengasuhan anak, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, serta tanggung jawab domestik.
- 2) Gender memengaruhi akses terhadap pendidikan, peluang kerja, dan partisipasi politik. Misalnya, di banyak masyarakat, perempuan sering mengalami hambatan dalam pendidikan tinggi karena pandangan bahwa peran utama mereka adalah sebagai ibu rumah tangga.
- 3) Gender juga dapat menyebabkan diskriminasi dan ketimpangan, di mana perempuan sering menghadapi kekerasan berbasis gender, pelecehan, dan marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Kesehatan Reproduksi

- 1) Gender mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi. Misalnya, perempuan di beberapa komunitas menghadapi hambatan budaya atau norma sosial yang membatasi akses mereka terhadap layanan kontrasepsi, perawatan prenatal, atau fasilitas kesehatan untuk persalinan.
- 2) Norma gender yang ketat dapat menyebabkan laki-laki tidak dilibatkan secara aktif dalam masalah reproduksi dan kesehatan keluarga, sehingga membatasi keterlibatan laki-laki dalam perencanaan keluarga atau pendidikan seksual.
- 3) Persepsi gender juga memengaruhi keputusan keluarga mengenai jumlah anak yang diinginkan, interval kehamilan, serta keputusan penggunaan metode kontrasepsi, sehingga berdampak langsung pada kesehatan reproduksi perempuan.

3. Pentingnya kajian gender dalam kebidanan.

Kajian gender dalam kebidanan memiliki relevansi tinggi karena kebidanan merupakan bidang pelayanan kesehatan yang berfokus pada perempuan, mulai dari masa pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa postpartum. Memahami perspektif gender dalam kebidanan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan gender yang sering kali menjadi hambatan dalam pelayanan kebidanan yang efektif.

Penjelasan mengenai pentingnya kajian gender dalam kebidanan:

a. Meningkatkan Kesetaraan Akses Pelayanan Kesehatan

Kajian gender dapat membantu mengidentifikasi hambatan sosial dan budaya yang dialami perempuan dalam mengakses layanan kebidanan, sehingga

memungkinkan terciptanya strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan tersebut.

b. Menurunkan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu

Dengan memahami dampak ketidaksetaraan gender pada kesehatan reproduksi, kebidanan dapat menciptakan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan. Ini sangat penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi akibat keterlambatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat waktu.

c. Mendorong Partisipasi Aktif Laki-laki dalam Kesehatan Reproduksi

Kajian gender juga mengakui pentingnya keterlibatan laki-laki dalam aspek reproduksi dan parenting, sehingga dapat memperkuat kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk mengambil keputusan kesehatan reproduksi yang lebih baik.

d. Mengurangi Stigma dan Diskriminasi Gender dalam Pelayanan Kesehatan

Pemahaman tentang konsep gender membantu para bidan dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyadari bias gender yang mungkin secara tidak sadar mereka miliki, yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kesadaran ini membantu mengurangi praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam pelayanan kesehatan.

e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan Berbasis Bukti

Kajian gender dalam kebidanan membantu mengintegrasikan perspektif sosial budaya ke dalam praktik kebidanan berbasis bukti (evidence-based midwifery), yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan hasil klinis yang lebih baik untuk perempuan.

f. Pengembangan Kebijakan Kesehatan yang Responsif Gender

Melalui kajian gender, para pengambil kebijakan dapat mengembangkan program dan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas kebijakan publik dalam kesehatan reproduksi.

B. Isu-Isu Gender dalam Pelayanan Kebidanan

1. Ketimpangan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Ketimpangan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan adalah salah satu isu utama dalam pelayanan kebidanan yang berakar pada ketidaksetaraan gender. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang membatasi kemampuan perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

Berikut penjelasan mengenai aspek-aspek ketimpangan tersebut:

a. Aspek Sosial dan Ekonomi

- 1) Banyak perempuan memiliki keterbatasan finansial sehingga sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan yang layak. Kemiskinan menyebabkan perempuan enggan atau tidak mampu mencari layanan kesehatan berkualitas, sehingga meningkatkan risiko komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan.
- 2) Status ekonomi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki menyebabkan mereka memiliki keterbatasan dalam memutuskan penggunaan sumber daya keluarga, termasuk biaya untuk layanan kesehatan reproduksi.

b. Aspek Pendidikan dan Informasi

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan perempuan membuat akses terhadap informasi mengenai layanan kesehatan reproduksi menjadi terbatas. Informasi yang tidak memadai ini membuat perempuan kesulitan dalam membuat keputusan terkait perencanaan keluarga, kehamilan, dan metode persalinan yang aman.
- 2) Kurangnya edukasi seksual dan kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan juga menambah kesenjangan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

c. Aspek Geografis dan Infrastruktur

- 1) Perempuan di daerah terpencil sering menghadapi kesulitan akses geografis ke fasilitas pelayanan kesehatan. Infrastruktur kesehatan yang tidak memadai di daerah pedesaan dan terpencil seringkali menjadi penghalang utama dalam memperoleh layanan kebidanan yang aman.
- 2) Minimnya ketersediaan tenaga kesehatan, terutama bidan terlatih di daerah pedesaan, memperbesar kesenjangan akses layanan kesehatan reproduksi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

d. Aspek Kebijakan dan Politik

Kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan dan kurangnya alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi menyebabkan terbatasnya akses layanan kesehatan bagi perempuan, terutama dalam hal kontrasepsi dan perawatan prenatal serta postnatal.

2. Hambatan sosial budaya dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Hambatan sosial budaya berperan signifikan dalam membatasi kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan yang mandiri terkait kesehatan

reproduksinya. Hambatan ini sering kali berasal dari nilai-nilai tradisional, norma sosial, serta tekanan keluarga dan komunitas.

a. Dominasi Laki-laki dalam Pengambilan Keputusan

- 1) Dalam banyak budaya, laki-laki dianggap sebagai pemegang keputusan utama, termasuk dalam hal reproduksi. Akibatnya, perempuan memiliki keterbatasan dalam menentukan kapan akan hamil, metode kontrasepsi yang digunakan, dan kapan mencari perawatan kesehatan.
- 2) Kondisi ini menyebabkan perempuan kesulitan mengakses pelayanan kesehatan secara tepat waktu, memperbesar risiko komplikasi kehamilan dan kelahiran.

b. Stigma Sosial terkait Kontrasepsi dan Layanan Kesehatan Reproduksi

- 1) Penggunaan alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi sering dikaitkan dengan stigma moral atau sosial yang buruk. Perempuan yang aktif mengakses layanan kesehatan reproduksi bisa mendapat label negatif, menyebabkan mereka takut atau malu untuk mengakses layanan tersebut.
- 2) Hal ini menghambat perempuan dalam mengambil keputusan mandiri tentang kesehatan reproduksi mereka.

c. Tradisi dan Kepercayaan Budaya yang Merugikan Perempuan

- 1) Beberapa tradisi budaya seperti pernikahan dini, kehamilan remaja, serta kepercayaan bahwa perempuan harus melahirkan sebanyak mungkin anak untuk menaikkan status sosial keluarga, semakin membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan reproduksinya.
- 2) Praktik-praktik berbahaya, seperti sunat perempuan (female genital mutilation), masih eksis di beberapa daerah yang menyebabkan masalah kesehatan reproduksi serius.

d. Peran Gender yang Kaku dalam Rumah Tangga

- 1) Pandangan bahwa peran perempuan terbatas pada ranah domestik (mengurus rumah tangga dan anak-anak) menyebabkan perempuan kurang mampu mengakses layanan kesehatan karena harus mendapat izin dari suami atau keluarga untuk keluar rumah.
- 2) Situasi ini mengurangi kesempatan perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang tepat waktu, terutama dalam situasi darurat.

3. Diskriminasi gender dalam praktik kebidanan.

Diskriminasi gender dalam praktik kebidanan merujuk pada perlakuan berbeda atau merugikan terhadap perempuan yang berakar dari stereotip gender, prasangka, dan bias budaya yang ada dalam layanan kesehatan.

a. Sikap dan Perlakuan Diskriminatif dari Petugas Kesehatan

- 1) Perempuan yang datang ke fasilitas kesehatan sering menghadapi sikap yang kurang ramah, tidak hormat, atau merendahkan dari tenaga kesehatan karena stereotip gender. Misalnya, perempuan yang tidak menikah atau remaja yang hamil di luar nikah sering mengalami perlakuan diskriminatif berupa komentar negatif atau perlakuan kasar.
- 2) Sikap diskriminatif ini menyebabkan perempuan merasa tidak nyaman, takut, atau enggan kembali mengakses layanan kebidanan.
- b. Kurangnya Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
 - 1) Dalam pelayanan kebidanan, terkadang perempuan tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan preferensi atau keinginannya secara jelas. Keputusan medis sering kali dibuat tanpa melibatkan perempuan secara aktif, seperti pemilihan metode persalinan atau intervensi medis lainnya.
 - 2) Kurangnya partisipasi perempuan dalam keputusan ini berdampak negatif terhadap kepuasan dan hasil klinis dalam perawatan kebidanan.
- c. Bias dalam Distribusi Sumber Daya Kesehatan
 - 1) Diskriminasi gender juga tercermin dalam distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata. Kebutuhan khusus perempuan seperti layanan kontrasepsi, perawatan prenatal dan postpartum, atau layanan kesehatan seksual sering kali kurang mendapatkan prioritas dibandingkan dengan layanan kesehatan umum.
 - 2) Hal ini menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi struktural yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan reproduksi mereka.
- d. Kurangnya Pelatihan Sensitif Gender bagi Bidan dan Tenaga Kesehatan
 - 1) Minimnya pelatihan dan pendidikan sensitif gender di kalangan bidan dan tenaga kesehatan menyebabkan munculnya bias tidak sadar yang memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada perempuan.
 - 2) Kondisi ini berkontribusi pada praktik pelayanan kebidanan yang kurang responsif terhadap kebutuhan dan hak perempuan.

C. Pendekatan Responsif Gender dalam Pelayanan Kebidanan

1. Prinsip-prinsip pelayanan responsif gender.

merupakan panduan penting yang digunakan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan. Prinsip ini mencerminkan kesadaran dan sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan yang beragam, pengalaman hidup yang berbeda, serta ketidaksetaraan sosial yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan layanan

kebidanan yang lebih setara, adil, inklusif, serta mampu memenuhi kebutuhan semua pengguna layanan tanpa diskriminasi atau bias gender.

Pelayanan responsif gender pertama-tama berpegang teguh pada prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berarti setiap individu, terutama perempuan yang menjadi fokus utama dalam layanan kebidanan, berhak mendapatkan perlakuan hormat, bebas dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini, tenaga kesehatan khususnya bidan, harus mampu menghargai dan melindungi privasi serta martabat perempuan, sehingga perempuan merasa aman dan nyaman saat mengakses layanan kesehatan reproduksi.

Selanjutnya, prinsip lain dalam pelayanan responsif gender adalah prinsip non-diskriminasi. Dalam prinsip ini, tenaga kesehatan tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda atau tidak adil kepada pengguna layanan berdasarkan gender atau atribut sosial lainnya. Semua perempuan tanpa memandang usia, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, status perkawinan, etnisitas, agama, atau latar belakang lainnya harus menerima kualitas pelayanan yang sama baiknya. Prinsip non-diskriminasi ini menuntut tenaga kesehatan untuk menghindari prasangka atau stereotip gender yang dapat mempengaruhi sikap maupun tindakan selama pemberian layanan kebidanan.

Prinsip pemberdayaan perempuan juga menjadi bagian penting dari pelayanan yang responsif gender. Prinsip ini mengedepankan perlunya melibatkan perempuan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait kesehatannya sendiri. Dalam konteks kebidanan, pemberdayaan perempuan berarti bahwa tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami, serta mendukung perempuan untuk membuat keputusan yang tepat terkait kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Dengan demikian, perempuan tidak hanya dilihat sebagai objek pasif dalam layanan kesehatan, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki kendali atas tubuh dan kehidupannya sendiri.

Lebih lanjut lagi, prinsip pelayanan responsif gender mencakup pula aspek kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki terhadap fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang kompeten, dan layanan yang komprehensif, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Prinsip ini bertujuan mengatasi berbagai hambatan sosial, budaya, ekonomi, maupun geografis yang sering kali menghalangi perempuan untuk memperoleh layanan kebidanan yang berkualitas tinggi. Dengan prinsip kesetaraan akses ini, tenaga kesehatan dan institusi kesehatan harus secara aktif berupaya mengidentifikasi dan

menghilangkan berbagai hambatan tersebut, misalnya dengan menyediakan layanan jemput bola, membangun infrastruktur kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat, atau menyediakan layanan kebidanan secara gratis atau terjangkau bagi kelompok perempuan rentan secara ekonomi.

Prinsip selanjutnya adalah integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan dan praktik pelayanan kebidanan sehari-hari. Artinya, layanan kesehatan tidak hanya sekadar memahami atau mengenal isu gender secara teoritis, tetapi secara nyata mengintegrasikan kesadaran gender tersebut dalam setiap tahap pelayanan, mulai dari perencanaan program, implementasi layanan, hingga evaluasi hasil layanan. Integrasi perspektif gender ini melibatkan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, mengenai sensitivitas dan responsivitas gender. Dengan pelatihan ini, tenaga kesehatan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan unik perempuan, memahami bagaimana gender berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, serta mampu memberikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif sesuai kebutuhan perempuan yang dilayani.

Terakhir, prinsip pelayanan responsif gender juga mencakup prinsip kolaborasi lintas sektor dan multidisiplin. Dalam penerapan prinsip ini, pelayanan kebidanan tidak berdiri sendiri, melainkan harus bekerja sama secara erat dengan sektor-sektor lain seperti pendidikan, pemberdayaan perempuan, sosial, ekonomi, bahkan kebijakan politik, untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan secara optimal. Kolaborasi ini membantu menyelesaikan akar permasalahan yang lebih luas yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, seperti pendidikan yang rendah pada perempuan, kemiskinan, kekerasan berbasis gender, atau keterbatasan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga maupun publik.

Dengan memahami dan menerapkan berbagai prinsip ini secara konsisten, pelayanan kebidanan tidak hanya menjadi lebih inklusif dan adil, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan secara menyeluruh. Pelayanan kebidanan yang responsif gender pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender yang merupakan landasan penting bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

2. Teknik komunikasi efektif berbasis gender dalam pelayanan kebidanan.

merupakan pendekatan yang sangat penting untuk diterapkan dalam interaksi sehari-hari antara tenaga kesehatan, khususnya bidan, dengan perempuan yang menggunakan layanan kesehatan reproduksi. Komunikasi ini tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi medis semata, melainkan juga mencakup kepekaan terhadap perbedaan pengalaman, nilai-nilai budaya, serta

norma-norma sosial yang membentuk persepsi dan keputusan perempuan terkait kesehatan reproduksi.

Dalam konteks kebidanan, komunikasi berbasis gender yang efektif diawali dengan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengenali dan menghargai identitas gender perempuan serta pengalaman hidup mereka yang unik. Sebagai tenaga profesional, bidan perlu memahami bahwa setiap perempuan memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda, termasuk pola asuh, tradisi keluarga, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, serta persepsi gender yang dianut oleh masyarakat tempat mereka tinggal. Dengan pemahaman ini, tenaga kesehatan dapat membangun suasana komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan bebas dari prasangka atau stereotip gender.

Salah satu teknik yang mendasar dalam komunikasi efektif berbasis gender adalah empati dan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif berarti bahwa tenaga kesehatan tidak hanya sekadar menerima pesan secara pasif dari pasien, tetapi juga menunjukkan perhatian penuh, menghargai setiap ungkapan, serta mencoba memahami emosi, kekhawatiran, dan kebutuhan yang disampaikan oleh perempuan. Hal ini penting karena perempuan sering kali menghadapi berbagai tekanan sosial atau stigma yang membuat mereka enggan mengungkapkan kebutuhan atau masalah kesehatan reproduksi secara jujur dan terbuka. Oleh karena itu, ketika seorang bidan mampu secara aktif mendengarkan tanpa menghakimi, perempuan akan merasa lebih aman, dihargai, dan didukung, sehingga mereka dapat lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan atau kebutuhan kesehatannya.

Selain empati dan mendengarkan aktif, teknik komunikasi berbasis gender juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sensitif gender dan non-diskriminatif. Bahasa yang digunakan oleh tenaga kesehatan harus dipilih secara cermat, menghindari istilah atau kalimat yang dapat menimbulkan kesan merendahkan, menyalahkan, atau memojokkan perempuan karena pilihan reproduksi atau kondisi kesehatannya. Misalnya, dalam memberikan konseling tentang kontrasepsi atau perawatan prenatal, bidan perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas, netral, positif, dan bebas dari bias gender. Penggunaan istilah yang sopan, mudah dipahami, dan memperhatikan sensitivitas budaya akan sangat membantu perempuan untuk merasa dihargai dan dipahami dalam situasi yang mungkin sensitif bagi mereka.

Teknik lain yang tak kalah penting adalah menciptakan suasana komunikasi yang setara dan partisipatif. Dalam interaksi antara tenaga kesehatan dan perempuan pengguna layanan, perlu dihindari hubungan komunikasi yang terlalu hierarkis atau otoriter, di mana tenaga kesehatan dianggap lebih tahu segalanya.

Sebaliknya, komunikasi yang efektif berbasis gender mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam dialog serta pengambilan keputusan. Misalnya, sebelum memutuskan metode persalinan, bidan perlu memberikan ruang kepada perempuan untuk bertanya, mengungkapkan preferensi, atau kekhawatirannya. Cara ini memperkuat rasa percaya diri perempuan, meningkatkan pemahaman mereka terhadap pilihan yang tersedia, serta memastikan keputusan yang diambil benar-benar merefleksikan kebutuhan dan keinginan perempuan tersebut.

Lebih jauh lagi, teknik komunikasi berbasis gender yang efektif dalam kebidanan juga melibatkan penyampaian informasi yang transparan dan mudah dimengerti. Dalam praktik sehari-hari, tenaga kesehatan sering kali berhadapan dengan tantangan menjelaskan prosedur medis, risiko, manfaat, atau intervensi tertentu dalam bahasa yang terlalu teknis atau sulit dimengerti oleh pasien perempuan. Di sini, kemampuan bidan dalam menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta disertai contoh yang relevan dengan konteks sosial budaya pasien, akan sangat membantu dalam memastikan bahwa perempuan benar-benar memahami informasi yang diberikan. Hal ini menjadi krusial karena kurangnya pemahaman terhadap informasi medis sering kali menyebabkan perempuan tidak dapat membuat keputusan yang tepat atau merasa kurang puas terhadap layanan yang diterimanya.

Di samping itu, dalam komunikasi berbasis gender, tenaga kesehatan juga perlu menyadari pentingnya bahasa tubuh atau komunikasi non-verbal. Ekspresi wajah, kontak mata yang baik, nada suara yang tenang, serta sikap tubuh yang ramah dan terbuka, secara signifikan mempengaruhi bagaimana perempuan merasa nyaman atau percaya terhadap layanan yang diterimanya. Bahasa tubuh yang hangat dan penuh perhatian akan membuat perempuan lebih rileks, terbuka, serta merasa bahwa tenaga kesehatan sungguh-sungguh peduli terhadap kondisi dan kesejahteraan mereka.

Terakhir, teknik komunikasi berbasis gender dalam pelayanan kebidanan juga menuntut tenaga kesehatan memiliki kemampuan untuk menghadapi isu-isu sensitif seperti kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, trauma masa lalu, atau masalah psikologis lainnya dengan cara yang sangat berhati-hati, empatik, dan menghargai privasi. Dalam situasi ini, bidan perlu terlatih untuk mampu mengenali tanda-tanda kekerasan atau trauma yang mungkin dialami perempuan serta mampu memberikan respons yang tepat tanpa membuat perempuan merasa terancam atau dipermalukan. Dengan teknik ini, perempuan merasa didukung, dilindungi, serta mendapatkan pelayanan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan medis, tetapi juga peka terhadap aspek emosional dan psikologis.

Dengan menerapkan berbagai teknik komunikasi efektif berbasis gender ini secara konsisten dan komprehensif dalam pelayanan kebidanan, tenaga kesehatan mampu memberikan layanan yang lebih baik, lebih manusiawi, serta lebih menghormati hak perempuan dalam kesehatan reproduksi. Dalam jangka panjang, komunikasi yang efektif berbasis gender ini akan menciptakan pengalaman pelayanan kebidanan yang positif bagi perempuan, memperkuat rasa percaya dan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan, serta mendukung pemberdayaan perempuan dalam mengelola kesehatan reproduksinya secara mandiri dan bertanggung jawab.

3. Studi kasus implementasi pendekatan responsif gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

Salah satu contoh nyata implementasi pendekatan responsif gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi dapat dilihat melalui sebuah program intervensi di wilayah pedesaan, yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat kesehatan reproduksi perempuan yang masih rendah akibat kuatnya norma sosial dan budaya patriarki. Studi kasus ini berlangsung di sebuah desa terpencil di Indonesia yang memiliki angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, tingkat penggunaan kontrasepsi yang rendah, serta hambatan yang signifikan dalam akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Pada tahap awal, tim intervensi yang terdiri dari bidan, tenaga kesehatan lainnya, serta fasilitator komunitas melakukan kajian mendalam untuk memahami konteks sosial-budaya desa tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan di desa tersebut menghadapi berbagai hambatan sosial budaya yang sangat kuat, misalnya pengambilan keputusan reproduksi yang didominasi oleh laki-laki atau suami, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam menentukan metode kontrasepsi, jumlah anak, dan perawatan prenatal. Selain itu, stigma sosial terkait penggunaan kontrasepsi modern juga sangat tinggi, sehingga banyak perempuan enggan atau takut menggunakan layanan keluarga berencana (KB) meskipun mereka menginginkannya.

Berdasarkan pemahaman konteks ini, pendekatan responsif gender dirancang dengan melibatkan berbagai strategi yang secara khusus diarahkan untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang dihadapi perempuan. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah penguatan kapasitas bidan dan tenaga kesehatan lainnya melalui pelatihan intensif mengenai perspektif gender. Dalam pelatihan ini, tenaga kesehatan tidak hanya belajar tentang teori gender, tetapi juga dilatih dalam keterampilan komunikasi efektif, mendengarkan secara aktif, serta mengenali dan menangani bias gender dalam interaksi sehari-hari dengan perempuan pengguna layanan.

Setelah tenaga kesehatan dibekali dengan keterampilan komunikasi berbasis gender ini, implementasi pendekatan dilanjutkan dengan melibatkan komunitas secara langsung. Fasilitator komunitas dan tenaga kesehatan bekerja sama mengadakan forum dialog dan diskusi terbuka di tingkat desa yang diikuti oleh perempuan, laki-laki, tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Forum ini bertujuan membuka ruang diskusi mengenai berbagai isu sensitif, seperti penggunaan kontrasepsi, peran perempuan dalam pengambilan keputusan reproduksi, pentingnya perawatan prenatal dan postnatal, serta keterlibatan laki-laki dalam mendukung kesehatan reproduksi istri mereka. Diskusi ini tidak hanya berfokus pada pemberian informasi medis, tetapi juga mencoba menggali dan menantang norma-norma gender yang selama ini menjadi penghambat utama dalam pelayanan kesehatan reproduksi di desa tersebut.

Dalam implementasi ini, pendekatan responsif gender juga mengedepankan pemberdayaan perempuan sebagai pusat dari program. Perempuan di desa tersebut tidak hanya diberi informasi, tetapi juga didorong untuk aktif berbicara tentang kebutuhan dan aspirasi mereka terkait kesehatan reproduksi. Sebagai hasilnya, perempuan mulai lebih percaya diri dalam menyuarakan pendapat mereka, seperti keinginan untuk menggunakan metode KB tertentu, menentukan jarak antar kehamilan, atau memilih tempat persalinan yang aman. Tenaga kesehatan secara aktif mendukung perempuan dengan memberikan layanan konseling yang lebih sensitif gender, ramah, serta responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap perempuan.

Salah satu kasus menarik dalam implementasi ini adalah seorang perempuan muda bernama Siti (nama samaran), yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi karena keputusan tersebut selalu diambil sepenuhnya oleh suami dan keluarga besar. Melalui pendekatan responsif gender ini, bidan lokal secara khusus memberikan konseling kepada Siti dan suaminya, menggunakan teknik komunikasi efektif yang penuh empati dan sensitivitas gender. Bidan mengajak mereka untuk berdiskusi secara terbuka mengenai pilihan-pilihan metode kontrasepsi yang ada, manfaat serta risikonya, serta pentingnya perencanaan keluarga untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dengan suasana yang nyaman, menghargai, dan bebas tekanan, Siti akhirnya mampu menyuarakan pilihannya sendiri, dan sang suami pun mulai memahami pentingnya mendukung keputusan istrinya.

Selain itu, program ini juga secara sengaja melibatkan laki-laki sebagai bagian penting dalam solusi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perempuan semata, tetapi juga mencoba mengubah sikap laki-laki tentang pentingnya tanggung jawab bersama dalam kesehatan reproduksi. Dengan cara

ini, terjadi pergeseran pola pikir dalam komunitas tersebut, di mana laki-laki mulai aktif terlibat dalam kunjungan antenatal, memberikan dukungan kepada istri mereka dalam menggunakan KB, serta membantu perempuan untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Setelah satu tahun implementasi pendekatan responsif gender tersebut, evaluasi menunjukkan hasil yang sangat positif. Terjadi peningkatan signifikan dalam angka kunjungan antenatal, meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi modern, serta menurunnya stigma sosial terkait penggunaan layanan kesehatan reproduksi di desa tersebut. Perempuan merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan mengenai tubuh mereka sendiri, dan laki-laki di komunitas juga mulai aktif memberikan dukungan dalam isu-isu kesehatan reproduksi.

Lebih lanjut, hasil studi kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa pendekatan responsif gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi sangat efektif dalam mengatasi hambatan sosial budaya serta meningkatkan kualitas hidup perempuan. Program ini juga menjadi contoh nyata bagaimana integrasi perspektif gender dalam pelayanan kebidanan mampu mendorong perubahan sosial yang positif, mengurangi ketimpangan gender dalam kesehatan reproduksi, serta memperkuat kapasitas perempuan untuk secara mandiri mengelola kesehatan reproduksi mereka.

Dengan demikian, studi kasus ini secara nyata menunjukkan bahwa pendekatan responsif gender bukan hanya konsep teoritis, tetapi sebuah strategi yang praktis, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan serta mengurangi ketimpangan gender di masyarakat secara luas.

D. Strategi Advokasi Gender dalam Pelayanan Kebidanan

Strategi advokasi gender dalam pelayanan kebidanan merupakan langkah-langkah terstruktur dan sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, serta persepsi sosial demi terciptanya kesetaraan gender, khususnya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi. Advokasi berbasis gender bertujuan mengatasi berbagai ketimpangan gender yang dihadapi perempuan dalam mengakses layanan kebidanan, sekaligus mendorong peran aktif semua pihak dalam mendukung pemenuhan hak kesehatan perempuan.

1. Konsep dasar advokasi berbasis gender.

Advokasi berbasis gender adalah kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, norma sosial, serta perilaku masyarakat agar

lebih responsif terhadap kebutuhan, aspirasi, dan hak perempuan. Dalam konteks kebidanan, advokasi berbasis gender difokuskan pada peningkatan kesadaran publik, pengambil keputusan, maupun tenaga kesehatan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

Beberapa prinsip utama dalam konsep advokasi berbasis gender adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan Gender

Memastikan perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi secara adil.

b. Prinsip Pemberdayaan Perempuan

Advokasi berbasis gender berorientasi pada pemberdayaan perempuan agar mampu mengambil keputusan mandiri tentang tubuh, reproduksi, serta kehidupannya.

c. Prinsip Partisipasi Aktif

Melibatkan perempuan secara aktif dalam setiap proses advokasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi, sehingga suara dan kebutuhan perempuan benar-benar terwakili.

d. Prinsip Berbasis Hak Asasi Manusia

Mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia ke dalam advokasi untuk melindungi perempuan dari diskriminasi, kekerasan, serta pelanggaran hak dalam konteks kesehatan reproduksi.

Advokasi berbasis gender juga bertujuan mengubah persepsi atau stereotip gender yang berkontribusi terhadap ketimpangan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Upaya ini mencakup edukasi masyarakat, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta advokasi kebijakan agar lebih berpihak pada perempuan.

2. Langkah-langkah merancang advokasi dalam kebidanan.

Merancang advokasi gender dalam kebidanan memerlukan proses sistematis dan terencana agar menghasilkan dampak yang nyata. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam merancang advokasi gender dalam kebidanan:

a. Analisis Situasi Gender

- 1) Melakukan analisis mendalam mengenai isu gender yang spesifik dalam layanan kebidanan.
- 2) Mengidentifikasi hambatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dihadapi perempuan.
- 3) Mengkaji data dan fakta aktual tentang status kesehatan reproduksi perempuan di wilayah target advokasi.

b. Menentukan Tujuan Advokasi

- 1) Menentukan tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dan realistis.

- 2) Misalnya, meningkatkan akses perempuan terhadap layanan antenatal, memperbaiki kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, atau mengurangi stigma sosial tentang kontrasepsi.
- c. Mengidentifikasi Target dan Mitra Advokasi
 - 1) Menentukan sasaran advokasi, seperti pengambil kebijakan, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah, maupun organisasi masyarakat sipil.
 - 2) Menjalin kerjasama dengan kelompok atau individu yang memiliki pengaruh besar dalam mendukung kesetaraan gender.
- d. Menyusun Pesan Advokasi
 - 1) Membuat pesan yang jelas, sederhana, kuat, dan mudah dipahami.
 - 2) Pesan advokasi harus mencerminkan isu gender secara sensitif, mengedepankan manfaat dari kesetaraan gender dalam layanan kebidanan.
- e. Menentukan Strategi dan Media Advokasi
 - 1) Memilih strategi advokasi yang tepat, seperti kampanye publik, audiensi kebijakan, edukasi masyarakat, atau dialog dengan tokoh agama dan adat.
 - 2) Menggunakan media efektif seperti media sosial, radio komunitas, brosur edukasi, serta pelibatan langsung komunitas dalam forum diskusi.
- f. Implementasi Kegiatan Advokasi
 - 1) Melaksanakan kegiatan advokasi sesuai perencanaan, dengan keterlibatan penuh komunitas lokal, tenaga kesehatan, serta pemangku kepentingan.
 - 2) Menjalankan kegiatan secara konsisten, teratur, serta mampu menangani dinamika yang muncul dalam proses advokasi.
- g. Evaluasi dan Pemantauan Advokasi
 - 1) Melakukan pemantauan secara berkala untuk mengukur dampak advokasi.
 - 2) Mengevaluasi keberhasilan berdasarkan perubahan kebijakan, perubahan perilaku, serta peningkatan kualitas layanan kebidanan yang responsif gender.

3. Kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi isu gender dalam kebidanan.

Kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan strategis yang sangat esensial untuk mengatasi isu gender dalam pelayanan kebidanan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antar berbagai pihak yang berasal dari berbagai latar belakang sektor, baik sektor kesehatan, pendidikan, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, hingga tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Kompleksitas permasalahan gender dalam kebidanan tidak memungkinkan diselesaikan oleh sektor kesehatan semata, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi krusial untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan efektif.

Dalam pelaksanaannya, kolaborasi lintas sektor dimulai dengan pembentukan kesepakatan bersama mengenai pentingnya mengatasi isu gender yang mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Langkah awal ini umumnya berupa dialog antar pemangku kepentingan, yang bertujuan membangun pemahaman bersama tentang urgensi dan dampak negatif ketidaksetaraan gender terhadap pelayanan kebidanan. Melalui proses dialog ini, berbagai pihak dapat saling berbagi perspektif, menyamakan persepsi, serta menemukan titik temu mengenai peran masing-masing dalam mendorong kesetaraan gender.

Salah satu contoh nyata kolaborasi lintas sektor dalam isu gender di bidang kebidanan adalah kemitraan dengan sektor pendidikan. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi dan informasi mengenai kesetaraan gender serta kesehatan reproduksi sejak usia dini. Sektor pendidikan memiliki peran penting karena mampu menjangkau generasi muda, di mana nilai-nilai gender masih bisa dibentuk dan dikembangkan. Melalui kerja sama ini, sekolah-sekolah di berbagai tingkat pendidikan mulai mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi yang responsif gender ke dalam kurikulum mereka. Tujuannya adalah agar anak-anak, remaja, serta masyarakat pada umumnya memahami pentingnya kesetaraan gender dan mampu menolak stigma atau prasangka gender yang selama ini merugikan perempuan dalam mengakses layanan kebidanan.

Selain sektor pendidikan, kolaborasi lintas sektor juga mencakup kemitraan yang erat dengan sektor pemerintah atau pembuat kebijakan. Dalam hal ini, lembaga pemerintah yang terlibat, seperti dinas kesehatan, kementerian pemberdayaan perempuan, dan lembaga legislatif, berperan sangat strategis dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di layanan kesehatan reproduksi. Kolaborasi ini dilakukan melalui audiensi rutin, konsultasi publik, maupun penyusunan kebijakan bersama yang bertujuan menghapus praktik diskriminatif, mengurangi hambatan akses perempuan ke layanan kesehatan reproduksi, serta mengembangkan berbagai kebijakan yang responsif gender. Dengan keterlibatan aktif pemerintah, kebijakan publik dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan perempuan, sehingga menciptakan perubahan struktural yang signifikan dalam sistem pelayanan kebidanan.

Lebih lanjut lagi, kolaborasi lintas sektor yang tak kalah penting melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO) dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Organisasi ini seringkali memiliki kedekatan langsung dengan komunitas dan mampu mengadvokasi hak perempuan secara efektif di tingkat akar rumput. Kolaborasi dengan NGO atau CSO memungkinkan adanya mobilisasi komunitas yang lebih luas, edukasi masyarakat yang mendalam, serta penyampaian pesan-

pesan advokasi yang efektif tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pelayanan kebidanan. Dengan melibatkan NGO dan CSO, upaya advokasi menjadi lebih partisipatif, di mana suara perempuan di komunitas dapat secara aktif didengar dan menjadi pusat perhatian dalam proses perubahan kebijakan atau praktik pelayanan kesehatan.

Tidak kalah strategis adalah kolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh adat. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik serta perilaku masyarakat. Dengan melibatkan mereka dalam dialog terbuka serta edukasi yang berkelanjutan tentang isu-isu gender dalam kebidanan, maka pesan-pesan advokasi menjadi lebih diterima, kredibel, dan sesuai dengan norma setempat. Dalam banyak kasus, pendekatan ini berhasil mengurangi resistensi sosial terhadap pelayanan kebidanan yang responsif gender, sehingga perempuan lebih bebas mengakses layanan kesehatan reproduksi tanpa stigma atau tekanan sosial.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga mencakup peran penting media massa. Media berperan strategis dalam menyebarkan informasi mengenai isu gender dalam kebidanan kepada masyarakat luas. Melalui berbagai kampanye sosial, liputan khusus, talkshow, hingga publikasi digital, media mampu mempengaruhi opini publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menggalang dukungan luas terhadap isu kesetaraan gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan kolaborasi ini, informasi penting yang tadinya terbatas dalam lingkup kecil menjadi lebih luas jangkauannya dan lebih mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor juga melibatkan institusi kesehatan serta perguruan tinggi yang memiliki peran krusial dalam penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam isu-isu gender. Kerjasama ini mencakup pelaksanaan pelatihan intensif mengenai perspektif gender bagi tenaga kesehatan, integrasi materi responsif gender dalam pendidikan kebidanan, serta penelitian bersama tentang berbagai aspek kesehatan reproduksi dan gender. Dengan demikian, tenaga kesehatan seperti bidan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan yang peka gender, ramah, serta mampu memenuhi kebutuhan perempuan secara efektif.

Melalui berbagai bentuk kolaborasi lintas sektor ini, muncul berbagai dampak positif nyata seperti meningkatnya pemahaman publik tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kebidanan, terciptanya kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan responsif gender, serta meningkatnya keterlibatan laki-laki dalam mendukung hak reproduksi perempuan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor

ini mampu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perempuan dalam mengambil keputusan kesehatan reproduksi secara mandiri, serta menurunkan stigma dan diskriminasi gender dalam masyarakat secara luas.

Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi isu gender dalam kebidanan bukan hanya menjadi pendekatan efektif secara praktis, tetapi juga merupakan strategi penting dalam menciptakan perubahan sosial yang mendalam, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender bagi semua perempuan.

E. Latihan Soal

Soal 1

Ibu Sinta, usia 25 tahun, ingin menggunakan kontrasepsi IUD tetapi tidak mendapat persetujuan dari suaminya karena dianggap tabu dalam norma keluarga besar mereka. Bidan perlu menerapkan konsep gender dalam menghadapi kasus ini. Apa yang harus dilakukan bidan?

- A. Mengikuti keputusan suami tanpa diskusi
- B. Mengarahkan ibu menggunakan kontrasepsi lain tanpa konsultasi
- C. Melakukan konseling bersama pasangan untuk memberi pemahaman mengenai gender dan hak reproduksi
- D. Memaksa ibu menggunakan kontrasepsi IUD secara diam-diam
- E. Menyarankan ibu menunda penggunaan kontrasepsi hingga disetujui keluarga besar

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Konseling bersama pasangan efektif dalam mengedukasi suami tentang konsep gender, yaitu kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan reproduksi. Ini membantu mengatasi hambatan sosial budaya serta mendukung keputusan reproduksi yang adil dan informatif bagi perempuan.

Soal 2

Seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi hamil tanpa menikah. Ia merasa takut dan malu karena mengalami stigma negatif dari masyarakat dan keluarga. Sebagai bidan yang responsif gender, langkah apa yang paling tepat?

- A. Menyuruh perempuan tersebut untuk pulang dan menyelesaikan masalah keluarganya terlebih dahulu

- B. Memberi pelayanan seadanya karena status sosialnya
- C. Memberikan konseling yang empati, dukungan psikologis, serta menjamin privasinya
- D. Menyarankan perempuan tersebut segera menikah untuk menghindari stigma
- E. Meminta perempuan tersebut datang dengan keluarganya agar mudah menyelesaikan masalahnya

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pelayanan kebidanan yang responsif gender menekankan empati, penghormatan privasi, dan memberikan dukungan psikologis tanpa diskriminasi. Langkah ini membantu mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perempuan dalam situasi sulit.

Soal 3

Di sebuah desa terpencil, para perempuan tidak mendapatkan pelayanan antenatal karena harus mendapat izin dari suami atau kepala keluarga untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Sebagai bidan yang menerapkan pendekatan responsif gender, upaya apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini?

- A. Menunggu perempuan datang sendiri jika mereka benar-benar membutuhkan
- B. Mengabaikan permasalahan tersebut karena menghormati norma budaya lokal
- C. Mengadakan diskusi komunitas yang melibatkan laki-laki untuk edukasi mengenai pentingnya pelayanan antenatal
- D. Menyediakan layanan kesehatan tanpa melibatkan laki-laki sama sekali
- E. Menginstruksikan perempuan secara tegas untuk mengabaikan izin dari keluarga

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Diskusi komunitas yang melibatkan laki-laki adalah bentuk pendekatan responsif gender. Pendekatan ini membantu mengubah norma sosial dan mendorong partisipasi laki-laki dalam mendukung kesehatan reproduksi perempuan.

Soal 4

Seorang bidan tanpa sadar lebih sering memberi perhatian dan layanan lebih baik kepada ibu hamil yang datang bersama suaminya daripada yang datang sendiri atau tanpa pasangan. Dalam konteks diskriminasi gender, hal apa yang harus diperbaiki oleh bidan tersebut?

- A. Mendorong semua perempuan harus datang bersama suami
- B. Mengurangi perhatian pada ibu yang datang bersama pasangan

- C. Memberikan pelatihan sensitif gender untuk mengenali dan memperbaiki bias pelayanan
- D. Tidak melakukan perubahan karena dianggap wajar
- E. Memisahkan pelayanan khusus untuk ibu yang datang tanpa pasangan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pelatihan sensitif gender diperlukan untuk membantu tenaga kesehatan mengenali bias-bias yang tidak sadar, sehingga pelayanan yang diberikan adil, setara, dan tidak diskriminatif terhadap perempuan yang datang sendiri.

Soal 5

Di suatu wilayah ditemukan angka kehamilan berisiko tinggi yang tinggi, karena perempuan tidak menggunakan kontrasepsi akibat minimnya informasi dan pendidikan. Strategi advokasi gender apa yang paling tepat dilakukan bidan dalam situasi ini?

- A. Hanya melibatkan perempuan dalam pemberian informasi kontrasepsi
- B. Melakukan edukasi intensif hanya di klinik kebidanan
- C. Mengadvokasi kebijakan kesehatan setempat untuk mendukung pendidikan seksual yang responsif gender bagi perempuan dan laki-laki
- D. Menghindari pembahasan kontrasepsi agar tidak bertentangan dengan nilai lokal
- E. Meningkatkan pelayanan kontrasepsi tanpa edukasi terlebih dahulu

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Advokasi kebijakan yang responsif gender bertujuan untuk memberikan edukasi yang seimbang bagi perempuan dan laki-laki sehingga dapat mengatasi minimnya informasi serta mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan dan komplikasi yang mungkin terjadi.

F. Rangkuman Materi

Pemahaman konsep gender dalam kebidanan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Gender yang merupakan konstruksi sosial, berbeda dengan seks biologis yang bersifat anatomis dan fisiologis. Peran gender secara signifikan memengaruhi kehidupan sosial perempuan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, serta tanggung jawab domestik. Selain itu, gender juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, khususnya dalam hal akses pelayanan kesehatan,

pengambilan keputusan keluarga tentang kontrasepsi, perencanaan kehamilan, serta keterlibatan laki-laki dalam isu reproduksi.

Isu-isu gender dalam kebidanan, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan reproduksi, hambatan sosial budaya, serta diskriminasi gender, menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang optimal. Berbagai hambatan seperti dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya pendidikan seksual, hingga minimnya infrastruktur kesehatan, semakin memperbesar risiko kesehatan reproduksi perempuan.

Pendekatan responsif gender menjadi solusi penting yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Pendekatan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip non-diskriminasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, kesetaraan akses, integrasi perspektif gender, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan secara menyeluruh. Komunikasi efektif berbasis gender juga menjadi keterampilan kunci bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk memberikan layanan yang sensitif, empati, menghormati privasi, serta mampu mengatasi isu-isu sensitif seperti kekerasan berbasis gender maupun stigma sosial.

Studi kasus implementasi pendekatan responsif gender menunjukkan bahwa intervensi berbasis gender di masyarakat dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran, keterlibatan, serta partisipasi aktif perempuan maupun laki-laki dalam pengambilan keputusan reproduksi. Strategi advokasi gender dalam kebidanan, termasuk melalui analisis situasi gender, penetapan tujuan yang jelas, kolaborasi lintas sektor dengan pendidikan, pemerintah, NGO, tokoh masyarakat, media, dan institusi kesehatan, menjadi langkah penting dalam menciptakan kebijakan dan praktik kesehatan reproduksi yang responsif gender.

Dengan demikian, integrasi perspektif gender dalam kebidanan tidak hanya penting dalam memperbaiki akses layanan kesehatan reproduksi, tetapi juga sangat strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan gender yang lebih luas. Upaya ini pada akhirnya akan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.

G. Glosarium

Advokasi berbasis gender:

Proses atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dan persepsi sosial agar lebih responsif terhadap kebutuhan, aspirasi, dan hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan.

Bias gender:

Kecenderungan atau sikap yang memihak salah satu jenis kelamin secara tidak adil, sering kali terjadi tanpa sadar, dan berdampak pada pelayanan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Diskriminasi gender:

Perlakuan yang berbeda dan merugikan berdasarkan jenis kelamin atau gender, yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta pelayanan kesehatan.

Empati dalam komunikasi gender:

Kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami perasaan dan kondisi perempuan secara mendalam, yang membantu menciptakan suasana pelayanan yang aman, nyaman, dan saling percaya.

Gender:

Konsep sosial yang mencakup peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dianggap sesuai oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Gender bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh budaya, norma sosial, serta proses sosialisasi.

Hak reproduksi:

Hak individu untuk menentukan keputusan secara bebas dan bertanggung jawab terkait jumlah, jarak, serta waktu kehamilan, termasuk akses informasi, metode kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi yang aman.

Kesetaraan gender:

Kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati hak, peluang, dan perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi dan kebidanan.

Konstruksi sosial:

Proses pembentukan norma, peran, dan harapan yang dilakukan masyarakat terhadap individu berdasarkan faktor-faktor sosial budaya, bukan biologis.

Pelayanan responsif gender:

Pelayanan kesehatan yang memperhatikan dan memenuhi kebutuhan spesifik perempuan serta sensitif terhadap isu gender, termasuk menghormati privasi, memberikan perlakuan non-diskriminatif, dan mendukung pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan:

Upaya untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan mandiri tentang tubuh, reproduksi, dan kehidupannya, melalui pendidikan, informasi, dan keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Perspektif gender:

Cara pandang yang mempertimbangkan pengaruh konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan reproduksi, yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan layanan kesehatan yang adil.

Seks biologis:

Kategori yang ditentukan secara anatomi dan fisiologi sejak lahir, meliputi kromosom, hormon, serta organ reproduksi yang digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan secara biologis.

Sensitivitas gender:

Kesadaran dan pemahaman mengenai perbedaan pengalaman serta kebutuhan antara laki-laki dan perempuan yang memungkinkan pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, adil, dan setara.

Stigma sosial:

Pandangan negatif atau label negatif yang diberikan masyarakat terhadap individu atau kelompok yang menggunakan layanan kesehatan reproduksi tertentu, yang mengakibatkan hambatan dalam mengakses pelayanan tersebut.

Strategi advokasi gender:

Langkah-langkah terstruktur dan sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, persepsi, dan praktik sosial guna menciptakan kesetaraan gender dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi.

Teknik komunikasi efektif berbasis gender:

Pendekatan komunikasi yang peka terhadap perbedaan pengalaman, budaya, dan norma sosial yang mempengaruhi persepsi perempuan terhadap kesehatan reproduksi, dengan tujuan menciptakan pelayanan yang lebih inklusif, terbuka, dan partisipatif.

Kolaborasi lintas sektor:

Kerja sama antar berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintah, organisasi masyarakat, media massa, tokoh agama, dan kesehatan, untuk menciptakan perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kebidanan.

H. Daftar Pustaka

- Agustina, S., & Wahyuni, S. (2021). Konstruksi sosial gender dalam pelayanan kebidanan. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 6(1), 20-29. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyy>
- Dahlui, M., Azahar, N., & Oche, O. M. (2021). Gender equity and reproductive health: Issues, challenges, and future directions. *Global Public Health*, 16(7), 1055-1069. <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1820541>
- Fitria, E. N., & Wulandari, N. (2020). Peran bidan dalam advokasi gender untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(2), 95-103. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyy>
- García-Moreno, C., & Amin, A. (2019). Violence against women and gender-based discrimination in health services: A global perspective. *Health and Human Rights*, 21(2), 157-166.
- Handayani, L., & Yanti, D. (2021). Komunikasi terapeutik berbasis gender dalam pelayanan kebidanan. *Jurnal Kebidanan Komunitas*, 4(2), 145-153. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyy>

- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Panduan pelayanan kesehatan reproduksi yang responsif gender. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI.
- Maryati, S., Setyawati, D. L., & Oktarina, L. (2020). Pendekatan responsif gender dalam peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil. *Jurnal Penelitian Kebidanan dan Kesehatan*, 7(2), 120-130. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyy>
- Ningsih, E. S., & Wijaya, E. (2022). Implementasi pendekatan sensitif gender dalam pelayanan antenatal untuk menurunkan angka kematian ibu. *Indonesian Journal of Midwifery Research*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyy>
- Pusat Kajian Gender dan Anak (2021). Modul pelatihan gender dan kesehatan reproduksi untuk tenaga kesehatan. Universitas Indonesia.
- Rokhmah, D., & Wijayanti, T. (2022). Strategi advokasi berbasis gender untuk meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 45-54. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyy>
- Sari, N., & Rahman, A. (2020). Ketimpangan gender dalam akses layanan kesehatan reproduksi di Indonesia: Sebuah tinjauan sosiokultural. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(1), 35-42. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyy>
- UN Women. (2021). Gender equality in sexual, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health: A comprehensive review. UN Women Publication.
- WHO. (2020). Gender and health: Fact sheet. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gender>
- Yuliani, E., & Setyawati, D. A. (2021). Kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi isu gender pada pelayanan kesehatan reproduksi. *Indonesian Journal of Community Health Nursing*, 5(2), 78-86. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyy>

BAB 7

KEILMUAN KEBIDANAN, DEFINISI NORMAL CHILBIRTH (KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS), STANDARD ICM

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif tentang keilmuan kebidanan dengan mengacu pada definisi childbirth normal dan standar praktik kebidanan yang ditetapkan oleh ICM.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu:
- Menjelaskan konsep dasar keilmuan kebidanan dan lingkup praktiknya.
- Menguraikan definisi dan karakteristik childbirth normal (kehamilan, persalinan, dan nifas).
- Memahami dan mengimplementasikan standar praktik kebidanan menurut ICM.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan sejarah dan perkembangan keilmuan kebidanan.
- Menjelaskan peran bidan dalam menjaga proses alami selama kehamilan, persalinan, dan nifas.
- Mengidentifikasi kriteria kehamilan normal, tanda-tanda persalinan normal, serta tanda-tanda masa nifas normal.
- Menganalisis pentingnya menghindari intervensi medis yang tidak perlu dalam childbirth normal.
- Menjelaskan elemen-elemen utama dalam standar praktik kebidanan menurut ICM, termasuk aspek etik, kompetensi, keselamatan, dan kualitas pelayanan.
- Mengaplikasikan standar ICM dalam simulasi praktik klinik dan kasus nyata.

Pendahuluan

Kebidanan adalah disiplin ilmu kesehatan yang secara khusus berfokus pada perawatan wanita selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Keilmuan kebidanan menekankan pendekatan holistik, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Profesi bidan memiliki tanggung jawab penting

untuk mendukung dan memfasilitasi proses alami dari kehamilan hingga nifas dengan menerapkan prinsip profesionalisme sesuai standar internasional, khususnya yang ditetapkan oleh International Confederation of Midwives (ICM).

Definisi childbirth normal mencakup proses kehamilan, persalinan, dan nifas yang berlangsung tanpa komplikasi yang signifikan atau tanpa intervensi medis yang tidak perlu. Pemahaman yang jelas tentang proses normal ini penting untuk memastikan bahwa intervensi medis dilakukan hanya jika diperlukan demi keselamatan ibu dan bayi. ICM telah menetapkan standar yang jelas untuk praktik kebidanan guna menjamin kualitas layanan yang optimal secara global.

Uraian Materi

A. Keilmuan Kebidanan

Keilmuan kebidanan merupakan sebuah disiplin ilmu kesehatan yang memiliki cakupan luas, terfokus secara khusus pada perawatan perempuan selama masa reproduksi, mencakup kehamilan, persalinan, serta masa nifas, termasuk juga perawatan bayi baru lahir. Dalam cakupan ini, kebidanan secara fundamental tidak hanya menitikberatkan pada aspek biologis atau fisiologis semata, melainkan juga secara signifikan memperhatikan aspek psikologis, sosial, emosional, serta budaya yang melekat pada perempuan dalam konteks kesehatan reproduksi mereka.

Secara fisiologis, kebidanan mengacu pada ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh perempuan beradaptasi dan berubah selama proses kehamilan, persalinan, hingga masa pemulihan pasca melahirkan. Proses ini mencakup pemahaman tentang anatomi dan fisiologi tubuh wanita, perubahan hormonal, perkembangan janin, mekanisme persalinan, serta dinamika masa nifas hingga proses menyusui. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek fisiologis memungkinkan bidan untuk memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif dan tepat, sehingga perempuan bisa menjalani periode penting ini secara alami, aman, dan nyaman.

Sementara dari sudut pandang psikologis, kebidanan mengakui bahwa kehamilan dan persalinan adalah momen yang penuh dengan tantangan emosional bagi seorang perempuan. Perubahan suasana hati, kecemasan, ketakutan, hingga perasaan bahagia bercampur menjadi satu. Bidan, melalui keilmuan ini, diharapkan mampu memahami berbagai kondisi psikologis tersebut dan memberikan dukungan psikososial yang tepat sehingga perempuan merasa aman, tenang, dan mampu menghadapi setiap tahapan dengan percaya diri. Bidan dituntut mampu mengedukasi dan memberikan konseling yang berbasis empati, sehingga mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan ibu selama proses kehamilan, persalinan, maupun masa nifas.

Lebih jauh lagi, keilmuan kebidanan juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek sosial. Seorang perempuan tidak menjalani proses kehamilan dan persalinan dalam isolasi, melainkan selalu dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk keluarga, komunitas, dan masyarakat secara luas. Aspek sosial ini meliputi bagaimana interaksi sosial, dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar, serta struktur sosial budaya mempengaruhi pengalaman perempuan dalam menjalani proses ini. Kebidanan dengan demikian melibatkan keterampilan dalam membangun komunikasi efektif dan mampu bekerja sama secara harmonis dengan keluarga serta masyarakat demi mendukung kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh.

Selain itu, budaya memiliki posisi sentral dalam keilmuan kebidanan. Bidan dituntut memahami bahwa setiap masyarakat memiliki kepercayaan, nilai, dan

praktik yang berbeda-beda seputar kehamilan dan persalinan. Keilmuan kebidanan secara kritis mengapresiasi perbedaan budaya ini, memahami bahwa praktik kesehatan yang efektif adalah yang menghormati nilai-nilai budaya setempat tanpa mengorbankan standar kesehatan modern. Dengan demikian, bidan harus mampu menjembatani kesenjangan antara praktik budaya lokal dengan standar praktik kebidanan berbasis bukti (evidence-based midwifery practice).

Sejarah perkembangan kebidanan sendiri mencatat bagaimana profesi ini telah mengalami evolusi yang signifikan. Pada masa lampau, kebidanan banyak dipandang sebagai sebuah profesi yang lebih berbasis pengalaman tradisional, diturunkan secara turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan, kebidanan telah bertransformasi menjadi profesi yang profesional, terstruktur, dan berbasis bukti ilmiah. Kini, kebidanan tidak hanya menjadi sebuah profesi yang diakui secara luas tetapi juga menjadi sebuah disiplin ilmu yang terus berkembang melalui riset ilmiah, inovasi teknologi medis, serta kolaborasi antar disiplin ilmu lainnya seperti kedokteran, keperawatan, psikologi, sosiologi, hingga antropologi kesehatan.

Dengan demikian, keilmuan kebidanan tidak hanya sekadar ilmu praktis tentang membantu persalinan, tetapi merupakan ilmu yang komprehensif, multidimensional, serta humanis, yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat menjalani setiap tahap kehidupan reproduksi mereka dengan aman, sehat, dan bermartabat. Di era modern ini, kebidanan telah berkembang menjadi ilmu yang mengedepankan pendekatan holistik, melibatkan pemberdayaan perempuan, serta menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam menentukan keputusan mengenai kesehatan dirinya sendiri, keluarganya, maupun komunitasnya.

B. Definisi Normal Childbirth

Istilah normal childbirth atau persalinan normal merujuk pada keseluruhan proses alamiah yang dialami perempuan mulai dari periode kehamilan, persalinan hingga masa pemulihan setelah melahirkan (masa nifas). Proses ini dikategorikan sebagai "normal" jika seluruh tahapan tersebut berjalan alami, tanpa adanya komplikasi atau intervensi medis signifikan yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan bayinya. Penjelasan lebih rinci mengenai definisi persalinan normal dapat dipahami melalui penjabaran tiga tahap utama berikut ini:

1. Kehamilan Normal

Kehamilan normal merupakan tahapan awal dari proses childbirth normal. Dalam konteks medis, kehamilan dianggap normal apabila berlangsung antara 37 hingga 42 minggu, dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir (HPMT). Rentang waktu tersebut menunjukkan periode optimal untuk janin mencapai

tingkat perkembangan dan maturasi organ-organ tubuh yang memadai sehingga siap dilahirkan secara alami.

Tanda-tanda kehamilan normal meliputi berbagai indikator yang menunjukkan kondisi ibu dan janin dalam keadaan sehat. Pertumbuhan janin yang baik tercermin melalui hasil pemeriksaan antenatal yang rutin, seperti tinggi fundus uteri (TFU) yang sesuai dengan usia kehamilan, detak jantung janin (DJJ) dalam batas normal, serta hasil ultrasonografi yang menunjukkan kondisi anatomi dan perkembangan janin tanpa kelainan signifikan. Selain itu, ibu juga tidak mengalami kondisi medis berat seperti preeklampsia, diabetes gestasional, perdarahan antepartum, atau gangguan kesehatan lainnya yang dapat mengganggu perkembangan janin maupun kesehatan ibu secara keseluruhan.

Dalam kehamilan normal, ibu secara rutin mengikuti pemeriksaan antenatal minimal 4 kali selama periode kehamilan, yakni minimal satu kali pada trimester pertama, minimal satu kali pada trimester kedua, dan minimal dua kali pada trimester ketiga. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin tetap optimal hingga tiba waktunya persalinan.

2. Persalinan Normal

Persalinan normal merupakan tahapan kedua dalam childbirth normal, ditandai dengan dimulainya proses persalinan secara spontan atau alami tanpa bantuan induksi kimiawi atau operasi caesar. Persalinan ini diawali dengan kontraksi uterus yang efektif, teratur, dan semakin intens, sehingga menyebabkan perubahan pada serviks berupa penipisan (efasemen) dan pembukaan (dilatasi) sampai pembukaan lengkap (10 cm).

Proses persalinan normal meliputi tiga kala, yakni kala I (fase pembukaan), kala II (fase pengeluaran bayi), dan kala III (fase pengeluaran plasenta). Seluruh tahapan ini berlangsung dalam waktu yang dianggap wajar, yakni kala I sekitar 12-18 jam untuk primipara (persalinan pertama kali) dan 8-12 jam untuk multipara (persalinan kedua kali atau lebih). Kala II berlangsung sekitar 1 jam untuk primipara dan sekitar 30 menit untuk multipara. Kala III berlangsung tidak lebih dari 30 menit.

Dalam persalinan normal, proses kelahiran bayi berlangsung tanpa tindakan invasif seperti penggunaan alat bantu ekstraksi vakum, forceps, episiotomi rutin, atau intervensi bedah lainnya. Jika terjadi episiotomi (pemotongan jaringan perineum), tindakan ini hanya dilakukan atas indikasi yang kuat untuk mencegah robekan yang lebih serius. Hasil akhir dari persalinan normal adalah kondisi ibu dan bayi yang sehat, dengan skor Apgar bayi normal (minimal 7-10 pada menit pertama dan kelima pasca lahir).

3. Masa Nifas Normal

Setelah melewati proses persalinan, ibu memasuki periode nifas, yaitu masa pemulihan pasca melahirkan yang berlangsung hingga 6 minggu (sekitar 42 hari).

Masa nifas dianggap normal jika selama periode ini ibu mengalami pemulihan fisik yang baik, ditandai dengan involusi uteri (pengecilan rahim) yang berlangsung normal hingga rahim kembali ke ukuran sebelum hamil.

Pada periode ini, ibu juga mengalami keluarnya lokia (cairan nifas) dalam jumlah, warna, dan bau yang wajar. Proses nifas normal juga ditandai dengan fungsi laktasi yang lancar, yang berarti ibu mampu memproduksi ASI dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi dan proses menyusui berlangsung tanpa hambatan berarti seperti mastitis atau gangguan menyusui lainnya.

Selain aspek fisik, masa nifas juga melibatkan adaptasi psikologis ibu terhadap perannya sebagai ibu baru. Pada masa ini, ibu bisa mengalami berbagai kondisi emosional, mulai dari rasa bahagia hingga kelelahan fisik maupun emosional, tetapi tidak sampai pada kondisi depresi postpartum yang berat. Dalam kondisi normal, ibu mampu beradaptasi dengan baik, mendapatkan dukungan keluarga, serta memiliki rasa percaya diri dalam merawat bayi.

C. Standard ICM

International Confederation of Midwives (ICM) atau Konfederasi Bidan Internasional merupakan organisasi global yang secara khusus bertanggung jawab untuk menetapkan standar internasional dalam praktik kebidanan. Standar yang dikembangkan oleh ICM bertujuan untuk menciptakan pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi, aman, berbasis bukti ilmiah, serta menghormati hak-hak perempuan. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk memastikan bahwa di mana pun seorang bidan bekerja—baik di negara maju maupun berkembang—mereka mampu memberikan pelayanan yang konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip praktik terbaik yang berlaku secara global.

Standar internasional yang ditetapkan oleh ICM ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu kompetensi inti, etika profesional, pendidikan berkelanjutan, serta prinsip keselamatan dan kualitas layanan. Berikut adalah uraian detail dari aspek-aspek tersebut:

1. Memastikan praktik yang berbasis bukti ilmiah terbaru.

Praktik kebidanan berbasis bukti ilmiah merupakan inti dari standar ICM. Dalam konteks ini, bidan dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya dengan informasi yang didasarkan pada penelitian terbaru serta rekomendasi praktik terbaik yang sudah tervalidasi secara ilmiah. Konsep Evidence-Based Midwifery (EBM) menekankan bahwa semua keputusan klinis dan tindakan yang diambil oleh bidan harus mengacu pada penelitian ilmiah yang terbaru dan paling relevan, bukan sekadar tradisi, kebiasaan, atau pengalaman semata. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan benar-benar terbukti aman, efektif, efisien, dan memberikan hasil terbaik bagi ibu dan bayi.

2. Menghormati hak asasi manusia dan hak reproduksi perempuan.

Standar ICM sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak reproduksi perempuan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa bidan wajib memberikan asuhan dengan menghargai otonomi perempuan, termasuk menghormati hak mereka untuk membuat keputusan secara sadar tentang perawatan kesehatan reproduksinya. Bidan bertanggung jawab memastikan bahwa perempuan menerima informasi yang lengkap, jelas, dan akurat tentang kondisi kesehatan mereka, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Ini adalah prinsip dasar informed consent, di mana perempuan diberi kebebasan penuh untuk memutuskan berbagai tindakan medis atau non-medis terkait dirinya sendiri, tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Selain itu, penghormatan hak reproduksi perempuan juga mencakup perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang mungkin terjadi dalam pelayanan kebidanan. ICM menekankan bahwa setiap perempuan harus diperlakukan secara bermartabat, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, ekonomi, ras, agama, ataupun status lainnya.

3. Menjaga keselamatan pasien dengan menerapkan standar kompetensi klinis yang ketat.

Keselamatan pasien merupakan aspek kritis dalam pelayanan kebidanan, dan ICM menempatkan perhatian besar terhadap hal ini. Dalam rangka menjaga keselamatan pasien, ICM menetapkan standar kompetensi klinis yang ketat, yang mencakup berbagai keterampilan praktis yang harus dimiliki bidan seperti melakukan pemeriksaan antenatal yang akurat, mengenali tanda-tanda bahaya pada kehamilan dan persalinan, serta memberikan intervensi awal yang tepat dalam situasi darurat.

Standar ini juga mengharuskan bidan mampu mengenali kapan pasien perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan pertolongan pertama secara tepat dalam situasi darurat. Dengan demikian, standar kompetensi klinis ini memastikan bahwa risiko komplikasi dan kejadian tidak diinginkan bisa diminimalisir, serta meningkatkan peluang ibu dan bayi memperoleh hasil kesehatan yang optimal.

4. Mengedepankan komunikasi efektif, kolaborasi, serta pengambilan keputusan klinis yang tepat.

Aspek komunikasi yang efektif merupakan salah satu komponen penting dalam standar ICM, yang menegaskan bahwa praktik kebidanan tidak hanya bergantung pada keterampilan klinis, namun juga pada kemampuan interpersonal dan komunikasi yang baik. Komunikasi efektif ini mencakup kemampuan bidan dalam memberikan edukasi, konseling, serta informasi kesehatan dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien, keluarga, maupun komunitas.

Selain itu, kolaborasi juga merupakan prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh seorang bidan. Bidan dituntut untuk mampu bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, seperti dokter, perawat, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya, untuk memberikan pelayanan yang holistik dan berkesinambungan. Kolaborasi ini memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan layanan yang komprehensif, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan mereka.

Pengambilan keputusan klinis yang tepat juga merupakan bagian penting dari standar ini, yang menekankan bahwa seorang bidan harus mampu menganalisis situasi klinis secara kritis dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, profesional, serta sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Keputusan klinis yang baik didasarkan pada informasi lengkap, evaluasi risiko manfaat, serta kondisi individual dari masing-masing pasien.

D. Latihan Soal

Soal 1

Seorang ibu berusia 27 tahun, hamil pertama, datang ke bidan dengan usia kehamilan 38 minggu. Ibu terlihat cemas dan sering bertanya tentang kemungkinan rasa sakit saat melahirkan. Ia tampak kurang percaya diri menghadapi persalinan. Tindakan paling tepat yang dapat dilakukan bidan terkait kondisi ini adalah:

- A. Memberikan informasi mengenai metode persalinan tanpa nyeri
- B. Merujuk ibu ke rumah sakit untuk induksi persalinan
- C. Menyarankan ibu mempersiapkan operasi caesar
- D. Melakukan observasi klinis tanpa intervensi psikologis
- E. Memberikan konseling dukungan psikososial berbasis empati

Kunci: E

Rasional:

Keilmuan kebidanan menekankan pentingnya dukungan psikososial dan empati dalam mengatasi kecemasan ibu hamil. Bidan harus membantu ibu mengurangi rasa takut dan meningkatkan rasa percaya diri melalui konseling psikologis yang empatik. Opsi lain (induksi, operasi caesar) tidak tepat karena kondisi fisik ibu normal.

Soal 2

Seorang perempuan usia 30 tahun hamil 40 minggu datang ke klinik bersalin dalam kondisi stabil. Pemeriksaan fisik menunjukkan pembukaan serviks 6 cm, kontraksi teratur dan spontan sejak 4 jam terakhir, serta kondisi janin baik (DJJ

normal). Menurut definisi normal childbirth, tindakan apakah yang paling sesuai dilakukan bidan dalam situasi ini?

- A. Memberikan induksi oksitosin agar persalinan cepat selesai
- B. Melakukan operasi caesar untuk mencegah komplikasi
- C. Mendampingi proses persalinan secara alami dengan pemantauan teratur
- D. Segera melakukan episiotomi rutin
- E. Menginstruksikan ibu berbaring terlentang hingga bayi lahir

Kunci: C

Rasional:

Persalinan normal adalah proses alami tanpa intervensi signifikan seperti induksi atau operasi caesar. Tindakan yang tepat adalah mendampingi dan memantau persalinan secara alami, memastikan prosesnya berjalan aman, nyaman, serta meminimalkan intervensi.

Soal 3

Ibu berusia 26 tahun baru melahirkan anak pertamanya secara normal 2 minggu lalu. Ibu mengeluhkan sedikit nyeri ringan di perut bawah, lokia merah kecoklatan, payudara terasa penuh, dan sedang beradaptasi dengan menyusui. Berdasarkan definisi nifas normal, penanganan yang paling tepat oleh bidan adalah:

- A. Memberikan antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi
- B. Menjelaskan bahwa kondisi ini normal dan memberikan edukasi tentang teknik menyusui yang benar
- C. Segera merujuk ibu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut
- D. Memberikan obat penahan rasa sakit dosis tinggi
- E. Melakukan kuretase untuk membersihkan sisa lokia

Kunci: B

Rasional:

Gejala yang dialami ibu adalah bagian dari adaptasi normal pada masa nifas. Lokianya normal, payudara terasa penuh karena laktasi, dan nyeri ringan akibat involusi uterus adalah fisiologis. Yang dibutuhkan adalah edukasi dan dukungan menyusui, bukan intervensi medis.

Soal 4

Seorang bidan bertugas di sebuah desa yang masyarakatnya masih memiliki keyakinan budaya tertentu dalam proses persalinan. Banyak ibu menolak intervensi medis yang bertentangan dengan adat istiadat mereka. Sesuai dengan standard ICM, langkah yang paling tepat untuk diambil bidan adalah:

- A. Mengabaikan praktik budaya karena bertentangan dengan standar medis
- B. Menolak memberikan pelayanan jika masyarakat tetap berpegang pada praktik budaya
- C. Menghormati nilai budaya setempat dengan tetap memberikan edukasi berbasis bukti
- D. Menerapkan standar praktik medis secara tegas tanpa diskusi dengan komunitas
- E. Melaporkan masyarakat tersebut ke pihak berwenang karena menolak standar medis

Kunci: C

Rasional:

Standar ICM menegaskan pentingnya menghormati nilai budaya lokal sambil tetap memberikan edukasi kebidanan berbasis bukti (evidence-based practice). Bidan harus mampu menjembatani kesenjangan budaya tanpa mengorbankan standar keselamatan pasien.

Soal 5

Seorang perempuan usia 35 tahun sedang hamil 28 minggu, datang ke klinik kebidanan untuk konsultasi rutin. Ia menceritakan bahwa kehamilan ini menimbulkan ketegangan dalam rumah tangganya, karena kurangnya dukungan suami dan keluarga. Sesuai dengan konsep keilmuan kebidanan yang komprehensif, tindakan bidan yang paling tepat dalam situasi ini adalah:

- A. Merujuk pasien ke psikolog tanpa melakukan tindakan lebih lanjut
- B. Mengabaikan keluhan pasien karena di luar cakupan tugas bidan
- C. Menyarankan pasien untuk bertahan saja karena kondisi ini wajar terjadi
- D. Memberikan konseling keluarga, edukasi, serta melibatkan suami dalam perawatan kehamilan
- E. Melaporkan situasi ini ke petugas sosial karena termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga

Kunci: D

Rasional:

Dalam konsep kebidanan holistik, aspek sosial-psikologis mendapat perhatian khusus. Bidan harus membantu mengatasi konflik sosial dengan memberikan konseling keluarga, edukasi kesehatan, serta melibatkan anggota keluarga (terutama suami) dalam proses kehamilan, menciptakan dukungan sosial yang optimal.

E. Rangkuman Materi

Keilmuan kebidanan merupakan sebuah disiplin ilmu kesehatan yang bersifat multidimensional, komprehensif, dan humanis, mencakup aspek fisiologis, psikologis, sosial, emosional, serta budaya yang terkait erat dengan kesehatan reproduksi perempuan. Fokus utama kebidanan adalah memastikan perempuan dapat menjalani seluruh tahapan reproduksi mulai dari masa kehamilan, persalinan hingga masa nifas secara aman, nyaman, dan bermartabat. Keberhasilan dalam praktik kebidanan sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang anatomi, fisiologi, psikologi ibu, serta dukungan sosial budaya yang ada di sekitarnya.

Definisi normal childbirth menunjukkan bahwa proses kehamilan, persalinan, hingga masa nifas yang normal merupakan proses alami yang terjadi tanpa komplikasi serius atau intervensi medis yang signifikan. Proses ini mencakup tahapan kehamilan normal dengan pertumbuhan janin yang optimal, persalinan spontan yang berlangsung alami dan aman, serta masa nifas yang ditandai dengan pemulihan fisik dan psikologis yang lancar. Dalam setiap tahapan tersebut, bidan memiliki peran penting dalam mendampingi, memantau, serta memberikan edukasi yang tepat untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi.

Standard International Confederation of Midwives (ICM) menjadi landasan praktik kebidanan global yang menjamin pemberian pelayanan yang berkualitas tinggi, aman, serta menghormati hak-hak reproduksi perempuan. Standar ini menekankan pentingnya praktik berbasis bukti ilmiah terbaru, penghormatan terhadap hak asasi perempuan melalui informed consent, kompetensi klinis yang ketat untuk menjamin keselamatan pasien, serta komunikasi efektif dan kolaborasi antarprofesi dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan menerapkan standar ICM ini, bidan dapat memastikan asuhan yang diberikan tidak hanya profesional secara klinis tetapi juga manusiawi dan bermartabat.

Secara keseluruhan, keilmuan kebidanan yang holistik, definisi persalinan normal, serta penerapan standar ICM saling terkait dan mendukung dalam upaya mewujudkan pelayanan kebidanan yang unggul. Bidan sebagai tenaga profesional dituntut untuk mengintegrasikan seluruh aspek tersebut dalam praktiknya guna memberdayakan perempuan dalam menjalani kehidupan reproduksinya secara aman, sehat, serta penuh rasa percaya diri. Melalui pendekatan ini, bidan tidak hanya membantu memastikan kelahiran generasi yang sehat tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara luas.

F. Glosarium

Asuhan Kebidanan Komprehensif

Pendekatan pelayanan kebidanan yang menyeluruh, meliputi aspek fisiologis, psikologis, sosial, emosional, serta budaya, dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan bayi selama masa reproduksi.

Childbirth Normal

Keseluruhan proses persalinan yang berlangsung secara alami tanpa intervensi medis signifikan, mencakup kehamilan, persalinan, hingga masa pemulihan nifas yang berjalan normal dan sehat.

Evidence-Based Midwifery (EBM)

Praktik kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini dari hasil penelitian, bukan semata-mata berdasarkan tradisi atau kebiasaan, untuk menjamin kualitas layanan kebidanan yang aman dan efektif.

Efasemen

Proses penipisan leher rahim (serviks) sebagai persiapan sebelum terjadinya pembukaan penuh selama persalinan.

Episiotomi

Tindakan memotong jaringan perineum yang dilakukan berdasarkan indikasi klinis yang kuat untuk mempermudah kelahiran bayi serta mencegah robekan spontan yang lebih serius.

Informed Consent

Persetujuan yang diberikan pasien setelah menerima informasi lengkap, jelas, dan akurat tentang kondisi kesehatan serta tindakan medis yang akan dilakukan, tanpa adanya tekanan atau paksaan.

International Confederation of Midwives (ICM)

Organisasi internasional yang menetapkan standar global praktik kebidanan, meliputi kompetensi inti, etika, pendidikan berkelanjutan, serta keselamatan dan kualitas layanan kebidanan.

Involusi Uteri

Proses pengecilan rahim hingga kembali ke ukuran normal sebelum kehamilan, biasanya terjadi selama masa nifas (hingga 6 minggu setelah persalinan).

Kala Persalinan

Tahapan persalinan yang terdiri dari tiga tahap: kala I (pembukaan serviks), kala II (pengeluaran bayi), dan kala III (pengeluaran plasenta).

Kompetensi Klinis Kebidanan

Keterampilan klinis yang wajib dimiliki oleh bidan, termasuk pemeriksaan antenatal, pengenalan tanda bahaya, serta tindakan kegawatdaruratan dan intervensi klinis awal yang tepat.

Laktasi

Proses produksi dan sekresi air susu ibu (ASI), yang merupakan aspek penting dalam pemulihan pasca melahirkan dan kesehatan bayi.

Lokia

Cairan nifas yang keluar dari vagina setelah persalinan, terdiri dari darah, jaringan plasenta, dan sisa-sisa jaringan endometrium, yang biasanya berlangsung selama masa nifas.

Masa Nifas Normal

Periode pemulihan fisik dan psikologis ibu pasca persalinan yang berlangsung normal selama sekitar 6 minggu (42 hari), tanpa adanya komplikasi atau gangguan kesehatan serius.

Multidimensional (dalam kebidanan)

Sifat ilmu kebidanan yang tidak hanya mencakup satu aspek (fisiologis), melainkan berbagai dimensi lain seperti psikologis, sosial, emosional, serta budaya.

Multipara

Istilah untuk ibu yang telah melahirkan lebih dari satu kali, yang biasanya menjalani proses persalinan dengan durasi yang lebih singkat dibandingkan primipara.

Pendekatan Holistik

Cara pandang atau metode pelayanan kebidanan yang melihat pasien secara utuh, melibatkan aspek fisik, emosional, sosial, budaya, serta lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan klinis.

Primipara

Istilah untuk perempuan yang baru pertama kali melahirkan, biasanya memiliki proses persalinan yang relatif lebih lama dibandingkan dengan multipara.

Psikososial (dalam kebidanan)

Pendekatan kebidanan yang memperhatikan pengaruh faktor psikologis dan sosial terhadap kesehatan reproduksi perempuan, mencakup dukungan emosional dan interaksi sosial.

Skor Apgar

Sistem penilaian cepat terhadap kondisi fisik bayi baru lahir, dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah lahir, mencakup aspek detak jantung, pernapasan, tonus otot, refleks, serta warna kulit.

Standar ICM

Panduan internasional yang ditetapkan oleh International Confederation of Midwives untuk memastikan pelayanan kebidanan yang konsisten, aman, efektif, serta menghormati hak reproduksi perempuan di seluruh dunia.

G. Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & Farida, E. (2021). *Asuhan Kebidanan Berbasis Bukti: Konsep, Implementasi dan Tantangan Praktik Evidence-Based Midwifery*. Jakarta: Salemba Medika.
- Biroli, F., & Galvão, L. (2022). Women's autonomy, reproductive rights, and midwifery practices. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 67(3), 321-329. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13325>
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). Essential competencies for midwifery practice: 2021 Update. Retrieved from <https://www.internationalmidwives.org>
- Johnson, K. C., & Taylor, A. M. (2020). Midwives' communication and interpersonal skills: Essential competencies for effective midwifery practice. *Midwifery*, 82, 102617. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.102617>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi*

Kebiasaan Baru. Jakarta: Kemenkes RI.

Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). *Myles textbook for midwives* (17th ed.). Edinburgh: Elsevier.

Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2019). *Foundations of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing* (7th ed.). St. Louis: Elsevier Health Sciences.

Niven, C. (2022). Psychological care and emotional support during childbirth: The critical role of midwives. *Birth Issues in Perinatal Care*, 49(2), 157-163. <https://doi.org/10.1111/birt.12598>

Rahman, A. F., & Prasetyo, S. (2021). Pengaruh dukungan sosial dan budaya terhadap pengalaman perempuan selama masa kehamilan dan persalinan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 77-86. <https://doi.org/10.22435/kespro.v12i2.4217>

Reeder, S. J., Martin, L. L., & Koniak-Griffin, D. (2020). *Maternity Nursing: Family, Newborn, and Women's Health Care* (12th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

World Health Organization. (2022). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>

Yanti, E. D., & Rahayu, S. (2020). Hubungan asuhan kebidanan holistik terhadap hasil kesehatan ibu dan bayi. *Indonesian Midwifery Journal*, 4(1), 23-30. <https://doi.org/10.30597/imj.v4i1.6102>

Yuliati, S., & Winarsih, B. D. (2021). *Buku Ajar Kebidanan: Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Nuha Medika.

BAB 8

HUBUNGAN BIDAN-IBU DAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjalin hubungan terapeutik yang efektif dengan ibu dan keluarga melalui komunikasi yang jelas, empatik, dan profesional dalam konteks pelayanan kebidanan untuk mendukung pengambilan keputusan dan tercapainya kepuasan pelayanan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep hubungan terapeutik bidan-ibu serta menerapkan prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam berbagai situasi pelayanan kebidanan secara profesional.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan pentingnya hubungan terapeutik bidan-ibu dalam pelayanan kebidanan.
- Mengidentifikasi elemen-elemen komunikasi efektif dalam interaksi bidan-ibu.
- Menjelaskan hambatan-hambatan dalam komunikasi dan cara mengatasinya dalam konteks kebidanan.
- Mengimplementasikan keterampilan mendengarkan aktif, empati, dan komunikasi verbal serta non-verbal secara efektif dalam praktik kebidanan.
- Melakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi dalam berbagai situasi klinis kebidanan.

A. Hubungan Bidan-Ibu dalam Pelayanan Kebidanan

Hubungan Bidan-Ibu dalam Pelayanan Kebidanan merupakan fondasi penting yang menentukan keberhasilan asuhan kebidanan secara keseluruhan. Hubungan ini bersifat interpersonal, di mana interaksi antara bidan dan ibu tidak sekadar sebatas penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan, namun mencakup hubungan emosional dan psikologis yang lebih dalam. Hubungan yang dibangun antara bidan dan ibu didasarkan pada nilai-nilai utama berupa kepercayaan, empati, serta penghormatan yang tinggi terhadap martabat dan hak-hak individu, sehingga terbentuk suatu ikatan terapeutik yang efektif dan berkualitas.

Dalam hubungan ini, kepercayaan merupakan faktor paling krusial. Kepercayaan yang dibangun oleh seorang bidan terhadap ibu dan sebaliknya, menentukan sejauh mana ibu merasa nyaman untuk berbagi informasi tentang kondisi kesehatan, perasaan, serta kekhawatiran pribadinya. Dengan adanya rasa percaya yang kuat, ibu akan lebih terbuka menyampaikan informasi penting yang bisa membantu bidan dalam menilai kondisi kesehatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi ibu selama masa kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Tanpa adanya kepercayaan, proses komunikasi akan terhambat, yang bisa berujung pada kurang optimalnya asuhan yang diberikan.

Selain kepercayaan, empati merupakan aspek lain yang sangat menentukan kualitas hubungan bidan-ibu. Empati dalam konteks kebidanan adalah kemampuan bidan untuk memahami kondisi emosional ibu dengan merasakan apa yang ibu rasakan, serta menunjukkan perhatian tulus terhadap kondisi tersebut. Bidan yang empatik mampu menciptakan suasana yang nyaman, hangat, dan penuh dukungan, sehingga ibu merasa dihargai dan didengar. Hal ini sangat penting, terutama dalam kondisi tertentu seperti ibu yang sedang mengalami kecemasan menghadapi persalinan, masalah kehamilan yang kompleks, atau tantangan emosional setelah melahirkan. Melalui sikap empati, bidan bukan hanya memberikan asuhan fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang membantu mengurangi stres ibu.

Selanjutnya, hubungan yang baik juga ditandai dengan adanya sikap saling menghormati antara bidan dan ibu. Menghormati hak-hak ibu dalam membuat keputusan merupakan bagian penting dari hubungan terapeutik dalam kebidanan. Dalam konteks ini, bidan bertugas memberikan informasi yang jelas, lengkap, serta mudah dipahami kepada ibu, sehingga ibu dapat mengambil keputusan secara sadar dan penuh tanggung jawab (*informed consent*). Dengan menghormati otonomi ibu, bidan tidak sekadar berperan sebagai penentu keputusan klinis, tetapi

juga sebagai fasilitator yang memberdayakan ibu untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan bayinya.

Lebih jauh lagi, hubungan bidan-ibu yang erat dan positif secara signifikan dapat meningkatkan hasil pelayanan kebidanan. Ibu yang merasa terhubung secara emosional dengan bidannya cenderung memiliki pengalaman kehamilan dan persalinan yang lebih positif, yang pada akhirnya berkontribusi pada outcome kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, kurangnya hubungan interpersonal yang positif dapat menyebabkan ibu merasa terabaikan, cemas, atau bahkan takut, yang pada akhirnya dapat memicu komplikasi fisik maupun emosional selama proses kehamilan dan persalinan.

Dengan demikian, hubungan bidan-ibu tidak hanya merupakan elemen pelengkap dalam pelayanan kebidanan, melainkan inti dari proses asuhan yang holistik. Melalui hubungan terapeutik yang kuat, bidan mampu mengidentifikasi kebutuhan nyata ibu, baik secara klinis maupun psikososial, sehingga asuhan kebidanan yang diberikan bersifat komprehensif, berpusat pada ibu, serta mampu meningkatkan kepuasan, kesejahteraan, dan kualitas hidup ibu serta keluarganya secara keseluruhan.

B. Keterampilan Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kebidanan

Keterampilan Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kebidanan merupakan salah satu kompetensi mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap bidan untuk memberikan asuhan yang berkualitas dan tepat sasaran kepada ibu dan keluarganya. Komunikasi efektif dalam konteks ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi mencakup kemampuan bidan dalam mengirimkan pesan secara jelas, akurat, dan dapat dipahami dengan baik oleh ibu, serta mampu menerima informasi atau umpan balik dari ibu secara tepat. Keterampilan komunikasi efektif ini secara luas mencakup dua dimensi penting, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal.

Komunikasi verbal yang efektif di dalam pelayanan kebidanan melibatkan kemampuan bidan dalam memilih kata-kata yang tepat, sederhana, dan mudah dipahami oleh ibu yang memiliki latar belakang pendidikan, budaya, serta tingkat pemahaman yang beragam. Penggunaan kalimat yang singkat, jelas, dan tidak ambigu sangat penting agar ibu tidak mengalami kebingungan atau salah pengertian terhadap informasi yang diberikan. Nada suara juga memegang peranan penting dalam komunikasi verbal ini. Suara yang lembut, tenang, dan penuh perhatian dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman serta menenangkan

ibu, terutama pada saat-saat sensitif seperti masa menjelang persalinan, persalinan itu sendiri, ataupun ketika menghadapi situasi yang berpotensi stres atau kritis.

Selain komunikasi verbal, keterampilan komunikasi non-verbal juga menjadi aspek yang sangat krusial dalam pelayanan kebidanan. Komunikasi non-verbal mencakup bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, serta sentuhan fisik yang dilakukan secara tepat dan penuh perhatian. Kontak mata yang terjaga antara bidan dan ibu memperlihatkan bahwa bidan benar-benar memberikan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan oleh ibu. Ekspresi wajah yang ramah, hangat, serta penuh pengertian membantu menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman bagi ibu, sehingga ia lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan serta kekhawatirannya. Sikap tubuh yang terbuka dan santai juga menambah kenyamanan bagi ibu. Selain itu, sentuhan yang lembut, seperti genggam tangan atau sentuhan ringan pada bahu, dapat memberikan dukungan emosional serta memperkuat hubungan emosional antara bidan dan ibu.

Di samping keterampilan berbicara, mendengarkan aktif merupakan keterampilan lain yang tidak kalah penting dalam komunikasi efektif di pelayanan kebidanan. Mendengarkan aktif berarti bahwa bidan harus benar-benar memusatkan perhatian kepada ibu, memahami secara mendalam setiap kata yang diucapkan, serta merespon dengan empati dan penuh perhatian. Dengan mendengarkan aktif, bidan tidak hanya sekadar menangkap informasi yang disampaikan, tetapi juga mampu menangkap perasaan, harapan, maupun kekhawatiran yang tersirat dalam ucapan ibu. Melalui respons positif dan memvalidasi perasaan ibu, bidan dapat menciptakan rasa percaya, kenyamanan, dan keyakinan bahwa ibu memang didengar dan dipahami, sehingga hubungan terapeutik dapat terjalin lebih kuat.

Kemampuan komunikasi efektif ini sangat esensial, khususnya dalam situasi-situasi sulit atau krisis, seperti saat ibu mengalami kecemasan, stres tinggi, atau menghadapi komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Dalam situasi semacam ini, bidan dituntut untuk mampu berkomunikasi secara tenang, jelas, dan meyakinkan, agar ibu merasa mendapat dukungan yang kuat dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Informasi yang disampaikan dengan jelas serta ketenangan yang ditunjukkan oleh bidan dapat membantu meredakan kecemasan ibu, memberikan arahan tindakan yang tepat, serta meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menghadapi tantangan kesehatan yang dialaminya.

Dengan demikian, keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan bukan hanya merupakan tambahan dalam proses pemberian asuhan, tetapi menjadi bagian integral yang menentukan keberhasilan pelayanan kebidanan secara keseluruhan. Bidan yang terampil berkomunikasi secara efektif mampu

memberikan asuhan yang tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis ibu, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan ibu, memperkuat hubungan terapeutik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara menyeluruh.

C. Latihan Soal

Soal 1

Seorang ibu primigravida usia 26 tahun datang ke klinik bersalin dengan usia kehamilan 36 minggu. Ia terlihat cemas dan tampak ragu dalam menjawab pertanyaan bidan. Saat ditanya, ibu tersebut menyatakan bahwa dirinya takut menghadapi proses persalinan. Sebagai bidan, tindakan awal apa yang paling tepat untuk membangun hubungan terapeutik dengan ibu?

- A. Menjelaskan prosedur klinik secara detail
- B. Memberikan informasi mengenai proses persalinan
- C. Memberikan kesempatan ibu mengungkapkan kekhawatirannya
- D. Segera melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh
- E. Memberikan brosur tentang tahapan persalinan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Memberikan kesempatan ibu untuk mengungkapkan kekhawatirannya adalah langkah awal terbaik untuk membangun hubungan terapeutik. Sikap ini menunjukkan empati, menghargai perasaan ibu, serta membantu ibu merasa nyaman dan didengar sebelum masuk ke informasi klinis.

Soal 2

Seorang ibu berusia 32 tahun dengan kehamilan kedua mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan apakah ia akan melahirkan secara normal atau operasi sesar. Ibu merasa bingung karena memiliki trauma pada persalinan sebelumnya yang sulit. Dalam situasi ini, bagaimana pendekatan komunikasi terbaik yang harus dilakukan bidan untuk mendukung ibu?

- A. Menyarankan ibu langsung melakukan operasi sesar untuk menghindari trauma
- B. Mendiskusikan secara terbuka dan memberikan informasi jelas tentang kelebihan dan risiko masing-masing metode persalinan
- C. Meyakinkan ibu bahwa persalinan normal adalah pilihan terbaik
- D. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada ibu tanpa diskusi
- E. Meminta ibu segera berkonsultasi ke dokter kandungan

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pendekatan komunikasi yang tepat adalah mendiskusikan secara terbuka, memberikan informasi yang objektif tentang keuntungan dan risiko setiap pilihan. Dengan cara ini, bidan menghormati otonomi ibu, memberdayakannya untuk mengambil keputusan secara sadar berdasarkan informed consent.

Soal 3

Seorang ibu postpartum hari ketiga terlihat pendiam dan sering menangis ketika ditanya mengenai kondisi bayinya. Setelah ditanya lebih jauh, ibu menyampaikan bahwa ia merasa tidak mampu menjadi ibu yang baik. Dalam situasi tersebut, apa tindakan komunikasi efektif yang paling tepat dilakukan oleh bidan?

- A. Memberikan nasihat secara langsung mengenai cara merawat bayi
- B. Menghindari pembicaraan tentang perasaan ibu agar tidak bertambah sedih
- C. Mengajak ibu bicara dengan mendengarkan aktif dan memvalidasi perasaannya
- D. Menyarankan ibu beristirahat agar emosinya lebih stabil
- E. Menghubungi keluarga agar segera datang menemani ibu

Kunci Jawaban: C**Rasional:**

Mendengarkan aktif dan memvalidasi perasaan ibu adalah bentuk komunikasi efektif yang paling tepat. Tindakan ini membantu ibu merasa didukung, mengurangi rasa isolasi, serta membantu bidan memahami lebih dalam kondisi emosional ibu untuk memberikan intervensi lanjutan.

Soal 4

Seorang ibu multipara berusia 29 tahun datang untuk pemeriksaan antenatal. Saat proses anamnesis, ibu cenderung diam, menghindari kontak mata, dan memberikan jawaban pendek. Sikap non-verbal apa yang paling efektif dilakukan bidan untuk meningkatkan komunikasi dalam situasi ini?

- A. Menghindari kontak mata agar ibu tidak merasa tertekan
- B. Menyilangkan tangan di depan dada untuk menunjukkan keseriusan
- C. Duduk lebih dekat dengan ibu, menjaga kontak mata, dan tersenyum lembut
- D. Tetap berdiri agar ibu merasa situasi formal dan serius
- E. Menyentuh ibu tanpa izin untuk menunjukkan empati

Kunci Jawaban: C**Rasional:**

Bahasa tubuh berupa duduk lebih dekat dengan ibu, menjaga kontak mata secara wajar, dan tersenyum lembut adalah tindakan non-verbal efektif. Tindakan ini

menunjukkan keterbukaan, perhatian, dan memberikan rasa nyaman, mendorong ibu untuk lebih terbuka dalam komunikasi.

Soal 5

Seorang ibu hamil trimester ketiga menyampaikan keluhan bahwa dirinya tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas dari bidan sebelumnya. Ia merasa ragu apakah ia benar-benar memahami kondisi kehamilannya. Sebagai bidan yang menangani keluhan ini, apa tindakan komunikasi pertama yang paling tepat?

- A. Memberikan informasi lengkap tentang kondisi kehamilannya dengan detail ilmiah
- B. Menyalahkan bidan sebelumnya karena tidak memberikan informasi cukup jelas
- C. Menanyakan kembali pemahaman ibu terhadap informasi yang diterima sebelumnya
- D. Mengarahkan ibu untuk mencari informasi sendiri melalui internet
- E. Menyarankan ibu untuk lebih aktif bertanya

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Menanyakan kembali pemahaman ibu terhadap informasi sebelumnya adalah langkah pertama yang paling tepat. Hal ini membantu bidan mengidentifikasi secara jelas gap informasi atau kesalahpahaman yang dimiliki ibu, sehingga informasi lanjutan yang diberikan lebih tepat sasaran, jelas, dan mudah dipahami.

D. Rangkuman Materi

Hubungan Bidan-Ibu dan keterampilan komunikasi efektif merupakan dua aspek esensial yang saling berkaitan erat dalam menentukan keberhasilan asuhan kebidanan secara holistik. Hubungan terapeutik yang kokoh antara bidan dan ibu, yang didasarkan pada kepercayaan, empati, serta penghormatan terhadap hak ibu, menciptakan suasana pelayanan kebidanan yang nyaman, aman, dan efektif. Dalam hubungan ini, ibu merasa lebih terbuka menyampaikan informasi penting, harapan, serta kekhawatirannya, sehingga bidan dapat memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan individu secara klinis maupun psikososial.

Keterampilan komunikasi efektif, meliputi kemampuan komunikasi verbal maupun non-verbal, serta mendengarkan aktif, memainkan peran vital dalam membangun dan menjaga hubungan yang positif antara bidan dan ibu. Komunikasi verbal yang jelas, sederhana, dan penuh perhatian dipadukan dengan komunikasi non-verbal yang empatik dan suportif, membantu mengatasi situasi sulit serta

meredakan kecemasan yang dialami ibu. Bidan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik mampu memberikan dukungan emosional, memperjelas informasi yang diperlukan ibu untuk mengambil keputusan yang tepat, serta meningkatkan rasa percaya diri ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Berdasarkan latihan soal kasus yang disajikan, terbukti bahwa hubungan terapeutik yang kuat serta komunikasi efektif antara bidan dengan ibu berperan sentral dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan. Dengan demikian, penting bagi bidan untuk terus mengembangkan kemampuan interpersonal dan komunikasi agar mampu memberikan pelayanan yang berpusat pada ibu, meningkatkan kepuasan, kesejahteraan, serta kualitas hidup ibu dan keluarganya.

E. Glosarium

Asuhan Kebidanan

Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan perawatan komprehensif kepada ibu selama masa kehamilan, persalinan, nifas, serta bayi baru lahir, yang bertujuan untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan fisik, emosional, dan psikososial.

Bidan

Tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab memberikan perawatan kepada perempuan selama kehamilan, persalinan, masa nifas, serta merawat bayi baru lahir, dengan pendekatan yang holistik dan berpusat pada ibu.

Empati

Kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, serta menghargai perasaan dan pengalaman emosional orang lain, dalam hal ini kemampuan bidan untuk benar-benar memahami kondisi emosional ibu secara mendalam, sehingga tercipta rasa nyaman dan percaya.

Hubungan Terapeutik

Interaksi profesional yang bersifat interpersonal antara tenaga kesehatan (bidan) dan pasien (ibu), yang dibangun berdasarkan kepercayaan, empati, penghormatan, dan komunikasi yang baik, untuk mendukung tercapainya tujuan kesehatan dan kesejahteraan pasien.

Informed Consent

Proses di mana pasien menerima informasi yang jelas, lengkap, dan akurat tentang suatu tindakan medis atau prosedur, serta secara sukarela menyatakan persetujuannya setelah benar-benar memahami informasi tersebut, termasuk risiko dan manfaatnya.

Interpersonal

Interaksi atau hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih yang mencakup aspek emosional, psikologis, dan sosial, bukan hanya sekedar hubungan formal atau teknis.

Kepercayaan (Trust)

Perasaan yakin yang dibangun antara bidan dan ibu berdasarkan kompetensi, kejujuran, serta integritas, sehingga ibu merasa aman, nyaman, dan terbuka untuk berbagi informasi yang penting selama pelayanan kebidanan.

Komunikasi Efektif

Proses pertukaran informasi yang jelas, akurat, serta dapat dipahami oleh penerima pesan, melibatkan kemampuan komunikasi verbal, non-verbal, dan mendengarkan aktif yang bertujuan menciptakan pemahaman bersama dan mengurangi kemungkinan terjadinya miskomunikasi.

Komunikasi Non-verbal

Pertukaran pesan atau informasi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan mata, kontak mata, sikap tubuh, serta sentuhan fisik yang mendukung makna pesan verbal dalam sebuah interaksi.

Komunikasi Verbal

Proses komunikasi menggunakan kata-kata, kalimat, serta nada suara dalam menyampaikan informasi secara jelas, sederhana, dan tepat agar mudah dipahami oleh lawan bicara.

Mendengarkan Aktif (Active Listening)

Teknik komunikasi di mana seseorang secara penuh perhatian mendengarkan pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, menunjukkan pemahaman, memberikan respons empatik, serta memvalidasi perasaan dan pengalaman yang disampaikan oleh lawan bicara.

Otonomi Ibu

Hak ibu untuk membuat keputusan secara sadar, mandiri, dan bertanggung jawab terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya, di mana tenaga kesehatan, termasuk bidan, berperan sebagai fasilitator informasi serta mendukung ibu dalam proses pengambilan keputusan.

Psikososial

Aspek kesehatan yang mencakup kondisi psikologis (emosi, pikiran, perasaan) serta interaksi sosial seseorang dalam konteks keluarga maupun komunitas, yang turut mempengaruhi kesejahteraan fisik maupun mental.

Rasa Percaya Diri (Self-Confidence)

Perasaan yakin dan percaya pada kemampuan diri sendiri dalam menghadapi berbagai situasi, tantangan, atau permasalahan, yang dalam konteks kebidanan dapat ditingkatkan melalui komunikasi efektif dan hubungan terapeutik antara bidan dengan ibu.

Stres Emosional

Kondisi psikologis yang ditandai dengan perasaan tertekan, khawatir, takut, atau cemas yang intens, yang dapat muncul dalam situasi-situasi sulit seperti selama masa kehamilan, persalinan, atau masa nifas.

Terapeutik

Berkaitan dengan tindakan atau interaksi yang bertujuan untuk penyembuhan, pemulihan, atau peningkatan kesejahteraan fisik, emosional, maupun mental.

F. Daftar pustaka

Borrelli, S. E., Spiby, H., & Walsh, D. (2016). The kaleidoscopic midwife: A conceptual metaphor illustrating first-time mothers' perspectives of a good midwife during childbirth. *Midwifery*, 39, 103–111. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.05.008>

Bradfield, Z., Hauck, Y., Kelly, M., & Duggan, R. (2019). Midwives 'with woman' in the private obstetric model: Where divergent philosophies meet. *Women and Birth*, 32(2), 157–167. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.07.013>

Chang, Y. S., Coxon, K., Portela, A. G., Furuta, M., & Bick, D. (2018). Interventions to support effective communication between maternity care staff and women in

labour: A mixed-methods systematic review. *Midwifery*, 59, 4–16.
<https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.12.014>

Dahlberg, U., & Aune, I. (2013). The woman's birth experience: The effect of interpersonal relationships and continuity of care. *Midwifery*, 29(4), 407–415.
<https://doi.org/10.1016/j.midw.2012.09.006>

Fleming, S. E., Smart, D., & Eide, P. (2011). Grand multiparous women's perceptions of birthing, nursing care, and childbirth technology. *Journal of Perinatal Education*, 20(2), 108–117. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.20.2.108>

Foley, L., & Davis, E. (2017). Communication in maternity care: A reflection on challenges and strategies for improvement. *Journal of Communication in Healthcare*, 10(2), 136–141. <https://doi.org/10.1080/17538068.2017.1326426>

Hunter, B., Berg, M., Lundgren, I., Ólafsdóttir, Ó. Á., & Kirkham, M. (2008). Relationships: The hidden threads in the tapestry of maternity care. *Midwifery*, 24(2), 132–137. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2008.02.003>

Jones, L. K., & Smythe, L. (2015). Communication in midwifery: The importance of understanding lived experience. *British Journal of Midwifery*, 23(4), 236–242. <https://doi.org/10.12968/bjom.2015.23.4.236>

Leap, N., Dahlan, H., Brodie, P., Tracy, S., & Thorpe, J. (2011). Relationships – the glue that holds it all together: Midwifery continuity of care and sustainability. In Davies, L., Daellenbach, R., & Kensington, M. (Eds.), *Sustainability, Midwifery and Birth* (pp. 61–74). Routledge.

Noseworthy, D. A., Phibbs, S. R., & Benn, C. A. (2013). Towards a relational model of decision-making in midwifery care. *Midwifery*, 29(7), e42–e48. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2012.06.022>

Riley, V., & Mitchell, K. (2019). Improving communication in maternity services: Exploring experiences of women, midwives, and obstetricians. *Midwifery*, 74, 47–54. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.03.011>

Rowe, R. E., Garcia, J., Macfarlane, A. J., & Davidson, L. L. (2002). Improving communication between health professionals and women in maternity care: A structured review. *Health Expectations*, 5(1), 63–83. <https://doi.org/10.1046/j.1369-6513.2002.00159.x>

- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>
- Schmied, V., Beake, S., Sheehan, A., McCourt, C., & Dykes, F. (2011). Women's perceptions and experiences of breastfeeding support: A metasynthesis. *Birth*, 38(1), 49–60. <https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2010.00446.x>
- Simpson, M., Catling, C., & Homer, C. S. E. (2016). Communication in maternity care: A scoping review of literature. *Women and Birth*, 29(5), 398–406. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2016.04.002>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO Press.

BAB 9

MEDIA SOCIAL DAN PROFESIONALISME

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam menggunakan media sosial sebagai seorang bidan, dengan memperhatikan aspek hukum, etika, dan integritas profesi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang Media Sosial dan Profesionalisme dalam Kebidanan, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam menggunakan media sosial secara bijak, etis, dan bertanggung jawab, untuk mendukung peran profesionalnya sebagai bidan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar media sosial dan relevansinya dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi manfaat dan risiko penggunaan media sosial bagi profesi kebidanan.
- Menganalisis kasus-kasus pelanggaran profesionalisme yang terkait dengan penggunaan media sosial dalam pelayanan kebidanan.
- Mengembangkan strategi untuk menggunakan media sosial secara profesional dan bertanggung jawab, termasuk menjaga privasi dan kerahasiaan pasien.
- Mengintegrasikan prinsip-prinsip etik dan hukum dalam aktivitas online sebagai seorang profesional kebidanan.
- Menyusun pedoman penggunaan media sosial yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme bidan dalam lingkup pelayanan kesehatan.

Pendahuluan

Dalam era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali bagi tenaga kesehatan termasuk profesi kebidanan. Media sosial menawarkan berbagai manfaat seperti akses informasi yang cepat, komunikasi profesional yang efektif, serta peluang pengembangan jejaring profesional. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang dapat

mempengaruhi profesionalisme bidan, seperti pelanggaran privasi pasien, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta risiko terhadap reputasi profesional.

Profesionalisme dalam kebidanan menuntut seorang bidan untuk menjaga etika, kerahasiaan, dan integritas profesi, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi bidan untuk memahami penggunaan media sosial yang bijak agar tetap dapat mempertahankan standar etika profesi, melindungi privasi pasien, serta memperkuat citra profesionalisme yang positif dalam masyarakat. Topik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak media sosial terhadap profesionalisme dalam kebidanan serta strategi untuk mengelola media sosial secara profesional dan bertanggung jawab.

A. Konsep Dasar Media Sosial dalam Kebidanan

1. Pengertian dan jenis-jenis media sosial

Media sosial merupakan platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi konten, serta berpartisipasi dalam komunikasi interaktif dengan pengguna lain secara cepat dan luas. Media sosial tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau hiburan semata, tetapi juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang profesional termasuk kebidanan.

Adapun jenis-jenis media sosial yang sering digunakan dalam konteks kebidanan antara lain:

a. Media sosial jejaring sosial (Social Networking Sites)

Platform seperti Facebook, LinkedIn, dan WhatsApp yang digunakan untuk membangun koneksi profesional serta komunitas khusus seperti kelompok ibu hamil atau komunitas bidan.

b. Platform Berbagi Konten (Content Sharing Platforms)

Instagram, YouTube, TikTok, dan Pinterest digunakan untuk berbagi konten visual berupa gambar, video, infografis, edukasi seputar kebidanan, promosi layanan, serta tips-tips perawatan kesehatan ibu dan bayi.

c. Platform Mikroblogging

Twitter, yang menyediakan komunikasi singkat dan cepat, memungkinkan bidan untuk berbagi informasi penting, mengirimkan pesan kesehatan, serta memperbarui perkembangan terbaru dalam kebidanan secara ringkas dan real-time.

d. Platform Blog dan Website Profesional

Blog atau website pribadi maupun institusional seperti Blogger, Wordpress, atau platform khusus yang sering digunakan untuk menulis artikel mendalam terkait kesehatan reproduksi, asuhan kebidanan, serta informasi edukatif lainnya yang dapat diakses secara luas.

2. Peran media sosial dalam pelayanan kebidanan

Media sosial memiliki berbagai peran strategis dalam pelayanan kebidanan, antara lain:

a. Sarana Promosi dan Edukasi Kesehatan

Media sosial menjadi alat efektif untuk promosi kesehatan dan edukasi. Bidan dapat menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai

pentingnya kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan, proses persalinan, dan masa nifas.

b. Komunikasi Efektif dengan Pasien dan Masyarakat

Melalui media sosial, bidan dapat menjaga komunikasi yang berkesinambungan dengan pasien dan masyarakat. Contohnya melalui grup WhatsApp, Facebook, atau Instagram live, di mana bidan dapat menjawab pertanyaan, memberikan konsultasi ringan, atau menginformasikan jadwal layanan kesehatan.

c. Platform Konseling Virtual

Media sosial seperti WhatsApp atau Instagram Direct Message memfasilitasi konseling virtual di mana bidan bisa memberikan layanan konsultasi awal atau bimbingan yang fleksibel dan responsif bagi ibu hamil dan keluarga mereka tanpa harus bertatap muka secara langsung.

d. Membangun Personal Branding dan Profesionalisme

Melalui konten edukatif, bidan bisa membangun reputasi positif sebagai profesional kesehatan terpercaya. Konsistensi dalam berbagi informasi yang akurat dan kredibel membantu memperkuat citra profesional seorang bidan.

e. Jaringan Profesional dan Kolaborasi

Media sosial memungkinkan bidan terhubung dengan kolega sesama bidan, tenaga kesehatan lain, maupun organisasi profesi. Hal ini membuka peluang kolaborasi riset, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga penyelenggaraan webinar atau workshop bersama.

3. Tren penggunaan media sosial di kalangan bidan

Tren penggunaan media sosial di kalangan bidan terus berkembang seiring meningkatnya literasi digital dan kebutuhan akan interaksi yang cepat dan efektif. Beberapa tren yang berkembang di antaranya:

a. Penggunaan Media Sosial untuk Edukasi Visual

Tren konten visual seperti infografis dan video singkat semakin meningkat, karena lebih menarik perhatian dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan teks panjang. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadi favorit untuk edukasi visual.

b. Webinar dan Pelatihan Online

Sejak masa pandemi COVID-19, webinar dan pelatihan daring melalui media sosial dan platform digital semakin diminati oleh bidan untuk peningkatan kompetensi profesional secara berkelanjutan (Continuous Professional Development/CPD).

c. **Konseling Online (Telekonsultasi)**

Konseling atau konsultasi online melalui media sosial seperti WhatsApp atau Telegram kini menjadi bagian umum dalam pelayanan kebidanan, terutama untuk pasien dengan keterbatasan akses geografis ke fasilitas kesehatan.

d. **Personal Branding Profesional Bidan**

Bidan semakin menyadari pentingnya membangun branding profesional melalui media sosial dengan menyusun konten edukatif yang terstruktur dan konsisten, serta secara aktif berinteraksi dengan audiens untuk memperkuat hubungan dan kepercayaan.

e. **Kolaborasi Interprofesional**

Media sosial juga semakin menjadi platform kolaborasi antartena kesehatan, termasuk bidan yang terlibat dalam diskusi daring interprofesional mengenai topik-topik klinis terbaru, penelitian bersama, atau advokasi terkait isu-isu kesehatan perempuan.

B. Manfaat dan Risiko Media Sosial bagi Profesi Kebidanan

Dalam perkembangan dunia digital, media sosial telah menjadi salah satu instrumen yang sangat berpengaruh dalam profesi kebidanan. Seperti dua sisi mata uang, media sosial membawa manfaat signifikan sekaligus risiko yang harus dikelola dengan baik agar penggunaan platform digital ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi profesi maupun pasien.

1. Manfaat media sosial dalam edukasi kesehatan dan penyebaran informasi

Media sosial memberikan banyak manfaat dalam mendukung tugas profesional bidan, terutama dalam aspek edukasi kesehatan masyarakat dan penyebaran informasi kesehatan secara luas dan cepat:

a. **Mempermudah Penyebaran Informasi Kesehatan**

Media sosial dapat menjangkau khalayak luas dalam waktu yang singkat. Informasi penting seperti tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, teknik menyusui, hingga manajemen nifas dapat dengan cepat tersebar melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter.

b. **Efisiensi dalam Edukasi Publik**

Media sosial memungkinkan bidan membuat konten edukasi berupa gambar, video singkat, infografis, serta konten audio-visual yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. Metode ini lebih efektif dibandingkan metode edukasi tradisional seperti brosur atau poster cetak.

c. Interaksi Langsung dan Responsif

Melalui media sosial, bidan dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Fitur seperti live streaming, direct messages, serta kolom komentar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan respons instan dari bidan yang kompeten.

d. Biaya Efektif dalam Edukasi Kesehatan

Dibandingkan dengan metode konvensional, edukasi melalui media sosial lebih hemat biaya. Dengan modal akses internet dan perangkat elektronik, pesan kesehatan dapat menjangkau masyarakat luas tanpa biaya tambahan yang signifikan.

e. Menjangkau Masyarakat yang Sulit Diakses

Media sosial memungkinkan edukasi mencapai daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau oleh tenaga kesehatan secara fisik. Masyarakat di daerah pelosok dapat memperoleh informasi terkini dan relevan terkait kebidanan melalui platform digital ini.

2. Risiko pelanggaran privasi pasien dan penyebaran informasi keliru

Meski media sosial memberikan manfaat, penggunaannya juga disertai berbagai risiko yang perlu diwaspadai oleh bidan:

a. Risiko Pelanggaran Privasi Pasien

Penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan termasuk bidan, sering kali berisiko tinggi terhadap pelanggaran privasi pasien. Informasi pribadi atau detail kasus pasien yang seharusnya rahasia, dapat secara tidak sengaja atau sengaja disebarluaskan, yang melanggar kode etik dan peraturan hukum mengenai kerahasiaan medis.

Contoh kasus pelanggaran privasi meliputi:

- 1) Membagikan foto pasien tanpa persetujuan tertulis.
- 2) Membahas kasus klinis pasien secara terbuka yang bisa teridentifikasi identitasnya secara langsung atau tidak langsung.

b. Penyebaran Informasi yang Keliru atau Tidak Valid

Media sosial sering menjadi tempat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks. Bidan yang kurang berhati-hati dapat secara tidak sengaja menyebarkan informasi yang keliru tentang kesehatan reproduksi dan kebidanan, yang berpotensi membahayakan pasien maupun masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran informasi keliru antara lain:

- 1) Tidak melakukan verifikasi sumber sebelum membagikan informasi.
- 2) Ketidakmampuan membedakan antara sumber informasi yang terpercaya dan yang tidak kredibel.

c. Dampak Hukum dan Etik

Pelanggaran privasi pasien dan penyebaran informasi palsu atau keliru tidak hanya menciptakan masalah etik, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius bagi bidan, seperti gugatan hukum, pencabutan izin praktik, atau sanksi administratif lainnya.

3. Dampak penggunaan media sosial terhadap citra profesional

Penggunaan media sosial oleh bidan juga dapat secara signifikan mempengaruhi citra profesional mereka, baik secara positif maupun negatif. Berikut dampaknya:

a. Dampak Positif

1) Memperkuat Personal Branding dan Profesionalisme

Penggunaan media sosial yang bijak dan profesional dapat meningkatkan citra positif seorang bidan di mata masyarakat. Menyajikan konten edukatif yang berkualitas, informatif, serta berbasis bukti ilmiah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan integritas profesional seorang bidan.

2) Meningkatkan Jaringan Profesional

Media sosial memudahkan bidan dalam memperluas jejaring profesionalnya. Interaksi dengan tenaga kesehatan lain, institusi kesehatan, organisasi profesi, maupun komunitas masyarakat akan memperkuat posisi bidan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan terpercaya.

3) Menunjukkan Responsibilitas dan Empati

Penggunaan media sosial secara aktif dalam memberikan edukasi kesehatan, merespons pertanyaan masyarakat, serta menunjukkan sikap empati melalui interaksi daring dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap profesi bidan.

b. Dampak Negatif

1) Kerusakan Reputasi akibat Konten Tidak Profesional

Postingan yang tidak pantas, kurang sopan, atau tidak memperhatikan etika profesional dapat merusak reputasi bidan secara cepat. Bahkan satu postingan saja bisa berdampak jangka panjang dan sulit dihilangkan dari persepsi publik.

2) Terlalu Personal atau Kontroversial

Menampilkan kehidupan pribadi yang terlalu banyak, komentar politik kontroversial, atau konflik pribadi di media sosial dapat merusak citra profesional bidan yang semestinya netral, bijak, dan objektif.

3) Persepsi Kompetensi Profesional yang Menurun

Konten yang kurang akurat, kurang kredibel, atau tidak berbasis bukti ilmiah bisa mengurangi persepsi publik terhadap kompetensi profesional seorang bidan. Masyarakat yang menerima informasi tidak akurat mungkin meragukan kemampuan klinis bidan tersebut secara keseluruhan.

C. Kasus-Kasus Pelanggaran Profesionalisme di Media Sosial

Dalam praktik profesional kebidanan, integritas, privasi pasien, serta akurasi informasi adalah hal yang sangat penting. Seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial, kasus-kasus pelanggaran profesionalisme semakin banyak terjadi dan menjadi perhatian khusus. Berikut berbagai kasus pelanggaran tersebut.

1. Studi kasus pelanggaran privasi dan kerahasiaan pasien

Pelanggaran privasi pasien adalah pelanggaran serius dalam praktik kebidanan. Privasi merupakan hak mendasar pasien yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip etika profesi.

Contoh Kasus:

- a. Seorang bidan memposting foto ibu yang baru saja melahirkan tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari pasien. Meski tujuan awal adalah untuk menunjukkan kesuksesan praktik kebidanan, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap privasi pasien karena identitas pasien dapat dikenali oleh publik.
- b. Sebuah kasus viral di mana seorang tenaga kebidanan melakukan live streaming di media sosial tanpa sengaja menampilkan identitas pasien secara jelas dalam proses persalinan, termasuk menyebutkan nama dan lokasi pasien secara langsung di media sosial.

Detail Dampaknya:

- a. Pasien merasa tidak nyaman dan malu karena data pribadinya tersebar luas.
- b. Potensi tekanan psikologis yang berat bagi pasien dan keluarganya.
- c. Hilangnya kepercayaan publik terhadap tenaga kesehatan tersebut, bahkan fasilitas kesehatan tempat dia bekerja.
- d. Risiko hukum berupa tuntutan pelanggaran privasi oleh pasien.

2. Penyebaran informasi tidak valid dan dampaknya terhadap pasien dan masyarakat

Dalam kebidanan, akurasi informasi sangat penting. Informasi yang keliru atau tidak berbasis bukti dapat menyesatkan pasien dan masyarakat luas serta menyebabkan dampak negatif.

Contoh Kasus:

- a. Seorang bidan mengunggah informasi mengenai metode persalinan atau praktik kesehatan tertentu tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi kebenaran atau validasi secara ilmiah. Misalnya, merekomendasikan suatu terapi alternatif tanpa dasar bukti ilmiah yang memadai.
- b. Kasus penyebaran berita palsu tentang efek samping vaksinasi pada ibu hamil melalui media sosial yang dilakukan oleh tenaga kebidanan karena kurangnya literasi digital dan tidak mengecek sumber yang kredibel.

Dampak yang Ditimbulkan:

- a. Menurunnya tingkat kepercayaan pasien terhadap rekomendasi tenaga kesehatan profesional.
- b. Pasien atau masyarakat yang mempercayai informasi keliru dapat mengambil keputusan yang berbahaya bagi kesehatan mereka, seperti menolak vaksinasi atau pengobatan medis yang seharusnya penting.
- c. Ketegangan antara pasien dengan institusi kesehatan akibat kesalahpahaman yang disebabkan oleh informasi yang keliru.
- d. Penurunan efektivitas program kesehatan masyarakat akibat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap informasi resmi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi kesehatan.

3. Konsekuensi hukum dan etika dalam pelanggaran di media sosial

Pelanggaran profesionalisme di media sosial tidak hanya berdampak secara personal dan sosial, tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum dan etika serius bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Konsekuensi Etika:

- a. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kebidanan
Melanggar prinsip kerahasiaan pasien (confidentiality), prinsip autonomy (menghormati hak pasien), serta prinsip non-maleficence (tidak membahayakan pasien).
- b. Sanksi oleh Organisasi Profesi
Organisasi profesi kebidanan bisa memberikan teguran, peringatan keras, hingga pencabutan izin praktik sementara atau permanen jika pelanggaran yang terjadi cukup berat dan berdampak luas.

Konsekuensi Hukum:

- a. Gugatan Sipil
Pasien yang merasa dirugikan akibat pelanggaran privasi atau penyebaran informasi keliru berhak mengajukan gugatan hukum sipil dengan tuntutan ganti rugi secara material maupun immaterial.

b. Konsekuensi Administratif dari Institusi Kesehatan

Institusi tempat bidan bekerja dapat mengenakan sanksi administratif, seperti skorsing, pemutusan kontrak kerja, atau pemecatan, untuk menjaga reputasi dan integritas institusi.

c. Konsekuensi Hukum Pidana

Dalam kasus berat seperti penyebaran data pribadi pasien tanpa izin (pelanggaran UU ITE), bidan dapat diancam hukuman pidana berupa denda besar atau bahkan penjara, tergantung pada beratnya dampak pelanggaran yang dilakukan.

D. Strategi Menggunakan Media Sosial secara Profesional dan Bertanggung Jawab

Penggunaan media sosial oleh bidan perlu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, mengingat profesi ini sangat erat kaitannya dengan etika, privasi pasien, serta kredibilitas informasi yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk memastikan media sosial digunakan secara profesional dan bertanggung jawab.

1. Panduan menjaga privasi dan kerahasiaan pasien dalam unggahan media sosial

Privasi dan kerahasiaan pasien merupakan aspek penting dalam etika kebidanan. Berikut panduan praktis agar privasi pasien tetap terlindungi saat menggunakan media sosial:

a. Hindari Menampilkan Informasi Identitas Pasien

- 1) Jangan pernah memposting informasi yang dapat mengungkap identitas pasien secara langsung maupun tidak langsung (nama lengkap, alamat, foto wajah, nomor telepon, tanggal lahir, nomor rekam medis).
- 2) Gunakan metode anonymisasi jika ingin menceritakan kasus untuk tujuan edukasi, misalnya memakai inisial atau kode tertentu, serta mengubah detail yang dapat mengidentifikasi pasien.

b. Minta Persetujuan Tertulis (Informed Consent)

- 1) Sebelum memposting konten apapun yang terkait pasien, pastikan telah memperoleh persetujuan tertulis (written consent) yang jelas, spesifik, dan informatif.
- 2) Informasikan secara jelas pada pasien mengenai tujuan, konten yang akan diunggah, serta dampak dari postingan tersebut sebelum pasien memberikan persetujuan.

c. Gunakan Konten Ilustratif atau Simulasi

- 1) Gunakan ilustrasi, simulasi, atau gambar edukasi yang tidak berasal dari pasien asli untuk konten media sosial guna menghindari pelanggaran privasi.
- 2) Gunakan ilustrasi bebas royalti atau sumber terbuka yang aman dan profesional untuk mendukung informasi edukasi kebidanan.

d. Patuhi Kode Etik Profesi dan Regulasi

- 1) Kenali dengan baik pedoman kode etik profesi kebidanan, regulasi hukum yang berlaku, serta panduan organisasi profesi dalam penggunaan media sosial.
- 2) Lakukan update berkala terkait perubahan regulasi tentang privasi dan kerahasiaan informasi medis, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Teknik komunikasi efektif dan profesional di media sosial

Teknik komunikasi yang profesional sangat penting untuk menjaga citra positif profesi kebidanan. Berikut panduan agar komunikasi di media sosial tetap efektif dan profesional:

a. Gunakan Bahasa yang Santun dan Jelas

- 1) Pilih kata-kata yang sopan, ramah, tidak menyinggung, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
- 2) Hindari jargon medis berlebihan; gunakan bahasa sederhana yang edukatif agar mudah dipahami oleh masyarakat luas.

b. Bersikap Responsif dan Empati

- 1) Tunjukkan sikap empati dan rasa peduli dalam menjawab pertanyaan atau komentar dari audiens. Komunikasikan pesan dengan nada ramah dan responsif.
- 2) Jika ada pertanyaan sensitif atau bersifat pribadi, arahkan audiens untuk melanjutkan diskusi melalui pesan pribadi (direct message) atau konsultasi tatap muka.

c. Gunakan Konten yang Akurat dan Berbasis Bukti

- 1) Pastikan konten yang diposting selalu bersumber dari literatur ilmiah terbaru, panduan klinis resmi, atau informasi terpercaya dari lembaga kesehatan yang diakui.
- 2) Jika merujuk suatu penelitian atau panduan tertentu, berikan referensi atau link yang valid dan kredibel agar audiens bisa memverifikasi informasi tersebut.

d. Tunjukkan Profesionalisme dan Kredibilitas

- 1) Konsistenlah dalam menyampaikan pesan yang mencerminkan standar tinggi profesionalisme kebidanan.
- 2) Jaga integritas dengan tidak terlibat dalam debat tidak perlu atau menunjukkan emosi negatif secara terbuka di media sosial.

3. Strategi menghadapi komentar negatif atau kontroversial secara profesional

Komentar negatif atau kontroversial sangat mungkin terjadi di media sosial.

a. Respons dengan Tenang dan Bijaksana

- 1) Jangan terburu-buru memberikan respons emosional; ambil jeda waktu singkat sebelum menjawab komentar negatif agar tidak terbawa emosi sesaat.
- 2) Gunakan bahasa yang netral, santun, namun tetap tegas dalam memberikan klarifikasi atau penjelasan yang diperlukan.

b. Tetap Fokus pada Fakta dan Informasi Valid

- 1) Hadapi komentar negatif dengan informasi ilmiah dan fakta valid, hindari argumen emosional atau subyektif yang memperpanjang konflik.
- 2) Jika komentar bersifat keliru atau tidak berbasis bukti, berikan klarifikasi secara jelas disertai rujukan informasi terpercaya.

c. Jangan Abaikan Kritik yang Konstruktif

- 1) Bedakan antara kritik konstruktif dan kritik yang sifatnya destruktif atau troll. Jika komentar negatif mengandung kritik membangun, respons dengan berterima kasih serta tunjukkan sikap terbuka untuk perbaikan ke depan.

d. Gunakan Moderasi dan Kebijakan Akun dengan Jelas

- 1) Gunakan fitur moderasi komentar atau filter otomatis terhadap kata-kata kasar yang tersedia di berbagai platform media sosial.
- 2) Buat kebijakan jelas yang mencantumkan standar komunikasi dalam akun media sosial profesional, serta informasikan kepada audiens bahwa komentar tidak sopan, menyerang, atau tidak relevan akan dihapus atau dibatasi aksesnya.

e. Privatisasi atau Pindahkan Diskusi jika Diperlukan

- 1) Jika komentar semakin intens, sensitif, atau tidak kondusif untuk dibahas di ranah publik, arahkan diskusi melalui pesan pribadi atau konsultasi offline secara langsung dengan pihak terkait.
- 2) Jika dirasa perlu, matikan sementara fitur komentar pada postingan tertentu yang kontroversial untuk menghindari eskalasi konflik lebih jauh.

E. Integrasi Prinsip Etik dan Hukum dalam Penggunaan Media Sosial

1. Prinsip etik kebidanan yang relevan dalam media sosial

Dalam penggunaan media sosial, seorang bidan wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip etik profesi secara penuh, terutama karena profesi ini terkait erat dengan hak-hak pasien yang sangat sensitif, khususnya privasi dan kerahasiaan informasi. Salah satu prinsip etik utama dalam kebidanan yang sangat relevan adalah prinsip autonomi, yang menuntut bidan untuk menghormati hak pasien dalam membuat keputusan terkait informasi pribadinya. Bidan harus memastikan bahwa setiap informasi atau gambar pasien yang dibagikan melalui media sosial telah mendapat persetujuan jelas dari pasien secara tertulis, setelah pasien benar-benar memahami maksud dan tujuan penyebaran informasi tersebut.

Selain itu, prinsip beneficence (berbuat baik) juga sangat relevan dalam penggunaan media sosial. Dalam prinsip ini, bidan dituntut untuk selalu mengunggah informasi yang bersifat edukatif, ilmiah, akurat, serta memberikan manfaat nyata bagi pasien dan masyarakat. Dengan prinsip ini, konten media sosial yang disajikan tidak hanya bertujuan mendapatkan popularitas atau perhatian semata, tetapi lebih pada tujuan utama profesi kebidanan, yakni untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Prinsip lain yang juga sangat penting adalah non-maleficence (tidak membahayakan), di mana bidan wajib memastikan bahwa setiap aktivitasnya di media sosial tidak menimbulkan risiko bahaya atau kerugian pada pasien dan masyarakat. Artinya, bidan harus sangat berhati-hati dalam menyajikan informasi, memastikan kebenaran data dan fakta sebelum dipublikasikan, serta menghindari hal-hal yang berpotensi menyebabkan salah paham atau kepanikan di masyarakat.

Terakhir, prinsip justice (keadilan) juga harus diterapkan dalam menggunakan media sosial. Artinya, bidan perlu menjaga agar konten yang diunggahnya bersifat netral dan tidak diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Bidan harus menjamin bahwa informasi yang diberikan dapat diakses dan diterima secara setara oleh semua kalangan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, pendidikan, atau latar belakang budaya tertentu.

2. Regulasi dan hukum yang terkait dengan media sosial di bidang kesehatan

Penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, tidak hanya diatur oleh prinsip-prinsip etik profesi, tetapi juga oleh berbagai regulasi dan peraturan hukum. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyebaran informasi yang tidak benar, pencemaran nama

baik, hingga pelanggaran privasi seseorang. Bidan harus memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap privasi pasien melalui media sosial bisa berakibat pada konsekuensi pidana yang serius, termasuk denda besar maupun hukuman penjara, jika terbukti melanggar UU ITE tersebut.

Regulasi lainnya adalah Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan ini bisa berdampak pada tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana, tergantung tingkat kerugian yang dialami pasien akibat tersebarnya informasi medis secara tidak sah.

Di sisi lain, terdapat pula peraturan khusus dari Kementerian Kesehatan seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, yang secara khusus menegaskan bahwa rekam medis adalah dokumen rahasia yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pasien. Dengan demikian, setiap publikasi atau pengungkapan isi rekam medis di media sosial tanpa persetujuan pasien adalah pelanggaran hukum serius.

Organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga mengeluarkan kode etik yang secara spesifik mengatur perilaku bidan di ranah publik, termasuk penggunaan media sosial. Kode etik ini menjadi pedoman wajib yang mengikat seluruh anggota, dan pelanggaran terhadap kode etik tersebut dapat mengakibatkan sanksi etik mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik.

3. Implementasi prinsip etika dan hukum dalam aktivitas online

Implementasi prinsip etika dan regulasi hukum dalam aktivitas online bagi seorang bidan memerlukan pendekatan yang konsisten, disiplin, serta penuh tanggung jawab. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penerapan ketat terhadap kewajiban mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari pasien secara tertulis sebelum memposting konten yang melibatkan informasi pribadi atau klinis pasien di media sosial. Bidan perlu memastikan bahwa pasien benar-benar paham apa yang akan dibagikan, risiko yang mungkin timbul, serta manfaat edukasi yang ingin dicapai.

Selanjutnya, bidan harus secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap setiap konten yang akan dipublikasikan. Ini meliputi memastikan keakuratan informasi yang akan disebar, serta sumber atau referensi yang digunakan sebagai dasar konten tersebut. Sebelum melakukan unggahan informasi kesehatan di media sosial, bidan harus melakukan verifikasi terlebih dahulu dari sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah terbaru, panduan klinis resmi dari

organisasi profesi, atau lembaga kesehatan terakreditasi agar terhindar dari penyebaran informasi tidak valid yang dapat menyesatkan pasien.

Selain itu, implementasi prinsip ini juga mencakup bagaimana bidan menjaga komunikasi yang sopan, netral, profesional, dan tidak terlibat dalam konflik online yang tidak konstruktif. Jika terjadi komentar negatif atau kontroversial, bidan harus mampu memberikan respons yang tenang, berdasarkan fakta ilmiah, tidak emosional, serta tetap menjaga profesionalisme. Dalam hal terjadi situasi sulit atau konflik yang tidak kondusif, bidan dapat menggunakan opsi komunikasi privat atau konsultasi secara langsung dengan pasien atau pihak terkait, bukan menyelesaikannya secara terbuka di platform publik.

Untuk mendukung implementasi prinsip etik dan hukum ini, institusi kesehatan tempat bidan bekerja atau organisasi profesi sebaiknya memiliki kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Pelatihan dan edukasi reguler tentang etika digital, manajemen risiko hukum, serta prinsip komunikasi efektif secara online menjadi bagian penting dalam membentuk kompetensi digital yang bertanggung jawab pada tenaga kebidanan.

Dengan menjalankan prinsip etika kebidanan dan regulasi hukum secara menyeluruh dalam penggunaan media sosial, bidan tidak hanya mampu memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat, tetapi juga melindungi pasien dari potensi kerugian akibat pelanggaran privasi. Lebih jauh, implementasi yang disiplin dan bertanggung jawab ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan, sekaligus membangun reputasi positif seorang bidan sebagai profesional yang mampu menjaga integritas, privasi pasien, serta kualitas pelayanan kesehatan di era digital.

F. Penyusunan Pedoman Penggunaan Media Sosial untuk Profesionalisme Kebidanan

1. Langkah-langkah menyusun pedoman internal penggunaan media sosial

Penyusunan pedoman internal penggunaan media sosial untuk kebidanan merupakan suatu langkah strategis yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta perlindungan terhadap privasi pasien. Proses ini memerlukan pendekatan sistematis yang dimulai dengan pembentukan tim kerja yang terdiri dari perwakilan profesi kebidanan, manajemen institusi, tenaga ahli hukum, serta pakar etika kesehatan dan komunikasi digital. Tim ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengidentifikasi seluruh kebutuhan organisasi

terkait penggunaan media sosial, baik dari aspek hukum, etika, maupun dampak komunikasi yang potensial.

Selanjutnya, dilakukan analisis menyeluruh tentang permasalahan aktual maupun potensial yang mungkin terjadi dalam konteks kebidanan di media sosial. Pada tahap ini, tim perlu mengidentifikasi contoh-contoh pelanggaran yang pernah terjadi, mengkaji aturan hukum terkait privasi pasien dan kerahasiaan medis, serta meninjau kode etik profesi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Data dan informasi dari tahap ini kemudian menjadi dasar untuk merumuskan poin-poin penting dalam pedoman yang akan disusun.

Setelah identifikasi masalah selesai, langkah berikutnya adalah menyusun rancangan awal pedoman media sosial yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua staf kebidanan di institusi tersebut. Rancangan ini harus mencakup secara rinci ketentuan tentang bagaimana bidan harus menjaga privasi pasien di media sosial, tata cara permohonan persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien untuk keperluan edukasi, batasan-batasan konten yang boleh dan tidak boleh dipublikasi, serta mekanisme pengawasan internal yang efektif. Rancangan ini juga perlu mencantumkan panduan bagaimana cara bidan menangani situasi sensitif seperti komentar negatif atau konten kontroversial di media sosial.

Setelah rancangan pedoman selesai, tim kemudian melakukan tahap sosialisasi internal secara menyeluruh. Sosialisasi ini melibatkan seluruh elemen staf kebidanan, mulai dari tenaga kesehatan langsung hingga staf administrasi yang terkait dengan pelayanan pasien. Tujuan sosialisasi ini tidak sekedar memberikan informasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi staf untuk bertanya, memberikan masukan, dan berdiskusi tentang berbagai situasi konkret yang mungkin dihadapi dalam implementasi pedoman tersebut.

Tahap akhir dari proses penyusunan pedoman ini adalah pengesahan secara resmi oleh pimpinan institusi pelayanan kesehatan atau organisasi profesi kebidanan. Dengan pengesahan tersebut, pedoman resmi berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh staf di lingkungan institusi tersebut. Selain itu, dokumen pedoman ini harus didokumentasikan secara baik dan mudah diakses oleh seluruh staf, misalnya melalui website internal institusi, poster, maupun dalam bentuk buku saku sebagai referensi harian.

2. Contoh pedoman penggunaan media sosial dalam institusi pelayanan kesehatan

Sebagai gambaran konkret tentang bagaimana pedoman penggunaan media sosial di lingkungan pelayanan kesehatan kebidanan dapat diterapkan, sebuah institusi biasanya menyusun dokumen yang menjelaskan secara eksplisit

berbagai ketentuan terkait aktivitas online para stafnya. Contoh pedoman penggunaan media sosial yang baik biasanya mencakup pengaturan spesifik seperti ketentuan untuk tidak menyebarkan identitas pasien (baik secara langsung maupun tidak langsung) tanpa persetujuan tertulis yang jelas dari pasien. Pedoman ini juga mencakup larangan untuk memposting informasi klinis detail yang berpotensi membocorkan rahasia medis pasien atau mengarah kepada identifikasi pasien.

Lebih lanjut, pedoman juga memberikan contoh yang jelas tentang batasan-batasan interaksi antara staf kebidanan dan pasien melalui media sosial pribadi, seperti aturan tentang komunikasi hanya boleh dilakukan melalui akun resmi institusi atau akun profesional yang sudah diverifikasi. Selain itu, pedoman juga menegaskan bahwa setiap konten edukasi yang diunggah di media sosial harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaru, bebas dari opini pribadi yang tidak profesional, serta selalu mencantumkan sumber atau referensi yang dapat dipercaya.

Di dalam pedoman tersebut juga terdapat arahan spesifik tentang bagaimana staf harus menanggapi komentar negatif atau kontroversial di media sosial. Sebagai contoh, institusi memberikan panduan bahwa staf kebidanan harus memberikan respons dengan sikap tenang, tidak emosional, serta mengutamakan fakta-fakta ilmiah dalam menjelaskan atau memberikan klarifikasi. Bila ada situasi yang sensitif atau konflik yang meningkat, staf disarankan untuk membawa diskusi tersebut ke ranah privat atau offline agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi citra institusi maupun profesi.

3. Evaluasi dan revisi berkala terhadap pedoman media sosial untuk menjaga relevansi

Pedoman penggunaan media sosial bukanlah dokumen statis yang hanya dibuat sekali lalu diabaikan, melainkan suatu dokumen dinamis yang perlu secara rutin dievaluasi dan direvisi untuk menjaga relevansinya dengan perkembangan teknologi, peraturan hukum, serta kebutuhan institusi yang berubah dari waktu ke waktu. Institusi pelayanan kebidanan perlu menetapkan periode evaluasi rutin, misalnya setiap satu atau dua tahun sekali, di mana tim khusus bertugas untuk meninjau kembali pedoman tersebut.

Proses evaluasi meliputi pengumpulan data mengenai pelaksanaan pedoman di lapangan, wawancara dengan staf tentang tantangan atau kesulitan yang dihadapi, serta kajian ulang terhadap perkembangan regulasi hukum, teknologi media sosial, serta tren komunikasi kesehatan terkini. Dari hasil evaluasi tersebut, tim dapat mengetahui bagian mana dari pedoman yang sudah tidak

relevan atau kurang efektif dalam pelaksanaan, sehingga perlu direvisi atau diperbarui.

Setelah evaluasi dilakukan, tim merekomendasikan revisi pada bagian tertentu dari pedoman. Revisi tersebut kemudian disosialisasikan kembali kepada seluruh staf dengan jelas, termasuk alasan perubahan serta manfaat dari pembaruan tersebut. Proses ini bertujuan agar seluruh staf kebidanan terus mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi hukum, praktik etis, dan teknologi komunikasi digital sehingga pedoman tetap efektif dalam menjaga profesionalisme institusi.

Selain evaluasi rutin, institusi juga perlu memiliki mekanisme khusus untuk melakukan evaluasi dan revisi jika terjadi kasus khusus atau insiden signifikan yang berhubungan dengan media sosial. Misalnya, jika ada pelanggaran serius terhadap privasi pasien yang terjadi akibat unggahan media sosial, maka tim khusus tersebut segera melakukan evaluasi mendalam serta merekomendasikan perubahan yang diperlukan untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan.

Dengan pendekatan sistematis dalam menyusun, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pedoman penggunaan media sosial secara berkala, institusi pelayanan kebidanan dapat secara efektif meminimalkan risiko pelanggaran etik dan hukum, sambil terus menjaga citra positif profesi kebidanan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pasien serta masyarakat luas.

G. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan di sebuah klinik memposting video singkat edukasi di akun Instagram pribadinya mengenai teknik menyusui yang tepat. Dalam video tersebut, secara tidak sengaja terlihat jelas wajah seorang ibu yang baru melahirkan beserta nama lengkapnya yang tertulis pada papan informasi kamar. Pasien mengetahui hal ini dari saudaranya yang melihat unggahan tersebut, lalu mengajukan keberatan.

Apa prinsip etik kebidanan yang paling dilanggar oleh bidan tersebut?

- A. Beneficence
- B. Non-maleficence
- C. Autonomi
- D. Justice
- E. Fidelity

Jawaban: C. Autonomi

Rasional:

Prinsip autonomi dilanggar karena bidan tidak meminta persetujuan tertulis dari pasien sebelum menyebarkan identitas pasien di media sosial. Pasien berhak menentukan sendiri apakah informasi pribadinya boleh atau tidak boleh disebarluaskan.

Soal 2

Seorang bidan aktif menggunakan TikTok untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi. Suatu hari ia mengunggah konten tentang manfaat imunisasi TT bagi ibu hamil. Namun, bidan tersebut kurang berhati-hati dan menyebutkan secara keliru bahwa imunisasi TT dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada bayi. Akibat konten tersebut, beberapa ibu hamil menolak imunisasi TT.

Apa dampak paling serius yang muncul dari unggahan informasi tidak valid ini?

- A. Turunnya jumlah pengikut media sosial
- B. Konflik dengan sesama tenaga kesehatan
- C. Penurunan citra pribadi bidan
- D. Risiko masalah hukum akibat UU ITE
- E. Risiko kesehatan serius bagi ibu dan bayi

Jawaban: E. Risiko kesehatan serius bagi ibu dan bayi

Rasional:

Informasi yang keliru menyebabkan ibu hamil menolak imunisasi yang penting untuk mencegah penyakit, sehingga risiko kesehatan ibu dan bayi meningkat secara serius. Dampak ini lebih signifikan dibandingkan dampak lainnya.

Soal 3

Seorang bidan melakukan live streaming di Facebook ketika sedang memberikan asuhan persalinan di sebuah klinik. Ia sudah mendapat persetujuan lisan dari pasien, namun tidak memiliki persetujuan tertulis. Pasien merasa malu setelah melihat video tersebut tersebar luas dan melaporkan kasus ini ke organisasi profesi.

Apa konsekuensi hukum yang paling mungkin dihadapi oleh bidan tersebut?

- A. Teguran lisan saja dari organisasi profesi
- B. Denda administratif ringan
- C. Gugatan pidana dan denda besar karena pelanggaran UU ITE
- D. Hukuman pidana berupa penjara tanpa alternatif denda
- E. Teguran keras, sanksi administratif, hingga pencabutan izin praktik

Jawaban: E. Teguran keras, sanksi administratif, hingga pencabutan izin praktik

Rasional:

Tindakan tersebut melanggar etika dan regulasi mengenai privasi pasien. Organisasi profesi biasanya akan memberikan sanksi administratif berat seperti teguran keras hingga pencabutan izin praktik. Gugatan pidana mungkin terjadi jika pasien memilih membawa kasus ini ke ranah hukum pidana.

Soal 4

Seorang bidan memiliki akun profesional Instagram yang digunakan untuk edukasi. Namun, ia sering terlibat dalam perdebatan emosional dengan pengikutnya di kolom komentar ketika ada yang tidak sepakat dengan konten edukasinya. Akibatnya, banyak pengikut yang menilai bidan tersebut tidak profesional dan menganggapnya emosional serta kurang bijak.

Apa dampak utama dari perilaku komunikasi tersebut terhadap citra profesional bidan?

- A. Meningkatkan popularitas karena kontroversi
- B. Mengurangi kepercayaan pasien dan masyarakat
- C. Memperluas jaringan profesional secara signifikan
- D. Meningkatkan efektivitas edukasi karena interaktif
- E. Menunjukkan empati dan keterlibatan aktif kepada audiens

Jawaban: B. Mengurangi kepercayaan pasien dan masyarakat

Rasional:

Perilaku komunikasi emosional dan tidak profesional di media sosial dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap kompetensi dan profesionalisme bidan tersebut. Hal ini merusak citra profesional yang seharusnya dibangun dengan komunikasi efektif, tenang, dan berbasis bukti.

Soal 5

Sebuah institusi kebidanan belum memiliki pedoman penggunaan media sosial yang jelas. Akibatnya, seorang bidan di institusi tersebut tanpa sengaja mengunggah informasi detail tentang riwayat kesehatan pasien dalam akun media sosial pribadinya. Pasien yang merasa privasinya dilanggar mengadukan kasus ini ke pihak berwenang.

Langkah paling tepat yang harus segera dilakukan institusi kebidanan dalam menangani kasus tersebut adalah:

- A. Mengabaikan aduan pasien karena belum ada pedoman
- B. Menyusun pedoman penggunaan media sosial dengan segera
- C. Memberikan sanksi tanpa evaluasi mendalam
- D. Menyarankan pasien menyelesaikan secara pribadi dengan bidan

E. Menutup semua akun media sosial tenaga kebidanan secara permanen

Jawaban: B. Menyusun pedoman penggunaan media sosial dengan segera

Rasional:

Institusi harus segera menyusun pedoman penggunaan media sosial yang jelas untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan. Langkah ini penting agar semua staf memahami batasan-batasan penggunaan media sosial terkait privasi dan etika profesi. Mengabaikan atau langsung memberi sanksi tanpa evaluasi bukan solusi jangka panjang yang efektif.

H. Rangkuman Materi

Media sosial telah menjadi elemen penting dalam praktik kebidanan modern yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi personal, tetapi juga sebagai media efektif untuk edukasi, promosi kesehatan, dan memperkuat hubungan profesional dengan masyarakat. Bidan dapat memanfaatkan berbagai jenis media sosial seperti jejaring sosial, platform berbagi konten visual, mikroblogging, serta blog atau website profesional untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan serta menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Namun, pemanfaatan media sosial dalam kebidanan juga membawa sejumlah risiko, terutama berkaitan dengan pelanggaran privasi pasien dan penyebaran informasi yang tidak valid. Kasus-kasus nyata menunjukkan bahwa kurangnya kehati-hatian dalam penggunaan media sosial dapat menyebabkan implikasi serius secara hukum maupun etik, serta menurunkan citra profesional seorang bidan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang, disiplin, serta pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika seperti prinsip autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice, yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap aktivitas online.

Implementasi prinsip etik dan regulasi hukum terkait media sosial, seperti UU ITE, Undang-Undang Kesehatan, serta kode etik profesi kebidanan, wajib menjadi dasar dalam setiap interaksi online oleh tenaga kebidanan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi, menghindari dampak negatif, serta memberikan perlindungan optimal terhadap pasien dan masyarakat.

Sebagai langkah strategis, setiap institusi pelayanan kebidanan disarankan menyusun pedoman penggunaan media sosial secara internal yang jelas, rinci, serta mengikat. Pedoman ini harus mencakup tata cara menjaga kerahasiaan pasien, standar komunikasi profesional, serta mekanisme penanganan komentar atau situasi kontroversial di media sosial. Selain itu, pedoman tersebut perlu dievaluasi dan

direvisi secara berkala untuk memastikan relevansi dengan perkembangan hukum, teknologi, dan tren komunikasi terkini.

Dengan pendekatan yang bertanggung jawab, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah, media sosial dapat menjadi instrumen strategis yang sangat efektif bagi bidan dalam memberikan edukasi kesehatan, memperluas jaringan profesional, serta membangun kepercayaan masyarakat secara luas. Akhirnya, integrasi yang bijak antara teknologi digital dengan prinsip-prinsip etik dan regulasi hukum akan membantu mewujudkan praktik kebidanan yang berkualitas, profesional, serta aman di era digital ini.

I. Glosarium

Autonomi

Prinsip etik yang menekankan penghormatan terhadap hak pasien dalam membuat keputusan secara mandiri dan sadar tentang informasi pribadi dan tindakan medis yang akan diterima.

Beneficence (Berbuat Baik)

Prinsip etik yang menuntut seorang tenaga kesehatan, termasuk bidan, untuk selalu melakukan tindakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pasien dan masyarakat.

Blog Profesional

Platform digital yang digunakan oleh bidan untuk menulis artikel, panduan, atau informasi edukatif terkait kebidanan secara mendalam dan sistematis yang dapat diakses masyarakat luas.

Content Sharing Platforms (Platform Berbagi Konten)

Platform media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Pinterest yang memungkinkan bidan membagikan konten visual berupa gambar, video edukasi, serta infografis terkait kesehatan ibu dan anak.

Jejaring Sosial (Social Networking Sites)

Media sosial seperti Facebook, LinkedIn, dan WhatsApp yang memungkinkan bidan membangun hubungan profesional, membentuk komunitas khusus, serta berinteraksi secara aktif dengan pasien dan masyarakat.

Justice (Keadilan)

Prinsip etik yang menuntut agar bidan memberikan pelayanan dan edukasi secara adil, merata, tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan status sosial, ekonomi, pendidikan, atau budaya.

Kerahasiaan Pasien (Confidentiality)

Kewajiban etis dan hukum bagi tenaga kesehatan untuk menjaga rahasia informasi pribadi dan medis pasien agar tidak tersebar tanpa izin pasien.

Kode Etik Profesi Kebidanan

Pedoman perilaku dan standar moral yang wajib diikuti oleh semua bidan dalam menjalankan tugas profesionalnya, termasuk dalam penggunaan media sosial.

Komunikasi Efektif

Proses penyampaian pesan secara jelas, akurat, sopan, serta responsif, yang memudahkan pemahaman audiens dan memperkuat citra profesional seorang bidan.

Konseling Virtual (Telekonsultasi)

Layanan konsultasi kesehatan melalui media sosial atau platform digital lainnya yang memungkinkan interaksi antara bidan dengan pasien secara fleksibel tanpa pertemuan fisik langsung.

Media Sosial

Platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten serta melakukan komunikasi interaktif secara luas, cepat, dan efisien.

Mikroblogging

Platform media sosial seperti Twitter yang memungkinkan penyampaian pesan atau informasi singkat secara cepat dan real-time.

Non-maleficence (Tidak Membahayakan)

Prinsip etik yang mengharuskan bidan untuk memastikan bahwa setiap tindakannya tidak menyebabkan bahaya atau kerugian pada pasien maupun masyarakat.

Personal Branding

Proses membangun dan mempertahankan reputasi positif seorang bidan sebagai profesional kesehatan yang kompeten, kredibel, serta dipercaya oleh masyarakat melalui penggunaan media sosial secara konsisten dan bertanggung jawab.

Platform Digital

Teknologi berbasis internet yang digunakan sebagai media komunikasi, edukasi, promosi, serta interaksi profesional, contohnya webinar, pelatihan daring, dan media sosial.

Privasi Pasien

Hak dasar pasien yang mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi dan medis agar tidak disebarluaskan tanpa izin yang jelas dan tertulis.

Regulasi Media Sosial di Bidang Kesehatan

Peraturan hukum yang mengatur penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang bertujuan melindungi privasi pasien serta mencegah penyebaran informasi keliru.

Risiko Media Sosial

Potensi bahaya yang muncul akibat penggunaan media sosial yang kurang hati-hati, misalnya pelanggaran privasi pasien, penyebaran informasi tidak valid, hingga risiko hukum dan etika bagi profesi kebidanan.

Sanksi Administratif

Hukuman atau tindakan disiplin yang dapat diberikan oleh institusi atau organisasi profesi kepada bidan yang melakukan pelanggaran terkait penggunaan media sosial.

Telekonsultasi

Lihat Konseling Virtual.

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk media sosial, untuk melindungi individu dari pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik, serta mencegah penyebaran informasi palsu.

J. Daftar pustaka

- American College of Nurse-Midwives. (2020). Code of ethics. Diambil dari <https://www.midwife.org/code-of-ethics>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2008). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Chretien, K. C., & Kind, T. (2013). Social media and clinical care: Ethical, professional, and social implications. *Circulation*, 127(13), 1413–1421. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.128017>
- George, D. R., Rovniak, L. S., & Kraschnewski, J. L. (2013). Dangers and opportunities for social media in medicine. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, 56(3), 453–462. <https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e318297dc38>
- Gottlieb, M., & Chan, T. M. (2021). Building professional identity through personal branding and social media. *Academic Medicine*, 96(9), 1308–1311. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000004021>
- Grajales, F. J., Sheps, S., Ho, K., Novak-Lauscher, H., & Eysenbach, G. (2014). Social media: A review and tutorial of applications in medicine and health care. *Journal of Medical Internet Research*, 16(2), e13. <https://doi.org/10.2196/jmir.2912>
- Ikatan Bidan Indonesia. (2018). *Kode Etik Profesi Bidan Indonesia*. Jakarta: IBI.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Kesehatan RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>

- Kind, T., Patel, P. D., & Lie, D. A. (2014). Opting in to online professionalism: Social media and pediatrics. *Pediatrics*, 134(2), e523–e529. <https://doi.org/10.1542/peds.2014-0192>
- Marques, I. C., Theiss, L. M., & Johnson, C. Y. (2019). The role of digital platforms in health communication: Opportunities and challenges. *Health Promotion Practice*, 20(3), 404–410. <https://doi.org/10.1177/1524839919834991>
- McKee, R. (2013). Ethical issues in using social media for health and health care research. *Health Policy*, 110(2–3), 298–301. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.02.002>
- Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A new dimension of health care: Systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. *Journal of Medical Internet Research*, 15(4), e85. <https://doi.org/10.2196/jmir.1933>
- Ventola, C. L. (2014). Social media and health care professionals: Benefits, risks, and best practices. *P&T: A Peer-reviewed Journal for Formulary Management*, 39(7), 491–520.
- World Health Organization. (2021). Ethical principles in health care. Diakses dari <https://www.who.int>

BAB 10

PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT) DAN PENTINGNYA BELAJAR SEPANJANG HAYAT

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip pengembangan profesional berkelanjutan dan pentingnya belajar sepanjang hayat dalam praktik kebidanan secara efektif dan berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dan tujuan pengembangan profesional berkelanjutan (CPD).
- Mengidentifikasi pentingnya belajar sepanjang hayat dalam konteks profesi kebidanan.
- Mengintegrasikan kegiatan CPD dalam rencana pengembangan karier profesional bidan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan secara rinci konsep, tujuan, dan bentuk-bentuk pengembangan profesional berkelanjutan.
- Menguraikan prinsip dan manfaat belajar sepanjang hayat dalam profesi kebidanan.
- Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi CPD dan strategi untuk mengatasinya.
- Merancang rencana personal untuk kegiatan CPD secara terstruktur dan berkelanjutan.

A. Konsep dan Tujuan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD)

Konsep Dasar CPD dalam Kebidanan

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) adalah suatu proses pembelajaran sepanjang hayat yang dirancang secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kompetensi profesional bidan. CPD mencakup berbagai kegiatan edukasi formal maupun informal, seperti pelatihan, seminar, workshop, refleksi praktik, mentoring, dan penelitian mandiri, yang secara keseluruhan berperan dalam memastikan pelayanan yang diberikan tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks kebidanan, CPD tidak hanya sekadar mengikuti pelatihan atau seminar, tetapi juga melibatkan proses refleksi terhadap praktik klinis sehari-hari, evaluasi diri, serta pengembangan pribadi dan profesional secara menyeluruh. Proses ini sangat penting karena profesi bidan berhubungan langsung dengan nyawa ibu dan bayi, sehingga standar kompetensi yang tinggi harus selalu terjaga dan diperbaharui.

Tujuan Utama Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) dalam Kebidanan

Secara umum, CPD bertujuan untuk menjaga profesionalisme bidan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul seiring perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Adapun tujuan spesifik CPD dalam kebidanan adalah:

1. Memperbaharui pengetahuan ilmiah dan keterampilan klinis secara rutin.

a. Pembaruan pengetahuan ilmiah

Bidan wajib mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu kebidanan, seperti pengetahuan tentang kehamilan risiko tinggi, teknik persalinan terbaru, manajemen komplikasi kebidanan, serta intervensi terkini berdasarkan bukti ilmiah.

b. Peningkatan keterampilan klinis

CPD membantu bidan dalam melatih dan meningkatkan keterampilan klinis yang esensial seperti resusitasi bayi baru lahir, teknik aseptik, penatalaksanaan komplikasi persalinan, serta keterampilan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga.

c. Contoh implementasi praktis:

Melalui kegiatan seperti pelatihan simulasi klinis, workshop penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetri, dan seminar tentang inovasi teknologi dalam pelayanan kebidanan.

2. Memastikan pelayanan kebidanan yang diberikan berbasis bukti terbaru (evidence-based practice).

a. Penerapan Evidence-Based Practice (EBP)

CPD membantu bidan memahami pentingnya praktik kebidanan yang didasarkan pada hasil penelitian terbaru, sehingga setiap keputusan klinis yang diambil memiliki landasan ilmiah yang kuat.

b. Penggunaan bukti ilmiah

Bidan diajarkan untuk mengakses, menilai, serta mengintegrasikan hasil penelitian terbaru ke dalam praktik sehari-hari, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan aman.

c. Contoh implementasi praktis:

Penggunaan pedoman klinis terbaru yang dirilis oleh organisasi profesional seperti International Confederation of Midwives (ICM), WHO, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pelatihan sistematis tentang cara membaca dan menginterpretasi jurnal ilmiah.

3. Meningkatkan kualitas layanan kepada ibu, bayi, dan keluarga.

a. Kualitas layanan yang optimal

CPD mendorong bidan untuk terus meningkatkan pelayanan melalui refleksi praktik, analisis kritis terhadap kasus-kasus yang ditemui, serta pembaruan terus-menerus terhadap metode pelayanan kebidanan yang digunakan.

b. Orientasi pada keluarga

Bidan yang terus mengembangkan kompetensinya akan lebih mampu memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada kebutuhan individu ibu, bayi, dan keluarga secara komprehensif dan humanis.

c. Contoh implementasi praktis

Workshop komunikasi terapeutik, pelatihan konseling keluarga, serta pelatihan tentang perawatan maternitas yang berpusat pada keluarga (Family-Centered Maternity Care).

4. Memenuhi kewajiban profesional, regulasi, dan etika profesi.

a. Kewajiban profesional

CPD merupakan tanggung jawab etis dan profesional seorang bidan yang dituntut oleh berbagai lembaganya untuk selalu menjaga kualitas kompetensinya.

b. Regulasi profesi

Pelaksanaan CPD diatur dalam regulasi profesi kebidanan yang mensyaratkan setiap bidan memiliki jumlah tertentu dari kegiatan CPD sebagai syarat perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).

c. Etika profesi

CPD juga merupakan bagian dari etika profesi yang mengharuskan seorang bidan menjaga kompetensi dan integritasnya secara berkesinambungan agar selalu dapat dipercaya oleh masyarakat dan profesinya sendiri.

d. Contoh implementasi praktis

Seminar tentang hukum kesehatan, pelatihan etika kebidanan, dan kegiatan refleksi kasus etik yang membantu bidan memahami aspek hukum dan moral dalam menjalankan tugasnya.

B. Pentingnya Belajar Sepanjang Hayat dalam Kebidanan

Belajar sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menegaskan bahwa proses pendidikan tidak terbatas hanya pada pendidikan formal di institusi pendidikan saja, tetapi berlangsung secara berkelanjutan sepanjang kehidupan seseorang. Dalam konteks kebidanan, konsep ini sangat fundamental mengingat profesi bidan berhubungan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan ibu, bayi, serta keluarga secara luas. Profesi kebidanan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan klinis terkini agar dapat memberikan pelayanan kebidanan yang optimal.

Dalam bidang kebidanan, perubahan terjadi sangat cepat, terutama terkait dengan perkembangan teknologi kesehatan dan penemuan terbaru dalam penelitian medis. Pengetahuan dan keterampilan klinis yang sebelumnya dianggap terbaik, dalam beberapa waktu bisa menjadi usang dan tidak relevan lagi akibat munculnya berbagai bukti ilmiah terbaru. Misalnya, perubahan praktik persalinan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan intervensi medis, kini bergeser ke pendekatan yang lebih alami, humanistik, dan berpusat pada keluarga. Kondisi ini menuntut setiap bidan agar mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut melalui pembelajaran yang terus-menerus. Tanpa kesadaran untuk terus belajar sepanjang hayat, seorang bidan dapat tertinggal dari perkembangan ilmu yang pesat ini, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, belajar sepanjang hayat dalam kebidanan sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kebidanan yang diberikan selalu memenuhi standar internasional dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan berkembang secara dinamis. Standar internasional, seperti yang diterapkan oleh International Confederation of Midwives (ICM) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),

mengalami pembaruan secara berkala berdasarkan hasil penelitian terbaru dan praktik terbaik yang telah diuji secara global. Bidan yang aktif dalam pembelajaran sepanjang hayat akan selalu dapat mengintegrasikan standar terbaru ini ke dalam praktik sehari-hari. Hal ini akan menjamin bahwa layanan yang mereka berikan tidak hanya memenuhi standar minimal tetapi juga sesuai dengan ekspektasi internasional serta harapan masyarakat yang terus berubah seiring waktu.

Lebih jauh lagi, pembelajaran sepanjang hayat dalam kebidanan sangat penting dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis oleh bidan. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan melalui pembelajaran berkelanjutan, seorang bidan menjadi lebih kritis dan mampu melakukan analisis mendalam terhadap berbagai situasi klinis yang kompleks. Kemampuan berpikir kritis ini tidak hanya membantu bidan dalam menentukan diagnosis yang tepat, tetapi juga dalam memilih tindakan klinis yang paling aman dan efektif bagi ibu dan bayi. Misalnya, kemampuan untuk mengenali tanda-tanda komplikasi secara dini, memahami berbagai alternatif solusi yang tersedia, serta memilih pendekatan yang paling tepat berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Dengan demikian, pembelajaran sepanjang hayat membantu meningkatkan kepercayaan diri, efisiensi, serta efektivitas bidan dalam memberikan layanan yang aman, tepat guna, dan berkualitas tinggi.

Secara keseluruhan, komitmen untuk belajar sepanjang hayat merupakan kunci penting yang menentukan keberhasilan dan kualitas pelayanan kebidanan. Bidan yang menerapkan prinsip ini dalam kehidupannya akan mampu menghadapi berbagai tantangan klinis, teknologi, sosial, serta etika dengan lebih baik, sekaligus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

C. Tantangan dalam Implementasi CPD dan Strategi Mengatasinya

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuous Professional Development, CPD) merupakan elemen penting untuk menjaga kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan para bidan agar tetap relevan dan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang mutakhir. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, CPD kerap kali menemui berbagai tantangan nyata di lapangan. Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi yang tepat agar tidak menghambat proses pengembangan profesional para bidan.

Implementasi CPD dalam kebidanan tidak terlepas dari berbagai tantangan, di antaranya adalah:

1. Keterbatasan waktu karena beban kerja yang tinggi.

Beban kerja yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama bagi bidan dalam mengikuti program CPD secara konsisten dan efektif. Profesi bidan dituntut untuk senantiasa siap menangani kasus kebidanan, mulai dari pelayanan antenatal, persalinan, hingga pelayanan postnatal yang berlangsung sepanjang waktu. Kondisi ini sering kali menyebabkan para bidan merasa sulit mengalokasikan waktu khusus untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional secara rutin.

Selain pelayanan klinis, beban administratif yang juga tinggi sering kali menambah tekanan bagi bidan, sehingga mereka lebih memprioritaskan pekerjaan sehari-hari dibandingkan pengembangan kompetensi diri. Akibatnya, partisipasi dalam kegiatan CPD sering dianggap sebagai beban tambahan dibandingkan sebagai kebutuhan esensial untuk menjaga kualitas praktik.

2. Keterbatasan akses ke pelatihan atau seminar yang relevan.

Tidak semua bidan memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan CPD lainnya yang relevan dengan kebutuhan profesional mereka. Hal ini terutama terjadi di wilayah pedesaan atau daerah terpencil di mana fasilitas pendidikan dan pelatihan masih sangat terbatas. Keterbatasan akses ini menyebabkan ketimpangan kompetensi antarbidan di berbagai wilayah.

Faktor geografis, jarak tempuh yang jauh ke lokasi pelatihan, serta keterbatasan dana dan transportasi juga memperparah kendala ini. Akibatnya, bidan di daerah yang terpencil dan terisolasi sering kali kesulitan mendapatkan informasi terbaru tentang praktik kebidanan berbasis bukti.

3. Kurangnya dukungan institusional terhadap CPD.

Implementasi CPD membutuhkan dukungan penuh dari institusi tempat bidan bekerja. Namun, tidak jarang ditemukan institusi yang kurang memprioritaskan pengembangan profesional berkelanjutan ini. Misalnya, tidak adanya kebijakan khusus terkait CPD, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan staf, atau kurangnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan digital atau ruang pelatihan yang memadai.

Kurangnya dukungan ini menghambat motivasi bidan untuk mengikuti CPD, sehingga mereka menjadi pasif dalam pengembangan diri karena merasa bahwa upaya mereka tidak mendapat apresiasi maupun dukungan institusional yang memadai.

Strategi mengatasi tantangan ini meliputi:

1. Membuat jadwal kegiatan CPD yang terstruktur dan fleksibel.

Strategi pertama dalam mengatasi keterbatasan waktu adalah dengan menyusun jadwal kegiatan CPD secara terstruktur namun fleksibel. Penyusunan jadwal ini melibatkan perencanaan yang matang, di mana institusi dan individu bidan bekerja sama menentukan waktu yang paling efektif tanpa mengganggu tugas pelayanan klinis utama.

Misalnya, kegiatan CPD dapat dijadwalkan secara berkala dalam format yang singkat namun intensif seperti sesi pelatihan mingguan atau bulanan dengan durasi pendek, sehingga tidak menambah beban kerja secara signifikan. Fleksibilitas juga dapat diterapkan melalui sistem rotasi tugas sehingga setiap bidan mendapat kesempatan yang adil untuk mengikuti CPD tanpa meninggalkan tanggung jawab klinisnya secara berlebihan.

2. Memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses pembelajaran secara daring (online).

Untuk mengatasi kendala keterbatasan akses, pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi yang efektif. Dengan berkembangnya teknologi internet dan komunikasi, berbagai platform pembelajaran online seperti webinar, e-learning, video tutorial, serta forum diskusi profesional dapat dimanfaatkan secara luas oleh para bidan, terutama yang bekerja di wilayah terpencil.

Penggunaan platform online memungkinkan bidan untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka tetap dapat memperbaharui pengetahuan tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau meninggalkan tempat tugas. Selain itu, metode daring ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif, memperkuat jaringan profesional antar bidan di berbagai daerah.

3. Advokasi kepada institusi agar mendukung secara penuh kegiatan CPD melalui kebijakan dan fasilitas yang memadai.

Strategi ketiga adalah melakukan advokasi secara aktif dan sistematis kepada institusi atau pimpinan organisasi pelayanan kesehatan agar mendukung kegiatan CPD secara maksimal. Advokasi ini melibatkan penyampaian bukti empiris tentang manfaat CPD bagi peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dan dampaknya terhadap keselamatan pasien.

Langkah-langkah advokasi meliputi pembuatan proposal kebijakan CPD, mengajukan anggaran khusus untuk kegiatan pengembangan profesional, serta

menunjukkan manfaat nyata CPD dalam peningkatan standar praktik kebidanan. Melalui dukungan institusi yang jelas berupa kebijakan formal, alokasi dana yang cukup, fasilitas seperti ruang belajar, perpustakaan digital, dan akses internet yang stabil, akan meningkatkan partisipasi aktif para bidan dalam kegiatan CPD secara berkelanjutan.

D. Merancang Rencana Personal untuk CPD

Rencana personal dalam pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) merupakan dokumen penting yang secara khusus dirancang oleh seorang bidan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesionalnya secara terperinci dan sistematis. Dokumen ini membantu bidan dalam menentukan tujuan belajar, memilih aktivitas pembelajaran yang relevan, dan menetapkan strategi serta metode evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai secara efektif. Rencana personal CPD berfungsi sebagai panduan sekaligus alat evaluasi mandiri yang memastikan bahwa bidan senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan profesinya.

1. Penilaian kebutuhan pembelajaran (learning needs assessment).

Langkah pertama yang paling esensial dalam penyusunan rencana personal CPD adalah melaksanakan penilaian kebutuhan pembelajaran atau learning needs assessment. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara jelas area kompetensi yang perlu ditingkatkan atau diperbaharui oleh seorang bidan.

Penilaian kebutuhan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui beberapa metode yang komprehensif, di antaranya:

a. Refleksi Praktik Klinis

Bidan melakukan refleksi diri terhadap pengalaman klinis sehari-hari dengan mengidentifikasi situasi atau kasus yang dirasa sulit atau kompleks, sehingga menemukan titik lemah yang membutuhkan perbaikan.

b. Evaluasi Mandiri (Self-assessment)

Menggunakan alat evaluasi seperti kuisioner atau instrumen penilaian kompetensi profesional yang disediakan oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembelajaran.

c. Feedback dari Supervisor atau Mentor

Bidan dapat meminta umpan balik dari supervisor, mentor, atau rekan sejawat mengenai performa klinis, komunikasi, serta keterampilan lainnya. Umpan balik ini sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan secara objektif.

d. Review Standar Kompetensi Nasional/Internasional

Melakukan perbandingan antara kompetensi pribadi dengan standar kompetensi yang ditetapkan organisasi profesional, seperti International Confederation of Midwives (ICM) atau Kementerian Kesehatan RI. Hal ini akan memperjelas gap kompetensi yang harus dipenuhi.

2. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik.

Setelah kebutuhan pembelajaran teridentifikasi secara detail, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan pembelajaran ini penting agar proses CPD berjalan terarah dan efektif.

Dalam menetapkan tujuan pembelajaran, penting memperhatikan prinsip SMART, yaitu:

a. Specific (Spesifik)

Tujuan harus jelas dan spesifik, seperti meningkatkan kemampuan penatalaksanaan perdarahan postpartum atau memperbaiki keterampilan komunikasi terapeutik dengan pasien.

b. Measurable (Terukur):

Harus ada indikator yang jelas untuk menilai apakah tujuan tersebut berhasil dicapai, seperti mampu melakukan prosedur tertentu dengan benar atau meningkatkan skor evaluasi praktik klinis.

c. Achievable (Dapat dicapai):

Tujuan yang dirancang harus realistis sesuai dengan kemampuan, waktu, serta sumber daya yang tersedia.

d. Relevant (Relevan):

Tujuan yang ditetapkan harus relevan dengan kebutuhan praktik kebidanan saat ini serta kebutuhan masyarakat atau pasien yang dilayani.

e. Time-bound (Ada batas waktu):

Setiap tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas, misalnya menyelesaikan pelatihan atau mencapai kompetensi tertentu dalam kurun waktu tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun.

3. Jenis aktivitas CPD yang relevan dan realistis.

Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, langkah berikutnya adalah memilih jenis aktivitas CPD yang relevan, realistis, serta efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini bisa mencakup berbagai format yang beragam, tergantung kebutuhan pribadi serta situasi individu bidan.

Berbagai aktivitas CPD yang umum digunakan antara lain:

- a. Pelatihan Klinis atau Workshop
Misalnya, pelatihan resusitasi neonatus, manajemen emergensi obstetri, atau pelatihan komunikasi interpersonal dalam kebidanan.
- b. Seminar dan Webinar
Mengikuti seminar atau webinar yang membahas tentang bukti ilmiah terbaru dalam praktik kebidanan, seperti manajemen kehamilan risiko tinggi atau teknik baru dalam asuhan nifas.
- c. E-Learning (Pembelajaran Daring)
Mengakses platform pembelajaran online untuk modul-modul CPD yang memungkinkan fleksibilitas waktu dan lokasi.
- d. Peer-learning atau Studi Kelompok
Melakukan diskusi kelompok atau jurnal klub dengan rekan sejawat untuk mendalami kasus klinis dan jurnal terbaru secara rutin.
- e. Mentoring atau Supervisi
Mendapatkan supervisi langsung dari mentor yang lebih berpengalaman atau melakukan shadowing pada tenaga ahli dalam bidang yang spesifik.

4. Evaluasi keberhasilan kegiatan CPD dan penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi.

Langkah akhir yang tidak kalah penting dalam rencana personal CPD adalah melakukan evaluasi terhadap keberhasilan aktivitas CPD yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran berhasil dicapai dan menentukan apakah diperlukan penyesuaian strategi.

Evaluasi keberhasilan kegiatan CPD dapat dilakukan dengan beberapa metode:

- a. Evaluasi diri (Self-evaluation)
Menggunakan catatan reflektif atau jurnal belajar, yang membantu bidan menilai apakah kegiatan CPD telah memberikan manfaat signifikan terhadap kompetensi mereka.
- b. Penilaian Kinerja atau Observasi Langsung
Melalui observasi praktik oleh supervisor atau mentor untuk menilai secara objektif apakah ada peningkatan kompetensi atau keterampilan.
- c. Tes atau Ujian Kompetensi
Melakukan asesmen formal seperti post-test setelah mengikuti pelatihan atau seminar untuk mengukur secara obyektif keberhasilan proses pembelajaran.

Setelah evaluasi dilakukan, hasilnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi atau penyesuaian rencana personal CPD. Jika tujuan belum tercapai secara optimal, maka bidan dapat menentukan strategi baru atau

tambahan aktivitas CPD yang lebih sesuai untuk mencapai target kompetensi yang diinginkan.

E. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan, Ny. Dewi, telah bekerja di puskesmas selama 15 tahun. Ia merasa bahwa pengetahuan tentang manajemen preeklamsia yang dimilikinya tidak lagi sesuai dengan pedoman klinis terbaru. Ia ingin meningkatkan kompetensinya tetapi terbatas dalam hal waktu karena beban tugas harian yang padat. Langkah awal yang paling efektif untuk membantu Ny. Dewi dalam merancang rencana CPD pribadinya adalah...

- A. Langsung mengikuti pelatihan klinis preeklamsia.
- B. Membaca pedoman klinis terbaru secara mandiri.
- C. Melakukan penilaian kebutuhan pembelajaran (learning needs assessment).
- D. Mengikuti ujian kompetensi secara formal.
- E. Menyusun jadwal seminar tahunan di luar daerah.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Langkah awal dalam CPD yang efektif adalah melakukan penilaian kebutuhan pembelajaran untuk mengetahui secara tepat area yang perlu diperbaiki sehingga aktivitas CPD lebih terarah.

Soal 2

Bidan Nurul bekerja di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh transportasi umum. Ia kesulitan mengikuti pelatihan tatap muka secara rutin, namun tetap ingin memperbaharui kompetensi kebidanannya secara berkala. Strategi terbaik yang dapat dilakukan Bidan Nurul untuk mengatasi kendala geografisnya adalah...

- A. Secara berkala mengajukan cuti untuk pelatihan di kota besar.
- B. Mengikuti webinar dan modul e-learning secara teratur.
- C. Mengabaikan pelatihan karena kendala transportasi.
- D. Menunggu adanya pelatihan di wilayahnya saja.
- E. Mengirim staf junior untuk mengikuti pelatihan.

Kunci Jawaban: B

Rasional: Teknologi digital seperti webinar atau modul e-learning memungkinkan bidan di daerah terpencil tetap mengikuti perkembangan terbaru tanpa kendala geografis.

Soal 3

Seorang bidan muda, Ny. Anita, baru selesai mengikuti workshop resusitasi neonatus. Untuk mengetahui apakah keterampilan barunya telah efektif dan berhasil diterapkan dalam praktiknya sehari-hari, metode evaluasi CPD yang paling tepat untuk dilakukan adalah...

- A. Mengikuti seminar tambahan terkait resusitasi neonatus.
- B. Melakukan refleksi praktik mandiri tanpa dokumentasi.
- C. Mengajukan permintaan supervisi langsung dari mentor atau supervisor klinis.
- D. Mengikuti ujian teoritis kembali di akhir tahun.
- E. Mempelajari pedoman klinis tambahan secara mandiri.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Supervisi langsung memungkinkan penilaian secara objektif dan mendalam terkait keterampilan klinis yang diperoleh selama pelatihan, sehingga evaluasi hasil CPD menjadi lebih valid.

Soal 4

Sebuah klinik bersalin memiliki keterbatasan fasilitas pelatihan bagi para bidannya, dan institusi tersebut juga belum memiliki kebijakan yang mendukung pengembangan CPD. Tindakan prioritas yang paling efektif untuk meningkatkan implementasi CPD bagi seluruh bidan di klinik tersebut adalah...

- A. Setiap bidan secara pribadi mengajukan permohonan mengikuti pelatihan eksternal.
- B. Mengadakan diskusi rutin antar bidan tanpa melibatkan manajemen.
- C. Melakukan advokasi kepada pimpinan klinik untuk merancang kebijakan dan menyediakan fasilitas pendukung CPD.
- D. Secara mandiri mengikuti pelatihan dengan biaya sendiri.
- E. Mengabaikan CPD hingga ada perintah resmi dari atasan.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Advokasi institusional penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan CPD secara optimal melalui kebijakan formal, anggaran, dan fasilitas.

Soal 5

Bidan Sari menyadari bahwa selama ini ia jarang melakukan refleksi atas praktik klinisnya sehari-hari. Setelah memahami konsep CPD, ia ingin meningkatkan kualitas

pelayanan yang ia berikan melalui refleksi yang rutin. Manfaat utama dari refleksi praktik klinis secara rutin bagi bidan Sari adalah...

- A. Menurunkan beban administratif yang dimilikinya.
- B. Meningkatkan kompetensi praktis secara cepat tanpa pelatihan tambahan.
- C. Membantu mengenali kelemahan praktik dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis.
- D. Menghindari kebutuhan mengikuti pelatihan formal.
- E. Menggantikan kebutuhan supervisi dari mentor.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Refleksi praktik klinis secara rutin merupakan komponen penting dalam CPD, karena membantu bidan mengenali kelemahan praktiknya, memperkuat kemampuan berpikir kritis, dan secara signifikan memperbaiki kualitas keputusan klinis.

F. Rangkuman Materi

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) dalam kebidanan adalah proses pembelajaran sepanjang hayat yang terstruktur dan sistematis, bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional bidan agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat. CPD dalam kebidanan mencakup kegiatan pelatihan, seminar, refleksi praktik, mentoring, hingga penelitian mandiri untuk memperbarui pengetahuan ilmiah, meningkatkan keterampilan klinis, memastikan praktik berbasis bukti, serta meningkatkan kualitas layanan kebidanan secara keseluruhan.

Belajar sepanjang hayat menjadi prinsip utama CPD yang fundamental bagi profesi bidan, mengingat cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan serta perubahan praktik kebidanan yang dinamis. Tanpa komitmen pembelajaran berkelanjutan, kompetensi bidan bisa tertinggal dan tidak relevan, yang berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan. Selain itu, CPD juga penting dalam mempertahankan standar pelayanan internasional, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis bidan.

Dalam implementasinya, CPD menemui berbagai tantangan nyata, seperti keterbatasan waktu akibat beban kerja tinggi, keterbatasan akses pelatihan terutama di daerah terpencil, serta minimnya dukungan institusional. Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut mencakup penyusunan jadwal CPD yang fleksibel, memanfaatkan teknologi digital untuk akses pembelajaran daring, dan advokasi

institusional untuk mendapatkan dukungan penuh dalam bentuk kebijakan, fasilitas, serta anggaran.

Untuk efektivitas CPD, bidan perlu menyusun rencana personal yang mencakup penilaian kebutuhan pembelajaran (learning needs assessment), menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas berdasarkan prinsip SMART, memilih aktivitas CPD yang relevan dan realistis, serta melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan penyesuaian strategi belajar selanjutnya. Dengan implementasi yang baik, CPD akan memastikan bidan mampu menghadapi berbagai tantangan profesi, serta secara optimal memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara menyeluruh.

G. Glosarium

Advokasi Institusional

Proses memperjuangkan kebijakan, dukungan fasilitas, dan sumber daya dari institusi atau organisasi demi mendukung pelaksanaan program CPD secara optimal.

Belajar Sepanjang Hayat (Lifelong Learning)

Konsep bahwa proses pembelajaran dan pengembangan diri seseorang tidak terbatas hanya pada pendidikan formal, melainkan berkelanjutan sepanjang kehidupan.

Continuous Professional Development (CPD)

Suatu proses pembelajaran sepanjang hayat yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional tenaga kesehatan, khususnya bidan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Praktik klinis yang menggunakan hasil penelitian ilmiah terbaru sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan, guna menjamin kualitas layanan yang aman, efektif, dan efisien.

Evaluasi Diri (Self-Evaluation)

Penilaian mandiri oleh bidan terhadap kompetensi dan kinerjanya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan, serta menentukan kebutuhan pembelajaran lebih lanjut.

Evaluasi Keberhasilan CPD

Proses mengukur pencapaian tujuan pembelajaran melalui berbagai metode seperti observasi langsung, tes kompetensi, atau refleksi praktik, untuk memastikan efektivitas program CPD.

Feedback Supervisor/Mentor

Masukan dan penilaian konstruktif yang diberikan oleh supervisor atau mentor kepada bidan berdasarkan pengamatan langsung terhadap praktik klinis, bertujuan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Kompetensi Klinis

Kemampuan praktis dan keterampilan teknis seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang mencakup prosedur klinis seperti persalinan, resusitasi bayi baru lahir, hingga penatalaksanaan komplikasi kebidanan.

Komunikasi Terapeutik

Keterampilan komunikasi yang bertujuan menciptakan hubungan saling percaya antara bidan dengan pasien, keluarga, dan komunitas, sehingga layanan kebidanan berjalan efektif dan empatik.

Learning Needs Assessment (Penilaian Kebutuhan Pembelajaran)

Proses sistematis untuk mengidentifikasi secara akurat kebutuhan pembelajaran spesifik yang diperlukan bidan guna meningkatkan kompetensi dan keterampilannya.

Mentoring

Hubungan bimbingan yang terstruktur antara seorang bidan senior atau ahli dengan bidan yang lebih junior atau kurang berpengalaman, bertujuan meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri, dan profesionalisme.

Metode SMART

Kerangka penetapan tujuan pembelajaran yang terdiri dari prinsip Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time-bound (memiliki batas waktu jelas).

Peer-learning

Metode pembelajaran yang melibatkan diskusi dan interaksi antar sejawat untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta memahami berbagai kasus klinis secara kolaboratif.

Pelatihan Klinis

Kegiatan CPD berupa pelatihan praktis yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknis klinis bidan dalam situasi nyata atau simulasi seperti manajemen emergensi obstetri atau resusitasi bayi baru lahir.

Pembelajaran Daring (E-Learning)

Metode pembelajaran menggunakan platform digital yang memungkinkan bidan mengakses materi pelatihan secara fleksibel tanpa batasan geografis dan waktu.

Pembelajaran Mandiri (Self-directed Learning)

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh bidan atas inisiatif sendiri, termasuk membaca jurnal, mengakses pedoman klinis terbaru, dan melakukan refleksi mandiri terhadap praktik kebidanan.

Penelitian Mandiri

Aktivitas penelitian atau pengumpulan informasi yang dilakukan secara mandiri oleh bidan, guna mengembangkan wawasan ilmiah dan penerapan praktik kebidanan berbasis bukti terbaru.

Perawatan Maternitas Berpusat pada Keluarga (Family-Centered Maternity Care)

Pendekatan pelayanan kebidanan yang memprioritaskan kebutuhan dan keterlibatan aktif keluarga dalam perawatan ibu dan bayi.

Refleksi Praktik Klinis

Proses berpikir kritis dan evaluasi mendalam oleh bidan terhadap pengalaman praktik klinis sehari-hari, bertujuan mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan area pengembangan lebih lanjut.

Regulasi Profesi

Ketentuan dan aturan yang dibuat oleh lembaga atau otoritas profesi kebidanan yang mengatur kewajiban bidan dalam melaksanakan kegiatan CPD untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).

Seminar dan Workshop

Kegiatan edukasi formal berupa pertemuan ilmiah atau pelatihan singkat yang membahas perkembangan terbaru dalam bidang kebidanan untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan.

Standar Kompetensi Nasional/Internasional

Kriteria dan acuan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh bidan dalam menjalankan tugas profesionalnya, ditetapkan oleh lembaga nasional maupun internasional seperti Kementerian Kesehatan RI, International Confederation of Midwives (ICM), atau WHO.

Supervisi Klinis

Proses pengawasan langsung oleh tenaga ahli atau mentor terhadap praktik klinis bidan, bertujuan menilai kompetensi secara objektif dan memberikan umpan balik konstruktif untuk peningkatan kualitas layanan.

Teknik Aseptik

Keterampilan dan prosedur klinis yang bertujuan mencegah infeksi dengan menjaga sterilitas selama pelayanan kebidanan, khususnya selama persalinan atau tindakan medis lainnya.

Teknologi Digital dalam CPD

Pemanfaatan perangkat lunak, platform online, atau aplikasi digital dalam memudahkan akses materi, informasi, dan interaksi antar profesional untuk mendukung kegiatan CPD secara fleksibel.

H. Daftar Pustaka

- Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pengembangan profesional berkelanjutan tenaga kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Browning, L., & Lavender, T. (2020). The impact of continuing professional development on midwives' clinical competence: A systematic review. *Midwifery*, 87(2020), 102-111. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102727>
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). Essential competencies for midwifery practice 2021 update. Retrieved from <https://www.internationalmidwives.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelayanan kebidanan berbasis bukti (evidence-based midwifery practice). Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Lestari, S., & Purwanti, A. (2020). Pelaksanaan pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) dalam peningkatan kompetensi bidan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kebidanan Indonesia*, 10(2), 71-79. <https://doi.org/10.32584/jiki.v10i2.654>
- McCarthy, C., Cornally, N., & Courtney, M. (2020). Midwives' experiences of continuing professional education: A qualitative study. *Nurse Education Today*, 92(2020), 104502. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104502>

- Notoatmodjo, S. (2022). Pendidikan dan perilaku kesehatan (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik profesional. Jakarta: Salemba Medika.
- Setyowati, S., & Supriyatiningsih, S. (2020). Pentingnya continuing professional development dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 12-21. <https://doi.org/10.32960/jkki.v5i1.789>
- Sholikhah, M., & Nuraini, T. (2021). Implementasi pembelajaran sepanjang hayat pada tenaga kesehatan di layanan primer. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 201-208. <https://doi.org/10.26553/jikm.2021.12.3.201-208>
- World Health Organization. (2021). Continuing professional development (CPD) guidelines for midwives and nurses: Ensuring competency and quality care. Geneva: WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications-detail/cpd-guidelines-midwives-nurses>
- Yanti, Y., & Marthias, T. (2021). Analisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan CPD pada bidan di wilayah terpencil Indonesia. *Indonesian Journal of Midwifery and Maternal Health*, 5(1), 34-42. <https://doi.org/10.26714/ijmmh.5.1.2021.34-42>

BAB 11

PENGANTAR KEPEMIMPINAN DALAM KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menunjukkan kompetensi sebagai pemimpin dalam praktik kebidanan, yang mencakup kemampuan mengelola pelayanan kebidanan, mengambil keputusan secara etis dan profesional, serta mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar kepemimpinan dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi berbagai tipe dan gaya kepemimpinan yang relevan dalam praktik kebidanan.
- Mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kebidanan.
- Menganalisis tantangan dan peluang kepemimpinan dalam praktik kebidanan kontemporer.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan subtopik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi, tujuan, dan pentingnya kepemimpinan dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi dan membedakan berbagai tipe dan gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan transformasional, transaksional, demokratis, otoriter, dan laissez-faire dalam konteks kebidanan.
- Menguraikan prinsip dasar kepemimpinan seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, delegasi tugas, pengambilan keputusan secara kolaboratif, dan advokasi pasien.
- Menganalisis studi kasus yang menunjukkan peran kepemimpinan dalam peningkatan kualitas layanan kebidanan.
- Merancang strategi pengembangan keterampilan kepemimpinan secara kontinu dalam praktik kebidanan.

Pendahuluan

Kepemimpinan dalam kebidanan adalah elemen esensial yang menentukan kualitas layanan kebidanan serta kesejahteraan ibu dan bayi. Seorang bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi pelayanan klinis, tetapi juga sebagai pemimpin yang efektif, mampu mengambil keputusan secara profesional, mengelola tim, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan inspirasi kepada rekan sejawat serta masyarakat luas. Dalam konteks kebidanan, kepemimpinan mencakup kemampuan manajerial, pengambilan keputusan etis, advokasi pasien, serta pengembangan diri secara kontinu demi menghadapi tantangan dalam dunia kesehatan yang terus berkembang.

Kepemimpinan dalam kebidanan bertujuan untuk memastikan terciptanya praktik kebidanan yang aman, efektif, efisien, dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, keterampilan kepemimpinan perlu dikembangkan secara sistematis melalui pendidikan formal dan informal agar seorang bidan mampu menjadi agen perubahan positif di lingkungan kerjanya.

A. Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Kebidanan

Kepemimpinan dalam kebidanan merupakan bagian integral dari kompetensi profesional seorang bidan. Secara konseptual, kepemimpinan dalam kebidanan mengacu pada kemampuan seorang bidan dalam memengaruhi, mengarahkan, dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Kepemimpinan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan memimpin secara administratif atau manajerial, tetapi juga mencakup kemampuan klinis, etis, dan interpersonal dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Secara umum, konsep dasar kepemimpinan dalam kebidanan didasarkan pada pemahaman bahwa bidan tidak hanya berperan sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan langsung kepada ibu dan bayi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan, advokat kesehatan, pengambil keputusan klinis, edukator, dan mentor bagi rekan sejawat maupun generasi penerus dalam profesi. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi kepemimpinan sebagai elemen inti dalam kurikulum pendidikan kebidanan.

Kepemimpinan dalam kebidanan menekankan pada prinsip kolaborasi, yaitu kemampuan bidan untuk bekerjasama secara harmonis dengan berbagai profesi kesehatan lainnya, seperti dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, serta dengan keluarga pasien. Kolaborasi ini esensial karena proses persalinan dan perawatan maternal neonatal sering melibatkan berbagai pihak yang harus bekerja bersama secara efektif demi keselamatan pasien.

Selain kolaborasi, konsep kepemimpinan dalam kebidanan juga mencakup kemampuan komunikasi yang efektif. Bidan sebagai pemimpin dituntut untuk mampu menyampaikan informasi dengan jelas, akurat, dan empati kepada pasien dan keluarganya, serta mampu berkomunikasi secara asertif dengan rekan sejawat dan pihak lain dalam lingkungan kerja. Kemampuan komunikasi yang baik akan meminimalkan kesalahan dan miskomunikasi, yang berkontribusi langsung terhadap keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan.

Selanjutnya, aspek penting lainnya dari konsep dasar kepemimpinan kebidanan adalah pengambilan keputusan klinis berbasis bukti (evidence-based practice). Sebagai pemimpin dalam praktik klinis, bidan harus mampu mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis, serta preferensi pasien dalam membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Proses

pengambilan keputusan yang efektif ini memerlukan keterampilan berpikir kritis, kemampuan analitis, serta kesadaran akan etika dan legalitas praktik.

Di samping kemampuan teknis tersebut, kepemimpinan dalam kebidanan juga mencakup tanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Hal ini meliputi manajemen waktu, tenaga, alat medis, hingga sumber daya keuangan yang tersedia dalam pelayanan kebidanan. Seorang bidan pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan, mengatur prioritas, serta merancang strategi untuk mengoptimalkan sumber daya demi tercapainya pelayanan yang optimal bagi pasien.

Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan kebidanan juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, positif, dan suportif. Seorang bidan pemimpin diharapkan mampu memberikan motivasi, membangun semangat tim, serta menciptakan budaya kerja yang menghormati hak-hak tenaga kesehatan maupun pasien. Budaya kerja yang sehat dan kondusif akan meningkatkan kepuasan kerja staf, yang pada akhirnya juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, seorang bidan pemimpin juga perlu memiliki kesadaran akan pengembangan profesional berkelanjutan (Continuous Professional Development/CPD). Bidan sebagai pemimpin harus mampu mendorong dirinya sendiri maupun rekan-rekannya untuk terus belajar, mengikuti pelatihan, seminar, dan melakukan refleksi terhadap praktik klinis yang telah dijalankan. Dengan demikian, kompetensi dan wawasan mereka terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Pada akhirnya, konsep dasar kepemimpinan dalam kebidanan berpusat pada pemahaman bahwa seorang bidan yang mampu memimpin tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan maternal neonatal, tetapi juga memainkan peran penting dalam advokasi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks sosial budaya yang lebih luas. Melalui kepemimpinan yang efektif, bidan mampu memastikan bahwa setiap ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang aman, berkualitas, dan bermartabat.

B. Teori dan Gaya Kepemimpinan dalam Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, pemahaman mengenai teori dan gaya kepemimpinan memiliki peranan penting untuk menunjang efektivitas pelayanan serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif. Kepemimpinan dalam kebidanan tidak sekadar bertumpu pada aspek manajerial dan administratif saja,

melainkan juga melibatkan bagaimana seorang bidan mampu menggerakkan orang lain, mengelola berbagai situasi klinis yang kompleks, serta memfasilitasi komunikasi yang efektif antarprofesi dan dengan pasien. Untuk memahami ini lebih dalam, berbagai teori kepemimpinan dapat diterapkan dan dikaji secara kontekstual dalam pelayanan kebidanan.

Salah satu teori klasik yang relevan dalam konteks kebidanan adalah teori kepemimpinan situasional (Situational Leadership) yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling ideal untuk semua situasi. Sebaliknya, seorang pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kematangan bawahan atau anggota tim yang dipimpinnya, baik secara kompetensi teknis maupun kesiapan mental. Dalam konteks kebidanan, seorang bidan yang memimpin tim di klinik bersalin atau unit maternitas perlu mampu secara fleksibel menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi pasien, kapasitas anggota tim, dan situasi klinis yang dihadapi. Misalnya, ketika menghadapi situasi darurat persalinan, gaya kepemimpinan yang lebih otoritatif dan terarah (directive leadership) mungkin diperlukan untuk memastikan tindakan cepat dan tepat diambil. Sebaliknya, dalam kondisi tim yang matang, berpengalaman, dan kondisi stabil, gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan delegatif lebih tepat, guna memberikan ruang kreativitas dan meningkatkan motivasi serta tanggung jawab anggota tim.

Selanjutnya, teori lain yang banyak digunakan dalam kepemimpinan kebidanan adalah teori kepemimpinan transformasional yang pertama kali dikemukakan oleh James MacGregor Burns dan kemudian dikembangkan oleh Bernard M. Bass. Kepemimpinan transformasional menekankan pada kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi anggota tim melalui visi, semangat, nilai-nilai etika, serta hubungan interpersonal yang kuat. Seorang pemimpin transformasional dalam kebidanan mampu menciptakan perubahan positif dalam tim maupun organisasi dengan cara memberdayakan staf melalui edukasi, mentoring, dan pemberian contoh yang baik dalam praktik klinis dan etika. Misalnya, seorang bidan senior dapat menerapkan kepemimpinan transformasional dengan memotivasi para bidan muda untuk terus meningkatkan keterampilan klinis mereka melalui pembelajaran berkelanjutan, mendukung inovasi dalam praktik kebidanan, serta mendorong refleksi kritis terhadap pelayanan yang mereka berikan. Kepemimpinan jenis ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan

kesehatan, kepuasan kerja tim, serta membangun budaya organisasi yang positif dan progresif.

Sementara itu, teori kepemimpinan transaksional juga memberikan perspektif yang relevan dalam praktik kebidanan. Berbeda dengan kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada perubahan jangka panjang dan motivasi intrinsik, kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada pertukaran atau transaksi antara pemimpin dengan anggota tim. Dalam pendekatan ini, hubungan antara pemimpin dengan anggota tim didasarkan pada pemberian penghargaan atau sanksi sesuai pencapaian atau kegagalan yang dialami. Dalam kebidanan, gaya transaksional ini mungkin efektif diterapkan dalam situasi-situasi tertentu, seperti pengelolaan administrasi, pemantauan standar praktik klinis, dan pengawasan pencapaian target-target pelayanan kesehatan tertentu yang terukur secara objektif.

Selain berbagai teori tersebut, gaya kepemimpinan dalam kebidanan juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal pemimpin dan budaya organisasi tempat bidan bekerja. Gaya kepemimpinan yang umum diterapkan dalam kebidanan mencakup gaya otoritatif, demokratis, laissez-faire, dan gaya coaching. Gaya otoritatif merujuk pada pemimpin yang mengambil keputusan secara mandiri dan memberikan arahan yang jelas kepada anggota tim. Gaya ini sangat efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat harus diambil untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Namun, jika diterapkan secara berlebihan dalam kondisi yang tidak mendesak, gaya ini bisa menimbulkan rasa ketidakpuasan di antara staf, karena minimnya ruang partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan demokratis menjadi gaya yang banyak diterapkan dalam praktik kebidanan modern. Gaya ini menekankan pentingnya partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan serta mendukung dialog terbuka dan kolaborasi antar anggota tim. Dalam konteks kebidanan, gaya ini menciptakan lingkungan kerja yang suportif, di mana setiap anggota merasa dihargai, didengar pendapatnya, serta ikut bertanggung jawab atas hasil keputusan bersama. Hal ini terbukti efektif meningkatkan kepuasan kerja staf dan kualitas pelayanan yang lebih baik karena keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat.

Gaya laissez-faire merujuk pada gaya kepemimpinan yang cenderung pasif dan membiarkan anggota tim untuk mengatur dirinya sendiri. Meskipun gaya ini memberi kebebasan maksimal kepada staf, penerapannya dalam praktik kebidanan perlu kehati-hatian tinggi, karena jika tidak disertai pengawasan yang tepat, bisa berpotensi menurunkan kualitas pelayanan atau menimbulkan konflik internal.

Umumnya, gaya ini cocok diterapkan pada tim kebidanan yang sudah sangat berpengalaman dan memiliki tingkat kematangan profesional tinggi.

Terakhir, gaya coaching atau mentoring merupakan gaya kepemimpinan yang banyak digunakan dalam konteks kebidanan pendidikan. Seorang pemimpin dengan gaya ini fokus pada pengembangan profesional dan personal anggota timnya, dengan memberikan bimbingan, pelatihan, serta umpan balik yang konstruktif secara terus-menerus. Gaya coaching sangat efektif diterapkan dalam lingkungan akademik maupun klinis, khususnya dalam membentuk generasi bidan yang kompeten, percaya diri, serta mampu berpikir kritis dalam menghadapi tantangan klinis dan profesional.

Secara keseluruhan, teori dan gaya kepemimpinan dalam kebidanan tidak bersifat kaku dan eksklusif, tetapi lebih bersifat dinamis, adaptif, serta kontekstual sesuai situasi dan kebutuhan yang dihadapi. Seorang bidan pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memahami, memilih, serta menerapkan berbagai teori dan gaya kepemimpinan secara tepat dan fleksibel, sehingga mampu mencapai hasil pelayanan kebidanan yang optimal serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, dan progresif bagi tim kesehatan maupun pasien.

C. Peran Pemimpin dalam Praktik Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, peran pemimpin tidak sekadar terbatas pada pengawasan administratif atau klinis, melainkan juga mencakup tanggung jawab luas yang mempengaruhi keseluruhan sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Pemimpin dalam praktik kebidanan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa asuhan yang diberikan kepada ibu dan bayi berjalan secara optimal, aman, efisien, serta sesuai dengan standar kompetensi profesi. Oleh karena itu, penting bagi seorang bidan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran kepemimpinan tersebut diwujudkan dalam praktik sehari-hari, baik secara klinis maupun organisasi.

Pertama-tama, pemimpin dalam praktik kebidanan berperan sebagai agen perubahan dan inovator. Dalam hal ini, pemimpin bertanggung jawab untuk mempromosikan perubahan positif dalam praktik kebidanan, baik melalui implementasi penelitian terbaru, pengembangan metode pelayanan yang inovatif, atau adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan praktik berbasis bukti (evidence-based practice). Sebagai agen perubahan, seorang bidan pemimpin dituntut untuk selalu terbuka terhadap pembaruan pengetahuan dan keterampilan, serta mampu menginspirasi rekan sejawatnya agar turut mengikuti perkembangan

yang ada. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Selanjutnya, pemimpin dalam praktik kebidanan berfungsi sebagai pengambil keputusan klinis yang efektif. Tanggung jawab ini melibatkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengidentifikasi masalah secara cepat dan tepat, menganalisis situasi klinis secara kritis, dan mengambil keputusan yang berdasarkan bukti ilmiah terbaru serta kondisi spesifik pasien. Keputusan yang diambil pemimpin di sini sangat vital karena langsung mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Dalam situasi kritis seperti kegawatdaruratan obstetri, pemimpin harus mampu menunjukkan ketenangan, ketegasan, dan kejelasan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari risiko yang dapat mengancam keselamatan pasien.

Sebagai edukator atau pendidik, pemimpin kebidanan berperan dalam pengembangan kompetensi profesional bidan lainnya melalui pelatihan, bimbingan klinis (mentoring), serta edukasi berkelanjutan. Dalam peran ini, pemimpin tidak hanya berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas asuhan yang diberikan oleh timnya, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan budaya pembelajaran yang kondusif. Bidan pemimpin sering kali terlibat aktif dalam memberikan pelatihan keterampilan klinis, workshop, dan seminar yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kompetensi klinis para bidan muda maupun mahasiswa kebidanan. Edukasi yang diberikan juga mencakup penguatan aspek etika, komunikasi efektif, dan keterampilan interpersonal yang esensial dalam praktik sehari-hari.

Lebih lanjut, pemimpin dalam praktik kebidanan juga memiliki peran penting sebagai advokat atau pembela hak pasien. Dalam konteks ini, pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pasien, terutama perempuan dan bayi yang sering kali menjadi kelompok rentan, terpenuhi dan terlindungi. Pemimpin kebidanan harus mampu memperjuangkan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang manusiawi, menghormati keputusan dan pilihan pasien, serta melindungi mereka dari praktik-praktik yang tidak etis. Dalam peran advokasi ini, pemimpin kebidanan sering kali menjadi suara penting dalam mengedukasi keluarga pasien maupun komunitas tentang hak-hak kesehatan reproduksi serta pentingnya keterlibatan aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatannya.

Selain itu, dalam perannya sebagai fasilitator komunikasi, pemimpin dalam kebidanan bertugas memastikan bahwa komunikasi yang terjalin di antara anggota

tim kesehatan, pasien, serta keluarga pasien berlangsung efektif, jelas, dan empatik. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung komunikasi terbuka, mendorong anggota tim untuk menyuarakan pendapat, dan memastikan bahwa semua informasi klinis tersampaikan dengan jelas kepada pasien. Pemimpin yang mampu memfasilitasi komunikasi secara efektif dapat mencegah terjadinya miskomunikasi, yang sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan medis serta ketidakpuasan pasien.

Dalam aspek manajerial, pemimpin kebidanan juga berperan sebagai manajer sumber daya yang baik. Seorang bidan pemimpin perlu mampu mengelola sumber daya manusia, peralatan medis, anggaran pelayanan kesehatan, serta waktu secara efisien dan efektif. Tugas ini melibatkan perencanaan kebutuhan pelayanan, penjadwalan staf, alokasi sumber daya secara proporsional, hingga evaluasi secara berkala atas pemanfaatan sumber daya tersebut. Peran ini memastikan bahwa pelayanan kebidanan dapat berjalan dengan optimal tanpa pemborosan ataupun kekurangan sumber daya yang vital.

Selanjutnya, pemimpin kebidanan memainkan peran penting sebagai pembangun budaya kerja yang sehat dan suportif. Bidan sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kontribusi seluruh anggota tim, memberikan apresiasi atas pencapaian staf, serta memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan dalam situasi-situasi menantang. Dengan membangun budaya kerja yang sehat, pemimpin membantu meningkatkan motivasi, semangat kerja, serta kesejahteraan mental dan emosional anggota tim, yang secara langsung berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kebidanan.

Tidak kalah pentingnya, seorang pemimpin dalam praktik kebidanan juga bertindak sebagai mentor atau role model profesional. Dalam peran ini, pemimpin harus mampu memberikan teladan positif dalam aspek kompetensi klinis, profesionalisme, integritas, serta etika praktik kebidanan. Bidan pemimpin bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan kepada bidan muda, membantu mereka dalam mengembangkan karier, membangun kepercayaan diri, serta mendorong perkembangan personal dan profesional secara seimbang.

Secara keseluruhan, peran pemimpin dalam praktik kebidanan sangatlah kompleks dan multidimensional. Seorang pemimpin kebidanan harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek ini secara harmonis dan efektif dalam praktik klinis sehari-hari, dengan tujuan akhir memastikan bahwa setiap ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang berkualitas, aman, manusiawi, dan berbasis bukti.

ilmiah terbaik. Dengan menjalankan berbagai peran tersebut secara konsisten dan penuh tanggung jawab, pemimpin kebidanan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga turut membentuk generasi penerus profesi yang kompeten, berdedikasi, dan berintegritas tinggi.

D. Strategi Kepemimpinan Efektif dalam Pelayanan Kebidanan

Strategi kepemimpinan efektif dalam pelayanan kebidanan merupakan serangkaian pendekatan yang dirancang secara sistematis oleh seorang bidan pemimpin untuk memastikan tercapainya pelayanan kebidanan yang optimal, berkualitas tinggi, aman, serta mampu memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif. Kepemimpinan yang efektif dalam kebidanan tidak hanya bergantung pada keterampilan klinis yang unggul, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengelola tim secara harmonis, berkomunikasi secara jelas dan empatik, serta memastikan terlaksananya pelayanan kebidanan berdasarkan bukti ilmiah terkini.

Salah satu strategi utama dalam mencapai kepemimpinan efektif dalam kebidanan adalah penguatan komunikasi interpersonal dan tim. Dalam praktik kebidanan sehari-hari, komunikasi menjadi jantung dari setiap interaksi, baik antar tenaga kesehatan maupun antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga pasien. Seorang pemimpin yang efektif akan memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka, jelas, dan saling menghormati dalam tim, sekaligus mampu mendengarkan secara aktif terhadap masukan dan kebutuhan anggota tim serta pasien. Pemimpin kebidanan harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi yang dihadapi, sehingga mampu mencegah terjadinya miskomunikasi atau konflik yang dapat mengganggu jalannya pelayanan. Strategi ini mencakup pula kemampuan bidan pemimpin dalam memberikan umpan balik yang konstruktif serta memastikan bahwa informasi penting terkait kondisi pasien maupun prosedur klinis tersampaikan secara efektif kepada seluruh anggota tim kesehatan.

Strategi berikutnya adalah pengembangan budaya kolaborasi antarprofesi dalam pelayanan kebidanan. Seorang pemimpin yang efektif memahami pentingnya sinergi antara berbagai profesi kesehatan, seperti dokter kandungan, dokter anak, perawat, apoteker, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan maternal neonatal. Strategi ini melibatkan pendekatan multidisiplin di mana setiap profesi dapat memberikan kontribusi terbaiknya secara harmonis demi keselamatan pasien. Pemimpin kebidanan yang efektif mampu menciptakan suasana kerja kolaboratif dengan mendorong dialog terbuka, menghargai peran

masing-masing profesi, dan memastikan bahwa setiap keputusan klinis diambil melalui proses konsultasi dan diskusi tim yang konstruktif. Dengan demikian, hasil akhir pelayanan kebidanan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih optimal karena mencerminkan keahlian kolektif seluruh tim kesehatan.

Selanjutnya, strategi penting lainnya dalam kepemimpinan efektif dalam pelayanan kebidanan adalah penerapan manajemen risiko berbasis bukti (evidence-based risk management). Bidan pemimpin harus mampu secara aktif mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai risiko klinis yang mungkin terjadi dalam pelayanan kebidanan. Strategi ini melibatkan penerapan protokol standar yang jelas berdasarkan penelitian ilmiah terbaru, serta pendekatan preventif dalam menghadapi situasi klinis yang berisiko tinggi, seperti kasus preeklamsia, perdarahan postpartum, atau asfiksia neonatus. Pemimpin kebidanan yang efektif akan memastikan bahwa seluruh anggota tim memahami dan mematuhi standar prosedur yang berlaku, serta mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat. Strategi ini juga mencakup evaluasi rutin terhadap kualitas pelayanan serta pengembangan tindakan korektif yang berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Strategi efektif lainnya dalam kepemimpinan kebidanan adalah pemberdayaan tim melalui pendekatan edukasi berkelanjutan (Continuous Professional Development/CPD). Pemimpin yang efektif harus mampu mendorong anggota timnya untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan formal maupun informal, seminar, workshop, serta proses refleksi praktik klinis secara rutin. Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi teknis anggota tim, tetapi juga untuk membangun rasa percaya diri, tanggung jawab, serta rasa memiliki terhadap pekerjaan yang dilakukan. Pemimpin kebidanan yang mampu menerapkan strategi edukasi berkelanjutan ini secara konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang proaktif, adaptif terhadap perubahan, dan selalu berorientasi pada kualitas pelayanan yang tinggi.

Strategi lainnya yang tidak kalah penting dalam kepemimpinan efektif adalah pendekatan mentoring dan role modelling. Pemimpin kebidanan yang efektif tidak sekadar memberikan arahan atau instruksi, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. Seorang bidan pemimpin yang menjadi role model profesional akan memberikan dampak besar terhadap pembentukan karakter dan etika kerja anggota tim lainnya. Selain itu, melalui pendekatan mentoring, pemimpin mampu membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan anggota tim, memberikan bimbingan pribadi maupun profesional, serta membantu mereka

dalam mengatasi tantangan atau kesulitan klinis yang dihadapi. Strategi ini menciptakan rasa saling percaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kohesivitas tim serta kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan.

Selanjutnya, strategi yang tak boleh dilupakan dalam mencapai efektivitas kepemimpinan kebidanan adalah kemampuan pengambilan keputusan klinis secara cepat, tepat, dan berbasis bukti ilmiah terbaru. Pemimpin kebidanan harus mampu menganalisis setiap situasi klinis secara kritis, memanfaatkan berbagai sumber informasi yang relevan, serta mempertimbangkan kondisi pasien secara holistik dalam mengambil keputusan. Kemampuan pengambilan keputusan yang baik ini akan memberikan rasa aman kepada anggota tim serta pasien, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pelayanan klinis. Strategi ini juga mencakup kemampuan pemimpin untuk mengkomunikasikan keputusan tersebut secara jelas dan rasional kepada tim maupun pasien, sehingga dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Tidak kalah pentingnya, strategi kepemimpinan yang efektif juga mencakup pengelolaan emosi dan stres dalam tim. Dalam praktik kebidanan, situasi klinis yang dihadapi sering kali menantang dan penuh tekanan. Seorang pemimpin kebidanan yang efektif harus mampu membantu anggota timnya dalam mengelola stres, menciptakan lingkungan kerja yang suportif, serta memberikan dukungan emosional ketika diperlukan. Strategi ini menciptakan kondisi kerja yang positif, meningkatkan kesejahteraan mental tenaga kesehatan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Pada akhirnya, strategi kepemimpinan yang efektif dalam pelayanan kebidanan menuntut seorang pemimpin untuk mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan ini secara harmonis dan kontekstual sesuai situasi klinis maupun organisasional yang dihadapi. Pemimpin kebidanan yang berhasil menerapkan berbagai strategi ini tidak hanya akan menciptakan tim yang kompeten dan berdedikasi tinggi, tetapi juga akan memastikan bahwa pelayanan kebidanan yang diberikan kepada masyarakat selalu optimal, aman, manusiawi, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

E. Kepemimpinan dalam Manajemen Risiko dan Keamanan Pasien

Kepemimpinan dalam manajemen risiko dan keamanan pasien dalam praktik kebidanan merupakan aspek fundamental yang berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan serta keselamatan ibu dan bayi. Manajemen risiko dalam konteks

kebidanan merujuk pada serangkaian proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko klinis atau administratif yang dapat memengaruhi keselamatan pasien maupun kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan proses ini dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi dalam setiap aspek pelayanan kebidanan.

Pemimpin kebidanan memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya keselamatan pasien, yaitu lingkungan kerja yang secara aktif mengutamakan identifikasi risiko, pelaporan kesalahan, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, dan penerapan langkah-langkah preventif agar insiden yang membahayakan pasien dapat diminimalisasi. Seorang pemimpin kebidanan yang efektif harus mampu menciptakan suasana kerja yang terbuka dan suportif, di mana staf merasa nyaman melaporkan kejadian yang hampir menyebabkan kesalahan (near miss), maupun insiden keselamatan yang telah terjadi tanpa rasa takut disalahkan atau diberi sanksi secara sepihak. Lingkungan kerja yang terbuka ini memungkinkan pemimpin untuk mendapatkan informasi akurat yang diperlukan dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap potensi risiko dalam pelayanan kebidanan, sehingga langkah perbaikan dan pencegahan dapat segera diterapkan.

Dalam upaya mencapai manajemen risiko yang efektif, pemimpin kebidanan harus mampu mengadopsi pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based). Artinya, setiap keputusan klinis maupun kebijakan organisasi dalam praktik kebidanan didasarkan pada penelitian ilmiah terbaru, pedoman klinis yang telah divalidasi, dan standar kompetensi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Seorang pemimpin kebidanan harus secara aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini, baik melalui pelatihan berkelanjutan, membaca literatur terbaru, ataupun berpartisipasi dalam forum diskusi profesional yang relevan. Dengan demikian, pemimpin mampu memastikan bahwa semua protokol klinis yang digunakan tim kebidanan selalu mutakhir, relevan, dan mampu meminimalkan potensi kesalahan yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi.

Dalam kaitannya dengan manajemen risiko klinis, seorang pemimpin kebidanan juga bertanggung jawab atas implementasi sistem pelaporan dan dokumentasi yang efektif dan sistematis. Kepemimpinan yang baik memastikan bahwa dokumentasi klinis dalam setiap tindakan kebidanan terisi lengkap, akurat, dan konsisten. Hal ini esensial, mengingat dokumentasi yang baik tidak hanya menjadi dasar hukum dalam pertanggungjawaban profesi, tetapi juga berfungsi

sebagai referensi penting dalam mengevaluasi insiden atau kesalahan klinis yang mungkin terjadi. Pemimpin kebidanan harus mampu memastikan bahwa semua anggota tim memahami pentingnya dokumentasi yang baik, serta bertanggung jawab dalam memastikan dokumentasi tersebut selalu diperbarui secara tepat waktu dan akurat.

Pemimpin kebidanan juga memiliki peran krusial dalam memberikan pelatihan khusus tentang manajemen risiko dan keselamatan pasien kepada timnya. Pelatihan tersebut mencakup pengenalan terhadap jenis-jenis risiko umum dalam praktik kebidanan, prosedur penanganan kegawatdaruratan obstetri, serta bagaimana melakukan komunikasi efektif dalam situasi krisis. Dalam hal ini, kepemimpinan tidak hanya bertindak sebagai pemberi instruksi tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong diskusi interaktif dan refleksi mendalam di antara anggota tim. Pelatihan rutin yang difasilitasi pemimpin kebidanan akan meningkatkan kesiapsiagaan staf dalam menghadapi berbagai situasi darurat, serta membangun kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya keselamatan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Dalam aspek klinis yang lebih spesifik, pemimpin kebidanan juga berperan langsung dalam memastikan bahwa tindakan-tindakan kebidanan dilakukan sesuai protokol klinis yang berlaku, seperti manajemen perdarahan postpartum, penanganan preeklamsia dan eklamsia, resusitasi bayi baru lahir, serta manajemen infeksi postpartum. Pemimpin kebidanan harus mampu mengawasi secara aktif penerapan prosedur klinis tersebut dan memastikan bahwa staf tidak mengambil jalan pintas atau mengabaikan standar prosedur yang sudah ditentukan. Dalam situasi tertentu, seorang pemimpin juga harus turun tangan langsung untuk memberikan bimbingan atau demonstrasi klinis guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar tepat dan aman.

Selain itu, pemimpin kebidanan juga memainkan peran penting dalam melibatkan pasien dan keluarganya sebagai mitra aktif dalam memastikan keselamatan pelayanan. Pemimpin harus mampu mendorong timnya untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada pasien dan keluarga mengenai risiko yang mungkin terjadi selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Strategi ini penting untuk menciptakan kesadaran serta membangun kerja sama dari pasien dan keluarga dalam meminimalisasi risiko yang dapat terjadi, seperti keterlambatan dalam mencari bantuan medis atau kurangnya kepatuhan terhadap instruksi klinis yang diberikan.

Tidak kalah pentingnya, pemimpin kebidanan juga bertugas untuk secara aktif memonitor dan mengevaluasi hasil pelayanan yang diberikan, dengan menggunakan indikator keselamatan pasien seperti angka kejadian perdarahan postpartum, insiden infeksi, mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi, serta insiden keselamatan lainnya. Evaluasi rutin terhadap indikator-indikator ini memungkinkan pemimpin untuk secara proaktif mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan risiko tertentu serta mengambil langkah-langkah preventif dan korektif secara tepat waktu.

Terakhir, pemimpin kebidanan memiliki peran strategis dalam menciptakan kerja sama multidisiplin yang kuat dengan tenaga kesehatan lainnya. Dalam konteks ini, pemimpin harus mampu menjalin komunikasi efektif, kolaborasi erat, serta membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara seluruh anggota tim, baik itu dokter kandungan, perawat, apoteker, maupun tenaga kesehatan lainnya. Kerja sama tim yang kuat dan harmonis akan sangat menentukan efektivitas dalam penanganan risiko klinis serta memastikan keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan kebidanan.

Dengan demikian, kepemimpinan dalam manajemen risiko dan keamanan pasien dalam praktik kebidanan tidak hanya mencakup pemahaman teori atau konsep semata, melainkan lebih pada implementasi praktis, aktif, dan berkelanjutan di semua lini pelayanan. Seorang pemimpin kebidanan yang efektif harus mampu mengintegrasikan berbagai strategi tersebut secara konsisten, sehingga tercipta budaya keselamatan pasien yang kuat, pelayanan kebidanan yang berkualitas, serta kepercayaan tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maternal neonatal yang diberikan.

F. Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Kebidanan di Era Digital

Kepemimpinan kebidanan di era digital menghadapi berbagai tantangan sekaligus menyajikan peluang unik yang harus dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan profesi kebidanan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Era digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kepemimpinan kebidanan saat ini tidak hanya harus adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga proaktif dalam mengelola dampak yang ditimbulkan dari perkembangan digitalisasi tersebut.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemimpin kebidanan di era digital adalah kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi

informasi yang begitu cepat. Digitalisasi di bidang kebidanan mencakup berbagai aplikasi teknologi, seperti rekam medis elektronik (electronic medical records atau EMR), telemedicine atau telekonsultasi kebidanan, aplikasi mobile untuk edukasi pasien, hingga penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi kesehatan. Hal ini menuntut pemimpin kebidanan untuk memiliki kompetensi digital yang memadai serta kemampuan teknis untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Pemimpin kebidanan yang kurang peka atau lambat dalam mengadaptasi perkembangan ini dapat mengalami hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga relevansi profesi di tengah tuntutan masyarakat yang semakin melek teknologi.

Selain adaptasi teknologi, tantangan berikutnya adalah masalah keamanan data pasien. Era digital memungkinkan data kesehatan pasien tersimpan dalam bentuk elektronik, yang meskipun memudahkan akses dan pertukaran informasi, juga rentan terhadap ancaman seperti kebocoran data atau serangan siber. Pemimpin kebidanan perlu memahami aspek keamanan siber (cyber security) serta mampu memastikan bahwa sistem digital yang digunakan memenuhi standar keamanan tertinggi. Tantangan ini mengharuskan pemimpin untuk menjalin kerja sama erat dengan tenaga IT profesional dalam merancang sistem digital yang aman, serta memberikan edukasi dan pelatihan kepada tim kebidanan tentang pentingnya menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pasien.

Di sisi lain, pemimpin kebidanan juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa semua anggota tim kebidanan memiliki kompetensi yang merata dalam menggunakan teknologi digital. Tantangan ini muncul terutama karena adanya kesenjangan digital di antara tenaga kesehatan, yang dipengaruhi oleh faktor generasi, pendidikan, serta akses terhadap pelatihan teknologi. Pemimpin kebidanan dituntut untuk menyediakan pelatihan rutin, mentoring, serta dukungan teknis yang cukup untuk memastikan bahwa semua staf mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan percaya diri. Kegagalan dalam mengatasi kesenjangan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan, di mana sebagian pasien mungkin tidak menerima manfaat penuh dari kemajuan teknologi.

Namun demikian, di balik tantangan-tantangan tersebut, era digital juga menghadirkan peluang besar bagi pemimpin kebidanan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan. Salah satu peluang utama adalah kemudahan akses informasi berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice). Teknologi digital memungkinkan pemimpin kebidanan dengan mudah mengakses penelitian terbaru,

pedoman klinis mutakhir, serta data statistik kesehatan yang relevan, sehingga proses pengambilan keputusan klinis menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti ilmiah terbaik. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh pemimpin kebidanan untuk mendorong penerapan praktik klinis terbaik serta meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Selain itu, era digital membuka peluang luas untuk pengembangan layanan kebidanan jarak jauh melalui telemedicine. Pelayanan kebidanan berbasis telemedicine memungkinkan bidan untuk memberikan konsultasi dan edukasi kepada pasien yang tinggal di daerah terpencil atau sulit diakses secara fisik. Pemimpin kebidanan harus mampu memanfaatkan peluang ini dengan membangun infrastruktur digital yang memadai, mengembangkan protokol telekonsultasi yang jelas, serta memastikan bahwa seluruh tim kebidanan memiliki kompetensi yang cukup dalam memberikan pelayanan secara virtual. Dengan demikian, pelayanan kebidanan dapat menjangkau lebih banyak pasien tanpa terbatas oleh faktor geografis, yang pada akhirnya mampu mengurangi kesenjangan akses pelayanan kebidanan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Era digital juga memberikan peluang besar dalam hal peningkatan edukasi pasien dan promosi kesehatan melalui platform digital seperti media sosial, aplikasi mobile, serta situs web interaktif. Pemimpin kebidanan dapat secara aktif menggunakan media ini untuk memberikan informasi yang akurat dan menarik tentang kesehatan ibu dan anak, asuhan antenatal, persalinan aman, perawatan bayi baru lahir, serta berbagai topik kesehatan reproduksi lainnya. Dengan strategi komunikasi digital yang efektif, pemimpin kebidanan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kebidanan yang berkualitas, sekaligus memperkuat posisi bidan sebagai profesional yang kompeten dan terpercaya di bidangnya.

Lebih lanjut, teknologi digital juga menyediakan peluang besar dalam hal manajemen risiko dan keamanan pasien. Dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, pemimpin kebidanan dapat secara real-time memonitor dan mengevaluasi berbagai indikator kinerja pelayanan kebidanan, seperti angka kejadian komplikasi, mortalitas ibu dan bayi, serta tingkat kepuasan pasien. Informasi ini memungkinkan pemimpin untuk segera melakukan intervensi ketika terjadi indikasi penyimpangan atau masalah klinis yang berisiko tinggi. Kemampuan untuk melakukan analisis data secara real-time ini meningkatkan kecepatan respons dan ketepatan tindakan korektif, yang secara langsung akan meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kebidanan.

Tidak kalah pentingnya, era digital juga memungkinkan pemimpin kebidanan untuk membangun jejaring profesional yang lebih luas dan kolaboratif. Platform digital seperti forum profesional, webinar, konferensi daring, serta jejaring sosial profesional memungkinkan pemimpin kebidanan untuk berkolaborasi dan bertukar informasi dengan kolega secara nasional maupun internasional. Peluang ini sangat penting untuk memperluas wawasan, memperkuat kompetensi kepemimpinan, serta membuka ruang bagi inovasi baru dalam praktik kebidanan.

Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan besar, kepemimpinan kebidanan di era digital juga menyediakan peluang yang luar biasa untuk pengembangan profesi dan peningkatan pelayanan. Pemimpin kebidanan yang efektif di era ini adalah mereka yang mampu secara proaktif mengatasi tantangan-tantangan tersebut sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia untuk menciptakan pelayanan kebidanan yang lebih inklusif, efisien, aman, dan berkualitas tinggi. Melalui strategi adaptasi teknologi yang bijak, pemimpin kebidanan mampu membawa profesi kebidanan ke tingkat yang lebih maju dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa depan.

G. Studi Kasus Kepemimpinan dalam Praktik Kebidanan

Untuk memahami lebih mendalam tentang kepemimpinan dalam praktik kebidanan, diperlukan kajian berupa studi kasus nyata yang mampu memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan diterapkan dalam konteks pelayanan kebidanan sehari-hari. Studi kasus ini membantu mengilustrasikan situasi konkret yang menuntut kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya manusia, mengambil keputusan klinis yang tepat, mengkomunikasikan keputusan secara efektif, serta menangani situasi kritis secara cepat dan efektif.

Sebagai contoh, kita dapat mengkaji suatu situasi yang terjadi di sebuah klinik kebidanan yang terletak di daerah pinggiran kota dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan lanjutan. Klinik ini dipimpin oleh seorang bidan senior bernama Ibu Rina, yang telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam praktik kebidanan. Suatu hari, di tengah situasi klinik yang cukup sibuk dengan sejumlah pasien yang tengah menjalani pemeriksaan rutin, tiba-tiba datang seorang pasien, Ny. Ani, usia 29 tahun, yang mengalami perdarahan postpartum hebat setelah melahirkan secara spontan di rumah dibantu oleh seorang dukun bersalin tradisional.

Dalam kondisi tersebut, kepemimpinan klinis dan manajerial dari Ibu Rina diuji secara nyata. Pertama-tama, ia harus segera melakukan penilaian awal terhadap kondisi Ny. Ani, termasuk pemeriksaan tanda vital, penilaian kehilangan darah, dan kondisi uterus. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien mengalami

perdarahan aktif, uterus lembek (atonia uteri), tekanan darah yang mulai turun, denyut nadi meningkat, serta tanda-tanda syok yang mulai tampak. Sebagai seorang pemimpin, Ibu Rina harus segera mengambil keputusan cepat berdasarkan protokol kegawatdaruratan obstetri yang berlaku.

Dalam situasi ini, Ibu Rina menunjukkan kepemimpinan yang efektif dengan segera memberikan instruksi jelas kepada tim kebidanan di klinik. Ia membagi peran secara terarah, satu bidan ditugaskan untuk memasang akses vena dan memulai pemberian cairan intravena untuk stabilisasi pasien, bidan lainnya membantu menyiapkan obat-obatan uterotonika yang diperlukan untuk menghentikan perdarahan. Ia juga menugaskan staf lain untuk berkomunikasi dengan keluarga pasien agar tetap tenang, memberikan penjelasan yang jelas dan empati tentang kondisi pasien, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh tim kebidanan.

Selain tindakan klinis, Ibu Rina juga langsung menghubungi rumah sakit rujukan terdekat untuk mempersiapkan transportasi dan koordinasi transfer pasien jika kondisi tidak segera membaik. Di sinilah kemampuan komunikasinya diuji, di mana ia harus menyampaikan informasi secara cepat, jelas, dan terstruktur kepada dokter spesialis obstetri di rumah sakit rujukan, memastikan bahwa informasi yang diterima benar-benar lengkap agar persiapan penerimaan pasien berjalan optimal.

Dalam beberapa menit berikutnya, setelah pemberian terapi cairan dan uterotonika, perdarahan mulai berkurang dan tanda vital pasien mulai stabil. Namun demikian, Ibu Rina tetap memutuskan bahwa pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk pemantauan lanjutan dan memastikan tidak ada komplikasi tambahan yang dapat membahayakan nyawa pasien. Proses rujukan ini dipandu langsung oleh Ibu Rina dengan menginstruksikan salah satu staf senior untuk mendampingi pasien selama perjalanan menuju rumah sakit, sekaligus memastikan seluruh dokumen medis yang diperlukan tersusun dengan baik dan lengkap.

Setelah insiden tersebut, sebagai pemimpin, Ibu Rina tidak berhenti pada penanganan akut saja. Ia segera mengadakan pertemuan refleksi bersama seluruh staf klinik untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Dalam pertemuan ini, ia menciptakan suasana yang terbuka dan suportif sehingga staf merasa nyaman berbagi pengalaman mereka tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dari kasus tersebut, memperkuat pemahaman tim tentang protokol manajemen perdarahan postpartum, serta memperbaiki sistem internal klinik yang berhubungan dengan manajemen risiko dan keamanan pasien.

Lebih lanjut, sebagai tindak lanjut dari pertemuan refleksi tersebut, Ibu Rina menyusun serangkaian pelatihan tambahan bagi staf kliniknya mengenai penanganan kegawatdaruratan obstetri, manajemen risiko, serta komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga dalam situasi darurat. Ia juga melakukan evaluasi

terhadap ketersediaan alat dan obat-obatan emergensi di klinik, memastikan stok obat dan alat yang dibutuhkan selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu.

Di sisi lain, Ibu Rina juga menggunakan kasus ini sebagai momen edukasi kepada masyarakat sekitar, terutama tentang pentingnya persalinan yang aman dan terpantau oleh tenaga kesehatan profesional. Ia menginisiasi pertemuan komunitas di wilayahnya dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta para ibu hamil, untuk menyampaikan informasi tentang risiko persalinan di rumah tanpa pendampingan tenaga kesehatan yang kompeten. Strategi ini mencerminkan kepemimpinan proaktif dalam aspek preventif yang bertujuan mengurangi risiko komplikasi serupa di masa depan.

Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana berbagai aspek kepemimpinan, mulai dari klinis, administratif, komunikasi, manajemen risiko, hingga edukasi komunitas, diintegrasikan oleh pemimpin kebidanan dalam menangani situasi nyata yang kritis. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif tidak hanya dilihat dari keberhasilan menangani situasi darurat, tetapi juga dari kemampuan pemimpin untuk memanfaatkan insiden tersebut sebagai bahan evaluasi, refleksi, pembelajaran tim, serta peningkatan sistem pelayanan secara menyeluruh.

Dengan demikian, studi kasus semacam ini sangat penting dalam konteks pendidikan dan pengembangan kepemimpinan dalam praktik kebidanan. Kajian mendalam atas kasus-kasus nyata ini membantu bidan muda maupun pemimpin kebidanan lainnya dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengambil keputusan berbasis bukti, serta mengelola tim dan sumber daya secara efektif, sehingga mampu memberikan pelayanan kebidanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada pasien secara holistik dan berkelanjutan.

H. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan di sebuah klinik pedesaan mendapati pasien yang mengalami komplikasi postpartum (perdarahan postpartum). Kondisi pasien semakin memburuk, sementara klinik tidak memiliki fasilitas yang memadai. Sebagai pemimpin di klinik tersebut, tindakan utama yang harus dilakukan bidan adalah:

- A. Memberikan motivasi kepada pasien agar tetap tenang
- B. Segera merujuk pasien ke fasilitas yang lebih lengkap
- C. Mengadakan pertemuan tim untuk evaluasi
- D. Memberi edukasi kepada keluarga tentang bahaya perdarahan
- E. Mengarahkan staf agar lebih berhati-hati

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Dalam situasi kegawatdaruratan seperti perdarahan postpartum, prioritas utama pemimpin kebidanan adalah mengambil keputusan klinis yang tepat dan cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien, yaitu segera melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap.

Soal 2

Di sebuah Rumah Bersalin, ditemukan kasus tingginya angka infeksi postpartum dalam sebulan terakhir. Sebagai pemimpin tim kebidanan, tindakan strategis paling tepat yang dilakukan oleh bidan pemimpin adalah:

- A. Melakukan edukasi rutin tentang kebersihan tangan
- B. Mengganti sebagian staf yang dianggap kurang terampil
- C. Melakukan evaluasi dan audit klinis terhadap prosedur aseptik
- D. Mengisolasi pasien yang mengalami infeksi
- E. Memberikan sanksi bagi staf yang melanggar SOP

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pemimpin kebidanan harus menggunakan pendekatan berbasis bukti (evidence-based) dalam mengelola risiko dan keselamatan pasien. Evaluasi dan audit klinis terhadap prosedur aseptik merupakan tindakan strategis paling tepat untuk mengidentifikasi akar masalah dan melakukan perbaikan sistematis.

Soal 3

Bidan Wati adalah pemimpin di unit kebidanan RS daerah. Ia menghadapi tim yang mulai mengalami stres kerja akibat banyaknya kasus komplikasi. Sebagai pemimpin, strategi efektif yang harus diambil adalah:

- A. Mengabaikan stres anggota tim karena dianggap biasa dalam pekerjaan
- B. Memberikan pelatihan tambahan mengenai manajemen stres
- C. Menginstruksikan tim untuk bekerja lebih keras agar kasus berkurang
- D. Memberikan sanksi terhadap anggota tim yang terlihat stres
- E. Memindahkan sebagian anggota tim ke unit lain tanpa diskusi

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pemimpin kebidanan harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara emosional dan psikologis. Strategi terbaik adalah memberikan pelatihan manajemen stres sehingga anggota tim lebih mampu menghadapi tekanan kerja secara efektif.

Soal 4

Seorang pemimpin kebidanan di era digital menyadari bahwa timnya kurang kompeten dalam menggunakan rekam medis elektronik (EMR). Untuk mengatasi tantangan ini, tindakan prioritas pemimpin adalah:

- A. Membatasi penggunaan teknologi digital di klinik
- B. Memberikan pelatihan rutin dan mentoring tentang penggunaan EMR
- C. Menggunakan kembali catatan medis manual
- D. Mempekerjakan tenaga IT tanpa melibatkan staf kebidanan
- E. Menegur staf yang lambat dalam beradaptasi dengan teknologi

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Di era digital, seorang pemimpin kebidanan harus proaktif mengatasi kesenjangan kompetensi digital timnya. Memberikan pelatihan rutin dan mentoring adalah strategi terbaik untuk memastikan staf mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif.

Soal 5

Seorang bidan senior memimpin praktik kebidanan di sebuah daerah terpencil. Ia menghadapi situasi di mana masih banyak ibu yang memilih melahirkan dengan bantuan dukun bersalin. Sebagai pemimpin, langkah efektif yang harus dilakukan bidan tersebut adalah:

- A. Melarang keras praktik persalinan dengan dukun secara langsung
- B. Mengabaikan fenomena tersebut karena dianggap budaya lokal
- C. Mengadakan edukasi rutin dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat serta dukun
- D. Melakukan tindakan administratif terhadap dukun lokal
- E. Menutup klinik karena kurangnya kesadaran masyarakat

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Sebagai pemimpin, bidan perlu menunjukkan kepemimpinan proaktif dan kolaboratif, yaitu melalui pendekatan edukasi dan kolaborasi bersama tokoh masyarakat serta dukun bersalin. Hal ini efektif untuk merubah perilaku masyarakat secara perlahan dan mengurangi risiko komplikasi persalinan di rumah.

I. Glosarium

A

Advokat: Orang yang bertanggung jawab membela atau memperjuangkan hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi, etis, dan bermartabat.

Agen Perubahan: Individu yang berperan aktif dalam mendorong perubahan positif dalam praktik kebidanan melalui adopsi inovasi dan pendekatan berbasis bukti.

Asuhan Berbasis Bukti (Evidence-based practice): Pendekatan dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan integrasi bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis, dan preferensi pasien.

Asertif: Kemampuan berkomunikasi secara jelas, tegas, namun tetap menghormati pandangan pihak lain.

B

Budaya Kerja Kondusif: Lingkungan kerja yang positif, sehat secara emosional, serta mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas staf.

C

Continuous Professional Development (CPD): Pengembangan profesional secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pendidikan formal dan informal, refleksi praktik, serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Coaching: Gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada bimbingan pribadi dan profesional secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan staf.

Collaborative Care (Kolaborasi): Pendekatan kerja tim yang melibatkan berbagai profesi kesehatan, pasien, dan keluarga dalam pengambilan keputusan klinis demi keselamatan dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

D

Demokratis (Gaya Kepemimpinan): Gaya kepemimpinan yang menekankan partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan, dialog terbuka, dan penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota tim.

Directive Leadership (Gaya Kepemimpinan Otoritatif): Gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengambil keputusan secara mandiri dan memberi arahan yang jelas kepada anggota tim, biasanya dalam situasi darurat.

E

Edukator: Peran pemimpin dalam memberikan pelatihan, bimbingan, serta edukasi kepada staf atau pasien dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi.

Evaluasi dan Audit Klinis: Proses sistematis untuk menilai kualitas pelayanan klinis berdasarkan standar tertentu untuk tujuan peningkatan kualitas dan keamanan pasien.

F

Fasilitator Komunikasi: Peran pemimpin dalam memastikan bahwa komunikasi antarprofesi maupun komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien berlangsung efektif, jelas, dan empatik.

I

Integritas: Konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam praktik kebidanan sehari-hari.

K

Kompetensi Digital: Kemampuan dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, terutama dalam mengelola informasi kesehatan pasien dan meningkatkan pelayanan kebidanan.

Komunikasi Efektif: Proses pertukaran informasi yang jelas, tepat, dan empatik antar anggota tim kesehatan serta pasien.

L

Laissez-faire (Gaya Kepemimpinan): Gaya kepemimpinan pasif yang memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk mengatur dirinya sendiri, cocok diterapkan pada tim yang sangat kompeten.

M

Manajemen Risiko: Proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko klinis atau administratif dalam pelayanan kebidanan guna memastikan keselamatan pasien.

Mentoring: Pendekatan kepemimpinan berupa bimbingan intensif dari pemimpin kepada anggota tim dalam rangka pengembangan personal dan profesional.

Motivasi Intrinsik: Dorongan internal yang berasal dari diri seseorang dalam melakukan sesuatu karena ketertarikan atau kepuasan pribadi.

N

Near Miss: Kejadian yang hampir menyebabkan kesalahan medis atau insiden yang dapat membahayakan pasien, namun tidak sampai terjadi.

P

Pengambilan Keputusan Klinis: Proses memilih tindakan atau solusi berdasarkan analisis situasi klinis, bukti ilmiah, dan preferensi pasien.

Pelatihan Berkelanjutan: Kegiatan pendidikan berkelanjutan yang bertujuan memperbaharui pengetahuan dan keterampilan staf secara rutin.

Praktik Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice): Penggunaan bukti ilmiah terkini sebagai dasar pengambilan keputusan dalam praktik klinis.

R

Role Model Profesional: Individu yang menjadi panutan bagi anggota tim karena memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta perilaku profesional dalam praktik kebidanan.

Refleksi Praktik: Proses evaluasi diri terhadap tindakan atau keputusan klinis yang telah diambil untuk tujuan pembelajaran dan peningkatan kualitas praktik di masa mendatang.

S

Situational Leadership (Kepemimpinan Situasional): Teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan berdasarkan situasi dan tingkat kematangan anggota tim.

T

Transformasional (Gaya Kepemimpinan): Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan staf untuk melakukan perubahan positif dan inovasi.

Transaksional (Gaya Kepemimpinan): Gaya kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip pertukaran (reward and punishment) dalam mengelola anggota tim untuk mencapai tujuan tertentu.

Telemedicine: Layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi digital, memungkinkan konsultasi dan edukasi pasien secara virtual.

V

Visi Kepemimpinan: Pandangan atau arah masa depan yang jelas, mampu menginspirasi tim dalam mencapai tujuan organisasi atau pelayanan kebidanan.

J. Daftar Pustaka

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2021). *Transformational leadership* (3rd ed.). Psychology Press.
- Biro, M. A., Dawson, A., Weller-Newton, J., & Snowball, J. (2021). Leadership in midwifery: A national survey of midwifery leaders. *Midwifery*, 95, 102934. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102934>
- Blanchard, K. H., & Hersey, P. (2021). *Management of organizational behavior: Leading human resources* (11th ed.). Pearson Education.
- Cummings, G. G., Tate, K., Lee, S., Wong, C. A., Paananen, T., & Chatterjee, G. E. (2020). Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 110, 103642. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103642>
- Dahlberg, U., & Aune, I. (2021). The midwife's role in managing obstetric emergencies: A leadership perspective. *Women and Birth*, 34(4), e411-e418. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.09.005>
- Gardner, D. B. (2020). Leadership strategies for creating a safety culture in maternity care. *Nursing for Women's Health*, 24(2), 129-138. <https://doi.org/10.1016/j.nwh.2020.01.001>
- Kumah, E., Osei-Kyei, R., & Chan, A. P. C. (2021). Leadership styles and job performance in healthcare sector: A systematic review. *Journal of Healthcare Leadership*, 13, 109-125. <https://doi.org/10.2147/JHL.S296682>
- Lalonde, A. B. (2020). Effective leadership and teamwork in obstetric emergencies. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 67, 20-31. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.03.002>
- Leung, D. Y. P., Wong, E. M. L., Chan, S. S. C., & Chien, W. T. (2021). Leadership behaviors and their influence on nurses' well-being and quality of patient care. *Nursing Outlook*, 69(4), 571-580. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.01.006>
- McGowan, J. E., Murray, K., & Eustace, S. (2022). Midwives as clinical leaders: A qualitative descriptive study exploring midwives' perceptions of clinical leadership. *Midwifery*, 108, 103296. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103296>

- Rogers, S. E., & Chamberlain, G. E. (2021). Leadership development in midwifery: Promoting collaboration and innovation. *Midwifery*, 93, 102893. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102893>
- Salman, M., Gohar, F., Abbas, M., & Aslam, N. (2020). Effect of leadership styles on nurses' job satisfaction and patient safety: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 36(5), 1132-1137. <https://doi.org/10.12669/pjms.36.5.2138>
- Shorey, S., & Ng, E. D. (2021). The role of midwifery leadership in enhancing maternal and neonatal outcomes: A review. *Women and Birth*, 34(6), e616-e624. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.01.009>
- World Health Organization. (2020). Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications-detail/framework-for-action-on-interprofessional-education-and-collaborative-practice>

BAB 12

PENGENALAN PADA POLITI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN DAN MEDICAL MODEL DALAM PELAYANAN OBSTETRIK

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan profesional dalam menerapkan konsep politi kesehatan dan medical model obstetrik dalam pemberian asuhan kebidanan yang aman, efektif, serta berdasarkan bukti ilmiah dan kebijakan yang berlaku.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian dan pentingnya politi kesehatan dalam pelayanan kebidanan.
- Memahami medical model dalam praktik obstetrik dan implikasinya terhadap pelayanan kebidanan.
- Mengidentifikasi pengaruh politi kesehatan terhadap pengambilan keputusan klinis dalam pelayanan kebidanan.
- Menerapkan konsep medical model obstetrik secara tepat dalam konteks pelayanan kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti sub-topik ini, mahasiswa mampu:

- Mendeskripsikan konsep dasar politi kesehatan dalam konteks kebidanan.
- Menjelaskan jenis-jenis kebijakan atau politi yang relevan dalam pelayanan kebidanan.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi politi kesehatan dalam pelayanan kebidanan.
- Menguraikan medical model dalam pelayanan obstetrik.
- Mengidentifikasi karakteristik medical model yang membedakannya dari pendekatan pelayanan kebidanan lainnya.
- Menjelaskan keuntungan dan kelemahan medical model dalam pelayanan obstetrik.

Pendahuluan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam prakteknya, pelayanan kebidanan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan atau politi kesehatan serta pendekatan medis (medical model) yang menjadi dasar dalam pemberian asuhan obstetrik. Pemahaman tentang bagaimana politi memengaruhi pelayanan kebidanan serta pengenalan medical model yang digunakan dalam obstetrik sangat penting bagi profesionalisme bidan. Hal ini bertujuan agar bidan dapat memberikan asuhan yang sesuai dengan standar klinis, etika profesional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Konsep Dasar Politi dalam Pelayanan Kebidanan

Dalam konteks pelayanan kebidanan, konsep dasar politi merujuk pada serangkaian kebijakan, regulasi, dan aturan yang secara khusus disusun dan diberlakukan untuk memastikan bahwa pelayanan kebidanan yang diberikan kepada ibu dan bayi memenuhi standar keamanan, efektivitas, dan keadilan. Kebijakan-kebijakan ini memiliki fungsi utama untuk menciptakan keseragaman kualitas pelayanan, menetapkan batasan dan tanggung jawab profesional, serta memberikan perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan dan penerima layanan. Sebagai profesi yang secara langsung berkaitan dengan nyawa manusia, pelayanan kebidanan memerlukan suatu kerangka politi yang kokoh untuk menjamin praktik yang aman, konsisten, dan sesuai dengan norma profesional serta sosial.

Politi dalam kebidanan tidak hanya dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan, tetapi juga oleh organisasi profesional seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), yang berperan dalam menentukan standar kompetensi bidan, pedoman etika, serta protokol klinis yang harus diikuti oleh seluruh bidan di Indonesia. Selain itu, politi ini dapat pula terbentuk melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun regional, seperti Peraturan Menteri Kesehatan, Undang-undang Kesehatan, serta Keputusan Menteri terkait praktik kebidanan.

Salah satu bentuk politi penting dalam pelayanan kebidanan adalah kebijakan nasional yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Kebijakan ini biasanya mencakup program-program kesehatan reproduksi, kesehatan maternal dan neonatal, serta berbagai upaya pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan, dengan tujuan utama menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan prioritas program, mengalokasikan anggaran, serta mengembangkan berbagai intervensi kesehatan seperti program antenatal care (ANC), persalinan aman oleh tenaga kesehatan terlatih, hingga promosi menyusui eksklusif.

Politi lain yang sangat signifikan adalah standar kompetensi kebidanan, yang merupakan kerangka yang mendefinisikan secara eksplisit kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang bidan profesional. Standar kompetensi ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan, pelaksanaan uji kompetensi, serta pemberian izin praktik bagi bidan. Dengan adanya standar kompetensi, maka setiap bidan dapat dipastikan mampu memberikan pelayanan kebidanan yang konsisten dan aman, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Selain standar kompetensi, regulasi tentang praktik mandiri bidan juga merupakan bagian integral dari politi kebidanan. Praktik mandiri ini merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan pelayanan kebidanan secara independen, baik dalam bentuk klinik maupun rumah bersalin, yang diatur secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap dalam koridor keamanan dan profesionalisme. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien serta memberikan jaminan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar mutu tertentu.

Pedoman klinis dalam asuhan kebidanan merupakan komponen penting lainnya dalam politi kebidanan, yang menyediakan panduan praktis berdasarkan bukti ilmiah terkini dalam pelaksanaan asuhan kebidanan sehari-hari. Pedoman ini mencakup berbagai aspek mulai dari proses pemeriksaan kehamilan, persalinan, masa nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga manajemen komplikasi dan keadaan darurat kebidanan. Dengan adanya pedoman klinis, maka bidan memiliki acuan yang jelas dalam mengambil keputusan klinis yang tepat, sehingga meningkatkan kualitas dan keselamatan layanan kebidanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi politi kesehatan dalam pelayanan kebidanan meliputi berbagai dinamika sosial, budaya, ekonomi, serta kemajuan teknologi medis. Isu-isu kesehatan masyarakat seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya penyakit menular maupun tidak menular yang berisiko tinggi terhadap kehamilan dan persalinan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak kesehatan reproduksi, merupakan pendorong utama dalam pembentukan politi kebidanan yang lebih komprehensif dan responsif.

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis, seperti inovasi dalam diagnostik prenatal, teknik persalinan yang lebih aman, serta manajemen komplikasi kebidanan yang lebih efektif, turut mempengaruhi pembentukan politi pelayanan kebidanan. Kebutuhan sosial budaya masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam menyusun politi, terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai tradisional kuat terkait kehamilan dan persalinan. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan tidak hanya aman secara klinis tetapi juga diterima secara budaya, sehingga meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap program-program kebidanan.

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konsep dasar politi dalam pelayanan kebidanan penting bagi para profesional kebidanan, tidak hanya dalam rangka menjalankan tugas-tugas klinis mereka dengan baik tetapi juga sebagai landasan untuk terlibat aktif dalam advokasi kebijakan kesehatan yang berpihak kepada keselamatan ibu dan bayi serta penguatan profesi kebidanan secara keseluruhan.

B. Medical Model dalam Pelayanan Obstetrik

Medical model dalam pelayanan obstetrik adalah suatu pendekatan yang menempatkan perhatian utama pada aspek klinis dan medis dari kehamilan, persalinan, serta masa nifas. Pendekatan ini berpijak pada prinsip-prinsip ilmu kedokteran yang mengutamakan proses diagnosis, pengobatan, serta pengelolaan medis dalam menghadapi berbagai kondisi atau komplikasi selama proses reproduksi. Dengan demikian, medical model sangat erat kaitannya dengan penerapan teknologi medis, intervensi klinis, serta prosedur-prosedur berbasis bukti ilmiah yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan ibu serta bayi yang dikandungnya.

Pendekatan medical model dalam obstetrik cenderung bersifat kuratif, yang berarti bahwa fokus utamanya adalah pada penanganan masalah-masalah yang telah muncul atau berisiko muncul secara medis. Dalam hal ini, praktik obstetrik secara khusus diarahkan untuk mendiagnosis komplikasi secara dini, menentukan pengobatan yang tepat, dan melakukan berbagai tindakan klinis seperti intervensi bedah, pemberian obat-obatan, serta penggunaan teknologi canggih seperti ultrasonografi (USG), pemantauan elektronik janin (EFM), dan intervensi invasif lainnya apabila diperlukan. Pendekatan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa kehamilan dan persalinan memiliki potensi risiko yang signifikan, sehingga membutuhkan pengawasan intensif oleh tenaga medis yang terlatih secara profesional.

Salah satu karakteristik utama dari medical model dalam pelayanan obstetrik adalah standar intervensi medis yang ketat dan terstruktur. Artinya, tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis obstetri, menjalankan serangkaian protokol klinis yang telah ditetapkan berdasarkan panduan nasional maupun internasional yang berbasis bukti ilmiah (*evidence-based medicine*). Standarisasi ini dimaksudkan agar setiap intervensi klinis dilakukan secara konsisten dengan hasil yang terukur, sehingga risiko kesalahan medis diminimalkan.

Dalam penerapan medical model ini, pemantauan klinis terhadap ibu hamil dilakukan secara ketat dan teratur. Ini mencakup pemeriksaan rutin selama masa kehamilan, observasi tanda-tanda vital, serta berbagai tes laboratorium untuk memastikan kondisi ibu dan janin selalu dalam keadaan optimal. Ketika terjadi penyimpangan dari kondisi normal atau adanya tanda-tanda komplikasi, tindakan medis segera diambil, mulai dari pengobatan sederhana hingga intervensi bedah yang kompleks seperti operasi caesar atau intervensi medis lainnya.

Kelebihan utama dari medical model dalam pelayanan obstetrik adalah kemampuan dalam mendeteksi dini dan menangani komplikasi medis secara cepat dan efektif. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti, kondisi yang membahayakan ibu atau bayi seperti preeklampsia, diabetes gestasional, persalinan prematur, distosia (kesulitan persalinan), perdarahan postpartum, atau kondisi kritis

lainnya dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu. Hal ini sangat penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan keselamatan selama proses kehamilan dan persalinan.

Namun demikian, medical model tidak lepas dari kritik dan kelemahan tertentu. Salah satu kelemahan utama dari pendekatan ini adalah potensi terjadinya over-medikalisasi, yaitu kondisi di mana intervensi medis yang dilakukan justru berlebihan dibandingkan kebutuhan sebenarnya. Intervensi yang berlebihan ini dapat meningkatkan risiko efek samping, komplikasi akibat tindakan medis, maupun beban biaya kesehatan yang meningkat.

Selain itu, medical model juga sering dianggap kurang memperhatikan aspek psikologis, emosional, dan sosial ibu. Pendekatan ini terkadang menempatkan ibu hamil sebagai objek yang sekadar menerima berbagai tindakan medis, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang juga krusial dalam proses persalinan, seperti dukungan emosional, pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pengalaman positif selama proses melahirkan. Hal ini dapat menyebabkan pengalaman persalinan menjadi sesuatu yang menakutkan atau tidak menyenangkan bagi sebagian perempuan.

Sebagai akibat dari kurangnya pemberdayaan pasien, medical model juga sering dikritik karena tidak sepenuhnya melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan kehamilan dan persalinan. Dalam banyak kasus, keputusan klinis lebih banyak didasarkan pada pertimbangan medis semata, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pasien untuk menyuarakan preferensi atau pilihan mereka terkait tindakan medis tertentu.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa meskipun medical model memiliki manfaat besar dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi melalui pendekatan klinis yang terstruktur dan profesional, pendekatan ini tetap perlu diimbangi dengan pendekatan lain yang lebih holistik. Pendekatan komplementer yang memperhatikan aspek psikologis, sosial, budaya, serta pemberdayaan perempuan dalam proses melahirkan dapat menjadi pelengkap yang sangat baik agar pelayanan obstetrik yang diberikan tidak hanya aman secara klinis tetapi juga memberikan pengalaman positif, nyaman, dan bermakna bagi setiap ibu yang menjalani proses kehamilan dan persalinan. Dengan demikian, kombinasi pendekatan ini dapat menciptakan pelayanan kebidanan dan obstetrik yang lebih komprehensif, berkualitas tinggi, serta berpusat pada pasien.

C. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan berencana membuka praktik mandiri di wilayah pedesaan dengan angka kematian ibu yang tinggi. Bidan tersebut ingin memastikan bahwa praktiknya sesuai dengan standar kompetensi kebidanan nasional. Kebijakan atau regulasi mana yang harus dipahami dan diikuti secara khusus oleh bidan tersebut?

- A. Undang-undang Perlindungan Konsumen
- B. Pedoman Nasional Pencegahan Penyakit Menular
- C. Standar Kompetensi Bidan
- D. Peraturan Pajak Daerah
- E. Regulasi Ekspor Impor Obat

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Standar Kompetensi Bidan merupakan regulasi khusus yang memberikan panduan mengenai keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap bidan. Dengan mematuhi standar kompetensi ini, bidan dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan aman, konsisten, dan sesuai dengan regulasi nasional.

Soal 2

Seorang ibu, usia 32 tahun, datang ke fasilitas kesehatan dengan kehamilan 38 minggu, namun merasa khawatir karena petugas langsung menyarankan intervensi medis tanpa penjelasan yang jelas. Prinsip politi dalam pelayanan kebidanan mana yang diabaikan dalam situasi ini?

- A. Pemerataan pelayanan kesehatan
- B. Keselamatan klinis
- C. Perlindungan hukum
- D. Pemberdayaan pasien
- E. Standarisasi kompetensi

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Pemberdayaan pasien dalam politi kebidanan berarti melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka, dengan memberikan informasi yang jelas dan memadai. Dalam kasus ini, intervensi medis yang disarankan tanpa penjelasan yang jelas menunjukkan kurangnya pemberdayaan pasien.

Soal 3

Seorang perempuan hamil usia 28 tahun dirawat intensif karena preeklamsia berat. Dokter spesialis obstetri memutuskan tindakan segera berupa operasi caesar

berdasarkan hasil pemeriksaan klinis. Situasi ini mencerminkan implementasi prinsip apa dalam medical model obstetrik?

- A. Intervensi minimal invasif
- B. Dukungan emosional
- C. Pendekatan kuratif dan intervensi medis segera
- D. Pendidikan kesehatan keluarga
- E. Promosi kelahiran alami tanpa intervensi medis

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Medical model menekankan pendekatan kuratif yang mengandalkan intervensi medis segera berdasarkan bukti klinis untuk mencegah komplikasi berat, seperti dalam kasus preeklamsia berat. Operasi caesar segera yang diputuskan dokter merupakan implementasi langsung dari pendekatan ini.

Soal 4

Di sebuah daerah terpencil, angka kematian bayi tinggi karena kurangnya akses pelayanan antenatal care (ANC). Kebijakan nasional mana yang paling relevan untuk mengatasi permasalahan ini?

- A. Program imunisasi nasional
- B. Kebijakan pelayanan antenatal terpadu
- C. Regulasi mengenai produk pangan bayi
- D. Undang-undang tenaga kerja kesehatan
- E. Pedoman pencegahan infeksi menular seksual

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Kebijakan nasional mengenai pelayanan antenatal care terpadu bertujuan menjamin akses ANC berkualitas untuk seluruh ibu hamil, terutama di daerah dengan akses terbatas. Kebijakan ini sangat penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui pemeriksaan rutin dan deteksi dini komplikasi.

Soal 5

Seorang perempuan, usia 35 tahun, menjalani kehamilan pertama dengan berbagai intervensi medis rutin sejak awal kehamilan tanpa indikasi klinis yang jelas. Akibatnya, ia merasa stres, cemas, dan tidak nyaman selama kehamilan. Situasi ini mencerminkan kelemahan dari pendekatan medical model, yaitu:

- A. Kemampuan menangani komplikasi secara cepat
- B. Penggunaan teknologi medis canggih
- C. Pemantauan klinis secara intensif
- D. Potensi terjadinya over-medikalisasi
- E. Standarisasi intervensi klinis

Kunci Jawaban: D**Rasional:**

Salah satu kelemahan pendekatan medical model adalah potensi over-medikalisasi, yaitu tindakan medis yang berlebihan dibanding kebutuhan sebenarnya. Dalam kasus ini, intervensi medis rutin yang tidak disertai indikasi jelas menyebabkan ketidaknyamanan emosional dan psikologis bagi pasien.

D. Rangkuman Materi

Dari pembahasan mengenai konsep dasar politi dalam pelayanan kebidanan dan medical model dalam pelayanan obstetrik, dapat disimpulkan bahwa politi kebidanan merupakan suatu kerangka kebijakan dan regulasi penting yang bertujuan untuk menjamin pelayanan yang aman, efektif, dan adil bagi ibu dan bayi. Politi ini mencakup standar kompetensi, regulasi praktik mandiri, kebijakan nasional terkait kesehatan ibu-anak, serta pedoman klinis yang membantu bidan menjalankan tugasnya dengan konsisten dan bertanggung jawab. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, serta perkembangan teknologi medis turut memengaruhi pembentukan politi yang adaptif, relevan, dan diterima masyarakat.

Sementara itu, medical model dalam pelayanan obstetrik menempatkan perhatian pada aspek medis dan klinis dari proses kehamilan hingga persalinan, dengan pendekatan berbasis bukti dan intervensi medis intensif untuk menangani berbagai komplikasi. Model ini memiliki keunggulan dalam mendeteksi dini serta mengatasi komplikasi secara efektif, tetapi memiliki risiko berupa over-medikalisasi, kurang memperhatikan aspek emosional dan psikologis pasien, serta minimnya pemberdayaan pasien dalam pengambilan keputusan.

Oleh karenanya, pendekatan ideal dalam pelayanan kebidanan dan obstetrik adalah dengan mengintegrasikan politi kebidanan yang kuat dan medical model yang efektif, disertai pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, sosial, dan budaya pasien. Hal ini bertujuan untuk mencapai pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang tidak hanya aman secara klinis tetapi juga bermakna, nyaman, dan memberdayakan pasien secara optimal.

E. Glosarium

Advokasi

Upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendukung, membela, atau memperjuangkan kebijakan tertentu, terutama dalam konteks kebijakan kesehatan untuk melindungi hak ibu dan bayi.

Antenatal Care (ANC)

Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan yang bertujuan untuk memantau kesehatan ibu dan janin serta mendeteksi komplikasi sejak dini agar dapat ditangani secara efektif.

Intervensi Klinis

Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan atau komplikasi tertentu pada pasien, seperti pemberian obat, tindakan operasi, atau prosedur invasif lainnya.

Kebijakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak

Kumpulan peraturan, program, serta strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi, bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan secara umum.

Komplikasi Kebidanan

Kondisi kesehatan yang tidak normal atau berisiko yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau nifas, yang memerlukan intervensi medis khusus untuk mencegah terjadinya morbiditas atau mortalitas.

Medical Model (Model Medis)

Pendekatan dalam pelayanan obstetrik yang berorientasi pada penanganan medis secara intensif terhadap komplikasi yang muncul atau berisiko muncul selama kehamilan dan persalinan, menggunakan intervensi medis berbasis bukti ilmiah.

Over-medikalisasi

Kondisi dimana pasien menerima intervensi atau tindakan medis secara berlebihan tanpa indikasi klinis yang jelas, yang dapat menyebabkan efek samping, ketidaknyamanan emosional, dan meningkatnya biaya layanan kesehatan.

Pedoman Klinis Kebidanan

Dokumen yang disusun berdasarkan bukti ilmiah terkini, berisi panduan praktis tentang prosedur klinis yang harus diikuti bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan untuk menjamin kualitas layanan yang aman dan efektif.

Pelayanan Obstetrik

Pelayanan kesehatan khusus yang berfokus pada penanganan medis selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, terutama dalam menangani komplikasi atau kondisi berisiko pada ibu dan bayi.

Pemberdayaan Pasien

Pendekatan yang menempatkan pasien sebagai subjek aktif dalam pelayanan kesehatan, memberikan hak dan kesempatan untuk terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan dan intervensi medis yang mereka terima.

Politi dalam Pelayanan Kebidanan

Kerangka kebijakan, regulasi, serta aturan yang dibuat oleh pemerintah maupun organisasi profesional untuk memastikan standar pelayanan kebidanan terpenuhi secara aman, adil, dan berkualitas tinggi.

Praktik Mandiri Bidan

Kewenangan yang diberikan kepada bidan untuk memberikan pelayanan kebidanan secara independen di luar fasilitas kesehatan publik, dengan mematuhi regulasi dan standar kompetensi yang berlaku.

Standar Kompetensi Bidan

Pedoman yang secara eksplisit menetapkan kemampuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh seorang bidan profesional sebagai dasar dalam menjalankan praktik kebidanan yang aman dan konsisten.

Tenaga Kesehatan Terlatih

Individu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus bidang kesehatan serta telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara aman, efektif, dan profesional.

Ultrasonografi (USG)

Teknologi diagnostik medis berbasis gelombang suara yang digunakan untuk memantau kondisi janin dalam kandungan, mendeteksi kelainan sejak dini, serta membantu pengambilan keputusan klinis yang akurat.

F. Daftar Pustaka

- Depkes RI. (2020). Standar Kompetensi Bidan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI. (2021). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ferguson, S., Davis, D., & Browne, J. (2018). Does antenatal education affect labour and birth? A structured review of the literature. *Women and Birth*, 31(2), 132–139. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.09.007>
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2020). Pedoman Etik Profesi Bidan. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.
- Murray, S. F., & Hunter, B. (2019). Medicalisation of childbirth: A narrative review of practices, impacts, and alternatives. *Midwifery*, 71, 78–85. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.12.012>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., & Channon, A. A. (2018). Midwifery and quality care: Findings from the evidence-informed quality maternal and newborn care framework. *The Lancet*, 392(10155), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31144-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31144-3)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

World Health Organization. (2018). WHO Recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2020). Standards for Improving Quality of Maternal and Newborn Care in Health Facilities. Geneva: World Health Organization.

Young, D. C., & Allen, V. M. (2019). Over-medicalization of childbirth: Balancing interventions and outcomes. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 41(8), 1112–1115. <https://doi.org/10.1016/j.jogc.2019.04.004>

Zielinski, R., Ackerson, K., & Kane Low, L. (2020). Planned home birth: Benefits, risks, and opportunities. *International Journal of Women's Health*, 12, 361–377. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S239795>

BAB 13

PRINSIP PARTNERSHIP DALAM PROMOSI KESEHATAN: INTERPROFESSIONAL, INTERAGENCY DAN INTERSEKTOR

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan profesional dalam membangun kemitraan lintas profesi, lembaga, dan sektor dalam rangka meningkatkan kualitas promosi kesehatan ibu dan anak secara efektif dan berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep partnership dalam konteks promosi kesehatan kebidanan.
- Membedakan dan mengintegrasikan peran masing-masing profesi, lembaga, dan sektor dalam promosi kesehatan ibu dan anak.
- Menerapkan strategi kolaborasi interprofessional, interagency, dan intersektor secara efektif dalam pelayanan kebidanan.
- Mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi partnership untuk promosi kesehatan ibu dan anak.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan sub-bab ini, mahasiswa mampu:

- Mendeskripsikan definisi, prinsip, dan tujuan partnership dalam promosi kesehatan kebidanan.
- Menguraikan peran kolaborasi interprofessional dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.
- Menjelaskan pentingnya kerjasama interagency dalam mendukung program-program kesehatan ibu dan anak.
- Mengidentifikasi peran strategis intersektor dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat khususnya dalam lingkup kebidanan.
- Menerapkan komunikasi efektif dan manajemen konflik dalam menjalankan kemitraan lintas profesi, lembaga, dan sektor.

Pendahuluan

Pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi tidak dapat dicapai hanya melalui peran tunggal seorang bidan, melainkan memerlukan kerja sama yang kuat dengan berbagai profesi kesehatan, lembaga, dan sektor terkait lainnya. Konsep kemitraan atau partnership dalam promosi kesehatan menegaskan bahwa kolaborasi antara profesi kesehatan (interprofessional), lembaganya (interagency), serta lintas sektor (intersektor) merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif.

Melalui prinsip partnership ini, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam upaya mencapai tujuan bersama, seperti menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi. Tantangan dalam implementasi partnership mencakup perbedaan perspektif, budaya kerja, dan regulasi, namun dengan komunikasi efektif dan komitmen bersama, hambatan ini dapat diatasi demi peningkatan kesehatan masyarakat secara luas.

Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam konsep dasar, prinsip-prinsip utama, serta strategi penerapan partnership interprofessional, interagency, dan intersektor dalam konteks promosi kesehatan kebidanan.

A. Konsep dan Tujuan Partnership dalam Promosi Kesehatan Kebidanan

Dalam konteks pelayanan kebidanan, konsep partnership dalam promosi kesehatan memiliki makna yang sangat mendalam dan strategis. Partnership atau kemitraan dalam bidang kebidanan menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang efektif, saling melengkapi, dan memiliki tujuan yang jelas antara berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi tenaga kesehatan, institusi layanan kesehatan, lembaga pendidikan, komunitas, organisasi profesi, pemerintah, serta sektor swasta. Kerja sama ini dibangun atas dasar kepercayaan, rasa saling menghormati, dan pemahaman terhadap pentingnya kolaborasi lintas sektor demi pencapaian tujuan kesehatan yang maksimal bagi ibu dan anak.

Dalam kerangka ini, kemitraan bertujuan secara spesifik untuk memperkuat dan memperluas jangkauan promosi kesehatan kebidanan. Promosi kesehatan itu sendiri merupakan upaya preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku sehat masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan anak balita. Dengan kata lain, tujuan utama dari pendekatan partnership dalam promosi kesehatan kebidanan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak melalui intervensi yang terintegrasi, bukan terfragmentasi. Fragmentasi dalam intervensi kesehatan kerap kali menyebabkan berbagai kendala, seperti duplikasi upaya, ketidakkonsistenan informasi, keterbatasan sumber daya, dan minimnya kesinambungan layanan kesehatan.

Melalui partnership, berbagai intervensi kesehatan menjadi terkoordinasi, saling mendukung, serta memiliki kesinambungan jangka panjang. Hal ini memungkinkan layanan kebidanan diberikan secara holistik, mencakup aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, budaya, hingga lingkungan hidup. Pendekatan holistik ini menempatkan ibu dan anak dalam konteks kehidupan yang lebih luas, bukan sekadar individu yang mengalami perubahan biologis atau fisiologis, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, psikologis, dan lingkungan tempat mereka hidup.

Dalam implementasinya, partnership dalam promosi kesehatan kebidanan menempatkan berbagai pihak dalam posisi strategis untuk berbagi peran, tanggung jawab, dan sumber daya. Tenaga kesehatan, misalnya, berperan memberikan edukasi, konseling, dan pelayanan klinis secara langsung. Lembaga pendidikan menyediakan sumber daya akademik, penelitian, dan pelatihan tenaga kesehatan. Pemerintah menetapkan regulasi, kebijakan, serta memberikan dukungan anggaran untuk implementasi program kesehatan yang efektif. Organisasi profesi berperan menjaga standar pelayanan dan etika profesi. Komunitas atau masyarakat aktif terlibat dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan intervensi, serta evaluasi program

yang ada, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dalam bentuk pendanaan, pengadaan alat kesehatan, atau pengembangan inovasi teknologi kesehatan.

Melalui kemitraan ini, program promosi kesehatan kebidanan menjadi lebih efektif dan berdaya guna. Setiap pihak memiliki peran yang jelas dan berkontribusi aktif sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing, sehingga mencegah adanya kesenjangan atau overlapping dalam pelaksanaan program. Pada akhirnya, kemitraan ini dapat menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung dan memberdayakan ibu dan anak secara optimal, memastikan bahwa setiap intervensi kesehatan yang diberikan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif jangka panjang.

Dengan demikian, konsep partnership dalam promosi kesehatan kebidanan adalah pendekatan yang dinamis, partisipatif, dan inklusif. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh, menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai pentingnya pemeliharaan kesehatan dalam siklus kehidupan manusia.

B. Prinsip Partnership Interprofessional dalam Kebidanan

Partnership interprofessional dalam pelayanan kebidanan merupakan suatu bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai tenaga profesional kesehatan dengan latar belakang yang berbeda, seperti bidan, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, tenaga farmasi, serta profesi kesehatan lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya sekadar kumpulan berbagai profesi yang bekerja berdampingan, melainkan sebuah sinergi yang sengaja dibangun dan dikembangkan dengan prinsip-prinsip tertentu untuk menghasilkan dampak maksimal terhadap kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi.

Salah satu prinsip mendasar dalam partnership interprofessional ini adalah saling menghormati kompetensi dan keahlian masing-masing profesi yang terlibat. Dalam konteks kebidanan, bidan memiliki kompetensi spesifik dalam memberikan asuhan kebidanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, terutama yang terkait langsung dengan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, serta perencanaan keluarga. Di sisi lain, dokter kandungan memiliki keahlian dalam menangani komplikasi medis yang mungkin terjadi selama masa kehamilan dan persalinan. Demikian pula perawat, ahli gizi, dan psikolog yang masing-masing memiliki ranah keilmuan serta kompetensi spesifik yang sangat penting dalam menunjang asuhan komprehensif terhadap ibu dan bayi. Dengan saling menghormati kompetensi ini, masing-masing pihak mampu memberikan kontribusi terbaik dalam lingkup keahlian masing-masing, serta memahami batasan-batasan profesional yang harus dijaga untuk menghindari konflik atau tumpang tindih peran.

Prinsip berikutnya yang sama pentingnya dalam partnership interprofessional adalah komunikasi yang terbuka dan efektif antarprofesi. Dalam layanan kebidanan, berbagai informasi penting seperti hasil pemeriksaan, status kesehatan ibu dan bayi,

maupun riwayat medis harus disampaikan secara jelas, lengkap, dan akurat kepada seluruh anggota tim. Komunikasi yang terbuka memungkinkan semua pihak dapat berdiskusi, memberikan masukan, maupun mengajukan pertanyaan secara bebas, yang pada akhirnya memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewatkan atau salah interpretasi. Hal ini sangat krusial dalam situasi kompleks seperti kehamilan risiko tinggi atau komplikasi selama persalinan, di mana keputusan klinis yang cepat dan tepat sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi.

Prinsip berikutnya adalah pengambilan keputusan secara kolaboratif dan partisipatif. Dalam praktiknya, setiap keputusan klinis maupun non-klinis yang menyangkut kesehatan ibu dan bayi tidak lagi diambil secara sepihak, melainkan secara kolektif oleh tim interprofessional. Pengambilan keputusan bersama ini didasarkan pada diskusi mendalam, pertimbangan keilmuan masing-masing profesi, serta masukan dari seluruh anggota tim berdasarkan pengalaman dan kompetensinya. Dengan cara ini, keputusan yang dihasilkan akan lebih komprehensif, akurat, dan relevan dengan kondisi pasien yang bersangkutan, serta mampu menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil layanan yang diberikan.

Selain itu, prinsip interprofessional partnership juga menempatkan orientasi utama pada kebutuhan pasien atau ibu dan bayi sebagai pusat perhatian (*patient-centered care*). Prinsip ini menegaskan bahwa layanan kebidanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek medis atau klinis saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien. Kebutuhan dan preferensi pasien serta keluarganya menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas intervensi serta pendekatan layanan yang diberikan. Dengan menempatkan pasien sebagai pusat dari pelayanan, maka setiap tenaga kesehatan dalam tim interprofessional dapat menyesuaikan peran dan kontribusinya agar lebih efektif dan relevan dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi secara holistik.

Dalam implementasinya di lapangan, *partnership interprofessional* dalam kebidanan sangat penting ketika menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks seperti kehamilan risiko tinggi, gangguan nutrisi, masalah psikososial, dan gangguan kesehatan mental yang mungkin dialami ibu selama masa kehamilan hingga nifas. Situasi-situasi ini memerlukan pendekatan interdisipliner, di mana kontribusi berbagai tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang paling efektif dan tepat sasaran. Dengan menerapkan prinsip interprofessional partnership secara konsisten, tenaga kesehatan dapat memaksimalkan potensi sumber daya, pengetahuan, serta keterampilan masing-masing demi mencapai tujuan akhir, yaitu meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi secara optimal, efektif, serta berkelanjutan.

C. Prinsip Partnership Interagency dalam Kebidanan

Partnership interagency dalam pelayanan kebidanan adalah konsep kerja sama yang menghubungkan berbagai lembaga baik di bidang kesehatan maupun di luar bidang kesehatan, yang memiliki tujuan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa pencapaian kualitas pelayanan kebidanan yang optimal tidak mungkin tercapai jika upaya tersebut hanya dilakukan secara terpisah-pisah oleh masing-masing lembaga secara independen. Kolaborasi antar lembaga atau yang disebut dengan interagency ini menciptakan kekuatan sinergis yang memungkinkan pelayanan kebidanan berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam prinsip partnership interagency, keterlibatan institusi mencakup berbagai bentuk lembaga, mulai dari institusi kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas, klinik kesehatan ibu dan anak, hingga institusi non-kesehatan seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta lembaga pemerintah seperti dinas kesehatan, dinas sosial, bahkan sektor swasta. Setiap institusi ini memiliki peran khusus yang apabila digabungkan secara harmonis, dapat memperkuat pencapaian tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan ibu dan anak secara holistik.

Salah satu prinsip utama dalam partnership interagency dalam kebidanan adalah koordinasi kebijakan dan program antar lembaga. Koordinasi ini penting dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak berjalan secara terpisah-pisah atau bahkan bertentangan satu sama lain. Dalam implementasinya, koordinasi kebijakan antar lembaga berarti bahwa setiap institusi, meskipun memiliki kewenangan dan prioritas sendiri-sendiri, sepakat untuk merumuskan tujuan bersama, merancang strategi terpadu, serta menetapkan langkah-langkah operasional secara kolektif. Dengan demikian, program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh berbagai institusi tersebut dapat saling mendukung dan melengkapi, serta lebih efektif dalam mencapai tujuan akhirnya.

Prinsip lain yang sangat esensial dalam partnership interagency adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama (resource sharing). Dalam konteks kebidanan, kebutuhan sumber daya mencakup berbagai aspek seperti tenaga kesehatan yang terlatih, fasilitas kesehatan, alat-alat medis, sarana transportasi, bahan edukasi, hingga dukungan dana. Dengan menjalin partnership interagency, institusi-institusi yang terlibat dapat berbagi atau saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, sehingga tercipta efisiensi yang tinggi dan menghindari pemborosan sumber daya. Misalnya, rumah sakit dapat menyediakan fasilitas untuk pelatihan bidan, sementara lembaga pendidikan menyediakan pelatih atau pengajar yang kompeten. Lembaga swadaya masyarakat dapat terlibat dalam upaya pemberdayaan komunitas, sementara pemerintah melalui puskesmas dapat menyediakan layanan kesehatan dasar secara merata.

Dengan sumber daya yang dikelola secara bersama-sama, pelayanan kebidanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, lebih berkualitas, dan lebih berkesinambungan.

Selain koordinasi kebijakan dan pemanfaatan sumber daya bersama, prinsip lainnya dalam partnership interagency adalah evaluasi program yang terintegrasi. Evaluasi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi kerja sama antar lembaga tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Evaluasi program yang terintegrasi berarti setiap lembaga yang terlibat bersama-sama menetapkan indikator keberhasilan, melaksanakan monitoring secara berkala, dan melakukan evaluasi bersama terhadap hasil yang dicapai. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan strategis dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kebidanan di masa depan. Dengan evaluasi yang terintegrasi, setiap institusi tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian program masing-masing secara individual, melainkan juga bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan kolektif secara keseluruhan.

Dalam praktik nyata, contoh partnership interagency dalam kebidanan dapat dilihat dari kerjasama antara rumah sakit, puskesmas, dan klinik bersalin dalam sistem rujukan maternal neonatal emergensi. Kerja sama ini memastikan ibu dan bayi dengan kondisi komplikasi atau risiko tinggi mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Contoh lainnya adalah kolaborasi antara dinas kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi seperti IBI dalam pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, atau sosialisasi program kesehatan reproduksi di masyarakat.

Melalui penerapan prinsip partnership interagency secara konsisten, pelayanan kebidanan akan mampu memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan ibu dan anak secara menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan bahwa tantangan-tantangan kompleks dalam pelayanan kebidanan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi strategis yang melibatkan berbagai institusi secara sinergis dan harmonis.

D. Prinsip Partnership Intersektor dalam Kebidanan

Partnership intersektor dalam pelayanan kebidanan adalah konsep kemitraan yang sangat penting, melibatkan beragam sektor baik pemerintahan maupun swasta yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan atau pengaruh terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak. Kemitraan intersektor ini didasarkan pada kesadaran bahwa permasalahan kesehatan ibu dan anak bukanlah sekadar masalah medis yang bisa diatasi hanya melalui intervensi klinis atau pelayanan kesehatan semata. Sebaliknya, masalah tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan, transportasi,

komunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor menjadi sebuah pendekatan integral yang sangat penting untuk memastikan tercapainya hasil kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak.

Salah satu prinsip utama dalam kemitraan intersektor dalam kebidanan adalah integrasi program. Integrasi program dalam konteks ini berarti bahwa berbagai sektor yang terlibat secara aktif menyusun program dan strategi yang saling terkait dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan bersama, yakni peningkatan kesehatan ibu dan anak. Misalnya, sektor pendidikan berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, kehamilan sehat, persalinan yang aman, serta perawatan bayi yang tepat. Pendidikan formal maupun informal memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga intervensi medis atau klinis yang diberikan oleh sektor kesehatan bisa berjalan lebih efektif.

Sementara itu, sektor ekonomi juga memiliki peran vital dalam kemitraan ini. Kondisi ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan status gizi ibu dan anak, akses terhadap layanan kesehatan, serta kualitas hidup secara umum. Dengan adanya kemitraan intersektor yang melibatkan sektor ekonomi, maka kebijakan dan program yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga akan berdampak langsung terhadap peningkatan kemampuan keluarga untuk mengakses pelayanan kebidanan, memperoleh nutrisi yang baik, serta mempraktikkan pola hidup sehat. Demikian pula dengan sektor transportasi, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ibu dan anak dapat menjangkau fasilitas kesehatan dengan mudah dan cepat, terutama dalam situasi darurat seperti persalinan dengan komplikasi atau kasus-kasus kegawatdaruratan lainnya.

Selain itu, sektor lingkungan juga berperan sangat penting dalam kemitraan intersektor ini. Lingkungan yang sehat dan bersih, dengan sanitasi yang memadai, sangat krusial bagi kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Kondisi lingkungan yang buruk seperti air yang tidak bersih, lingkungan yang tercemar, serta fasilitas sanitasi yang buruk merupakan faktor risiko signifikan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu selama masa kehamilan dan nifas, serta kesehatan bayi dan balita dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, kemitraan dengan sektor lingkungan diarahkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan sehat melalui berbagai program seperti pengelolaan air bersih, sanitasi yang baik, pengelolaan limbah, dan peningkatan kualitas hunian.

Prinsip berikutnya yang mendasari partnership intersektor adalah advokasi kebijakan lintas sektor. Advokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

sektor memiliki kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan kesehatan ibu dan anak. Dalam praktiknya, kebijakan sektor-sektor tersebut harus mampu saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh, kebijakan dalam sektor tenaga kerja yang memberikan perlindungan khusus kepada ibu hamil melalui pemberian cuti hamil yang memadai dan fasilitas khusus di tempat kerja, kebijakan sektor transportasi yang menyediakan akses transportasi yang aman bagi ibu hamil dan bayi, serta kebijakan sektor pendidikan yang memasukkan materi tentang kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan formal. Advokasi kebijakan lintas sektor ini menegaskan pentingnya kesadaran bersama dan tindakan kolektif dari semua pihak terkait dalam mendukung tercapainya kesehatan optimal ibu dan anak.

Terakhir, prinsip fundamental dalam kemitraan intersektor adalah komitmen bersama dalam implementasi kebijakan publik yang pro-kesehatan ibu dan anak. Komitmen bersama ini mengimplikasikan bahwa setiap sektor yang terlibat tidak hanya merumuskan kebijakan atau strategi secara terpisah-pisah, tetapi juga secara konkret melaksanakan kebijakan tersebut dengan tanggung jawab dan konsistensi penuh. Hal ini menciptakan suasana kerja sama yang kuat, dengan masing-masing sektor merasa memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam menciptakan perubahan nyata di masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan intersektor ini secara konsisten dan komprehensif, berbagai tantangan dan hambatan yang selama ini menjadi penghalang dalam pencapaian tujuan kesehatan ibu dan anak dapat teratasi secara efektif. Kemitraan intersektor ini menegaskan bahwa peningkatan kesehatan ibu dan anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan semata, melainkan memerlukan kerja sama strategis yang melibatkan berbagai sektor secara lintas disiplin dan lintas lembaga secara sinergis dan terkoordinasi.

E. Strategi Implementasi dan Tantangan Partnership dalam Kebidanan

Implementasi konsep partnership dalam kebidanan, baik secara interprofessional, interagency, maupun intersektor, membutuhkan pendekatan dan strategi yang terencana secara matang. Implementasi ini tidak dapat dilakukan secara spontan, tetapi memerlukan perencanaan yang cermat dan strategi khusus yang secara aktif mempertimbangkan kompleksitas kolaborasi berbagai pihak dengan latar belakang, perspektif, dan kepentingan yang berbeda. Dalam praktiknya, strategi implementasi yang efektif mencakup beberapa aspek penting,

yaitu komunikasi efektif, manajemen koordinasi, advokasi kebijakan, dan evaluasi berkelanjutan.

Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dari keberhasilan implementasi kemitraan dalam kebidanan. Komunikasi ini harus berlangsung secara terbuka, transparan, jelas, dan konsisten antar berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Misalnya, dalam konteks *partnership interprofessional*, bidan, dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya harus mampu menyampaikan informasi klinis secara lengkap dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidakjelasan peran masing-masing pihak. Dalam skala lebih luas, komunikasi efektif juga sangat diperlukan dalam *partnership interagency* dan *intersektor*, di mana komunikasi melibatkan berbagai lembaga, pemerintah, serta pihak swasta yang masing-masing memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan khusus dalam berkomunikasi, seperti kemampuan mendengarkan secara aktif, empati terhadap perspektif pihak lain, dan menyampaikan pesan secara jelas dan diplomatis, sehingga mampu memfasilitasi kolaborasi yang efektif.

Selain komunikasi, manajemen koordinasi juga merupakan elemen penting yang menjadi bagian dari strategi implementasi *partnership* dalam kebidanan. Koordinasi ini melibatkan perencanaan program yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab secara tegas, serta mekanisme koordinasi rutin melalui pertemuan atau rapat koordinasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat berada dalam satu pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Dengan manajemen koordinasi yang baik, kolaborasi antar pihak dapat berlangsung dengan lebih terstruktur dan terorganisasi, sehingga mencegah terjadinya duplikasi kegiatan, tumpang tindih peran, atau konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan bersama.

Advokasi kebijakan merupakan strategi implementasi lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam membangun kemitraan kebidanan yang efektif. Advokasi kebijakan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kemitraan melalui kebijakan publik yang mendukung kolaborasi lintas profesi, lembaga, dan sektor. Hal ini melibatkan aktivitas seperti pendekatan kepada pembuat kebijakan, menggalang dukungan dari *stakeholder* kunci, serta melobi pihak-pihak strategis agar kebijakan dan regulasi yang diterapkan benar-benar pro-kesehatan ibu dan anak. Advokasi kebijakan juga bertujuan memastikan bahwa kolaborasi yang dilakukan memiliki legitimasi hukum dan mendapatkan dukungan anggaran yang cukup, sehingga dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi implementasi terakhir adalah evaluasi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pihak dalam *partnership* untuk mengukur sejauh mana implementasi kemitraan

telah mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran terhadap indikator-indikator kunci, seperti peningkatan status kesehatan ibu dan anak, efektivitas kerja sama antar pihak, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, tim dapat secara dini mengidentifikasi berbagai kendala atau permasalahan yang muncul dan segera melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa kemitraan tetap efektif dan relevan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Meskipun memiliki strategi implementasi yang matang, praktik kemitraan dalam kebidanan juga dihadapkan pada berbagai tantangan nyata yang perlu diantisipasi secara serius. Salah satu tantangan yang paling sering muncul adalah resistensi terhadap perubahan. Setiap pihak dalam kemitraan memiliki budaya kerja, kebiasaan, dan cara pandang masing-masing yang mungkin sulit diubah dalam waktu singkat. Resistensi ini bisa muncul dalam bentuk keengganan untuk berbagi informasi, mempertahankan pola kerja lama yang tidak sesuai dengan prinsip kolaborasi, atau bahkan penolakan secara terang-terangan terhadap perubahan yang diusulkan. Menghadapi resistensi semacam ini membutuhkan kemampuan manajemen perubahan yang baik, termasuk kemampuan meyakinkan pihak-pihak yang terlibat mengenai manfaat kemitraan serta pendekatan yang sabar dan konsisten dalam mendorong perubahan sikap.

Selain resistensi perubahan, tantangan lain yang kerap terjadi adalah masalah komunikasi yang kurang efektif antar pihak yang berkolaborasi. Komunikasi yang buruk bisa menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahpahaman, ketidaksepahaman terhadap tujuan bersama, hingga konflik interpersonal. Ini sangat penting untuk diatasi dengan mengembangkan mekanisme komunikasi yang terstruktur dan memastikan bahwa setiap pihak memahami pesan secara jelas dan akurat. Tantangan administratif atau regulasi juga seringkali muncul dalam bentuk peraturan yang tumpang tindih, birokrasi yang rumit, atau kurangnya dukungan administratif yang memadai dalam menjalankan kemitraan. Menghadapi kendala administratif ini memerlukan advokasi kebijakan secara terus-menerus serta pendekatan administratif yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

Mengingat kompleksitas strategi implementasi dan berbagai tantangan yang dihadapi, seorang bidan profesional perlu memiliki kompetensi khusus seperti keterampilan komunikasi interpersonal yang kuat, advokasi kebijakan yang efektif, manajemen konflik yang mumpuni, serta kepemimpinan yang kuat. Kompetensi ini akan memungkinkan bidan untuk memimpin kemitraan secara efektif, mengatasi berbagai tantangan yang muncul, serta memastikan bahwa implementasi kemitraan dalam pelayanan kebidanan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan di Puskesmas sedang menghadapi tantangan tingginya angka anemia pada ibu hamil di desa binaannya. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa penyebab utama adalah kurangnya kesadaran ibu mengenai pentingnya nutrisi seimbang, faktor ekonomi, dan sulitnya akses transportasi ke fasilitas kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah awal paling tepat yang dilakukan bidan melalui pendekatan kemitraan intersektor adalah...

- A. Mengadakan penyuluhan rutin di klinik bersalin.
- B. Melibatkan sektor transportasi dalam menyediakan akses khusus bagi ibu hamil.
- C. Memberikan suplementasi zat besi secara langsung di posyandu.
- D. Melibatkan tenaga kesehatan tambahan dari puskesmas terdekat.
- E. Meminta dana bantuan pemerintah untuk membeli alat medis.

Kunci: B

Rasional:

Pendekatan intersektor mengharuskan integrasi lintas sektor yang meliputi transportasi agar ibu hamil mudah menjangkau fasilitas kesehatan. Pilihan ini paling tepat karena faktor transportasi menjadi hambatan signifikan dalam akses layanan kebidanan.

Soal 2

Seorang bidan yang bertugas di klinik desa menemukan bahwa terdapat beberapa kasus depresi pasca persalinan yang tidak terdeteksi dini. Untuk menyusun program penanganan yang komprehensif, prinsip interprofessional yang paling relevan untuk diterapkan dalam situasi ini adalah...

- A. Meningkatkan layanan pemeriksaan fisik ibu secara rutin.
- B. Melakukan koordinasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan nutrisi ibu.
- C. Kolaborasi aktif dengan psikolog dalam pendeteksian dini gangguan mental.
- D. Memberikan pelatihan kepada perawat mengenai nutrisi.
- E. Menjalin kerja sama dengan LSM kesehatan ibu dan anak.

Kunci: C

Rasional:

Masalah psikologis seperti depresi membutuhkan kerja sama interprofessional yang spesifik dengan psikolog agar penanganan dan deteksi dini dapat dilakukan dengan akurat dan profesional.

Soal 3

Di suatu kota kecil, angka kematian bayi baru lahir meningkat akibat terlambatnya rujukan dari klinik bersalin ke rumah sakit umum. Solusi paling strategis berdasarkan prinsip partnership interagency yang dapat dilakukan adalah...

- A. Menambah tenaga bidan di klinik bersalin.
- B. Mengadakan evaluasi program secara independen di masing-masing fasilitas.
- C. Melakukan koordinasi sistem rujukan terpadu antara klinik bersalin dan rumah sakit.
- D. Mengadakan kampanye kesehatan di masyarakat secara rutin.
- E. Melatih lebih banyak kader kesehatan di masyarakat.

Kunci: C

Rasional:

Prinsip interagency menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga. Pilihan ini menunjukkan koordinasi sistem rujukan terpadu antara klinik dan rumah sakit yang paling efektif dalam menangani kasus darurat secara cepat dan tepat.

Soal 4

Bidan desa menyadari bahwa upaya edukasi kesehatan tentang ASI eksklusif belum optimal karena keterbatasan dana dan tenaga. Menurut prinsip kemitraan yang ideal dalam promosi kesehatan kebidanan, langkah paling tepat adalah...

- A. Meminta dana dari pemerintah pusat.
- B. Membentuk kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta untuk sumber dana dan dukungan edukasi.
- C. Mengadakan pelatihan tambahan untuk bidan desa saja.
- D. Meningkatkan penyuluhan secara mandiri di posyandu.
- E. Menyediakan buku panduan di klinik desa.

Kunci: B

Rasional:

Kemitraan dalam promosi kesehatan harus melibatkan berbagai sektor termasuk LSM dan sektor swasta, untuk sumber daya yang lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya tergantung pada pemerintah saja.

Soal 5

Seorang bidan baru ditempatkan di wilayah yang selama ini mengalami kesulitan dalam menjalin kerja sama lintas profesi karena konflik antar tenaga kesehatan. Tantangan utama yang akan dihadapi oleh bidan dalam membangun partnership yang efektif adalah...

- A. Kurangnya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
- B. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak.
- C. Regulasi dari pemerintah yang kurang jelas.
- D. Resistensi terhadap perubahan dan komunikasi yang kurang efektif antar tenaga kesehatan.
- E. Rendahnya jumlah tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

Kunci: D

Rasional:

Resistensi terhadap perubahan dan komunikasi yang kurang efektif adalah tantangan paling umum dan signifikan dalam membangun kemitraan lintas profesi, sebagaimana dijelaskan dalam strategi implementasi partnership kebidanan.

G. Rangkuman Materi

Kemitraan atau partnership dalam kebidanan merupakan pendekatan strategis yang melibatkan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, baik tenaga profesional kesehatan, lembaga kesehatan maupun non-kesehatan, hingga berbagai sektor pemerintahan dan swasta. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif dan berkelanjutan melalui intervensi yang terpadu, terkoordinasi, dan holistik. Pendekatan ini memerlukan prinsip saling menghormati kompetensi masing-masing profesi, komunikasi terbuka, pengambilan keputusan bersama, serta mengedepankan kebutuhan pasien (patient-centered care).

Dalam pelaksanaannya, partnership kebidanan menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, kendala komunikasi antar pihak yang berkolaborasi, serta hambatan administratif dan regulasi. Oleh karena itu, implementasi kemitraan memerlukan strategi yang matang berupa komunikasi efektif, manajemen koordinasi, advokasi kebijakan, serta evaluasi berkelanjutan. Kunci sukses kemitraan ini bergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kebidanan, khususnya bidan profesional, yang mencakup keterampilan komunikasi interpersonal yang kuat, kemampuan advokasi kebijakan, manajemen konflik, serta kepemimpinan yang baik.

Dengan menerapkan pendekatan partnership secara konsisten dan integratif, pelayanan kebidanan dapat mencapai dampak positif jangka panjang berupa peningkatan kualitas hidup ibu dan anak serta terciptanya ekosistem layanan kesehatan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

H. Glosarium

Advokasi Kebijakan:

Upaya strategis untuk mempengaruhi kebijakan publik agar mendukung pelaksanaan kemitraan dan program yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Evaluasi Terintegrasi:

Proses penilaian yang melibatkan berbagai institusi secara bersama-sama untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari program kemitraan kebidanan yang telah dilaksanakan.

Fragmentasi Intervensi:

Situasi di mana program atau layanan kesehatan berjalan secara terpisah-pisah, sehingga menyebabkan duplikasi upaya, ketidakkonsistenan informasi, dan minimnya kesinambungan layanan.

Integrasi Program:

Penyatuan berbagai program kesehatan dari berbagai sektor yang saling mendukung dan terkoordinasi secara efektif guna mencapai tujuan bersama, yakni peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Interagency Partnership:

Kerja sama yang melibatkan berbagai lembaga kesehatan maupun non-kesehatan untuk secara kolektif mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, melalui koordinasi kebijakan, penggunaan sumber daya bersama, dan evaluasi yang terintegrasi.

Interprofessional Partnership:

Kolaborasi aktif antara berbagai profesi kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan tenaga farmasi, yang dibangun atas dasar saling menghormati kompetensi, komunikasi efektif, pengambilan keputusan bersama, serta orientasi pada kebutuhan pasien.

Intersektor Partnership:

Kerja sama lintas sektor yang melibatkan institusi pemerintahan maupun swasta dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, transportasi, komunikasi,

dan sektor lainnya, untuk mendukung terciptanya lingkungan kondusif bagi kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.

Kemitraan (Partnership):

Hubungan kerja sama strategis antara berbagai pihak yang saling melengkapi, memiliki tujuan jelas, dan dibangun atas dasar kepercayaan serta saling menghormati, dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak.

Komunikasi Efektif:

Pertukaran informasi yang jelas, transparan, konsisten, dan saling memahami antar berbagai pihak yang terlibat dalam kemitraan untuk mencegah kesalahpahaman serta memastikan tercapainya tujuan bersama.

Manajemen Koordinasi:

Proses pengelolaan yang sistematis untuk memastikan semua pihak dalam kemitraan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, peran, tanggung jawab, serta langkah operasional guna menghindari konflik dan tumpang tindih kegiatan.

Patient-Centered Care:

Pendekatan layanan kesehatan yang berorientasi penuh pada kebutuhan pasien, dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien.

Promosi Kesehatan Kebidanan:

Upaya preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku sehat masyarakat, terutama ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan balita.

Resistensi terhadap Perubahan:

Hambatan berupa keengganan atau penolakan dari individu maupun institusi untuk menerima atau mengimplementasikan perubahan dalam praktik kerja atau budaya organisasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan kolaborasi.

Resource Sharing (Pemanfaatan Sumber Daya Bersama):

Praktik pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kesehatan, fasilitas, alat kesehatan, transportasi, edukasi, dan dana secara kolektif antar institusi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kesehatan ibu dan anak.

Strategi Implementasi:

Perencanaan yang matang mengenai langkah-langkah praktis dalam menjalankan kemitraan, yang melibatkan komunikasi efektif, manajemen koordinasi, advokasi kebijakan, serta evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan keberhasilan program.

I. Daftar Pustaka

-
- Ansari, W. E., Phillips, C. J., & Zwi, A. B. (2020). Public health partnerships: Factors for success. *Global Health Promotion*, 27(1), 67–76. <https://doi.org/10.1177/1757975919831087>
- Barr, H., & Low, H. (2019). *Interprofessional teamwork in health and social care*. Routledge.
- Clark, P. G. (2019). Narrative in interprofessional education and practice: Implications for professional identity, provider–patient communication, and teamwork. *Journal of Interprofessional Care*, 33(1), 3–6. <https://doi.org/10.1080/13561820.2018.1530725>
- Green, J., Cross, R., Woodall, J., & Tones, K. (2019). *Health promotion: Planning & strategies* (4th ed.). Sage Publications.
- McDonald, J., Jayasuriya, R., & Harris, M. F. (2021). The influence of power dynamics and trust on interagency collaboration in primary healthcare. *Health Policy and Planning*, 36(1), 31–42. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa104>
- Reeves, S., Lewin, S., Espin, S., & Zwarenstein, M. (2020). *Interprofessional teamwork for health and social care*. Wiley-Blackwell.
- Schneider, M. J. (2021). *Introduction to public health* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Taylor-Robinson, D. C., Lai, E. T. C., Wickham, S., Rose, T., Norman, P., Bambra, C., & Whitehead, M. (2019). Assessing the impact of rising child poverty on the

unprecedented rise in infant mortality in England, 2000–2017: Time trend analysis. *BMJ Open*, 9(10), e029424. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029424>

World Health Organization. (2020). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. WHO Press.

Zwarenstein, M., Rice, K., Gotlib-Conn, L., Kenaszchuk, C., & Reeves, S. (2019). Disengaged: A qualitative study of communication and collaboration between physicians and other professions on general internal medicine wards. *BMC Health Services Research*, 19(1), 340. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4164-9>

BAB 14

TREND DAN ISSUE

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, serta merespons tren dan isu terkini dalam praktik kebidanan secara kritis dan profesional, guna meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang berlaku.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Menguraikan berbagai tren terbaru dalam praktik kebidanan serta dampaknya terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- Menjelaskan berbagai isu kontemporer yang dihadapi profesi kebidanan dan strategi penanganannya.
- Menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi perubahan tren dan isu yang berkembang dalam kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi tren global dan nasional dalam pelayanan kebidanan.
- Menjelaskan dampak tren teknologi kesehatan dalam kebidanan.
- Menguraikan isu-isu etika dan legal terkini dalam kebidanan.
- Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi praktik kolaborasi interprofesional di bidang kebidanan.
- Merancang strategi untuk menghadapi perubahan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kebidanan.

A. Tren Terkini dalam Kebidanan

Tren terkini dalam kebidanan mencerminkan transformasi yang cepat dan signifikan, sejalan dengan kemajuan teknologi, peningkatan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan akan layanan kesehatan yang berkualitas serta berbasis bukti ilmiah. Salah satu perubahan besar yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir adalah integrasi teknologi informasi dalam berbagai aspek praktik kebidanan. Digitalisasi catatan kesehatan atau Electronic Health Records (EHR) menjadi contoh nyata dari kemajuan ini. Dengan adanya EHR, bidan dapat menyimpan, mengakses, dan berbagi data kesehatan pasien secara real-time. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memungkinkan koordinasi layanan antar tenaga kesehatan yang lebih baik, yang pada akhirnya menghasilkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

Telemedicine merupakan inovasi lain yang memberikan dampak besar dalam praktik kebidanan modern. Telemedicine merujuk pada pemanfaatan teknologi komunikasi seperti video conference, telekonsultasi, dan pemantauan jarak jauh untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kebidanan, terutama di daerah terpencil atau dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Dengan telemedicine, bidan dapat melakukan konsultasi jarak jauh, memantau perkembangan ibu hamil, serta memberikan edukasi kesehatan secara efektif tanpa harus bertatap muka secara fisik. Ini sangat penting khususnya di masa pandemi, atau dalam situasi bencana alam, ketika akses ke layanan tatap muka terbatas atau tidak memungkinkan.

Selain integrasi teknologi, tren penting lainnya adalah peningkatan penggunaan praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP). EBP dalam kebidanan menekankan pentingnya penggunaan bukti ilmiah terbaru dalam pengambilan keputusan klinis. Bidan dituntut untuk terus memperbaharui pengetahuan mereka melalui berbagai penelitian terbaru yang telah melalui proses validasi ilmiah yang ketat. EBP membantu bidan menentukan intervensi yang paling efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pasien, sekaligus meningkatkan keselamatan ibu dan bayi secara signifikan. Implementasi EBP juga berkontribusi pada peningkatan standar profesionalisme bidan serta membantu mereka mengurangi risiko praktik klinis yang tidak efektif atau bahkan berbahaya.

Perluasan peran bidan dalam pelayanan kesehatan primer juga menjadi tren penting dalam kebidanan saat ini. Peran bidan kini tidak hanya terbatas pada pelayanan kehamilan dan persalinan, tetapi juga mencakup berbagai aspek

kesehatan perempuan secara holistik. Bidan semakin aktif dalam memberikan layanan konseling keluarga berencana, edukasi kesehatan reproduksi, layanan skrining kanker serviks, dan manajemen kesehatan mental ibu selama masa kehamilan dan pasca persalinan. Peran yang semakin luas ini mencerminkan pengakuan terhadap kompetensi bidan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan primer perempuan dan meningkatkan kualitas hidup ibu serta anak secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, tren terkini dalam kebidanan mencerminkan perubahan paradigma menuju layanan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis teknologi informasi serta bukti ilmiah. Hal ini menuntut bidan untuk senantiasa beradaptasi, meningkatkan kompetensi teknologi mereka, dan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru ke dalam praktik sehari-hari, guna menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan beragam di era modern ini.

B. Isu Kontemporer dalam Kebidanan

Isu-isu kontemporer dalam kebidanan merefleksikan tantangan yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek etika, profesional, sosial, hingga regulasi dan akses pelayanan kesehatan yang adil. Salah satu isu mendasar adalah masalah etika terkait hak pasien dalam pengambilan keputusan mengenai pelayanan kesehatan. Hak ini semakin menjadi fokus perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya otonomi dalam menentukan pilihan kesehatan. Bidan menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa keputusan klinis tetap menghormati pilihan pasien, namun juga tetap mempertahankan prinsip keselamatan dan standar profesional. Tantangan ini semakin nyata terutama dalam situasi di mana pasien menginginkan metode atau pendekatan yang mungkin berbeda dengan rekomendasi medis yang berbasis bukti, sehingga menimbulkan dilema moral dan etis bagi bidan dalam praktik klinis sehari-hari.

Persoalan etika juga muncul dalam dilema antara mendukung persalinan alami versus melakukan intervensi medis. Tren global yang menyoroti pentingnya persalinan alami sebagai pendekatan yang lebih sehat dan ramah secara psikologis bagi ibu dan bayi, kadang bertentangan dengan realitas klinis di mana intervensi medis seperti induksi atau operasi sesar menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan demi keselamatan ibu dan bayi. Dilema ini membutuhkan kebijaksanaan bidan dalam menyeimbangkan keinginan pasien terhadap pengalaman persalinan alami dengan tanggung jawab profesional mereka dalam menjaga keselamatan

pasien melalui tindakan medis yang diperlukan, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan awal pasien.

Selain masalah etika, tantangan dalam kolaborasi antarprofesi juga menjadi isu penting dalam praktik kebidanan kontemporer. Pelayanan kebidanan modern menuntut integrasi berbagai profesi kesehatan seperti dokter spesialis, perawat, ahli gizi, psikolog, dan profesi kesehatan lain untuk bekerja secara sinergis dalam sebuah tim multidisiplin. Namun, kolaborasi semacam ini sering kali menghadapi kendala komunikasi, perbedaan pendekatan profesional, serta hambatan dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen untuk memperkuat budaya kerja tim, komunikasi efektif, serta penghormatan terhadap kompetensi masing-masing profesi kesehatan guna memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada pasien.

Di sisi lain, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi isu yang penting bagi bidan masa kini. Dalam era informasi yang semakin terbuka, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan kebidanan, baik dari segi aksesibilitas, kenyamanan, kecepatan respons, hingga hasil pelayanan yang optimal. Ekspektasi tinggi ini memberikan tekanan tambahan bagi bidan untuk terus meningkatkan kompetensi, mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan keterampilan interpersonal dalam berinteraksi dengan pasien.

Kompleksitas regulasi juga merupakan tantangan tersendiri dalam praktik kebidanan kontemporer. Bidan dihadapkan pada berbagai peraturan yang terus berubah dan berkembang, mulai dari standar praktik klinis, panduan pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga regulasi administratif dan hukum yang kompleks. Kompleksitas ini menuntut bidan untuk selalu update terhadap regulasi terkini, agar praktik kebidanan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari risiko kesalahan atau pelanggaran yang dapat berdampak negatif baik secara klinis maupun hukum.

Terakhir, tantangan besar lainnya adalah pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Banyak daerah di Indonesia, misalnya, yang masih kekurangan tenaga kebidanan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta akses transportasi dan teknologi yang menunjang pelayanan kesehatan. Kondisi ini memperbesar kesenjangan pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi di daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan berbagai upaya strategis, mulai dari kebijakan distribusi tenaga kesehatan, insentif khusus untuk

tenaga kebidanan yang bersedia bertugas di daerah terpencil, hingga pemanfaatan teknologi telemedicine untuk menjangkau wilayah sulit.

Dengan demikian, isu kontemporer dalam kebidanan memerlukan perhatian yang komprehensif, pendekatan yang terintegrasi, serta solusi yang berkelanjutan. Bidan, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak, harus mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan meningkatkan kompetensi profesional mereka, memperkuat kolaborasi antarprofesi, serta aktif berkontribusi dalam mendukung kebijakan publik yang berpihak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kebidanan secara nasional.

C. Tantangan Profesionalisme di Era Modern

Profesionalisme dalam kebidanan pada era modern mengalami perubahan signifikan, seiring dengan munculnya berbagai tantangan baru yang dipicu oleh perkembangan teknologi, kompleksitas regulasi, serta perubahan ekspektasi masyarakat. Bidan, sebagai tenaga profesional kesehatan yang memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi, harus mampu merespons dan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan ini agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan pelayanan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bidan di era modern adalah perubahan teknologi yang sangat pesat. Dalam praktik klinis sehari-hari, teknologi tidak hanya digunakan untuk membantu proses persalinan atau merawat bayi baru lahir, tetapi juga dalam sistem pendataan, komunikasi, dan layanan jarak jauh melalui telemedicine. Perubahan teknologi ini membawa keuntungan besar, tetapi juga menuntut bidan untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengoperasikan berbagai perangkat medis baru serta memanfaatkan sistem informasi kesehatan yang kompleks. Jika bidan tidak mampu mengikuti perubahan ini, mereka berisiko tertinggal dan kehilangan efektivitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Selain teknologi, kompleksitas regulasi juga menjadi tantangan serius bagi profesionalisme kebidanan. Di era modern, regulasi dalam bidang kesehatan berkembang dengan sangat dinamis dan semakin kompleks, mencakup standar praktik klinis, prosedur administratif, ketentuan hukum, hingga aspek perlindungan pasien dan tenaga kesehatan. Bidan dituntut untuk memahami dan menerapkan berbagai regulasi tersebut secara cermat dan konsisten. Kegagalan dalam mengikuti perkembangan regulasi dapat menyebabkan kesalahan dalam praktik, yang pada gilirannya bisa berdampak negatif secara profesional maupun hukum. Oleh karena

itu, bidan harus secara aktif mengikuti pelatihan reguler, workshop, dan seminar agar pemahaman regulasi mereka selalu up-to-date.

Di samping teknologi dan regulasi, ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan kesehatan juga memberikan tantangan besar. Masyarakat modern lebih kritis, lebih terinformasi, dan lebih menuntut kualitas layanan yang tinggi. Mereka tidak hanya mengharapkan pelayanan kebidanan yang aman dan efektif, tetapi juga pelayanan yang nyaman, empati, serta memiliki kualitas komunikasi interpersonal yang baik dari tenaga kesehatan. Hal ini berarti bidan tidak hanya dituntut memiliki keterampilan klinis yang tinggi, tetapi juga kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif dan empati yang mendalam terhadap pasien dan keluarganya. Bidan diharapkan mampu memberikan edukasi kesehatan yang jelas, menenangkan pasien yang cemas, serta menjalin hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan pasien dan komunitas yang mereka layani.

Dalam konteks yang lebih luas, tantangan profesionalisme kebidanan di era modern juga mencakup kemampuan dalam manajemen perubahan. Perubahan cepat dalam berbagai aspek, mulai dari kebijakan kesehatan hingga kondisi sosial-ekonomi, menuntut bidan untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Bidan perlu memiliki keterampilan manajerial yang kuat, termasuk kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, serta kemampuan bekerja sama dalam tim multidisiplin yang semakin kompleks. Kemampuan manajemen perubahan ini juga melibatkan kesiapan bidan untuk menghadapi berbagai skenario baru, mengelola stres profesional, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi agar tetap produktif dan sehat secara fisik maupun mental.

Untuk menjawab semua tantangan ini, pendidikan berkelanjutan menjadi komponen penting yang tidak boleh diabaikan. Bidan perlu secara aktif terlibat dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan lanjutan, baik formal maupun informal. Ini termasuk mengikuti kursus tambahan, pelatihan teknis, pelatihan interpersonal dan komunikasi, serta partisipasi aktif dalam organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Organisasi profesi memainkan peran krusial dalam menyediakan akses informasi terbaru, memberikan dukungan profesional, serta menciptakan standar dan panduan praktik kebidanan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, profesionalisme dalam kebidanan di era modern merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi para bidan. Dengan terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi, memahami regulasi

yang terus berkembang, serta menjaga komunikasi yang efektif dengan pasien, bidan dapat terus berkembang sebagai tenaga kesehatan profesional yang dihormati, mampu memberikan pelayanan terbaik, serta memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

D. Strategi Menghadapi Tren dan Isu dalam Kebidanan

Menghadapi tren dan isu yang berkembang, bidan perlu mengembangkan beberapa strategi penting seperti:

1. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan berkelanjutan.

Dalam menghadapi perkembangan yang pesat di dunia kesehatan, khususnya kebidanan, peningkatan kapasitas melalui pendidikan berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan mendasar. Pendidikan berkelanjutan bukan hanya berarti mengikuti pelatihan formal atau seminar, tetapi mencakup upaya yang terstruktur dan sistematis untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan bidan. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kursus khusus, pelatihan teknis lanjutan, workshop, seminar, simposium, webinar, serta studi mandiri yang terencana. Dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan, bidan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru, standar praktik klinis yang mutakhir, dan mampu menerapkan praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice) secara efektif. Pendidikan berkelanjutan ini juga mendukung bidan dalam memenuhi standar kompetensi profesional yang terus meningkat serta menjaga kredibilitas dan akuntabilitas mereka sebagai tenaga profesional kesehatan.

2. Pengembangan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik.

Komunikasi yang efektif dan keterampilan dalam manajemen konflik sangat penting dalam pelayanan kebidanan modern, terutama dalam konteks pelayanan yang semakin mengutamakan pendekatan pasien-sentris. Bidan dituntut tidak hanya terampil dalam aspek teknis dan klinis, tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan lain. Keterampilan komunikasi ini mencakup kemampuan mendengarkan secara empati, menjelaskan prosedur medis secara jelas dan sederhana kepada pasien, serta menangani keluhan atau kecemasan pasien dengan cara yang konstruktif dan suportif.

Selain itu, manajemen konflik menjadi penting karena dalam praktik sehari-hari, bidan sering dihadapkan pada situasi sulit atau konflik baik dengan pasien maupun sesama tenaga kesehatan. Menguasai keterampilan manajemen konflik

memungkinkan bidan menangani berbagai situasi secara profesional, menjaga hubungan interpersonal yang baik, dan memastikan lingkungan kerja tetap kondusif serta produktif.

3. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Dalam era modern ini, perkembangan teknologi di bidang kesehatan berlangsung dengan sangat cepat dan memberikan dampak signifikan pada praktik kebidanan. Teknologi informasi seperti telemedicine, aplikasi kesehatan digital, dan Electronic Health Records (EHR) menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, bidan perlu secara proaktif mengembangkan keterampilan teknologi mereka agar dapat memanfaatkan teknologi ini secara efektif dalam pelayanan sehari-hari. Adaptasi terhadap teknologi bukan hanya sekadar menguasai alat-alat baru, tetapi juga memahami bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas pelayanan pasien, dan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke daerah terpencil melalui metode telemedicine. Dengan adaptasi yang baik terhadap teknologi, bidan bisa memberikan pelayanan yang lebih terintegrasi, cepat, dan akurat.

4. Aktif dalam kolaborasi interprofesional dan intersektoral.

Dalam pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, kolaborasi interprofesional dan intersektoral menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan. Bidan perlu secara aktif terlibat dalam kolaborasi dengan berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan lainnya, guna menciptakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kolaborasi yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing profesi, kemampuan komunikasi yang jelas dan terbuka, serta kesediaan untuk bekerja sama secara tim dalam pengambilan keputusan klinis.

Selain kolaborasi antar profesi kesehatan, kolaborasi intersektoral dengan pihak-pihak di luar sektor kesehatan seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan juga penting dalam memperluas cakupan dan kualitas layanan kebidanan. Kolaborasi semacam ini membantu mengatasi tantangan-tantangan sistemik seperti kurangnya akses layanan di daerah terpencil, edukasi kesehatan masyarakat yang kurang memadai, serta permasalahan sosial-budaya yang sering kali mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

5. Pemahaman mendalam terhadap regulasi dan etika profesional.

Regulasi dan etika profesional merupakan landasan dasar yang sangat penting dalam praktik kebidanan. Bidan yang ingin sukses dalam menghadapi berbagai tren dan isu kontemporer wajib memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam praktik klinis, serta kode etik profesi kebidanan. Regulasi ini mencakup standar pelayanan klinis, prosedur administratif, perlindungan hukum pasien dan tenaga kesehatan, serta ketentuan lainnya yang bertujuan menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.

Selain regulasi, pemahaman yang mendalam tentang etika profesional juga sangat krusial. Bidan harus mampu menangani berbagai dilema etis yang sering muncul dalam pelayanan, misalnya hak pasien dalam mengambil keputusan terhadap kesehatan, atau situasi di mana terdapat perbedaan pandangan mengenai pendekatan terbaik dalam persalinan (alami atau intervensi medis). Dengan memahami secara mendalam prinsip-prinsip etika, bidan dapat mengambil keputusan klinis yang lebih bijaksana, menghormati hak-hak pasien, serta tetap memegang teguh integritas dan tanggung jawab profesional mereka.

E. Latihan Soal

Soal 1:

Seorang bidan di desa terpencil menghadapi kendala untuk merujuk pasien hamil risiko tinggi ke fasilitas kesehatan lanjutan karena keterbatasan akses transportasi. Sebagai solusi cepat dan praktis, ia memanfaatkan teknologi komunikasi video untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan di kota besar secara langsung. Strategi yang dilakukan oleh bidan tersebut merupakan bentuk implementasi dari konsep:

- A. Electronic Health Records (EHR)
- B. Telemedicine
- C. Evidence-Based Practice (EBP)
- D. Pendidikan Berkelanjutan
- E. Manajemen konflik

Kunci Jawaban:

B. Telemedicine

Rasional:

Telemedicine adalah pemanfaatan teknologi komunikasi untuk memberikan konsultasi kesehatan jarak jauh, khususnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Dalam kasus ini, bidan memanfaatkan video konsultasi dengan dokter spesialis, yang merupakan esensi dari telemedicine.

Soal 2:

Seorang ibu primigravida (hamil pertama kali) sangat ingin melahirkan secara alami tanpa intervensi medis. Namun saat persalinan berlangsung, ditemukan tanda-tanda gawat janin yang membutuhkan tindakan segera berupa operasi sesar. Dalam menghadapi situasi tersebut, sikap profesional yang harus ditunjukkan oleh bidan adalah:

- A. Menuruti keinginan pasien agar melahirkan normal
- B. Menghentikan layanan karena pasien menolak saran medis
- C. Mengutamakan keselamatan ibu dan bayi dengan menjelaskan risiko secara empati dan jelas
- D. Memaksa pasien menjalani tindakan medis tanpa penjelasan
- E. Mengabaikan pilihan pasien demi kenyamanan tenaga medis

Kunci Jawaban:

C. Mengutamakan keselamatan ibu dan bayi dengan menjelaskan risiko secara empati dan jelas

Rasional:

Meskipun menghormati keputusan pasien adalah prinsip penting dalam etika profesional, keselamatan pasien adalah prioritas utama. Bidan harus memberikan penjelasan secara empati, jelas, dan profesional terkait urgensi tindakan medis untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi.

Soal 3:

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan di puskesmas, seorang bidan mengusulkan penerapan praktik kebidanan berdasarkan bukti ilmiah terbaru (Evidence-Based Practice). Manakah tindakan awal yang paling tepat untuk mendukung implementasi tersebut?

- A. Mempertahankan metode lama yang sudah terbiasa digunakan
- B. Mengabaikan bukti ilmiah baru karena rumit diterapkan
- C. Mengikuti pelatihan khusus tentang penggunaan EBP
- D. Menolak perubahan karena takut akan teknologi baru
- E. Menggunakan teknologi baru tanpa pelatihan khusus

Kunci Jawaban:

C. Mengikuti pelatihan khusus tentang penggunaan EBP

Rasional:

Implementasi EBP membutuhkan kompetensi yang khusus terkait penggunaan hasil penelitian terbaru. Mengikuti pelatihan khusus merupakan langkah awal yang tepat agar bidan memahami secara benar bagaimana menerapkan EBP secara efektif dalam praktik klinis.

Soal 4:

Seorang bidan menghadapi konflik dengan seorang pasien yang merasa tidak puas dengan penjelasan terkait metode kontrasepsi yang disarankan. Pasien merasa informasinya kurang lengkap. Strategi terbaik yang harus dilakukan bidan dalam menghadapi konflik ini adalah:

- A. Menyuruh pasien mencari informasi sendiri
- B. Mengabaikan keluhan pasien karena sibuk
- C. Menyampaikan ulang penjelasan dengan cara yang lebih jelas, empati, dan terbuka terhadap pertanyaan pasien
- D. Menyuruh pasien untuk segera memutuskan
- E. Menyerahkan masalah kepada tenaga kesehatan lain

Kunci Jawaban:

C. Menyampaikan ulang penjelasan dengan cara yang lebih jelas, empati, dan terbuka terhadap pertanyaan pasien

Rasional:

Dalam situasi konflik dengan pasien, pendekatan terbaik adalah komunikasi yang empati, terbuka, dan jelas. Memberikan informasi ulang dengan pendekatan interpersonal yang baik dapat menyelesaikan konflik secara positif dan menjaga kepercayaan pasien terhadap bidan.

Soal 5:

Seorang bidan baru ditugaskan di sebuah desa yang minim akses teknologi modern. Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang efektif, bidan tersebut ingin menerapkan strategi adaptasi teknologi. Langkah awal terbaik yang sebaiknya dilakukan bidan tersebut adalah:

- A. Langsung membeli perangkat teknologi yang mahal
- B. Menolak penggunaan teknologi karena keterbatasan fasilitas
- C. Memetakan kebutuhan teknologi yang paling relevan untuk situasi di desa tersebut
- D. Menggunakan teknologi tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat

E. Menunggu instruksi khusus dari pusat tanpa inisiatif pribadi

Kunci Jawaban:

C. Memetakan kebutuhan teknologi yang paling relevan untuk situasi di desa tersebut

Rasional:

Sebelum menerapkan teknologi, bidan harus mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan dan kondisi aktual masyarakat. Strategi adaptasi teknologi yang efektif dimulai dengan memetakan kebutuhan teknologi yang relevan, praktis, dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

F. Rangkuman Materi

Perkembangan dunia kebidanan saat ini menunjukkan transformasi besar yang menuntut bidan untuk secara aktif merespons perubahan zaman. Integrasi teknologi informasi melalui penggunaan Electronic Health Records (EHR) dan telemedicine menjadi tren utama yang sangat membantu bidan dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, penerapan Evidence-Based Practice (EBP) menegaskan pentingnya keputusan klinis yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru demi memastikan keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Tren ini berjalan paralel dengan semakin meluasnya peran bidan dalam memberikan layanan kesehatan perempuan secara holistik, yang mencakup aspek kesehatan reproduksi, keluarga berencana, skrining penyakit, hingga kesehatan mental ibu.

Di tengah kemajuan ini, profesi bidan juga menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks seperti tantangan etika dalam pengambilan keputusan klinis, dilema antara persalinan alami dan intervensi medis, kolaborasi antarprofesi yang efektif, ekspektasi masyarakat yang meningkat, serta regulasi yang semakin kompleks. Isu-isu ini membutuhkan pemahaman mendalam dan pendekatan terintegrasi untuk mengelola berbagai tantangan secara bijaksana dan profesional.

Tantangan profesionalisme dalam kebidanan di era modern turut meningkat seiring cepatnya perubahan teknologi, dinamika regulasi, serta ekspektasi tinggi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Bidan diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi klinis yang mumpuni, tetapi juga mampu menguasai teknologi terbaru, memahami regulasi yang terus berkembang, dan menunjukkan keterampilan interpersonal serta manajerial yang tinggi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi penting seperti pendidikan berkelanjutan, pengembangan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, adaptasi terhadap perkembangan teknologi,

kolaborasi interprofesional dan intersektoral, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi dan etika profesional menjadi kunci utama keberhasilan.

Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang besar ini, bidan harus terus-menerus meningkatkan kapasitas dirinya agar tetap menjadi tenaga profesional yang kompeten, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat posisi profesi bidan, tetapi juga akan berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan pelayanan kebidanan yang aman, efektif, nyaman, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

G. Glosarium

Adaptasi Teknologi

Proses penyesuaian tenaga kesehatan, khususnya bidan, terhadap kemajuan teknologi yang mencakup kemampuan untuk menguasai dan menggunakan alat serta sistem teknologi baru demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Electronic Health Records (EHR)

Sistem pencatatan digital yang digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi informasi kesehatan pasien secara real-time, meningkatkan efisiensi administratif dan koordinasi layanan antar tenaga kesehatan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang menggunakan bukti ilmiah terbaru, hasil penelitian yang sudah divalidasi secara ketat, sebagai dasar pengambilan keputusan klinis demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keselamatan pasien.

Intervensi Medis

Tindakan medis seperti operasi sesar atau induksi persalinan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi komplikasi atau situasi darurat, yang bertujuan menjamin keselamatan ibu dan bayi meskipun kadang bertentangan dengan preferensi persalinan alami pasien.

Kolaborasi Interprofesional

Kerjasama antar berbagai profesi dalam bidang kesehatan, seperti bidan, dokter, perawat, psikolog, dan ahli gizi, yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada pasien.

Kolaborasi Intersektoral

Kerjasama antara sektor kesehatan dengan pihak-pihak di luar bidang kesehatan, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat, untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.

Kompetensi Profesional

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan, untuk melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan kebidanan secara efektif, aman, dan bertanggung jawab.

Manajemen Konflik

Keterampilan bidan dalam menangani situasi konflik dengan pasien maupun sesama tenaga kesehatan, dengan pendekatan empati, konstruktif, serta menjaga komunikasi yang positif demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.

Manajemen Perubahan

Kemampuan tenaga kesehatan, terutama bidan, untuk menghadapi dan beradaptasi secara proaktif terhadap berbagai perubahan cepat dalam regulasi, teknologi, dan ekspektasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Pendidikan Berkelanjutan

Kegiatan belajar secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang bertujuan memperbarui pengetahuan serta meningkatkan keterampilan profesional tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan dasar yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, termasuk layanan kebidanan yang berfokus pada kesehatan ibu, bayi, serta kesehatan perempuan secara holistik.

Persalinan Alami

Proses melahirkan tanpa intervensi medis, yang menekankan pada pendekatan alami, minim intervensi, dan seringkali dianggap lebih nyaman serta aman secara psikologis bagi ibu dan bayi dalam kondisi normal.

Profesionalisme Kebidanan

Standar sikap, perilaku, kompetensi klinis, serta tanggung jawab moral yang dipegang oleh seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, aman, dan beretika dalam pelayanan kepada pasien.

Regulasi Kebidanan

Peraturan-peraturan resmi yang mencakup standar pelayanan klinis, prosedur administratif, perlindungan hukum pasien dan tenaga kesehatan, serta kode etik yang menjadi pedoman bagi praktik kebidanan profesional.

Telemedicine

Pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti video conference, telekonsultasi, dan pemantauan jarak jauh, untuk memberikan layanan kesehatan secara efektif, terutama kepada pasien di lokasi terpencil atau sulit dijangkau secara fisik.

H. Daftar Pustaka

- Aboujaoude, E., & Gega, L. (2020). Editorial: From digital mental health to telemedicine. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 553-559. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00553>
- American College of Nurse-Midwives (ACNM). (2020). Core competencies for basic midwifery practice. American College of Nurse-Midwives. Retrieved from <https://www.midwife.org/core-competencies>
- Bashshur, R. L., Doarn, C. R., Frenk, J. M., Kvedar, J. C., & Woolliscroft, J. O. (2020). Telemedicine and the COVID-19 pandemic: Lessons for the future. *Telemedicine and e-Health*, 26(5), 571-573. <https://doi.org/10.1089/tmj.2020.29040.rb>
- Borrelli, S. E., Walsh, D., & Spiby, H. (2020). First-time mothers' choice and control preferences for childbirth: A qualitative approach. *Midwifery*, 89, 102825. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102825>
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). Essential competencies for midwifery practice: Update 2021. Retrieved from <https://internationalmidwives.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Panduan praktik klinis berbasis bukti dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu dan anak. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI.
- Macdonald, D., Snelgrove-Clarke, E., Campbell-Yeo, M., Aston, M., Helwig, M., & Baker, K. A. (2021). The impact of electronic health records on nursing and

- midwifery practice: A scoping review. *International Journal of Medical Informatics*, 145, 104327. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104327>
- Morley, L., Cashell, A., Cunningham, F., Smith, C., & Ncube, F. (2021). Enhancing interprofessional collaboration in maternity care: A narrative review. *Journal of Interprofessional Care*, 35(2), 305-313. <https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1807908>
- Phillippi, J. C., & Avery, M. D. (2018). The 2017-2019 ACNM research priorities: Aligning evidence-based practice and research. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 63(5), 506-510. <https://doi.org/10.1111/jmwh.12870>
- Reed, R., Sharman, R., & Inglis, C. (2017). Women's descriptions of childbirth trauma relating to care provider actions and interactions. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s12884-016-1197-0>
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd004667.pub5>
- World Health Organization (WHO). (2019). WHO recommendations on digital interventions for health system strengthening. Geneva: World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>
- World Health Organization (WHO). (2020). Maintaining essential health services: Operational guidance for the COVID-19 context. Geneva: WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications-detail/10665-332240>
- Yanti, N. L. M. E., Mulyadi, E., Wahiduddin, W., Novika, R. G. H., Arina, Y. M. D., & Daeng, N. A. (2020). Telehealth and telemedicine utilization during COVID-19 pandemic: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 9(9), 2614. <https://doi.org/10.3390/jcm9092614>
- Yazdkhasti, M., & Pirak, A. (2016). Electronic health record adoption and challenges in obstetric and gynecological practices: A systematic review. *Journal of Medical Systems*, 40(12), 252. <https://doi.org/10.1007/s10916-016-0605-z>

PROFIL PENULIS



Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr. Keb., M.Tr. Keb. Lahir di Madiun, 02 November 1994. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Husada Jombang untuk periode 2021–2026. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan pendidikan Diploma III di STIKes Bhakti Husada Mulia Madiun, kemudian melanjutkan pendidikan Diploma IV (Sarjana Sains Terapan) Kebidanan di Universitas Kadiri dan melanjutkan pendidikan Magister Terapan Kebidanan (M.Tr.Keb.) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Guna Bangsa Yogyakarta.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat. Penulis juga pernah mendapatkan hibah penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemendikbudristek, yang menjadi bagian dari kontribusinya dalam pengembangan ilmu kebidanan berbasis riset.

Selain aktivitas akademik, penulis juga aktif sebagai *volunteer* di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Cabang Madiun sebagai Ketua Divisi Edukasi dan Pelayanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rdwi3102@gmail.com

Motto: “Mengabdikan dengan ilmu, mendidik dengan hati”



Eka Rahmawati, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb. Penulis Lahir Di Kayuagung Tanggal 25 Mei 1994, Menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan di Stikes Mitra Adiguna Palembang Tahun 2015 dan Memperoleh Gelar Ahlimadiyah Kebidanan (Amd.Keb), Menyelesaikan Pendidikan D4 Kebidanan di Poltekes Bhakti Pertiwi Husada Cirebon Tahun 2017 dan Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb), menyelesaikan Pendidikan S2 Kebidanan di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2019

dan memperoleh gelar Magister Terapan Kebidanan (M.Tr.Keb), dan Menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Kader Bangsa Palembang Tahun 2023 dan Memperoleh gelar Bidan (Bdn). Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kebidanan Dan Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang.

PROFIL PENULIS



Arie Anggraini, S.ST., Bdn., M.Tr.Keb. Dosen Program Studi Profesi Bidan Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang Penulis dengan nama lengkap Arie Anggraini, S.ST., Bdn., M.Tr.Keb ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, kelahiran Jambi, 02 April 1994, beliau menamatkan D3 Kebidanan di STIKES Prima Jambi, lalu melanjutkan D4 Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta, Magister Terapan Kebidanan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, dan Profesi bidan di Universitas Kader Bangsa Palembang, Saat ini beliau berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas

Kader Bangsa Palembang dan saat ini menjabat sebagai Ka.Prodi Profesi Bidan.

Adapun beberapa buku yang ditulisnya antara lain: Komplikasi pada Kehamilan dan Penatalaksanaannya, Asuhan Kebidanan Komplementer, Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas dan Menyusui serta lain nya.

Keinginannya untuk menulis juga dimotivasi oleh kutipan Sastrawan senior Pramodya Ananta Toer yaitu " Orang Boleh Pandai Setinggi Langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian".

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi kemaslahatan bagi banyak orang.



Hana Nurhanifah Budiadi, SST., M.Tr.Keb Lahir di Bandung, 25 Maret 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Diploma IV Kebidanan Pendidik Politeknik Karya Husada Jakarta pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Terapan Kebidanan, STIKes Dharma Husada Bandung tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di STIKes Budi Luhur Cimahi mengampu mata kuliah Profesionalisme Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

hananurhanifah4@gmail.com

PROFIL PENULIS



Farida Utamingtyas, S. ST., M. Keb. Lahir di Kab. Semarang, 08 Mei 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Kebidanan pada AKBID Islam Al-Hikmah Jepara lulus pada tahun 2009. D-IV Bidan Pendidik pada STIKES Karya Husada Semarang lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjajaran Bandung dan lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja menjadi dosen tetap di Universitas Aufa Royhan Fakultas Kesehatan Prodi Kebidanan Program Sarjana dengan mengampu mata kuliah kebidanan. Penulis aktif di kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen pengajar mata kuliah kebidanan serta konsen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tentang kebidanan, penulis buku, publikasi, seminar, editor dan reviewer jurnal nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faridautamingtyas8@gmail.com.
Motto: "Menjadi pribadi yang bisa memberi manfaat bagi orang lain"



Bdn. Meli Doloksaribu, S.Tr.Keb., M.Keb. Lahir di Pematangsiantar, 30 November 1988. Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh Penulis yaitu jenjang D-III pada Program Studi Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara Tahun 2009, Pendidikan D-IV Bidan Pendidik pada Universitas Sumatera Utara dan lulus Tahun 2015, Pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus Tahun 2019, Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT) dan lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai bidan pelaksana di salah Praktik Bidan Mandiri di Kabanjahe. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT) mengampu mata kuliah Profesionalisme Kebidanan, Inovasi Pelayanan Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pada Pranikah dan Prakonsepsi, Asuhan Kebidanan Pada Remaja dan Premenopause, Manajemen Pelayanan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri darma Perguruan Tinggi dalam mengembangkan, mentransformasi ilmu pengetahuan melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: melidoloksaribu88@gmail.com.
"Selalu Jadi Versi Terbaik Dari Dirimu Sendiri Bukan Versi Kelas Dua Dari Orang Lain"

PROFIL PENULIS



Rona Riasma Oktobriarani, SST., M.Keb. Lahir di Madiun, 20 Oktober 1987. Penulis telah menyelesaikan pendidikan D4 di Program Studi Kebidanan Universitas Sebelas Maret lulus pada tahun 2010. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran lulus pada tahun 2014. Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelita Ilmu Depok. Penulis mengajar mata kuliah Konsep Kebidanan, Asuhan Kehamilan dan Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah. Penulis juga telah menghasilkan publikasi ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Nasional. Penulis dapat dihubungi di ronariasma@gmail.com.



Rochmanita Sandya Afindaningrum, S.Tr.Keb., M.Keb. Penulis lahir di Ponorogo pada tanggal 22 Agustus 1993. Menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 2000, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Ponorogo pada tahun 2006. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Ponorogo dan lulus pada tahun 2009. Ketertarikan penulis di bidang kebidanan membawanya melanjutkan pendidikan Diploma III Kebidanan di STIKES Aisyiyah Surakarta dan lulus pada tahun 2012. Pendidikan lanjutan ditempuh di jenjang Diploma IV Kebidanan di Universitas Kadiri dan diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis menyelesaikan studi Magister Kebidanan (S2) di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis saat ini aktif sebagai dosen di STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun. Penulis memiliki minat dalam bidang penelitian dan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kebidanan berbasis keilmuan.

PROFIL PENULIS



Bdn. Heni Haryani, M.Keb. Lahir di Sukabumi, 26 Oktober 1984. Pendidikan Tinggi yang ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Kebidanan Kebidanan pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan lulus pada tahun 2016 dan mengambil Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Kadiri, lulus tahun 2022. Riwayat Pekerjaan diawali pada tahun 2010-2011 di Stikes Rajawali Bandung. Klinik Mutiara Cikutra Bandung tahun selama tahun 2012. Kemudian di Bidan Praktik Mandiri Bd. Sri Wahyuningsih Bandung pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan pekerjaan sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Sorong, Papua Barat pada tahun 2017-2019 dan sejak tahun 2023 samapi saat ini mengajar di Prodi D3 Kebidanan Stikes Sukabumi. Penulis dapat dihubungi melalui email: haryaniheni20@gmail.com.



Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Prodi DIV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (MIKM) Minat Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, lulus tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Profesi Kebidanan di Univeritas Muhammadiyah Gombong. Saat ini (tahun 2023), penulis melanjutkan pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gajah Mada (UGM). Sejak tahun 2008, penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini aktif mengajar di Prodi Kebidanan Program Diploma dan Sarjana Univeritas Muhammadiyah Gombong. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis pernah mendapatkan Beasiswa Retooling Kompetensi Dosen Vokasi pada Tahun 2019 dari Kemenristekdikti. Penulis juga mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia (BPI) untuk Studi S3 dari Kendikbud tabun 2022. Penulis juga telah mengikuti pelatihan Training of trainer (TOT) Prenatal dan Post Natal Gentle Yoga serta Yoga Kids. Penulis dapat dihubungi melalui email ncuz.kusuma26@gmail.com
Pesan untuk para pembaca:
Hidup adalah tentang belajar....maka bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat...dan jangan pernah berhenti belajar....karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.

PROFIL PENULIS



Irma Seriana, lahir di Lam Neuheun, Aceh Besar pada tanggal 17 April 1982, dan telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan kesehatan khususnya bidang kebidanan selama lebih dari dua dekade. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari pendidikan menengah kesehatan di SPK Depkes RI Banda Aceh yang saya selesaikan pada tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang diploma dengan menempuh D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Depkes RI Banda Aceh dan lulus pada tahun 2001. Untuk meningkatkan kompetensi akademik, saya menyelesaikan pendidikan D-IV/S1 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Aceh pada tahun 2009. Tidak berhenti sampai di situ, saya melanjutkan studi ke jenjang

magister dengan mengambil program S2 Kebidanan di S2 Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, yang berhasil saya selesaikan pada tahun 2014. Puncak dari perjalanan akademik saya adalah ketika saya berhasil menyelesaikan program doktor pada tahun 2021 di Program Studi Doktor Matematika dan Aplikasi Sains Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pencapaian ini memungkinkan saya untuk mengintegrasikan pendekatan matematis dan sains dalam penelitian kebidanan. Sebagai dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh, saya berkomitmen untuk mendidik generasi bidan yang kompeten dan profesional. Pengalaman pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat menengah hingga doktor, memberikan saya perspektif yang luas dalam memahami kebutuhan pembelajaran mahasiswa di berbagai jenjang. Selain itu, saya memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan publikasi. Sejumlah karya tulis ilmiah telah saya publikasikan, baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Karya-karya ini mencerminkan komitmen saya untuk berkontribusi dalam kemajuan ilmu kebidanan dan kesehatan ibu serta anak. Dengan latar belakang pendidikan yang unik, khususnya gelar doktor dalam bidang Matematika dan Aplikasi Sains, saya berupaya mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan analitis dalam penelitian kebidanan. Hal ini memungkinkan pengembangan metode penelitian yang lebih rigorous dan inovatif dalam bidang kesehatan reproduksi. Sebagai seorang pendidik, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan kebidanan di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya percaya bahwa dengan pendidikan yang berkualitas dan penelitian yang berkelanjutan, kita dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di tanah air. Saya juga berharap dapat terus berkontribusi melalui publikasi ilmiah yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu kebidanan dan praktik pelayanan kesehatan di Indonesia.

PROFIL PENULIS



Bdn. Emilda AS, SST., MPH. lahir di Labuhan Haji, 5 Juli 1972 menempuh pendidikan D4 di Universitas Sumatera Utara dengan bidang ilmu Bidan Pendidik dangelar Magister KIA-Kespro di Universitas Gadjah Mada, serta Magister Profesi Kebidanan di Politeknik Kesehatan Jambi. Saat ini penulis merupakan staf dosen prgoram studi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh dengna jabatan fungsional Lektor Kepala. Sampai sekarang penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kebinana Persalinan dan BBL, Etikolegal dalam Praktik Kebinanan, Imunisasi, Asuhan Kebinanan Kehamilan, dan KDKK. Penulis aktif diberbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan HAKI. Penulis dapat dihubungi melalui email: emilda@poltekkesaceh.ac.id.
Motto: *All professionals start as beginners.*



Bdn. Evis Ritawani Hasibuan, S.S.T., M.Kes. lahir di Sorek Satu 25 Juni 1989. Dari ayah bernama Pinayungan Hasibuan dan Ibu bernama Nurjahasari Simamora. Penulis bertempat tinggal di Jl Teratai Ujung, Perum Villa Teratai Indah Blok A.9 Sidomulyo Barat, Pekanbaru, Riau. Telah menyelesaikan pendidikan D3 dengan Program Studi D3 Kebidanan di Akbid Helvetia Pekanbaru pada tahun 2007-2010, melanjutkan pendidikan D4 dengan Program Studi DIV Bidan Pendidik di STIKES Helvetia pada tahun 2010-2013 dan melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2013-2015 dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat di STIKES Helvetia. Awal karir dimulai pada tahun 2012 sampai dengan sekarang (tahun 2025) di kampus Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru. Saat ini menjabat sebagai ketua program studi D3 Kebidanan dengan mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Pengantar Asuhan Kebidanan dan Dokumentasi kebidanan. Sebagai pengajar penulis juga aktif di berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai penulis buku, kegiatan penelitian, kegiatan Abdimas, dan publikasi. Penulis juga aktif sebagai anggota IBI dan anggota AIPKIND Korwil Riau.

Sinopsis

Profesi kebidanan senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan mutu pelayanan kesehatan. Di tengah dinamika yang kian kompleks ini, kompetensi klinis saja tidak cukup; seorang bidan dituntut memiliki sikap profesional, kemampuan berkomunikasi efektif, integritas moral, serta pemahaman etika dan hukum yang kuat. Buku ajar *Profesionalisme dalam Kebidanan* hadir sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dan tenaga kebidanan untuk mengembangkan serta mempertahankan profesionalisme di berbagai situasi dalam praktik kebidanan.

Buku ini secara khusus membahas konsep dasar profesionalisme, tantangan penggunaan media sosial dalam pelayanan kebidanan, teknik komunikasi efektif dengan pasien maupun masyarakat luas, serta integrasi prinsip etika dan hukum dalam setiap tindakan bidan. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan berbagai studi kasus, contoh nyata, serta latihan soal yang aplikatif. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip profesionalisme secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini menyoroti manfaat dan risiko penggunaan media sosial, termasuk strategi untuk menjaga privasi pasien serta teknik menghadapi komentar negatif atau situasi kontroversial secara profesional di era digital. Pembahasan ini sangat relevan mengingat tingginya tantangan yang dihadapi para bidan dalam menjaga citra profesionalisme di ruang digital, serta pentingnya pemahaman mendalam terhadap regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Kesehatan.

Akhirnya, buku ajar ini diharapkan menjadi referensi utama dalam membentuk tenaga kebidanan yang tidak hanya kompeten dalam aspek klinis, tetapi juga memiliki integritas tinggi, etika kuat, serta mampu mengadaptasi teknologi digital secara bijak dan profesional. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan bidan Indonesia mampu memberikan pelayanan terbaik, beretika tinggi, serta mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat luas dalam era kesehatan modern.

Profesi kebidanan senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan mutu pelayanan kesehatan. Di tengah dinamika yang kian kompleks ini, kompetensi klinis saja tidak cukup; seorang bidan dituntut memiliki sikap profesional, kemampuan berkomunikasi efektif, integritas moral, serta pemahaman etika dan hukum yang kuat. Buku ajar Profesionalisme dalam Kebidanan hadir sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dan tenaga kebidanan untuk mengembangkan serta mempertahankan profesionalisme di berbagai situasi dalam praktik kebidanan.

Buku ini secara khusus membahas konsep dasar profesionalisme, tantangan penggunaan media sosial dalam pelayanan kebidanan, teknik komunikasi efektif dengan pasien maupun masyarakat luas, serta integrasi prinsip etika dan hukum dalam setiap tindakan bidan. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan berbagai studi kasus, contoh nyata, serta latihan soal yang aplikatif. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip profesionalisme secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini menyoroti manfaat dan risiko penggunaan media sosial, termasuk strategi untuk menjaga privasi pasien serta teknik menghadapi komentar negatif atau situasi kontroversial secara profesional di era digital. Pembahasan ini sangat relevan mengingat tingginya tantangan yang dihadapi para bidan dalam menjaga citra profesionalisme di ruang digital, serta pentingnya pemahaman mendalam terhadap regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Kesehatan.

Akhirnya, buku ajar ini diharapkan menjadi referensi utama dalam membentuk tenaga kebidanan yang tidak hanya kompeten dalam aspek klinis, tetapi juga memiliki integritas tinggi, etika kuat, serta mampu mengadaptasi teknologi digital secara bijak dan profesional. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan bidan Indonesia mampu memberikan pelayanan terbaik, beretika tinggi, serta mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat luas dalam era kesehatan modern.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta